

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR

II

VIVIAN LOEW

Instrumentación de juegos en Terapia Familiar

ANALIA KORNBLOT

Enfoques acerca de la problemática psicosomática
de la pareja

ALBERTO EIGUER

La transferencia en la Terapia Familiar de orientación
psicoanalítica

FRIDA RITERMAN

El concepto de espacio transicional de Winnicott

PAUL F. DELL

Más allá de la homeostasis:
Hacia un concepto de coherencia

ISRAEL ZWERLING

La lucha para sobrevivir

Dr. RAYMUNDO MACIAS AVILES

La familia y los problemas psicosociales

W. ROBERT BEAVERS

Un modelo sistémico de familias
para terapeutas familiares

ATENEO CLINICO

Alicia Budnik de Gibert, Diana Pavlosky, Gisela Ahlin,
Octavio Fernández Moujan y Hugo Hirsch

DIALOGO

A. Canevaro y C. Sluzki



terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar

Año VI - N° 11 - Septiembre de 1983

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina

Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Gerald Zuk (Filadelfia)

Alberto Serrano (Buenos Aires-San Antonio-Texas)

Jacques Rudrauf (París)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Maurizio Andolfi (Roma)

Richard Sauber (Massachusetts)

Robin Skynner (Londres)

Mara Selvini Palazzoli (Milán)

Raymundo Macías (México)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina-St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Donald Bloch (New York)

Ives Colas (Lyon)

C. Sluzki (Buenos Aires-S. Francisco-California)

J. Howells (Ipswich-Inglaterra)

Israel Zwerling (Filadelfia)

Florence Kaslow (Miami)

Alberto Eiguer (Buenos Aires - París)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Secretaria

Graciela Rodríguez

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Asesor Gráfico

Patricia Luppi

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Editorial ACE S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs. As., Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 142516.

Coordinación gráfica: Patricia Luppi, Tel. 33-3041, int. 505
Composición: Osmar Luis Bondoni, San Carlos 1520. Santos Lugares.

Tarifa reducida 3052 — Franqueo pagado 339 — Número del Registro Internacional de Publicaciones Científicas ISSN 0325-5905.

Impreso en Edigraf S.A.
Delgado 834
Septiembre 1983

INDICE

VIVIAN LOEW

Instrumentación de juegos en terapia familiar 9

ANALIA KORNBLOT

Enfoques acerca de la problemática psicosomática en la pareja 23

ALBERTO EIGUER

La transferencia en la terapia familiar de orientación psicoanalítica 35

FRIDA RITERMAN

El concepto de espacio transicional de Winnicott. Su valioso aporte a la tarea asistencial con familias 51

PAUL F. DELL

Más allá de la homeostasis: hacia un concepto de coherencia 75

ISRAEL ZWERLING

La lucha para sobrevivir. Perspectiva de un psiquiatra sobre la familia contemporánea 117

RAYMUNDO MACIAS AVILES

La familia y los problemas psicosociales. Hacia la atención de la familia, un problema, un camino .. 137

W. ROBERT BEAVERS

Un modelo sistémico de familias para terapeutas familiares 149

ALICIA BUDNIK DE GIBERT; DIANA PAVLOSKY; GISELA AHLIN; OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN y HUGO HIRSCH

Ateneo Clínico. De la aglutinación a la discriminación 167

A. CANEVARO con C. SLUZKI	
Diálogo	195
SINTESIS DE LIBROS	207
CONCURSO 1982 DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR	233
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR. ACTIVIDADES 1982 - 1983	235
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES	239

Instrumentación de juegos en terapia familiar.

Lic. VIVIAN LOEW

Av. del Libertador 662 - 4° 12 - Buenos Aires

En los últimos años se ha estado produciendo un rápido y muy productivo avance en el terreno de la Terapia Familiar. Se busca perfeccionar cada vez más las formulaciones teóricas, se buscan estrategias de cambio cada vez más efectivas. Esto lleva a que muchos terapeutas estén abocados a la integración de diferentes escuelas, a la utilización de técnicas provenientes de diferentes marcos teóricos con el objetivo de lograr una Terapia Familiar que pueda realizar cambios estructurales efectivos y rápidos.

Para la presente comunicación, tomaré elementos de la Teoría General de los Sistemas, trabajada por terapeutas de Familia y de Grupo terapéutico, juegos provenientes de la Gestalt, el Psicodrama y de Técnicas de formación actoral.

Richard Chasin y Henry Gruenbaum dividen los modelos de abordaje a la familia en tres perspectivas:

1. Perspectiva histórica: Qué pasó para que se esté dando esto.
2. Perspectiva interaccional: qué interjuego se está dando entre las partes y
3. Perspectiva experiencial: cómo se viven.

Dentro de la perspectiva *histórica* mencionan a Paul y Paul, quien trabaja sobre items irresueltos; Boszormenyi-Nagy y Spark con "fidelidades invisibles"; Toman estudia cómo influyen número de hermanos, lugar que se ocupa en relación a ellos en la familia, sexo, cuándo y dónde nació cada uno en relación al otro.

Dentro de la perspectiva interaccional, mencionan a Virginia Satir quien trabaja con tipos de comunicación disfuncional (el apaciguador, el distractor, el que produce confusión, el que hecha la culpa, el intelectualizador). David Kantor menciona cuatro posiciones psicopolíticas. A esta perspectiva pertenece la teoría del doble vínculo, las estructuras triangulares de Bowen, la teoría de la estructura familiar de Salvador Minuchin (jerarquías, límites, alianzas y coaliciones).

Dentro de la perspectiva experiencial incluye a Kantor, quien trabaja con la imagen que cada familia tiene de sí; a Bowen y la posibilidad de cada miembro de vivenciarse como diferenciado de los otros; los "climas familiares", etc.

Carlos Sluzki clasifica a los terapeutas de familia que trabajan desde la Teoría General de los Sistemas, siguiendo los siguientes modelos:

1. El modelo que busca el *proceso*: Comportamientos repetitivos, contruidos en forma de secuencias de acción que se autoperpetúan. Diferentes movimientos encadenados producen siempre la misma cadena. Visto desde un observador, muestra las reglas familiares: cuando sucede tal cosa, en esta familia se va a producir tal otra y luego tal otra. Si se modifica entonces alguna parte de la secuencia, lógicamente se tendrá que producir un cambio en el resto.

2. El modelo de *estructura*: cómo son los límites entre los integrantes, cómo se dan las jerarquías entre ellos. Se busca establecer un mapa de las relaciones entre ellos en cuanto, sobre todo, a reglas de participación y reglas de poder en diferentes áreas. Cómo se dan las transacciones entre sub-grupos dentro de la familia, cómo se dan entre la familia y el exo-grupo. Cómo se da la distribución y manejo del poder y la autoridad.

3. El modelo centrado en visiones de mundo o mapas de mundo: Toda conducta en una familia tiene un significado para sus miembros. Sluzki llama mapa de mundo a ese marco de referencia que comparten los miembros: símbolos, palabras claves, los "se debe y no se debe", historias que marcan quienes son los héroes y quienes los villanos de la familia, mitología compartida, anécdotas que conserva debido a que éstas organizan la experiencia en relación a acuerdos sobre valores y metas. Toda interacción en una familia está siempre enmarcada por esta visión de mundo. A partir de ésta la familia lee su historia, da significado a los hechos que viven, organiza su realidad.

Los tres modelos se complementan mutuamente. Cualquier conducta puede ser tomada desde cualquiera de los tres, y por supuesto, un cambio en el proceso lleva a cambios en estructura y contexto y viceversa.

En la presente comunicación seguiré la clasificación de Sluzki para ordenar los juegos, pero tomaré elementos de la clasificación de Chasin y Gruenbaum que me resultaron de utilidad.

Describiré juegos para detectar y modificar aspectos del proceso, estructura y mapa.

Proceso familiar

David Kantor clasificó los movimientos posibles de los diferentes integrantes de una familia como: iniciador, seguidor, opositor y observador.

Cada familia suele tener un par preferido, y arma sus secuencias de acuerdo a él. Así, en familias estilo peleador, la secuencia se arma así: alguien hace de iniciador, inmediatamente aparece un opositor. En estas familias es difícil llegar a cumplir metas, se desgastan en el camino (Vamos a... NO).

En familias estilo pacífico, a un iniciador suele seguirle un seguidor. Estas familias, al no tener observador, se estereotipan, encuentran dificultades en aprender algo nuevo desde adentro,

y suelen repetir un mismo error muchas veces (Vamos a... Bueno).

En familias estilo intelectual, a un iniciador aparece un observador, que objetiva lo que hizo el iniciador, con lo cual cuesta poner en acción cualquier proyecto (Vamos a... Vamos a pensarlo).

Toda familia necesita de los cuatro. Y habitualmente todos tienen la posibilidad de ser iniciadores, opositores, observadores y seguidores; y suelen serlo en diferentes contextos, fuera de la familia. Lo que sucede en una familia cuyos moldes se estereotipan es que alguna función no está disponible con esas personas que constituyen la familia.

Los juegos que relataré a continuación permiten abrir alguna posibilidad bloqueada con determinada persona, vivencialmente.

Si el estilo es *peleador*:

Para fomentar el par *iniciador-seguidor*: A menudo el estilo iniciador-opositor se establece debido a que les resulta difícil establecer un modelo basado en la confianza mutua. Para fomentarla y/o diagnosticar qué sucede con ella, un juego posible es el del 1. Lazarillo y el ciego: uno de ellos toma al otro de la mano y lo va conduciendo por la habitación. El conducido tiene los ojos cerrados y debe depositar su confianza en el iniciador.

2. Muñeco y dueño: uno hace de muñeco, el otro de dueño. El muñeco tiene que responder totalmente a lo que solicita el dueño.

3. Se pide a uno que comience una escena sencilla, sin palabras. El otro entra en escena, complementándolo (ej. uno barre, el otro pone la pala, ordena, plancha, etc.). Cambia la escena, donde el que fue seguidor comienza la acción.

Para fomentar el par *iniciador-opositor*: muchas veces, un seguidor no es opositor porque teme ser abandonado o castigado.

4. Juego del NO: Se le pide a un miembro de la familia que intente convencer al otro de algo. Que utilice todos los recursos que tenga a mano. La consigna para el otro es que tiene que

negarse y justificarlo, sin utilizar la palabra NO. Lentamente, con placer y sorpresa, van vivenciando un nuevo lugar, sin peligro, desde donde pueden ubicarse frente al otro, sin necesidad de ser abandonador. Van comprobando que el iniciador no sólo no se retira, sino que tiene la posibilidad de ser él mismo un nuevo seguidor, cambiar de rumbo a partir de la propuesta del nuevo opositor.

Para modificar el *estilo intelectual*: Este estilo está centrado más en pensar que en sentir. Uno hace o dice algo, el otro piensa sobre lo que hizo-dijo el primero.

5. Un juego: se ponen a distancia, enfrentados. Se van acercando, lentamente, mirándose a la cara hasta encontrar la distancia óptima a la que sienten quieren estar uno del otro. Ahí se paran. Se concentran en lo que SIENTEN y lo hacen (abrazarse, retirarse, agredirse, ignorarse, etc.). Aquí se cancela el estilo observador, y sólo queda descubrir y mostrar lo que se siente, es decir, lleva a sentimientos y acción.

6. El iniciador se para atrás del observador, a un metro aproximadamente. El observador tiene la consigna de dejarse caer hacia atrás, lentamente y observar qué siente en el pecho y la espalda mientras se tira para atrás. Este juego tiene por finalidad que el observador focalice su atención en lo que siente en vez de lo que piensa, y que pueda ir cobrando más confianza en el iniciador, de modo de no poner en tela de juicio cada cosa que hace, y esto permita llevar a la acción proyectos.

Las secuencias repetitivas toman diferentes formas. Cuando un terapeuta detecta una de ellas, un juego posible 7. es pedirles que reproduzcan exactamente lo mismo, pero en cámara lenta. Si hay algún fragmento que olvidan o excluyen, el terapeuta se ocupa en recordárselos. Se les pide luego que imaginen que una cámara lo tomó, y comenten, como espectadores, lo que "vieron". El objetivo es establecer distancia emotiva, de modo de poder pensar sobre lo que suelen hacer automáticamente.

Otro juego que tiene la misma finalidad 8. consiste en

pedirles que reproduzcan lo mismo que hicieron y dijeron, pero imaginando un contexto diferente, no coherente con la secuencia. La disonancia vivenciada en sesión lleva a que fuera de ella, en su vida cotidiana, alguno modifique algún movimiento de la secuencia, con lo que se altera todo el molde.

Otro juego con la misma finalidad 9. consiste en pedirles que reproduzcan la secuencia pero exagerando cada movimiento, sobre todo en lo emotivo. Ej.: "Tomá la leche, querida" "pero papá, la leche no me gusta" "te vas a poner flaca y fea" "me encantan las nenas flacas" "mirá, es mejor que tomes la leche... etc.". Exagerando desaparece el aparente tono amable que lleva a lo interminable: "tomá la leche o te incrusto la taza en la cara" "No la tomo nada así me mates". ¿De qué se trata? Nos estamos peleando por quién tiene más poder.

En cada secuencia, cada movimiento es interpretado por los otros con determinado significado. Una estrategia muy utilizada es resignificar la conducta de alguno de ellos, de modo que el resto de la familia no pueda continuar interpretándola de esa manera y necesite modificar los otros movimientos de la secuencia. Sucede con frecuencia que un miembro de la familia es vivenciado por los demás a través de una característica, se toma de ese miembro un aspecto parcial de su personalidad, una sola cara. Y se le atribuye un estilo.

Ej: El es el "sarcástico", ella la "quejosa", la hija "la zonza". Y las secuencias se arman a través de esta única característica: él se burla, ella se lamenta, la hija se distancia.

Un juego como para resignificar conductas consiste en 10. pedirle a la familia que imagine cómo se desenvolvería uno de sus miembros en una situación, pensada por el terapeuta, en la que esa característica no pueda ser usada. En nuestro ejemplo, se le pide a madre e hija que imaginen cómo se comportaría el padre viajando solo en un avión, ante una amenaza de accidente. Cómo se comportaría la madre en una entrevista por televisión hablando de un tema que conoce y le gusta, cómo se

comportaría la hija viviendo sola, de su trabajo, en otra ciudad. Una vez que aceptan una identidad coherente para el otro, basada en otras características, se vuelve a la secuencia repetitiva, resignificándola. "Fulano hace bromas porque teme entrar en depresión". El sarcasmo es cambiado por "broma" y se pide a la familia que lo ayude para enfrentar su depresión.

Existen algunas secuencias patológicas que aparecen con frecuencia. Una de ellas es la del *Perseguidor-Distante*: Cuanto más persigue un miembro a otro más se distancia el otro. En este caso es necesario que el perseguidor pueda vivenciar su vacío y encuentre el modo de llenarse, y que el distante vivencie su soledad. Se trabaja sólo con el perseguidor, el perseguido sólo escucha.

11. Se acompaña al perseguidor en una fantasía a través de un viaje imaginario por lugares y actividades, en los cuales estará sin su pareja. Como primera medida se trabaja su dificultad para desprenderse del otro, ya que ahí aparece la sensación de vacío. Luego se lo va llevando a que pueda irse llenando de otras cosas-lugares-actividades-proyectos hasta que se sienta a gusto. Una vez terminada esta parte del ejercicio (el perseguidor ya se encuentra instalado en un nuevo lugar, con otros contenidos), se le piden fantasías al perseguido, quien habitualmente relata un primer momento de alivio (al sentirse libre de su perseguidor) y un segundo momento de soledad. Llegado a este punto, se le pide al perseguido que intente introducirse en el mundo creado por el perseguidor. Aquí se rearma el molde, ya que es el perseguido el que tiene que entrar, no disparar. Y el perseguidor no está vacío.

Otra secuencia frecuente es la de un *acusador y un calculador-distante*. Aquí el juego 12. consiste en que cada uno mantenga su punto de vista, pero adoptando el estilo de comunicación no verbal del otro. Ej.: Ella: "sólo tenés ojos para mis defectos" (en tono acusador). El: "pero querida, estás irritada" (en tono amable-cariñoso). Ella: "me enferma tu sangre fría". El: "deberías descansar más", etc. Se les pide que repitan lo mismo que dijeron, pero que él adopte el tono acusador, ella el cariñoso.

Estructura

Vimos que en cuanto a estructura, nos ocupa eso que va quedando, como organización más estable, a partir del proceso. Los elementos con los que se trabaja son funciones, jerarquías, límites, alianzas y coaliciones.

Jerarquías:

Cómo vive cada miembro de la familia las jerarquías, puede ser visualizado fácilmente a través de la 13. esculturalización: Se le pide a cada uno que haga una escultura que represente cómo se viven. Luego, a partir de la segunda escultura, se les pide que la vayan modificando hasta que les guste el resultado.

Ejemplo: Ella lo vive a él como distante y dominante. El a ella como insaciable y poderosa. La escultura de ella fue: Puso a su marido en una silla en el living, de espaldas a ella, mirando TV. La escultura de él fue: El se ubicó en el piso, acostado, con sus manos cubriendo su cara, protegiéndose, y a ella la puso de pie, a sus pies, con las manos en la cintura, el pecho erguido, reprochándole. Al pedido de que lo modificaran, ella respondió alargando la mano para ayudarlo a levantarse. El se retrajo aún más. Se le pidió a ella que se alejara un poco para darle más espacio. El se incorporó y se puso de rodillas, en actitud de rezo. A ella no le gustó verlo así, y se dio vuelta, dándole la espalda. Entonces él se paró y se acercó a ella, ya que no la vivió más como una reprochadora. Desde esa posición, cuando ella abrió sus brazos, él se acercó, ya que lo vivió como una invitación a ser activo de un modo no amenazante para él.

Después de una esculturalización, es fácil encontrar cómo funcionan las jerarquías, más allá de las palabras, en lo cotidiano.

Funciones:

14. Se les pide que proyecten en conjunto una casa a la que irán a vivir. El terapeuta pone especial atención en a) qué ítems se negocian y cuánto; b) en qué ítems no se discute la autoridad de uno sobre el resto; c) en qué ítems se producen conflictos de jerarquías y límites.

15. Existe un candidato que quisiera pertenecer a esa familia. Se les pide a los integrantes, por separado, que escriban 1) Requisitos de ingreso; 2) Manual de instrucciones para desenvolverse bien con esa familia; 3) Manual de prohibiciones; 4) Instrucciones acerca de cómo tratar a cada miembro.

16. Cada uno de ellos dibuja un distintivo propio, basado en lo que supone son sus características en la familia. Luego los cotejan. Arman entre todos un distintivo familiar.

Límites:

Cuando los límites entre ellos son muy *rígidos*.

17. Se le pide a cada uno que repita, sin parodia, lo que el otro dijo, y lo amplíe hasta estar compenetrado con el sistema del otro.

18. Se les pide que vayan caminando, se vayan acercando, se sienten en el piso. El terapeuta pone una frazada encima de ellos. Los deja un tiempo así. Se saca la frazada y se les piden vivencias. Después de este ejercicio suele haber una gran carga emotiva, con lo cual es más fácil hablar de deseos y dificultades para acercarse uno al otro.

19. Se pide a cada uno que imagine una historia feliz para el otro, coherente con su personalidad. La finalidad es interiorizar a cada uno con el mundo del otro, llevarlos a pensar y sentir el mundo del otro, ya que tienen que imaginar desde él.

Cuando los límites entre ellos son *poco claros, borrosos*.

20. Se les pide que imaginen que van a asistir a un baile de disfraces. Cada uno va a elegir para sí y para cada uno de los otros miembros el disfraz que más lo represente. Aquí suelen delimitar, recortar roles de cada uno en relación a los demás, lo que lleva a definir límites.

21. Una de las maneras en la que dos personas consiguen no diferenciarse es a través de emitir señales no verbales, con lo cual ninguno de los dos completa una frase sin influencia del otro. El juego consiste en ponerlos de espalda, de modo que no puedan verse. Dialogan desde esa posición. Este juego apunta a que no perciban la comunicación analógica, ya que cada uno va regulando la conducta del otro con señales, con lo cual pierden

los límites. De espalda están solos, y pueden recuperar autonomía.

22. Cada uno se identifica con determinado personaje o animal, e interactúan, cuidando respetar las características de ese que eligieron. Habitualmente, mientras van eligiendo el animal, van recortando sus límites frente al otro. Por eso es importante darles tiempo para que vayan eligiendo, descartando, precisando cada elección hasta encontrar su lugar frente al otro.

Cuando las *alianzas están bloqueadas*.

23. Cuando dos personas tienen dificultades para aliarse, se les pide que juntos armen un rompecabezas, en determinado tiempo. Se habla luego de qué sintieron juntos.

24. Tienen que proyectar juntos una fantasía. Tienen una semana en la que pueden, juntos, hacer lo que quieren. No será recordado por nadie, no les va a contar en su historia ni a favor ni en contra. Al realizarla, lentamente van encontrando puntos en común, ítems en los que están de acuerdo, que les permite aliarse.

Para *desarmar coaliciones*.

25. Se pide a los dos miembros aliados que se pongan físicamente juntos, bien abrazados. Al excluido se le pide que intente forzar su inclusión físicamente. Esto grafica vivencialmente lo que sucede y permite exponer más directamente los sentimientos que la coalición produce en cada uno.

26. Se programan actividades de cada uno de los miembros aliados con el excluido. Esto lleva a que cada uno de los miembros aliados no sienta que "traiciona" al otro, aliándose con el excluido.

27. Cuando la alianza es con un miembro muerto de la familia: Se le pide al aliado que le escriba en voz alta al muerto una carta, donde le diga todo lo que siente por él, y por qué le está faltando. Esto moviliza mucho afecto en toda la familia. Los otros miembros comienzan a comprender qué necesita el que la escribió, y pueden, ofreciéndoselo, aliarse con él.

Para *fortalecer una estructura*, una vez modificada.

28. Se realiza un ensueño dirigido a 1, 5 y 10 años: Se

los relaja y se les pide que imaginen, con todo detalle, qué estará haciendo cada uno de ellos, en un día determinado, dentro de equis tiempo. Se pide que cada uno relate después qué están haciendo los otros miembros de la familia. Esto lleva a que puedan discutir, compartir y afianzar un proyecto de vida en común.

29. Se les pide que entre todos programen una vacación en el lugar deseado, y en el tiempo deseado.

30. Juego del altillo: cada uno imagina que entra en el altillo de su casa de la infancia. Ahí encuentra objetos de sus antepasados. Se analiza qué implica para ellos, cómo se comparan y en función de qué, ambas familias. Luego se les pide que imaginen un altillo donde sus nietos encontrarán sus cosas.

Estos últimos juegos tienen mucho contenido simbólico, además de facilitar la consolidación de la estructura.

Visiones del mundo o Mapas del mundo

Este modelo se refiere a qué ideales, metas, valores tienen. Su marco de referencia. Incluye cuáles son los modos preferidos de la familia de abordar conflictos, qué defensas son honrosas para con el afuera. Con qué imágenes se manejan.Cuál es su identidad como familia. Se toma también en cuenta aquí cuáles son los puntos en común, cuáles las diferencias, sobre todo en aquello en lo que se producen conflictos.

31. Se les pide que inventen un casamiento entre el padre de él y la madre de ella. Que imaginen cómo sería la vida de ese matrimonio y cómo sería un hijo de ellos. Se cotejan aquí valores y metas de las dos familias. Estableciendo diferencias se visualiza más el sistema de cada uno, así como también el sistema que establecieron entre los dos.

32. El terapeuta les pide que lleven a sesión una selección de fotos y cuenten por qué son importantes las fotos que eligieron para ellos. Aquí no importan los hechos históricos como tales sino que interesa encontrar el criterio en función del cual armaron su historia, ya que esto nos muestra su mitología.

33. El terapeuta les pide que lleven a sesión un objeto emotivamente valioso para cada uno de ellos. Se cotejan ahí valores de cada uno y diferencias entre ellos. Un objeto emotivamente valioso para los dos va mostrando cómo lograron la integración de los dos sistemas de valores.

34. El terapeuta pide a cada uno que dibuje una escena familiar, con el mayor detalle posible. Aparece aquí el recorte significativo para cada uno de ellos. Se discute por qué es significativo, qué implica en cuanto a sus valores.

35. Tienen la consigna siguiente: por 24 horas se han "vuelto locos". Eso les autoriza a hacer y decir todo lo que no suelen hacer ni decir. No se les tomará en contra ya que quedará claro que estaban "locos". En la segunda parte se les pide que imaginen qué harían los demás miembros de la familia, en el mismo estado. Habitualmente aparece aquí aquello que, por su sistema de valores, tienen prohibido, lo cual suele ser fácilmente asociado con el síntoma.

36. Se les pide que armen, por separado, una fantasía deseada y una temida, para dentro de cierto tiempo, en el futuro. Se analiza el presente en función de esa fantasía para el futuro y se trabajan las posibilidades de compatibilizarlas, compararlas. Esto nos permite visualizar de qué manera temores y deseos para el futuro están estructurando el presente de esta familia. Uno semejante es pedirles que inventen un pasado del cual son producto, inventen personajes y anécdotas que les hubiera gustado vivir, que hubieran temido vivir. Hechos desagradables y agradables, personajes queridos y odiados que podrían haberlos marcado.

Hasta aquí describí toda una serie de juegos, algunos tomados de la terapia de grupo. Trabajo con juegos ya que encuentro que el juego es una situación en la que se produce un conveniente equilibrio entre novedad y familiaridad. A través del juego, se pueden generar nuevas experiencias, encontrar nuevos modos que rompan estereotipos dolorosos para la familia y les permitan encontrar nuevos caminos, aún no transitados, que los lleve a mejores modos de encontrarse.

Resumen

Desde la Teoría General de los Sistemas, se toman dos clasificaciones de las distintas escuelas que trabajan en Terapia Familiar: la clasificación de R. Chasin y Henry Gruenbaum, y la de C. Sluzki.

Se toma luego esta última: él divide los modelos intermedios en aquéllos que enfatizan el proceso, los que se centran en estructura y los que toman visión de mundo.

A partir de esta clasificación, se describen diferentes juegos tendientes a diagnosticar y modificar distintos aspectos de estos tres modelos. Los juegos provienen de diferentes técnicas: psicodramática, gestáltica, técnicas de preparación actoral, ensueño dirigido, paradojales y resignificación.

Summary

From a General Systems Theory perspective, two classifications of Family Therapy models are mentioned: R. Chasin and H. Gruenbaum's, and C. Sluzki's.

Dr. Sluzki divides intermediate models in those which emphasize process, structure and world view.

In this paper, different exercises are described which tend to diagnose and change different aspects of these models.

The exercises come from different techniques: psychodrama, Gestalt, actor's training techniques, guided dream, paradoxes and reframing.

Bibliografía

- SLUZKI, CARLOS E.: *Process, Structure and Maps of the World in Family Therapy. Toward an Integrated View of Systemic Models*. Presented at the First International Biennial Conference "Innovatio" of the MRI/ETC, Nice, France, June 23, 1982.
- CHASIN, R.; GRUENBAUM, H.: *A Brief Synopsis of Current Concepts and Practices in Family Therapy. Family Therapy, Combining Psychodynamic and Family Systems Approaches*, ed. John K. Pearce and L. Friedman. Grune & Stratton 1980.
- FRIEDMAN, L. J.: *Integrating Psychoanalytic Object-relations Under-*

- standing with Family Systems Intervention in Couples Therapy*. Obra citada.
- KANTOR, David: *Critical Identity Image: A Concept Linking Individual, Couple and Family Development*. Obra citada.
- FREEMAN, D. S.: *Techniques of Family Therapy*, Aronson 1981.
- FAGAN, J.: "Las tareas del terapeuta". En *Teoría y técnica de la psicoterapia gestáltica*. Amorrortu editores.
- STEVENS, R.: "Body Work" en *Gestalt is*, ed. by John O. Stevens. Real People Press, 1975.
- SCHEFLEN, A.: *Communicational Structure: Analysis of a Psychotherapy Transaction*, Indiana University Press, 1973.
- JONES, S.: *Family therapy, a comparison of approaches*, R. J. Brady Co. 1980.
- LOEW, V.; FIGUEIRA, G.: *Cambio de juego, terapia, grupos, sistemas*, Ed. B&C, 1981.

CECAF

*Céntrico de Capacitación en
el Trabajo con Familias*

Director: Lic. Daniel Fränkel

Coordinadora: Lic. Psicología Social
Lydia Rapoport

Dto. Docencia e Investigación:

Cursos a profesionales que trabajan con familias.

Metodología sistémica aplicada al conocimiento de las
funciones familiares y de sus redes sociales

Dto. de Prevención:

Grupos operativos con parejas

Asesoramiento y orientación de la pareja.

Cosquín 256 - (1408) Bs. Aires Tel. 641-0752 y 659-8892

Enfoques acerca de la problemática psicosomática en la pareja.

Dra. ANALIA KORNBLIT

Moldes 1243, (1426) Buenos Aires

El modelo interaccional desarrollado por J. Haley y C. Madanes, denominado por ellos "estratégico", explica la sintomatología psicosomática en un miembro de la pareja como resultado de la presencia en su patrón interaccional, de una incongruencia jerárquica.

Dicho modelo asigna particular importancia en el establecimiento de patrones interaccionales, ya sea en una pareja o en una familia, a la estructura de *poder* que se desarrolla como parte de dichos patrones.

Se parte aquí del esquema introducido por Bateson (1936) y desarrollado después particularmente por la escuela de Palo Alto (Jackson, 1959), en cuanto a la diferencia entre relaciones simétricas y complementarias. Como se sabe, dichos términos fueron acuñados para describir dos posibles modalidades básicas de interacción. En las relaciones simétricas la definición de la situación entre los participantes es la misma, vale decir que A se relaciona con B como B con A. En las relaciones complementarias, en cambio, las conductas de los participantes son diferentes, pero mutuamente congruentes, como lo ejemplifican claramente los pares madre-hijo, dominación-sometimiento, etc.

Las formulaciones posteriores a Bateson adscribieron a las relaciones complementarias una dimensión subyacente de *poder*, en la medida en que uno de los participantes es visto como teniendo el control y por ende definiendo la situación de un modo que es aceptado por el otro. La posición del que tiene el control ha sido denominada "one-up", y la del que acepta tal control, "one-down" (o "superior-inferior" e "inferior-superior", respectivamente).

Al postular el concepto de "incongruencia jerárquica" en las parejas con un miembro psicósomático, Haley-Madanes hacen referencia al hecho de que se trata de una relación complementaria en la que el miembro sintomático está en una posición inferior al otro, y simultáneamente en una posición superior, en cuanto a que rechaza los intentos del segundo de ayudarlo a cambiar, y en cuanto a que a través de sus síntomas controla algún aspecto de la relación.

Podría decirse, pues, que se trata de una relación complementaria unida a una simetría oculta, puesta de manifiesto a través del poder que el síntoma confiere al enfermo, al que dota de un cierto carácter de intocable.

En esta concepción, el síntoma es una *metáfora* de otros tipos de interacción en otras áreas, y el sistema de interacción alrededor del síntoma es una *analogía* de otras situaciones de interacción en el matrimonio. El objetivo del terapeuta será organizar a la pareja de modo que el poder y la debilidad no se centren en el comportamiento sintomático, para lo cual puede recurrir a exagerar paradójicamente la incongruencia jerárquica, estimulando así a marido y mujer a reorganizarse en una jerarquía más congruente, de modo de coartar la posibilidad de que el sistema de interacción alrededor del síntoma exprese analógicamente las dificultades de la pareja.

Si bien esta caracterización podría decirse que se aplica en general a cualquier tipo de conducta sintomática, es en el área de la instrumentación de los síntomas corporales en la relación interpersonal donde puede verse con mayor claridad su carácter metafórico, en la medida en que se recurre a la introducción del cuerpo como área de expresión de fenómenos relacionales;

por ende, el "traslado" que implica lo metafórico se realiza apelando a un sistema no estrictamente interpersonal, como es lo corporal.

Esta aproximación del modelo estratégico de Haley-Madanes a la problemática de la "pareja psicósomática", puede ser completada abarcando otros elementos.

En primer lugar, pensamos que no se ha hecho bastante hincapié en el hecho de que la conducta sintomática en general, y en este caso la queja a nivel del cuerpo, representa *a la vez* un modo de evitar el conflicto subyacente y un modo de solucionarlo.

Se evita la confrontación directa —el choque, podría decirse— y se propone otro frente de relación, caracterizado por el patrón enfermo-necesitado de ser cuidado —sano-capaz de cuidar.

Las técnicas psicoterapéuticas más tradicionales apuntan especialmente a la evitación del conflicto, en una suerte de atajo directo que intenta bloquear la desviación. Recordando una vez más a Bateson, esto equivaldría a no ofrecer al sistema caminos para su autorregulación, y por lo tanto, la posibilidad de que se dé lo que en cibernética se conoce como un "runaway", o sea una carrera desenfrenada que culmina en la ruptura del sistema.

En nuestro modelo de abordaje, pues, respetamos la necesidad de la conducta evitativa, si ésta ha demostrado ser la pauta establecida del sistema, y trabajamos más especialmente con la posibilidad de ofrecer una respuesta alternativa en la modalidad sujeto cuidado - sujeto cuidador. Es éste un patrón complementario, y en esa medida es una solución al conflicto simétrico subyacente, si bien su consecución exige un alto costo tanto a nivel individual como al nivel del sistema, si pensamos en las limitaciones y sufrimientos que trae aparejado.

Se trata pues, de encontrar otra posibilidad de patrón complementario que pueda ser aceptado por ambas partes, sin que éste atente abiertamente contra el conflicto de simetría subyacente.

A este fin recurrimos a ciertas formulaciones del modelo

estructural de S. Minuchin. En dicho modelo, el concepto de *complementariedad* se define no en términos de la variable poder, sino como contingencia de la conducta de un individuo en relación con la de alguna otra persona. La conducta incontrolable de un niño es complementaria de la ineficacia por ejemplo de la madre, que a su vez es mantenida por el distanciamiento del padre. Como se ve, la complementariedad es postulada aquí como aquello capaz de describir el sistema. Lo que aquí postulamos es además que la patología a nivel del cuerpo denota la ausencia de roles complementarios funcionales.

En una relación de pareja funcional, la conducta por ejemplo de hiperactividad de uno de los cónyuges podrá ser regulada complementariamente por la asunción de un cierto rol de freno por parte del otro, así como la ausencia de tal rol complementario puede tener que ver con el desencadenamiento de situaciones de *strees* que culminen en la emergencia de patología corporal. En el caso del infarto, por ejemplo, se trataría de la falla de los mecanismos de alerta que llevan a un sujeto a controlar su participación a nivel de la exigencia de las interacciones en las que está inserto, más la ausencia de tal posibilidad de alerta por parte del cónyuge.

Por otra parte, en el modelo de Minuchin la existencia de un niño sintomático en una familia se explica a partir de su posición de triangulación con respecto a los padres, resultando así una configuración en la que el niño ocupa un rol central, con lo que se logra la evitación de los conflictos crónicos a nivel de la pareja paterna.

En nuestra concepción, la emergencia de síntomas corporales en uno de los miembros de la pareja puede ser analizada de forma similar, si se piensa en el cuerpo como una tercera instancia que se introduce metafóricamente en la díada, ofreciéndose como campo de expresión de conflictos que pertenecen a la esfera interaccional.

En ambos casos se trata de introducir una tercera instancia para manejar los conflictos que no pueden ser contenidos en el ámbito de la pareja.

La clásica formulación de "no soy yo sino mi jaqueca, úlcera, asma, etc., los que me impiden cumplir con tal cosa que me pides", habla a las claras de una disociación entre el síntoma y su portador, a la que éste recurre como modo de obviar conflictos crónicos en la relación, que no puede enfrentar de otro modo, subvirtiendo el orden de un modo indirecto.

Precisamente el carácter "subversivo" de los síntomas llamados "psicosomáticos" debe ser el elemento fundamental a tomar en cuenta en la psicoterapia de pareja en estos casos.

La simple denuncia de esta realidad por parte del terapeuta sólo puede llevar a que su propuesta sea rechazada, o bien aceptada a un nivel únicamente intelectual, que no basta para producir modificaciones en la estructura relacional.

A nuestro parecer, así como en palabras de S. Minuchin un niño incontrolable sólo puede ser tal si está subido a horcajadas sobre los hombros de uno de los padres. En estos casos, la sintomatología psicosomática de uno de los miembros de la pareja sólo puede ser mantenida si éste está apoyado abierta o encubiertamente por un miembro de la familia extensa.

Detectar quién es este miembro y cómo se verifica tal apoyo en términos de la variable enfermedad corporal es para nosotros el primer paso en la tarea con este tipo de parejas.

La subversión del orden en estos casos implica a la vez, volviendo al modelo de Haley-Madanes, la rebeldía frente al miembro ubicado en la posición "one-up", manifestada de un modo indirecto, y el permitir y/o favorecer la intromisión en el ámbito de la pareja de un miembro del sistema relacional más amplio en el que está inserta.

Nuestro primer objetivo en estos casos es descentrar la queja sintomática y lograr que la metáfora corporal sea reemplazada por otro organizador del conflicto, por ejemplo la defensa de la privacidad de la pareja frente a la familia extensa, concretada si es posible en uno de sus representantes. Este reemplazo de lo corporal por otro, como organizador de la queja permite:

- a) descentrar el síntoma.

b) romper un círculo aparentemente cerrado en la díada, pero que encubre la fuerte presencia de un tercero.

c) acceder a un nivel de simbolización menos primario que lo corporal, vale decir, cumplir una función de aprendizaje.

d) unir a la pareja a través de la defensa de su privacidad y de la elaboración de estrategias para mantenerla.

e) dibujar por ende un marco de interacción más directamente simétrico en la pareja, a través de puntualizar límites más claramente demarcados con el afuera.

De este modo, la nueva alternativa propuesta, si bien debe conservar, para ser efectiva, una cierta analogía con el patrón interaccional propio de la pareja, implica una metáfora con respecto a él, y como tal, un *traslado* a otro nivel. Es precisamente a través de dicho traslado que se cumple una modificación del patrón interaccional, dado que si bien se conservan los "lugares" iniciales (por ejemplo "necesitado" - "benefactor"), el contexto en el que son ubicados crea un ámbito relacional capaz de unir a la pareja de un modo menos disfuncional.

La metáfora tendrá como *referente* el patrón relacional que trae a la pareja a consulta, pero *denotará* otro patrón relacional posible.

Ejemplificaremos lo anterior con un breve comentario sobre un caso clínico. Se trata de una pareja joven, casada desde hace tres años. Consultan derivados por un gastroenterólogo, a causa de que la mujer sufre desde el casamiento de vómitos, mareos y otras manifestaciones para las que no se encuentra un correlato orgánico a partir de los numerosos estudios a los que se ha sometido. En la primera entrevista de pareja surgen dos datos significativos: las relaciones sexuales no han podido hasta el momento ser "completas", en su terminología, a causa de que ella rechaza la penetración. Por otra parte, la mujer está ligada de un modo particularmente estrecho a su padre, con el que se siente en deuda por los cuidados que siempre le ha prodigado. El patrón relacional de la pareja está establecido en torno a la regla de un marido algo distante, a quien los síntomas corporales de su mujer logran conmovir como para acercarse más cada

vez que ella "se descompone". Se trata de un sistema relacional caracterizado por el parámetro "distanciamiento-acercamiento", estando el marido ubicado en el polo del distanciamiento y la mujer en el polo del acercamiento. Para poner en práctica el mismo, ella recurre a manifestaciones corporales que han sido hasta el momento relativamente exitosas, si bien de un modo efímero.

Tanto el distanciamiento del marido como su acercamiento a partir de la expresión de sufrimiento por parte de la mujer, son evaluados por nosotros como lo que mantiene los síntomas corporales de la mujer.

Recíprocamente, pensamos que la negativa a la penetración por parte de ella reproduce el patrón "distanciamiento-acercamiento", si bien en este área es ella la ubicada en el polo del distanciamiento, mientras que la insistencia del marido en este plano lo ubica en el polo del acercamiento.

Tomando el patrón "distanciamiento-acercamiento" como referente, así como el dato sobre la particular ligazón de la mujer con su padre, nos fijamos como estrategia el conseguir un mayor distanciamiento en dicha relación, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento entre la pareja, a expensas de unirlos en una tarea común.

Le planteamos al marido, quien evidentemente aceptó su molestia por la estrecha ligazón de la mujer con su padre, la posibilidad de que no estuviera haciendo lo necesario para que la mujer se sintiera más motivada para con él, que para con su padre, con lo que lo pusimos en la senda de acercarse más a ella, revirtiendo su tendencia a alejarse, alimentada a su vez por la alianza de la mujer con su padre.

El aspecto más difícil de esta estrategia consistió en lograr motivar a la mujer para poner más distancia en la relación con el padre, uniéndose en esta tarea al marido. Se le dijo que debía focalizar su atención en encontrar otros recursos, diferentes a los síntomas corporales, para lograr que el marido se acercara, dado que su alejamiento era motivo de frecuentes quejas por parte de ella, y que cada vez que se descompusiera debía llamar al padre, en lugar de al marido.

Dado que la queja a nivel de lo corporal estaba dirigida al marido y no al padre, los ataques comenzaron a disminuir a partir de esta prescripción. Por otra parte el padre, indudablemente muy interesado en aprovechar cualquier resquicio para reforzar el vínculo con su hija, tomó los llamados de esta última cuando se sentía mal como pretextos para intentar incluirse más en la pareja, lo que produjo de parte de ésta una reacción conjunta de rechazo.

El patrón "distanciamiento-acercamiento" se mantuvo como referente del sistema relacional de la pareja, pero se lo encauzó incluyendo más al padre, en una maniobra paradójica que permitió el establecimiento de una mejor alianza entre marido y mujer. Tiempo después informaron que habían comenzado a tener relaciones sexuales "normales".

En este caso se trabajó con el mismo patrón que se consideró como privilegiado en la relación de pareja, pero de un modo tal que la inclusión de ambos en el polo del distanciamiento con respecto a un tercero denotó la posibilidad de un mayor acercamiento entre marido y mujer.

Nuestro modelo de abordaje de parejas con un miembro con sintomatología psicósomática incluye de un modo privilegiado la detección de los mecanismos de *mantenimiento* de la disfuncionalidad expresada como sintomatología corporal, de acuerdo con lo que Dell denomina la *coherencia del sistema*, en cuanto a que los síntomas corporales sufridos por un miembro de la pareja forman parte de un sistema que incluye al otro, a partir, ya sea de su inducción o de su falta de freno en las características del sistema que dan cuenta de la patología.

Es el sistema de interacciones entre los miembros de la pareja el que hace que en un determinado momento sea requerido el cuerpo en escena, a partir de una situación crítica frente a la que el *locus* corporal implica una suerte de reorganización.

Si bien lo anterior puede entenderse como un planteo causal, pensamos que el énfasis debe ser puesto en aquellas características de la interacción que *mantienen* el síntoma,

tanto en cuanto a lo que el miembro "sano" hace en tal sentido como en cuanto a lo que deja de hacer en relación con la condición patológica.

Esto significa que intentamos dejar de lado la etiología de la conducta sintomática, o en todo caso la consideramos en referencia a las interacciones "mantenedoras" de la condición que son las que nos interesan desde el punto de vista de las posibles intervenciones terapéuticas.

Si bien las puntuaciones anteriores se aplican más claramente a los síntomas tradicionalmente llamados "psicosomáticos", nuestra perspectiva incluye lo que Weakland ha llamado "familias somáticas", en las que lo interaccional puede postularse por un lado como factor de susceptibilidad que favorezca la emergencia de la enfermedad, y por otro, como factor en cuanto al desarrollo y evolución de la enfermedad, una vez que ésta se ha desencadenado.

En el caso de las coronariopatías, por ejemplo, la posibilidad de cambiar el estilo de vida que impone la enfermedad en aras de la prevención de su agravamiento, dependerá en buena medida de la posibilidad de readaptación del sistema, especialmente conyugal, a la limitación impuesta por la patología. Es por eso que pensamos que frente al desencadenamiento de un cuadro de este tipo es esencial el abordaje terapéutico de la pareja, dado que si bien es el órgano de uno de sus miembros el que falla, es en realidad el sistema el que debe modificarse en función de la creación de otras alternativas interaccionales, diferentes a las que precedieron a la aparición de la afección, que a nuestro criterio no podrán ser implementadas desde la perspectiva individual del sujeto enfermo.

La enfermedad humana, además de constituir una patología específica, se expresa en un determinado contexto ecológico, que para nosotros es de un modo privilegiado la interacción en la relación de pareja. Si bien desde nuestro punto de vista es imprescindible tal abordaje, por ejemplo específicamente como citábamos en la enfermedad coronaria, no ignoramos lo duro del intento, lo mismo que hace plantearse a Weakland: "Tal

vez, después de todo, deberíamos meternos en lo nuestro y no implicarnos en este tipo de abordajes" (op. cit., pág. 387). No obstante, en nuestra experiencia, vale la pena intentarlo.

Resumen

En esta comunicación se hace referencia a las formulaciones del modelo estratégico sobre las parejas con un miembro que presenta algún tipo de sintomatología orgánica. En dicho modelo se subraya la dimensión de poder, que adquiere aquí la forma de una incongruencia jerárquica.

Se presentan otros elementos útiles para operar en esta conflictiva, partiendo del concepto de complementariedad tal como es definido en el modelo estructural de S. Minuchin, como contingencia de la conducta de uno en relación con la del otro, lo cual es visto como patrón interaccional privilegiado.

La patología a nivel del cuerpo es concebida como la ausencia de roles complementarios funcionales en la pareja. Se destaca además el rol de la familia extensa en cuanto a alianzas de un miembro de este grupo con el miembro sintomático de la pareja.

El objetivo terapéutico en estos casos es descentrar la queja sintomática y lograr que la metáfora corporal sea reemplazada por otro organizador del conflicto, por ejemplo la defensa de la privacidad de la pareja frente a la familia extensa.

Se concibe la queja a nivel del cuerpo como una metáfora cuyo referente es el patrón relacional de la pareja, que denota otro patrón relacional posible, como modelo alternativo que la pareja puede poner en juego, a partir de la intervención terapéutica.

Summary

This paper is concerned about the concept of hierarchical incongruity in the couple from the Haley - Madanes' strategic model, applied specially to the couples in which one member presents psychosomatic or organic symptoms.

Other concepts feasible to work with that type of conflicts are presented, as the one of complementarity, in the sense in which is used by Minuchin' structural model in family therapy.

In this model, complementarity is described as the contingency of the

behaviour of one in relationship with the behaviour of the other one, which is seen as the privileged interactional pattern.

Body pathology is understood as the lack of functional complementary roles between the couple. Besides, it is supposed the role of the extended family in terms of alliances between one of its members and the symptomatic member of the couple.

In these cases, the therapeutic goal is to uncenter the symptomatic complaint, which must be replaced by another organizing element of the conflict, as the defense of the couple's privacy with respect to the extended family.

The complaint at the body level is described as a metaphor which *referent* is the couple's pattern of relationship, which *denotes* another possible pattern of relationship, as an alternative model that the couple can begin to display, starting from the therapeutic intervention.

Bibliografía

1. BATESON, G.: *Naven*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1936.
2. DELL, P.: "Beyond Homeostasis: Toward a Concept of Coherence", *Fam. Proc.* 21, 21-41, 1982.
3. HALEY, J.: *Leaving Home*, New York, Mc Graw Hill, 1980.
4. JACKSON, D.: Family Interaction, "Family Homeostasis and Some Implications for Conjoint Family Psychotherapy", en J. MASSERMAN (ed.): *Individual and Family Dynamics*, N. Y., Grune and Stratton, 1959.
5. MADANES, C.: *Strategic Family Therapy*, California, Jossey Bass, 1981.
6. MINUCHIN, S.: *Familias y Terapia Familiar*, Barcelona, Gedisa, 1977.
7. MINUCHIN, S. et al.: *Psychosomatic Families*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1978.
8. MINUCHIN, S. et al.: *Family Therapy Techniques*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1981.
9. SLUZKI, C. et al.: "Simetría y complementariedad: una definición operacional y una tipología de parejas", *Acta psiquiát., psicol. Amer. Lat.*, 1965, 11, 321.
10. SLUZKI, C. et al.: "Interacción familiar y esquizofrenia: I. Simetría-complementariedad." *Acta psiquiát. psicol. Amer. Lat.*, 1969, 15, 309.
11. WEAKLAND, J.: "Family Somatics". A Neglected Edge, en WATZ-LAWICK, P. y WEAKLAND, J.: *The Interactional View*, New York, W. W. Norton, 1977, 375-387.

salud mental

ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS TRASTORNOS PSÍQUICOS

- Psicoterapia Grupal - Individual - Familiar
- Clínica de Día
- Comunidad Terapéutica
- Internación

DIRECTOR PROFESOR
DR. JORGE GARCÍA BADARACCO
SUB-DIRECTOR
DR. NORBERTO PROVERBIO

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

d i t e m

O'HIGGINS 2328 - BS. AS.
TEL. 781-1306/7825/0557

La Transferencia en la Terapia Familiar de Orientación Psicoanalítica*

Dr. ALBERTO EIGUER

Médico psicoanalista. Psicoterapeuta y Docente del Hospital de Día, Servicio de Psicopatología del Adolescente y del Adulto Joven, Hospital Internacional de la Universidad de París. 154, rue d'Alésia, 75014 París (Francia). Traducción del francés: Lic. Stella Maris Molina.

I) El Funcionamiento Inconsciente del Grupo

La concepción y el tratamiento de la familia como un grupo nos han permitido encarar la técnica de la terapia familiar como una técnica semejante a aquella utilizada en la Terapia de grupo**.

El grupo familiar está compuesto de miembros que han

* Informe presentado en las Jornadas sobre el Abordaje Familiar en Psiquiatría, organizadas por la Asociación Francesa de Psiquiatría del 6 y 7 de Marzo de 1981.

** Por ejemplo, el nivel de angustia ante lo desconocido puede aparecer de un modo tan importante en las primeras sesiones de la terapia que nos suceda de consagrarle mucho tiempo e interpretaciones; por otra parte, su elaboración es necesaria para el devenir del proceso terapéutico y el investimento de la relación por la familia. La terapia de grupo nos enseñó a observar fenómenos semejantes y la respuesta técnica y sus consecuencias son aspectos largamente estudiados por los terapeutas de grupo. Esta técnica lleva por otra parte un nombre bastante claro en sí mismo como para no explicarlo; la interpretación centrípeta (Eiguer, 1981 c).

construido un funcionamiento inconsciente compartido, que deberemos tratar de concebir desde un ángulo diferente al del psiquismo individual. En efecto, en este período de nuestra Historia en que la esperanza de vida se ha prolongado considerablemente, no podríamos imaginar la cohesión familiar o la duración de la institución familiar (50 años) sin pensar que sólo el deseo de los partenaires pueda ser suficiente para semejante solidez. Además del *deseo* que va a determinar la elección de los objetos sexuales, tenemos todo el derecho de pensar que una nueva forma de funcionamiento inconsciente va a aparecer a partir del inconsciente de los individuos: un *inconsciente grupal* basado en las representaciones de objeto de los abuelos, en la coalición de las fantasías inconscientes y en respuesta a angustias personales tales como incertidumbre, penetración, castración. Hay que distinguir este inconsciente grupal del inconsciente colectivo de Jung, que Freud mismo rechazó proponiendo, en Totem y Tabú, otra noción de inconsciente social e introduciendo al mismo tiempo la posibilidad —incluso la necesidad— de las representaciones inconscientes compartidas.

Después del asesinato del padre de la horda primitiva, el grupo de los hermanos presta un solemne juramento de no matar más y se prohíben las relaciones incestuosas. Así nace para Freud, en un mismo acto, el tabú del incesto y la noción de lo colectivo, un espíritu de respeto recíproco y por último una búsqueda de coalición entre los humanos. Esto se renueva con cada individuo, el sujeto queda con la nostalgia de reencontrar en los otros y con los otros el grupo mítico y eso se realiza por el encuentro de las fantasías originarias... (Ruffiot, A., 1980).

Según Pichon-Rivière, incluso el mundo interior inconsciente en el individuo está construido como un grupo; el yo está en interrelación con los objetos introyectados del padre y de la madre. Relaciones ambivalentes o paradójales, todas conducen al individuo hacia el exterior al reencuentro de las experiencias idealizadas o no de la infancia. El grupo interno o el grupo concreto real se remiten uno al otro.

Aplicado a la psicología familiar, el inconsciente grupal familiar coexiste entonces con el inconsciente individual, y está representado en el psiquismo de cada miembro de la familia como una "ficción eficaz", término aportado por René Kaës. Este inconsciente familiar nutriría en primer lugar la vida afectiva y relacional de la familia y, en segundo lugar, explicaría la interacción tal como ha sido comprendida por los autores interaccionistas, sistémicos o estructurales; pero a diferencia de este abordaje que excluye la comprensión profunda, nosotros pensamos que es precisamente esta parte reprimida del psiquismo grupal que es puesta de manifiesto en la vida familiar de las familias conflictuadas o que presentan un hijo enfermo. Hemos querido enunciar una fórmula que, como toda fórmula, tiene el privilegio de la concisión y la desventaja de la reducción: "*Así como el síntoma neurótico es un compromiso entre dos instancias del aparato psíquico individual, el síntoma psicótico es una formación de compromiso producida por el inconsciente familiar*". En el caso del individuo, como en el caso de la familia, el compromiso permite un alivio económico, al precio, por cierto, de la disfunción de una parte, pero en provecho del resto. En el caso de la familia del paciente psicótico, la parte comprometida está representada por el sujeto enfermo, y el resto de la familia puede por ese hecho sentirse liberada de la carga fantasmática, tanto más cuando ésta provoca displacer.

II) "Se pretende hacer del terapeuta un segundo hijo psicótico. . ."

Cuando comenzamos la terapia familiar (T.F.) las reacciones defensivas de la familia van a tratar de desplegar con respecto al terapeuta los mismos mecanismos que están en el proceso de volverse enfermo en el interior de esa familia. El terapeuta está sumergido por esas reacciones transferenciales, por la torpeza, por la parálisis, por una actividad de disociación, y todo eso puede perturbar su pensamiento (cf. Whitaker y col.). El lugar del terapeuta, al saber que puede aportar el cambio por un lado y el descubrimiento por otro, es vivido con aprensión, lo cual es causa de resistencias a la transferencia.

He aquí dos cortos ejemplos de este tipo de resistencia a la "transferencia":

1) A la salida de una sesión de T.F. con una familia compuesta por el padre, la madre y un hijo psicótico, uno de los terapeutas pregunta al otro si escuchó algo, pues él es incapaz de recordar cualquier cosa del desarrollo de la sesión, a tal punto que estuvo a punto de dormirse. Con la cabeza y los párpados pesados, *él se moría de sueño*. El otro le dice que los miembros de la familia manifestaron su orgullo al ver al padre hacer una promoción tan buena en su empleo. En efecto, en la sesión anterior, el padre había contado que a la muerte de su patrón, la empresa había quedado en un estado desastroso: riesgo de quiebra, desocupación obrera, disputas por la sucesión. Entonces, habían recurrido a él (que hasta ese momento era cuadro contable) para que asumiera la dirección. Durante esta discusión post-sesión, los dos terapeutas pudieron entonces descubrir que la culpabilidad profunda del padre (culpabilidad compartida por los otros miembros de la familia) ante la agresividad que implicaba el hecho de tomar el lugar del patrón (padre) y el temor de la venganza de éste, había desencadenado en la transferencia un deseo de muerte de uno de los terapeutas. (Para la discusión sobre la "transferencia" a nivel institucional, cf. Lebovici, S.).

2) Un médico admite la internación de un joven toxicómano en crisis psicótica grave. Se entera en una entrevista con los padres (sin el hijo), que la verdadera madre del muchacho fue hospitalizada veinte años antes, en el mismo servicio, a causa de un estado psicótico. El hijo no lo ha "sabido" jamás y él "cree" que su madre es la mujer que se casó con su padre poco tiempo después, la que se ocupó de él durante su infancia y su adolescencia y que se encuentra ante el médico en ese momento. Desde la primera infancia, no ha vuelto a ver jamás a su madre. El médico queda consternado por esta historia: el secreto familiar de filiación inspira los pasos del joven, que vuelve allí donde su madre fue internada tiempo atrás! ¿Sin embargo sin saberlo? Como el padre y la "madre" se oponen a la revelación del secreto, el médico queda constantemente

preocupado por todo eso. Decide entonces ir a ver el legajo de la verdadera madre a los archivos del hospital y no encuentra allí ningún nuevo elemento de interés. El final de la historia es simple y relativamente feliz: el secreto es discutido en entrevistas colectivas. Dicho esto, hay que preguntarse si la diligencia del médico en busca del legajo fue un acto *inducido* por la política familiar del secreto.

La familia trata de *inducir* respuestas y comportamientos por medio de proyecciones narcisistas. Son numerosos los autores que señalan el poder de esta actividad de disociación, pero es allí donde nosotros nos diferenciamos de los autores sistémicos que predicán una contractitud distanciada ante el poder psicotizante de las familias de psicóticos. A este respecto, cito a Mara Selvini-Palazzoli:

"(...) Hemos llegado a la conclusión de que el riesgo más grave para un cambio terapéutico que amenaza al suprasistema familia-terapeutas es el de organizar ese supra-sistema de un modo estrechamente relacionado. La praxis empleada por nosotros nos parece útil para poder combatir eficazmente ese riesgo, por medio de dos modos operacionales simultáneos de los terapeutas:

a) introducir en el sistema familiar información terapéutica que quede invariable y actúe como constante no funcional de la organización en el instante preciso;

b) interrumpir la relación familia-terapeuta durante un tiempo prolongado, considerado indispensable para la acumulación de retroacciones observables".

Estas consideraciones sostienen el principio técnico del espaciamiento entre cada sesión, y el evitamiento de la instauración de una relación transferencial, cuando desde nuestro punto de vista eso es inevitable y también indispensable para la familia, y no solamente por el proceso terapéutico; según nosotros, es una nueva posibilidad que puede permitirse la familia.

A propósito de la transferencia en T.F., Stierlin (cf. Stierlin y otros, 1977) propuso distinguir una transferencia extra-familiar y una transferencia intra-familiar, según que el

fenómeno se manifieste entre miembros de la familia y el exterior, o entre miembros de la familia misma. Para aclarar este último punto, podemos examinar lo que la terapia de grupo ha permitido descubrir, a saber que en toda terapia hay que distinguir *una transferencia lateral entre los participantes, una transferencia del grupo sobre el grupo y por último una transferencia sobre el terapeuta* (Béjarano, cf. Bion, Ezriel, Ayel y Villier, Rouchy). La transferencia sobre el terapeuta sería una forma de transferencia extra-familiar (de Stierlin), mientras que la transferencia lateral y la transferencia sobre el grupo correspondería a la transferencia intra-familiar de este mismo autor.

A pesar de una sostenida atención a todo lo que escribe Stierlin, y a pesar de nuestra lealtad hacia los principios de la terapia de grupo, nosotros pensamos que en el caso de la terapia familiar, solamente la transferencia sobre el terapeuta puede ser considerada como una transferencia. La transferencia lateral o la transferencia de la familia sobre la familia no son ni más ni menos que el fundamento del mundo inconsciente de la familia. Se trata de los deseos fantasmáticos de los miembros entre ellos y de la representación inconsciente de lo colectivo: "el sí mismo familiar" (cf. Eiguer, 1981 c.). Dado que esos deseos y representaciones existen desde siempre en la familia, no vemos cómo podría considerárselos como transferencia.

La transferencia es un fenómeno actual. Nos queda aún por poner de relieve la transferencia sobre el terapeuta, pero en cuanto nuestra investigación penetra esta transferencia, nos vemos conducidos a distinguir un segundo nivel de transferencia, además del que se organiza sobre el terapeuta propiamente dicho: *una transferencia sobre el encuadre terapéutico* (digamos más bien una representación del encuadre) y *una transferencia sobre el proceso* (digamos: las expectativas familiares respecto de la evolución del proceso). En una palabra, sucede que la familia ataque el encuadre o el proceso, como para alcanzar al terapeuta pues piensa que él es el dueño. "Golpeando al perro, cree golpear al dueño". En su mirada omnipotente sobre el otro, la familia imagina que el terapeuta tiene el dominio del tiempo y de todo lo que pueda ocurrir en la terapia, cuyos

resultados conocería por adelantado y también todo lo que va a ser dicho en ella (cf. Béjarano: el superyo arcaico proyectado sobre el terapeuta de grupo).

III) El Objeto Idealizado y el Duelo por un Objeto Perdido

En "Contribución psicoanalítica a la teoría y a la práctica de la Terapia Familiar" (Eiguer A. y D., en Ruffiot y otros, cf., también, Eiguer, 1978) discutíamos acerca de las dificultades que existen para pensar una transferencia grupal y, sobre todo, una transferencia familiar por el hecho de que clásicamente, para facilitar la transferencia es necesario que el miembro de la familia "objeto de la transferencia"*, esté físicamente ausente de la sesión. Por el contrario, en T.F. pedimos a padres e hijos estar presentes en las entrevistas. A pesar de esas dificultades, hemos estimado que el interés del estudio de la transferencia se desplazaba entonces del fenómeno unigeneracional al fenómeno trans o multigeneracional, es decir hacia los abuelos, hacia otros objetos que jugaron un papel fundamental en la historia familiar. Por ejemplo los tíos, los personajes de la novela familiar o del delirio de filiación, los miembros desaparecidos de la familia y que descubrimos con mucha sorpresa durante las sesiones... A pesar de su alejamiento o su deceso, los personajes en cuestión están omnipresentes en el inconsciente familiar. La familia ha vivido duelos a menudo inelaborados y que coinciden con el comienzo de los disturbios en el hijo "designado".

Algunas de esas familias han soportado alejamientos geográficos, sea por maduración natural, sea con respecto a la familia ampliada de los abuelos, y es entonces que los conflictos, que habían estado demasiado mitigados por la hiperprotección macro-familiar, estallan.

Los objetos interiores de este inconsciente familiar son proyectados frecuentemente sobre los terapeutas y es así, mediante la puesta en escena dramática de los duelos, mediante

* Es decir que si se trata de una transferencia materna sobre el terapeuta, es preferible que la madre real esté ausente.

la reduplicación en el aquí y el ahora, que tales situaciones pueden ser abordadas.

El abordaje de la transferencia nos ha permitido sentir hasta qué punto, una vez pasados los primeros momentos en que la resistencia a la transferencia se manifiesta por ataques a nuestro pensamiento, *nuestra presencia era investida de idealización como tentativa probable de hacer revivir no sólo el objeto ausente sino también los vínculos con este objeto que había inhibido una parte de la actividad fantasmática de la familia*, a causa de haberse hundido la familia en una vivencia trágica de irreparabilidad. Nosotros representábamos la esperanza gracias a la cual el recuerdo vino a articularse, a reencontrarse en asociaciones más ricas y vivientes. Nuestra rigurosa técnica, con un encuadre bien enunciado al comienzo, permite la presencia y la ausencia, el alejamiento y el reencuentro del objeto fantasmático.

Es un poco arduo comunicarles aquí, en poco tiempo, lo que sucede en períodos de varios meses o varios años (nuestro trabajo se extiende de 1 a 3 años aproximadamente). Ustedes nos permitirán sin duda tratar otro punto antes de terminar con lo que se organiza durante las etapas avanzadas del proceso transferencial.

IV) Desnaturalización e Inversión de la Transferencia. Búsqueda de un arbitraje.

La resistencia a la transferencia a veces toma formas más caprichosas y sofisticadas que aparecen después de las formas abrumadoras y disgregantes mencionadas anteriormente (cf. Eiguer, 1981 b.). Podemos enunciarlas*.

* La distinción entre transferencia sobre el terapeuta, transferencia sobre el encuadre, y el proceso, puede sernos útil para explicar la evolución de la transferencia, desde el período inicial de resistencia psicotizante, hasta formas más ambivalentes consistentes en la proyección de un objeto inconsciente grupal sobre el terapeuta. Es cuando el encuadre se vuelve de alguna manera asunto de todos, como una parte estimable que cuidar, porque se vivencia ya no como "el perro a golpear"

1. *La desnaturalización de la transferencia* es una tentativa inconsciente de la familia de hacer de manera que el terapeuta se vuelva un personaje diferente a un terapeuta; y aunque la invitación pueda recaer en funciones altamente estimables, la familia puede proponer al terapeuta funcionar como médico, pidiéndole consejos sobre las "prescripciones" o sobre la conducta a poner en práctica en la casa, etc. Otras veces, la familia puede proponer al terapeuta familiar volverse el terapeuta individual del paciente, mientras que los otros miembros de la familia podrían suspender su tratamiento, y todo eso puede ser presentado como una necesidad imperativa, altamente valorizante del terapeuta, o bien todo eso puede quedar inconsciente pero expresándose en la metacomunicación.

Este problema está ligado al de la percepción y el manejo de la realidad. Cuanto más le cueste transferir a una familia, más va a tratar de utilizar la necesidad narcisista del terapeuta, sus fallas, lo que pueda conocer de la persona, de los contactos profesionales, o del rango jerárquico del terapeuta. La desnaturalización transferencial viene a colmar el vacío de la familia, una especie de hambre mimética, hambre de ver hacer, de ver vivir, de ver fantasear.

2. Cierta forma de transferencia que se puede llamar "*la inversión del rol terapeuta-familia*" consiste precisamente en una tentativa bastante cercana a lo dicho anteriormente: en lugar de dejar al terapeuta su función de exploración, los miembros de la familia tratan de explorar psicológicamente al terapeuta, por preguntas directas o indirectas sobre lo que piensa de ellos, sobre sus conclusiones en cuanto a su observación, o aún sobre su vida privada. Aunque el aspecto molesto de semejante invasión sea evidente, no habría que subestimar, detrás de todo eso, el aspecto positivo de demanda de ser guiado, de aprender a existir.

sino como "el perro guardián de la relación y de la posibilidad de fantasear". Guardián y garante del proceso, el encuadre es de cuando en cuando el continente de los aspectos más desorganizados del psiquismo grupal y su andamiaje narcisista.

Un ejemplo muy cercano de la desnaturalización, complicado sin embargo por una actividad fantasmática desbordante, es el de una familia que estaba experimentando intensamente la fantasía de la escena primitiva; el terapeuta se encontró ante la demanda de ir a exponer a la terapeuta individual del joven paciente algunas buenas sugerencias terapéuticas tales como, por ejemplo, hacer desarrollar su sentido artístico. Los miembros de esta familia imaginaban que el terapeuta familiar y la terapeuta individual eran tan íntimos que se mantenían al corriente de todo lo que se decía durante las sesiones; más aún, se daban recíprocamente consejos, sin duda. Debemos decir claramente que la familia no hablaba de intercambios sexuales; no creemos que eso fuera consciente, pero decían por ejemplo: "Ustedes (terapeuta individual y terapeuta familiar) se entienden en todo, se cuentan todo uno al otro..."

3. Una forma bastante conocida de transferencia es la *demanda implícita de un arbitraje*. El terapeuta es tomado (conscientemente o no) como un juez que debe decidir, quien tiene razón acerca de un diferendo. El conjunto del grupo familiar parece proyectar sobre el terapeuta un objeto super-voico idealizado, justo y al mismo tiempo punitivo.

Seguramente habrán ustedes comprendido hasta qué punto el tratamiento de la transferencia se torna fundamental en nuestra manera de encarar la T.F. (Eiguer, 1980 a). Pensamos que no es necesario insistir sobre el hecho de que no hay que precipitarse para anularla; al contrario, tenemos mucho interés en dejarla desarrollarse y progresar. La transferencia se manifiesta por emociones y afectos conscientes o inconscientes, que debemos respetar, sin desacreditarlos ni desaprobarnos; sin embargo eso es lo que hacen ciertos terapeutas, mucho más preocupados por restringir el investimento afectivo de la relación por la familia, situación que los conduce a ver en la transferencia una nueva maniobra anti-pensamiento. La transferencia es a menudo un compañero incómodo, embarazoso, pero nos es imposible "hacerlo desaparecer" del espacio terapéutico. Entonces debemos "proponernos hacerlo trabajar de nuestro

lado"; así podrá volverse un compañero de una ayuda inestimable.

V) Figuras de la Transferencia

Hacia el final del proceso va a aparecer lo que llamamos *las figuras de la transferencia*. No se trata ya de un objeto compartido y proyectado sobre el terapeuta, sino de relaciones transferenciales deseadas, dibujadas de una manera diferenciada por cada miembro de la familia. Es la vivencia edípica transportada a la sesión, el Edipo directo o invertido, con sentimientos de celos, de rivalidad, etc. La fantasía originaria (ICS) predominante es la de *seducción*. Esas figuras pueden aparecer muy fácilmente cuando se trata de la familia neurótica (cf. Eiguer 1981 a), o de parejas en terapia marital, cuando por ejemplo estas últimas se presentan desgarradas por conflictos entre partenaires que están decepcionados por la incompatibilidad entre la expectativa del objeto interno proyectado sobre el otro y su realidad; o aun cuando están confrontados a intensos sentimientos por el retorno de lo reprimido: una mujer puede constatar que se casó con un hombre que se parece a su madre y no a su padre, como ella había creído. Todas estas situaciones acarrearán conflictos; por la puesta en conflicto se "depositan" sobre el terapeuta, creando figuras de atracción, de rechazo, de seducción, de celos, etc. (Eiguer, 1980 b).

Debemos distinguir esa transferencia de la transferencia individual, por ejemplo, de un miembro de la familia sobre el terapeuta familiar (o sobre uno de los terapeutas si es una coterapia). Esta última transferencia es ciertamente muy fácil de detectar y aun muy frecuente —incluso se superpone con las figuras transferenciales—. Pero, la transferencia en la cual se asocian los diferentes miembros de la familia para expresar sus deseos edípicos es la más constante o al menos la más interesante para el trabajo terapéutico al final de la T.F. También es diferente de la transferencia colectiva solidaria, inspirada por el mismo fantasma primitivo del cual hablamos precedentemente, aunque los diferentes miembros de la familia puedan expresarla de una manera opuesta (Béjarano).

En el caso de una terapia con una pareja cuyo hijo fue decretado esquizofrénico, con una práctica homosexual bastante asidua, el terapeuta vio surgir esas figuras luego de tres años de T.F. (En este caso la pareja fue vista sola, cosa completamente excepcional en nuestra práctica, pues pedimos venir a toda la familia). En una sesión del último otoño, el terapeuta ve aparecer al padre solo. Justamente viene para informarle que su esposa está enferma. Sabe que no tendrá sesión sin ella; sin embargo, el terapeuta tiene la vaga impresión de que él desearía estar frente a frente con él. El dice que la esposa tiene gripe y que probablemente es por su culpa: le administró una vacuna antigripal en dosis homeopáticas, sin consultar al médico. El piensa que le dio demasiado —o tal vez poco— pero seguramente no lo que hacía falta. Después de eso su mujer tuvo fiebre, y ahora no puede salir de la casa. Luego de haber dicho eso, el padre del paciente se va.

Dejamos a ustedes aprehender el sentido de semejante declaración, tanto más interesante cuando es probablemente la primera vez que este padre admite haber cometido un error cualquiera. Su lenguaje extremadamente cuidado, muy raramente dejó aparecer un lapsus o cualquier otra expresión de su inconsciente. Una sola excepción, un solo olvido sintomático le impidió una vez expresarse con claridad: hablando de la profesión que su hijo había dicho irónicamente haber elegido, el padre no encontraba la palabra para "prostituto-macho".

Resumen

La práctica psicoanalítica de la terapia familiar tiene mucho interés en servirse de los descubrimientos de los psicosociólogos respecto de los fenómenos de "interacción", de inducción recíproca de los comportamientos, del establecimiento de reglas y de metarreglas en la comunicación paradójica. Pero, sin detenerse ahí, la concepción psicoanalítica de la familia, en tanto que grupo, puede proponer una explicación original de esos fenómenos. Por ejemplo, puede explicar la interacción, así como los fenómenos interpersonales, y el origen de ciertos síntomas, por las

fantasías inconscientes comunes y compartidas por todos los miembros de la familia y por el mundo de las representaciones objetales inconscientes de los individuos (con sus compatibilidades e incompatibilidades).

Esas nociones encuentran una aplicación en el proceso terapéutico de la familia. En esta intervención, se aborda el tema de la evolución de la transferencia. Al comienzo de la terapia, *las resistencias a la transferencia* adoptan la forma de manifestaciones globales en las que el (los) terapeuta(s) y el encuadre mismo son alcanzados por las proyecciones narcisísticas verbales o actuadas. Estas manifestaciones están directamente ligadas a los orígenes mismos de los conflictos no resueltos. Más tarde, la transferencia se define en una *transferencia grupal*, denominador común de objetos inconscientes compartidos por la familia. Finalmente las *figuras de transferencia* introducen la dimensión triangular. El abordaje y el trabajo de elaboración de la transferencia son un factor esencial para el cambio.

Summary

The psychoanalytic practice of family therapy is greatly interested in using the discoveries of psychologists with respect to the phenomena of "interaction", of reciprocal behavior induction, of the establishment of rules and metarules in paradoxical communication. However, going further, the psychoanalytic conception of the family as a group can offer an original explanation of these phenomena. For example, it can explain interaction, including interpersonal phenomena, and the origin of certain symptoms, through the unconscious fantasies shared in common by all the members of the family and also through the sphere of the unconscious object representations of the individuals (with their compatibilities and incompatibilities).

These notions find their application in the therapeutic process of the family. In this contribution, I approach the subject of the evolution of the transference. At the beginning of the therapy, the *resistances to the transference* take on the form of global manifestations in which the therapist(s) and the setting itself are the object of verbal or acted out narcissistic projections. These manifestations are directly linked to the very origins of the unresolved conflicts. Later on in the treatment, the transference defines itself in a *group transference*, common denominator of unconscious objects shared by the family. Finally, the *transferenceal figures* introduce the triangular dimension. The management and the working through of the transference are an essential factor for change.

Bibliografía

- AYEL, M.-H. y VILLIER, J., "Transfert et contretransfert dans un groupe thérapeutique; de quelques aspects le spécifiant comme groupe de psychanalyse", *Bulletin de psychologie*, N° spécial, 1974, Paris (pp. 327-328).
- BEJARANO, A., "Résistance et transfert dans les groupes", en Anzieu, D., y otros, *Le travail psychanalytique dans les groupes*, 1975 (pp. 65-144), Dunod, Paris.
- BION, W., *Recherches sur les petits groupes*, 1961, trad. francesa, PUF, 1965, Paris.
- EIGUER, A., "La prise en charge des familles dans un hôpital de jour", *L'information psychiatrique*, 1978.
- EIGUER, A., "Méthodologie de l'interprétation en psychothérapie familiale d'inspiration psychanalytique", *Psychiatries*, 1980 a n° 40 (pp. 13-26).
- EIGUER, A., "Thérapie familiale et hôpital de Jour", *Dialogue* n° 67, 1980 b.
- EIGUER, A., "L'impact de l'adolescence d'un enfant sur la famille", *Dialogue*, 1981 a, n° 72.
- EIGUER, A., "Guide de l'entretien clinique avec la famille", a aparecer en *L'information Psychiatrique*, 1981 b.
- EIGUER, A., "Considérations sur la famille du psychotique. Relation d'objet narcissique et vie fantasmatique groupale", a aparecer. *Psychologie Française*, 1981 c.
- EIGUER, A., y LITOVSKY de EIGUER, D., "Contribution psychanalytique à la théorie et à la pratique de la thérapie familiale", en Ruffiot A. y otros, *Thérapies familiales psychanalytiques*, Dunod, Paris, 1981.
- EZRIEL, H., "Le transfert et la psychothérapie de groupe", en Schneider P. B., *La pratique de la Psychothérapie de groupe*, II, PUF, Paris, 1968.
- FREUD, S. *Totem y tabú*, 1912, trad. francesa, Payot, Paris, 1977.
- KAES, R., *L'appareil psychique groupal*, Dunod, Paris, 1976.
- LEBOVICI, S., "A propos de l'approche familiale dans les psychoses de l'enfant", *Neuropsych. de l'enfance*, 1980, 28(9) (pp. 361-366).
- PICHON-RIVIERE, E., *Del psicoanálisis a la psiquiatría social*, Galerna, Buenos Aires, 1971.
- ROUCHY, J.-C., "Processus archaïques et transfert en groupe-analyse", *Connexions*, 1980, n° 31 (pp. 35-60).

- RUFFIOT, A., "Fonction mythopojétique de la famille", *Dialogue*, n° 70, 1980 (pp. 3-19).
- SELVINI-PALAZZOLI, M., "Terapia de la familia a transacción esquizofrénica. El control terapéutico del supra-sistema", *Terapia Familiar*, 1979, n° 4, Buenos Aires (pp. 99-107).
- STIERLIN, H., "Übertragung und Gegenübertragung in Lichte der Familientherapie", *Familien Dynamik*, 2, 3, 1977 (pp. 182-197).
- STIERLIN, H., y otros, *Le premier entretien familial*, Stuttgart, 1977, trad. franc. Paris, Delarge, 1979.
- WHITAKER, C. A., y otros, "Le contre-transfert dans le traitement familial de la schizophrénie", en Boszormenyi-Nagy, I. y Framo, J., *Psychothérapies familiales*, Harper and Row, 1965, trad. franc. Partielle, Paris, PUF, 1980.

CENTRO

de
D ocencia
I nvestigación y
A sistencia
P sicológica

Directores:

Dr. Roberto P. Montanelli
Dr. Carlos N. Díaz Usandivaras

PSICOPATOLOGÍA DE ADULTOS

PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL

PISCOPEDAGOGIA Y CLINICA DEL APRENDIZAJE

PSICOTERAPIA DEL GRUPO FAMILIAR

DOCENCIA - INVESTIGACION

ACASSUSO 907 - SAN ISIDRO - T.E. 743-8645 - Bs. AS.

SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA DEL "HOSPITAL ITALIANO"

Integrado al Dto. de Medicina

Guardia médica psiquiátrica activa permanente: de un médico de planta y un médico residente

- **Consultorio Externo:** Sectores de Adolescentes, Adultos y Personas de Edad.
- **Internación:** Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal.
- **Hospital de Día:** Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal, Psicodrama.

Jefa int.: Prof. Dra. Lía Ricón

Gascón 450

Tel. 811 - 4149



ASOCIACION ARGENTINA DE PERINATOLOGIA

Educación - Investigación - Desarrollo

Ofrecer Una manera de Nacer

Es elegir Una manera de Vivir

Eduquémonos y elijamos libremente

Parto Vertical
Nacimiento sin violencia
Perinatología y Stress
Puerperio - Lactancia

Informes: Av. Cnel. Díaz 2463 PB "A" (1425) Capital
T.E. 825-0657 de lunes a viernes de 17 a 21 horas

El concepto de espacio transicional de Winnicott. Su valioso aporte a la tarea asistencial con familias.

Lic. FRIDA RITERMAN

Lisandro de la Torre 177, (1638) Vicente López, Prov. de Buenos Aires

Quiero agradecer a aquellos colegas quienes en función de alumnos me dieron una posibilidad de integrar experiencias surgidas desde la clínica psicológica en la tarea asistencial con familias, con conocimientos brindados por maestros de mi quehacer.

Repetidas veces, a lo largo de estos últimos años, me he encontrado frente a dilemas que adoptaban la forma de mundo interno versus mundo externo. Esto que pudiera parecer —por su formulación— perteneciente al terreno de la clínica psicológica (de donde surgía en mi experiencia) en realidad resultaba no serlo.

Dada la circunstancia, como psicóloga argentina, de tener en mi origen una formación psicoanalítica Kleiniana, como psicoanalista de niños, a medida que me fui acercando a la perspectiva del trabajo con familias, fui sufriendo (a veces ese

era el pathos) transformaciones al intentar extender y flexibilizar mi cuerpo para ubicarme en otra mira.

El trabajo de familias parecía tener al menos un doble origen, la clínica psicológica y psicoanalítica con niños y adolescentes, y la tarea clínica psiquiátrica con personas psicóticas.

Experiencias de este nuevo territorio provenían a nosotros, en su mayoría desde los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas veces en franca oposición al psicoanálisis, mi casa de origen. Y es así como se iba imponiendo, al menos para mí, una doble imagen, a veces antagónica, dilemática. Mundo interno versus mundo externo. Desde el campo de la clínica, no lo podía resolver. Allí en cambio se daba el lugar donde sentía que no era cierto. Con la confianza que me proponía ese sentir y una antigua vocación de intentar una mirada más totalizadora partiendo de relativizar cada perspectiva, me alejé momentáneamente de ese campo para hallar otra forma de plantearme esa situación.

Si pudiéramos realizar una mirada abarcativa sobre los diversos grupos norteamericanos que practican la tarea clínica con familias, nós encontraríamos que se encuentran agrupados en torno a una franca apoyatura de centrar la tarea en el mundo externo. Entiéndase por mundo externo, el atenerse a lo dado, a lo que se ve, a la conducta producida en interacción. Entendemos que esto es coherente con una modalidad marcadamente anglosajona (como predominante y no como exclusiva) que tiene su correspondencia —no podía ser de otro modo— en una concepción filosófica fundamentalmente pragmática y que vertida a la clínica hace que la mira esté centrada en la modificación del sistema de relaciones observables y eso lo hace jerarquizar tanto, lo que en nuestra jerga se denomina mundo externo.

Los pueblos de crianza latina, como el nuestro, que pese a la colonización inglesa siempre conservó una fuerte influencia cultural latina, fundamentalmente francesa y española, tiene como arraigo una filosofía que vertida a la clínica psicológica-psicoanalítica y psiquiátrica, ha hecho mucho espacio a concep-

ciones que dan cuenta del mundo interno. Estas apreciaciones me permitían comprender desde cierta perspectiva, parcial por supuesto, también el fuerte arraigo del psicoanálisis en la Argentina, como una respuesta con afinidad a nuestra idiosincracia, respuesta digo, a una demanda que se hacía sentir con fuerza.

Hoy también quienes trabajamos como terapeutas de familias, sentimos la presión de una demanda que nos requiere concepciones teóricas que respaldan nuestro quehacer.

Hay quienes dicen, no sin razón, que por el momento, la psicoterapia de familias es una artesanía.

En todo caso en mi práctica he podido acceder a relativizar el posible fervor por una concepción determinada y también, intentando abrir —no siempre con éxito— mi disponibilidad de integración, sumado a una espera confiada en una futura producción de una teoría de la constitución de la familia.

No sólo desde la perspectiva psicopatológica, sino también desde la natural, los momentos de transición críticos del crecimiento —aunque parezca obvio— no terminan con la adolescencia, sino con la muerte.

La pelea mundo interno versus mundo externo, que tiene su correlato en lo femenino versus masculino, y a su vez su correlato de oriente versus occidente, ya se encuentra pareciera cerca de sus finales. Pienso que todo aporte por modesto que fuere, representa un relativo esfuerzo que se une a la energía de integración. Desde allí presento el mío.

Deseo aquí citar a D. W. Winnicott, quien afortunadamente para mí, vino a acompañarme como valiosísimo maestro e interlocutor, con su experiencia y reflexiones, a poner nombre a aquellas situaciones, que dada mi formación y práctica como psicoanalista de niños y mi trabajo anterior con el psicoanálisis como práctica clínica, entorpecían mi tarea con familias.

Citaré primero a Winnicott y retomaré el punto que acabo de enunciar, más adelante.

“... en general se reconoce que una exposición de la naturaleza humana en términos de relaciones interpersonales no

resulta suficiente ni siquiera cuando se tienen en cuenta la elaboración imaginativa de la función y el total de la fantasía, tanto consciente como inconsciente. Hay otra manera de describir a las personas, que surge de las investigaciones de las dos últimas décadas. De cada individuo que ha llegado a ser una unidad, con una membrana limitante, y un exterior y un interior, puede decirse que tiene una realidad interna, un mundo interior que puede ser rico o pobre, encontrarse en paz o en estado de guerra. Esto es una ayuda, pero ¿es suficiente?

Yo afirmo que así como hace falta esta doble exposición, también es necesaria una triple: la tercera parte de la vida de un ser humano, una parte de la que no podemos hacer caso omiso, es una zona intermedia de experiencia a la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior. Se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno, porque no se le presentan exigencias, salvo la de que existe como lugar de descanso para un individuo dedicado a la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez interrelacionadas, la realidad interna y la exterior...

"Estudio, pues, la sustancia de la ilusión, lo que se permite al niño y lo que en la vida adulta es inherente del arte y la religión, pero que se convierte en el sello de la locura cuando un adulto exige demasiado de la credulidad de los demás, cuando los obliga a aceptar una ilusión que no les es propia".

"Podemos compartir un respeto por una experiencia ilusoria y si queremos, nos es posible reunirlos y formar un grupo sobre la base de la semejanza de nuestras experiencias ilusorias. Esta es una raíz natural del agrupamiento entre los seres humanos". (D. W. Winnicott: *Realidad y Juego*; pág. 18-19).

Winnicott delimita el campo de lo transicional entre lo subjetivo y lo objetivo y le confiere el carácter de paradoja, es decir, que no es preciso intentar resolverla, sino aceptar su contradicción, como que esa es su idiosincracia, el reunir lo opuesto sin disolver la oposición, sin amalgamarla. Dejarla así, intacta, en suspenso.

Esta forma de concebir al hombre en uno de sus territorios, resonó en mí, velozmente; yo vivía a diario en la tarea como terapeuta de familias la existencia de un territorio que de algún modo comparte dos territorios distintos.

El concepto que se me imponía como un buen simil era el de frontera. Frontera en su doble significación: la de perfil que delimita (de-limita), y también la zona neutra que no es totalmente ni lo uno, ni lo otro. Una de las situaciones más difíciles de aceptar y a veces de vivir para el ser humano, es la existencia de fronteras tanto en lo de límite como y sobre todo en lo de una zona delimitada, no limitada. Muchos hemos hecho alguna vez la experiencia al viajar de pasar una frontera. Nos encontramos con el fin de un territorio, otro que no es de ninguno de los dos, llamado tierra neutral, y el otro territorio luego. Todo eso, que constituye la frontera, es un territorio "entre dos" logrado a partir de lo que Winnicott llama una "buena madre". Tener recorrida esa experiencia, ese territorio entre dos, o frontera, es tener la matriz de situaciones de pasaje. Pasaje, no como un corredor hacia, sino entendiendo el pasaje como instancia en sí, como potencial de virtualidades. Esto es difícil de adquirir en un mundo como el nuestro, que pone en juego una concepción estatizante, donde siempre lo fundamental es *llegar a, tener*. Fijando (dejando fijo) el logro como un objeto a poseer. Y donde se han convertido las situaciones de pasaje en un tránsito irremediable, que hay que recorrer a toda velocidad o instalarse en él, negándolo y convirtiéndolo en un paraje quieto. En niños criados en espera de ser grandes o en un como si lo fueran, el llegar al lugar, es el objeto focalizado; lo otro es un mal necesario. La mayor vida se da en el transcurrir, los lugares de supuesta y relativa llegada son situaciones de descanso y de cierre, microcierres. Depende de cómo se hace el tránsito, resulta el descanso.

En nuestro mundo, se concibe que en la vida lo fundamental a tener o lograr es "estar bien", es decir, estar en estado que no le pase nada a uno, estar sin conflicto, entendiéndose por conflicto "con-flictus", zonas de estrechamiento, angustia, que viene de angustia, también estrechamiento.

La adolescencia es un ejemplo límite de esto como momento de pasaje. Estatizado en nuestra época actual, tanto que se la pretende extender hasta los 30 años o más. Me refiero a la cultura económica y social del momento.

Cuando una persona tiene esta matriz adquirida y por lo tanto en funcionamiento —difícil tarea—, tiene un buen sistema de seguridad de vida creativa. Cuando eso no se da, el sujeto trata de llegar al lugar que cree que tiene que llegar y entonces construye personalidades “como si”; pues no tiene la estructuración de base que garantiza la *ligazón* de lo anterior en lo posterior.

Esto sería consecuencia de vivir el tránsito como una unidad valiosa en sí misma, y no como un corredor de paso, así, al llegar a los lugares —momentos de reposo— todo estaría ligadamente incluido. De otro modo, se logra un como si. El entusiasmo que despierta en mi establecer relaciones a partir del concepto de Winnicott, es decir de cómo él categoriza un hecho que me era y es tan familiar en mi tarea, quizás me haya alejado un poco, sobretodo por lo que siento profundamente afín partiendo desde la clínica (en este caso) a una concepción general de vida.

En la práctica asistencial clínica con familias, en mi territorio predominante de tarea (por eso lo focalizo allí) registré que el concepto de transferencia y contratransferencia me era insuficiente. Originado en la clínica psicoanalítica, había sido gestado desde la concepción de mundo interno y mundo externo individual. En su significación teórica, su alcance me era rico para comprender, no para operar. De hecho no había surgido ni sido reformulado para el ámbito de la tarea con familias, y parecía natural restringirlo entonces a su lugar de operación. Sin embargo, reconocía que yo, y otros muchos colegas, hacíamos lo mismo, pretendíamos utilizarlo extrapolado de su ámbito de operatividad clínica.

Yo me refiero a la tarea con familias, como dije, por ser ésta y la de parejas mi actividad especial desde hace largos años, pero intuyo que esto puede ser válido también para otros campos como por ejemplo el de la psicoterapia grupal. No digo

que esto sea una observación a indagar sólo en la tarea con familias; sino más bien que en mi surgió desde allí la necesidad, e invito a los terapeutas de grupo que reflexionen sobre estas hipótesis.

El concepto de Winnicott de espacio ilusorio, como frontera, me ayuda en la medida en que categoriza un territorio que yo siento el lugar donde transcurre la cura. Paso a definir más extensivamente esto.

Decía que se pone nombre a algo que sé que pasa, en ese territorio entre dos que se arma en un grupo familiar con el terapeuta. Pretendo proponer como hipótesis que el espacio de la relación donde “transcurre la cura” es el equivalente al espacio ilusorio de Winnicott. Es decir, ese espacio donde yo partiendo de mi función de terapeuta me pongo desde mi mundo interno y externo, y donde lo que me consultan se ponen desde su mundo interno-externo, y eso crea un gran espacio compartido, esa zona de frontera compartida, que es un espacio mío y del otro construyendo un espacio ilusorio, acordado como tal en la medida que se re-crea conjuntamente, y donde se registra la paradoja del adentro-afuera mutuo, que no pretende ser resuelta.

El concepto de transferencia y contratransferencia es más neto, de perfiles supuestamente precisos y surgidos de mundos individuales recreados en sesión.

En la consulta de familias, en sesión, al encontrarse en la tarea, donde se superponen tantas identificaciones introyectivas y proyectivas entre sus miembros, más las del terapeuta incluido en esa situación, el terreno es otro como lo dice Laing, al que nos referiremos luego.

Con la concepción de Winnicott que da margen a un territorio donde no es necesario definir qué es mundo interno y qué es mundo externo, nos encontramos con una zona de interrelación, una zona tercera (además de las otras dos relativamente diferenciadas) que es la que nos parece específica para transitar la cura y que como círculos concéntricos en irradiación isomórfica se van desplegando los otros momentos de diferenciación. Es responsabilidad del terapeuta poder transi-

tar e inducir su tránsito a quienes consultan, para restablecer ligazones interrumpidas.

Este concepto, el de Winnicott, tiene correspondencia, como he dicho en lo que he sentido vivencialmente como terapeuta de familia, ya que siendo más abarcativo contempla zonas de "supuesta" confusión o no-precisión, propias de las entrevistas de agrupamiento familiar, entre los miembros de la familia y en parte del territorio que participa el terapeuta (el de lo transferido).

De hecho en la concepción de Winnicott, esa matriz es gestante del ser humano y de la familia y lo es de las múltiples re-creaciones a lo largo de la vida.

En las entrevistas de agrupamiento familiar, se recrea esa situación, de participación múltiple, donde no tiene caso en determinado momento del proceso instaurar la diferenciación de supuesto mundo interno y externo, sino un tolerar transcurrir en ese espacio ilusorio gigantesco, siendo función del terapeuta, timonear en esos mares comunes de la humanidad, para llegar a buen puerto, el propio de cada uno.

Mares comunes de la humanidad, mitos según hemos dicho otras veces, estructuraciones universales pero que ya son una cierta resolución de esa primera indefinición o virtualidad que parecería ser un natural "*territorio de pasaje*" en el transcurrir terapéutico. Y que pienso forma parte de un territorio que no es específico de la cura, sino que la involucra; lo imagino como un centro de integración pulsátil infinito.

Quizás pueda resultar extraño a algunos esta forma de relacionarlo con otras circunstancias fuera de la específicamente clínica.

En este caso, lo realizo siguiendo naturalmente un sincero deseo de ampliar la visión, intentando relativizar el punto de mirada surgido del operar en clínica psicológica.

Veamos a continuación, una entrevista familiar, con el agrupamiento de todos sus miembros, donde una vez transcrita, intentaremos recuperar a través del material clínico —como suele decirse— imágenes que hemos ofrecido hasta ahora.

Esta es una entrevista, en curso de un proceso terapéutico.

El grupo familiar está integrado por el padre 45 años, la madre 40 años, y tres niñas: Luz de 13 años, Ada de 11 años y Nina de 9 años. La sancionada enferma había sido la tercera.

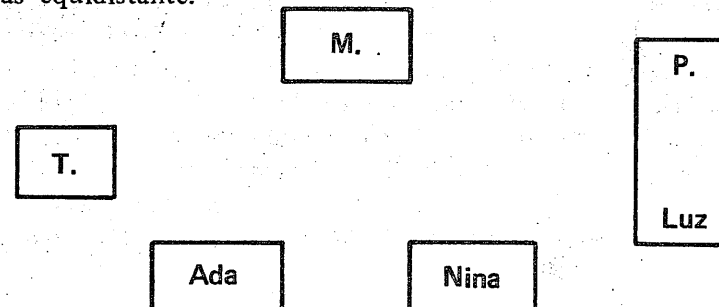
No voy a dar más información pues a los efectos del objetivo propuesto no lo consideramos necesario. En el libro "Cuerpo, Vínculo y Transferencia" realizado con Isabel Calvo (editado por Amorrortu) consta el desarrollo de la tarea realizada.

Este grupo fue coordinado sin co-terapeuta.

La entrevista que veremos tiene la concurrencia de todo el grupo luego de una serie de entrevistas diversas, habiendo sido la anterior realizada con los padres —formando parte de un proyecto de diseño múltiple.

La entrada al consultorio adquiere características habituales, las niñas lo hacen con mucho ritmo de acción que contrasta con una actitud corporal de retraimiento en los padres.

El padre se sienta en un sillón que tiene lugar para tres personas, la madre en una silla. Nina en el suelo sobre un almohadón, Ada en otro almohadón pero como en medio de los mismos con gesto gatuno centrado en su bienestar, mientras que Nina es un sentarse "lista para". . .; y Luz mira en derredor y se ubica junto a su padre, no muy cerca, hacia la zona de almohadones de sus hermanas. Yo espero que ellos se acomoden y luego elijo un lugar (como suelo hacerlo); mi lugar es móvil, y acostumbro a desplazarme si lo siento necesario, a modo de interpretación no verbalizada. Al decir que es móvil, significo que *realmente* lo es, es decir, tomo una silla y la coloco en el espacio que elijo, en función de lo que me parece oportuno. Al inicio de una sesión suele ser el que me parece más equidistante.



Se instala un breve silencio. Cada uno mira donde se acomodó el otro. Hacen comentarios. Nina dice que la madre siempre toma el mismo lugar y que el padre cambia un poco más. La hija mayor, Luz, pretende que no fastidien con observaciones. La del medio, Ada, se abstiene. El padre se burla de la madre aprovechando el comentario de Nina. Esto es dicho como superpuesto, por eso no lo transcribo en orden. Luego:

ADA: ¿Y vos Frida? Vos tenés una silla, pero la movés. Pocas veces venís a los almohadones.

COORD.: Sonríó y los miro a todos. Pienso que luego de no estar todos juntos, necesitan de un volver a acomodarse. No lo digo, prefiero dejar transcurrir, de hecho ellos se mueven y registran las ubicaciones familiares, en la que yo ya parezco tener un lugar, *individualizado y móvil*.

NINA (9a. la sancionada): Vengo acá y ya me acuerdo de lo que pasó en casa. *Es en esta casa* siempre lo mismo, uno no puede decir algo que ya estalla.

ADA (11a.): Nena, vos llamás, decís algo...

NINA: Sí, y qué... Algo. Sí. Lo que uno quiera y ya se armó.

LUZ (13 a): Depende de cómo se lo diga, del tono de la intención (*con mirada que dice no te parece y enjuiciarlo*).

NINA: Ya salió la sabia, sabionda. ¿Y entonces uno no puede estallar nunca?...

ADA: Yo digo las cosas y no se arma la podrida.

PADRE: Más que decir, hacer lo que querés... Como diría Frida, hacés lo que querés decir...

MADRE: Tiene un estilo más suave, como yo... Hemos visto con Frida lo de los estilos...

NINA: Y también que siempre la loca que estalla soy yo...

LUZ: Yo no te ví nunca así. Ninguno en casa es así.

PADRE: Vos rara vez, ves. Desde tu torre... ¡Ojo! que yo respeto tu actitud de hacer tu vida, comprendo tu edad. Pero no participás de los líos que nos trae Nina.

COORD.: Siento deseos de decir "una vez más"... el encierro y la violencia para zafarse, y al oírme entiendo que eso

es el encierro, el "una vez más". Repetir y repetir, como conmigo, donde yo a veces quedo en el encierro y a veces puedo ayudarlos a hacer una puesta que no sea un estallido (pienso y no digo que eso parece relacionarse entre ellos con la preferencia y exclusión; quedo pensando).

NINA: Sí, eso lo vimos.

COORD.: Tengo ganas de proponerles un juego...

NINA Y ADA: Sí, dale (*entusiasmo*).

(*Ada y madre se miran y sonríen*).

LUZ: No dice nada, pone cara de: si no hay más remedio. (*Aclaro que otras veces habíamos incluido juegos*).

COORD.: Sería así: Cada uno, después de pensar un rato, le va a decir a cada uno de los otros "fulanito, yo no te quiero por..." (*La consigna de "yo te quiero por..." ya había sido jugada*).

LUZ: ¡A la flauta!

ADA: Dale, vamos.

NINA: ¿Y si lo cambiamos un poco para que sea más fácil?

COORD.: ¿Cómo sería lo que proponés?

NINA: Por ejemplo: si yo no soy yo y le digo a otro "no te quiero por...", pero siendo yo por ejemplo Ada, ¿entienden?

TODOS: Sí, así va mejor.

NINA: Claro, si uno ya no es uno, es otro, se puede más fácil.

LUZ: Igual uno no es el otro, porque, qué sabés si cuando alguno habla por mí, yo voy a creer que de verdad es eso. Capaz que me parece una locura total, que yo nunca lo diría así...

ADA: Bueno, ¿pero te animás o no? Largate intelectual... (*Risas*).

MADRE: No empiecen a cargar...

COORD.: Yo acepto la rectificación propuesta por Nina, me gusta y si ustedes la aceptan también, comiencen.

PADRE: Sí, de acuerdo. En ronda como la otra vez del "yo te quiero por..."; ¿y quién empieza?

NINA: Yo, yo me animo. Bueno... (*mira a las hermanas*) no se rían. Yo soy Ada, le digo a Luz "No te quiero porque siempre estás en lo tuyo". Soy Ada, y le digo a Nina: "No te quiero porque vivís encima mío, queriendo todo lo mío (*el grupo mira sorprendido, gestos de asentimiento de Ada*)".

A mamá Ada le dice: "No te quiero porque ah... me cuesta encontrar algo. Ah, sí, ya sé, porque siempre está mirando lo que no hago bien".

A papá, Ada le dice: "No te quiero, porque no me das bolilla".

(*Risa general*)

ADA: Eso no se parece a no quererlo... (*la mira con picardía*)

Nina se sonroja y humedece su mirada. Más risas aún.

NINA: Y se terminó. Falto yo a mí misma. Y yo no me quiero porque yo soy yo. (*Muy conmovida*).

ADA: Tonta, no era de uno, era de jugar a que uno es otro.

NINA (*muy triste*): Sí, bueno, ahora sigan Uds.

COORD. (*Al ver que nadie toma la tristeza, decido intervenir*): Quizás aunque el juego tiene que seguir, podemos detenernos un poco aquí, en esta fuerte emoción tuya de tristeza, y ver qué les pasa a todos con eso.

NINA: No, no sirve, que se lo juegue, sino se van a echar atrás y seré la única que jugó.

COORD. (*Esto concuerda con que es la única que se quiebra en la acción, pero que tampoco se puede juntar con su emoción de tristeza cuando se gesta y recién sale como violencia*)

COORD.: Sí, creo que es necesario que todos puedan jugar y no sólo Nina, pero también es necesario sentir, darse permiso de sentir la emoción cuando aparece y que las demás la vean y sientan, si no, sólo sale cuando no se puede más y estalla.

Silencio denso, con un toque de tristeza-preocupación.

LUZ: Bueno, yo sigo... Pero quiero aclarar que me dolió que no te quieras nada. Más me duele eso que tus enojos caprichosos. Yo soy Nina y digo a Ada: No te quiero por que

so la que queda mejor parada siempre, como los gatos. A Luz: No te quiero porque no te ocupás de mí. (*Nina asiente con lágrimas en los ojos*). A mamá: No te quiero porque me tratás siempre como a una enferma. (*Miran todos a la madre*). A papá, (*rápido, apurada*) no te quiero porque hacés lo mismo que mamá. Bueno, ya está... (*con mucho alivio porque ya lo hizo*).

PADRE: Vos no te metés, pero cuando lo hacés metés un gol.

MADRE: Parece aislada... Pero no comparto lo que dijo.

PADRE: Lo compartas o no, se arriesgó.

ADA: Me toca a mí. Hagan silencio. Soy Luz, le digo a Nina: No te quiero porque sos una hinchada y siempre estás llamando la atención y haciendo que todos se ocupen de vos. A Ada: No te quiero porque pensás mucho en gustar a los chicos. (*Risas generales*).

PADRE: No sé si lo pensará Luz, pero que vos lo hacés es cierto...

MADRE: Callate y dejá jugar.

PADRE (*Muerto de risa*): Este juego ilumina.

ADA: Dejame seguir. Soy Luz a mamá: No te quiero porque estás siempre detrás de uno... A papá: No te quiero porque te ocupás mucho del trabajo.

MADRE: Bravo...

ADA: Ya terminé.

PADRE: Le cedo el lugar a la dama.

MADRE: No, yo al final.

HIJAS: Dale mamá.

MADRE: No. (*Gesto de negarse*)

PADRE: Bueno, pero luego sí... Soy mamá y le digo a papá: No te quiero porque te ocupás poco de mí y de tu propia persona, dejás el médico para el final, etc. Soy mamá y le digo a Luz: No te dediques tanto a los libros. Ya sabés que sos brillante...

NINA: Papá, no es así. Tenés que decir no te quiero por...

PADRE: Bueno sí; se parece. A Nina: No te quiero cuando

te veo que te hacés la loquita, *(visiblemente emocionado)*. A Ada: No te quiero... no sé. A ver... No te quiero cuando no te comportás como una mujercita.

LUZ: ¿Eso se lo decís como si fuera mamá? *(Risas)*

PADRE: Sí, como siendo mamá y como siendo papá. Bueno, ahora le toca a mami.

MADRE: No me da ganas.

LUZ: Eso no se puede hacer.

ADA: Animate.

NINA: Es tu turno.

MADRE: No quisiera. *(Mira al coordinador)*

COORD.: Todos deben haber sentido en algún momento eso mismo.

MADRE: Bueno, si no hay más remedio... Hablo como si fuera papi: Ada, no te quiero porque te interesa lo superficial. Luz, no te quiero porque solo te interesan los libros. Nina, no te quiero por hacerte la beba. Mamá, no te quiero porque vivís protestando.

PADRE: Finalmente lo hicimos. Estoy muy conmovido, no esperaba algo así. Es como haber visto muchas fotografías como ya lo hemos hecho con Frida. Fotos de verdad.

LUZ: Imágenes. Y en general no fueron muy desacertadas.

ADA: Te parecía que hablaba realmente el otro.

NINA: Por momentos sí, por momentos no.

COORD.: Siento la conmoción de Uds., de esta familia que pudo jugar y arriesgarse. Riesgo a lastimar, a lastimarse, a no ser querido, a no ser preferido. Pudieron salir del encierro de mirar y sentir de un solo modo. Y sin fuerte violencia, aunque dolió algunas veces, también había ironía, humor, alegría y sorpresa.

NINA: Lo que nos habías dicho hoy al principio y que nos costaba.

PADRE: Es notable lo brillante que podés ser aquí, Nina.

COORD.: El encierro de vuestras emociones, ese que ustedes describieron bien como enloquecedor si se enferman de la cabeza, o asmático si se enferman de los bronquios, o quizás

otros encierros el de los libros, el del trabajo, el de ser un bebé siendo grande, etc.

NINA: Durante mucho rato vos eras una de nosotros, yo esperaba que vos jugaras también, aunque sabía que no eras de la familia y no te tocaba. ¿Qué cosa no? que yo esperaba eso...

PADRE: Frida es ya para siempre un poco de nuestra familia.

LUZ: Me imagino que eso les pasará a otras familias, como con los médicos de chicos, como nuestro doctor "x", que es como de la casa.

MADRE: Es mucho lo que nos pasó hoy.

ADA: Ya casi es hora de irse.

LUZ: Yo no sé como decirlo, hoy me gustó mucho mi familia, pude acercarme a Nina.

NINA: Yo lo sentí cuando elegiste ser yo *(llora)*

PADRE: *(lagrimea)*: Estoy muy emocionado, acá me suele ocurrir.

ADA: No solo acá.

PADRE: La emoción de acá me viene como un alivio desde el pecho, me emociona que las dos nenas se acerquen, y verla a Nina así, porque aunque luego no le dure, si la veo así es que puede ser así.

ADA: Me están haciendo poner triste, no quiero, todo andaba bien.

COORD.: Algunos de ustedes pueden hoy sentir cerca la rabia y el cariño hacia la misma persona —como el papá, o como Luz o Nina—. Otras veces como Ada hoy, no lo soportan porque eso pone triste.

Hoy Ada prefería hacer sin sentir. La mamá, ni hacer, ni sentir. Otras veces Luz por ejemplo ha preferido pensar sin sentir y otras Nina, sentir hasta enloquecer.

Todos esos encierros... los dejan solos...

Silencio profundo, calmo y prolongado, va perdiendo densidad al ir incorporando acción.

Luz levanta la mirada, luego el padre, se miran. Ada está

mirando sus piernas. Nina tiene su mirada hacia adentro. La madre parece en un sopor. El padre mira el reloj. Me miran.

COORD.: Los encierros, decía, nos dejan solos como huérfanos. El silencio de recién era de una soledad distinta. De algún modo estábamos todos aquí unidos, así como ustedes manifestaron que me llevan a casa, o como hoy al principio Nina dijo "en esta casa", como que aquí estábamos de algún modo en casa.

NINA: Esa casa rara era de la que yo hablé, no sé si la siento cuando vos no estás, voy a ver. Pero si vos estás es seguro, es como un juego. ¿Será que yo como soy la más chica soy la que más juega y le veo el parecido?

COORD.: En ese "gran juego", aquí conmigo, podemos volver a inventarnos.

PADRE: Como hoy.

LUZ: Pero se veía también la realidad.

ADA: A mi me gusta cuando ese juego se parece a un teatro; cuando empiezan con la tristeza, ya no.

MADRE: Me parece que es como en un espejo donde uno mira y se ve diferente. A mi por eso me asusta.

NINA: Espejito, espejito, ¿quién es más bella que yo? Era así, ¿no mami? (*ironiza*).

Risas.

PADRE: Discupe Frida, pero es la hora ¿no? . Yo tengo que volver al trabajo.

COORD.: Sí, ya es la hora. Dejamos aquí por hoy. Volvemos a reunirnos todos así una vez más según lo convenido.

El análisis de este material clínico bien puede realizarse desde diferentes perspectivas. Es muy valioso a los efectos de ilustrar diversas situaciones. En cuanto a esta tarea concierne, pienso, centrar la mirada en la zona frontera, diferenciando la predominante familiar de aquella establecida con el terapeuta, por la que "transitaba la cura".

Intentaría incluir algunos conceptos de Ronald Laing en su trabajo "Familia y Estructuración Individual", que a mí me

han sido de excelente utilidad y que en el momento de hacer la entrevista, tuve especialmente en cuenta (la entrevista fue realizada hace cerca de cinco años). (El artículo de Laing, consta en un libro titulado: "The Predicament of the Family", editado por Peter Lomas del año 1967, por la International Universities Press. Gran Bretaña).

Considera Laing en su artículo del año 1967, que la familia es un sistema de relaciones único, donde cada persona es a su vez un sintetizador de las interacciones de los otros y desde este lugar de tercero, amén del que tiene en la díada, relaciona distinto las perspectivas de los demás. Así se superponen múltiples síntesis en un sistema abigarrado de conexiones y por lo tanto de imágenes, diría yo. De este modo la familia existe en cualquier lugar donde esté uno de sus miembros, como estructura complejísima de relaciones y de imágenes en acción o potencialmente en acción. Y se internaliza como un sistema espacio-temporal, no asimilable a la introyección de objetos en los que el psicoanálisis se detiene especialmente. Y en lo que concierne a la familia se internaliza una matriz múltiple de relaciones o sea una *estructura grupal* de relaciones, constituyéndose en la primera estructura grupal de relaciones internalizadas. Y esto lo lleva a Laing a incluir el concepto de defensas transpersonales que toma cuenta de la necesidad de intentar regular el mundo interno del otro para preservar el propio, que revelaría un actuar —a partir de cierto momento evolutivo— como teniendo una referencia interna de un sistema múltiple y no sólo el de una díada o de un triángulo. La familia sería entonces una estructuración del individuo desde donde el comportamiento de una parte comprometería todo el sistema.

Considerando estos pocos conceptos que precisamente tuvimos muy en cuenta en la coordinación de la entrevista familiar transcripta, veamos cómo esto nos da lugar a algunas de las reflexiones siguientes.

Ante la propuesta del juego, realizada por el coordinador y reformulada por Nina, se precipita un largo desarrollo donde podemos claramente atestiguar lo que citamos a través de Laing.

La misma reformulación de Nina nos mostraba que es posible hablarle al otro a través de un tercero como también lo puntualiza Luz más adelante, es un tercero que está dentro de uno mismo. Serían múltiples perspectivas desde puntos de síntesis de relaciones.

Curiosamente al empezar el juego, parece factible ir diferenciando quién mira a quién, quién habla a quién, quién odia a quién. Pero luego, ante el crescendo sinfónico de las múltiples síntesis triádicas y diádicas, ya no es más posible diferenciar esas instancias y tampoco interesa, pues estamos como ante la presencia de otra unidad de medida que supera el uno-dos-tres. Sí, quizás sean esas mismas pero desde un salto cualitativo. Pues es un territorio donde no es recuperable lo individual sino que se instaura un campo potencial de creación de lo individual —entendiéndose que la creación es siempre re-creación.

Como dice Nina sobre el final "es como un juego". El territorio ilusorio del que habla Winnicott, propio del juego del niño y el que en los adultos se da en lo artístico o religioso, como dice este autor.

Mientras ellos desarrollan el juego, en el que trato de no intervenir se produce el territorio frontera de la familia, que yo ayudo a instalar. El territorio de lo ilusorio, el propio de ese sistema que se despliega en progresión geométrica cual mundo *especular* múltiple.

Diferente en cierto sentido de aquel organizado, no ya desde mí como mediadora, sino conmigo como parte del territorio frontera, en esa tierra de nadie y de todos que se ha de mantener como una unidad así, tal cual.

Cuyo *nombre* es el de sistema de relaciones (la familia, en este caso), no el de un individuo. Y en el que quedo definitivamente incluida, por esa zona de resonancia propia de todo vínculo terapéutico y que en este caso es la zona compartida, construida entre todos que queda como matriz incorporada al sistema estructurante de la familia. La inclusión del terapeuta allí, recién efectiviza la instancia terapéutica, como muy claramente lo señala Nina, quien mirando esto

mismo desde otra perspectiva interpretativa, desarrollaba una relación diádica transferencial intensa con la terapeuta.

No es esa línea interpretativa individual dentro de lo grupal la elegida. Si bien en determinados momentos las interpretaciones están manifiestamente destinadas a afinar la diferenciación individual, no es desde ahí que se parte, sino de establecer y legalizar ese territorio frontera por considerar la unidad familiar como un sistema de relaciones abigarradas como tejido vivo, intentando ligar aquél que quedó parcialmente desligado y en estado de encierro repetitivo.

Pienso, y nuevamente ahora en contacto con la evocación de la sesión, que los conceptos de transferencia y contratransferencia no me alcanzan. Transferencia ¿de quién a quién? En ese especial laberinto de espejos, más que el cotejo con lo real de cada uno, era necesario una confianza básica en recorrerlo contando con el hilo de Ariadna que se encuentra a mano del terapeuta para que luego, a la luz, nos miremos y nos reconozcamos. Aquí hago alusión al comentario de la madre acerca de mirarse a un espejo distinto. Nina, con la especial lucidez de su patología, también era quien rápidamente entraba en ese mundo de lo ilusorio, apenas pudiéndose conceder un pequeño descanso que ya introducía a la madre en el mito de la madrastra de Blanca Nieves. Es decir, recreaba constantemente lo ilusorio.

Una vez más el concepto de defensas transpersonales nos esclarece acerca de la premura con que Nina necesitaba influir en el mundo interno del otro, enloqueciéndolo para regular el suyo propio, desde esa zona, donde todo es de todos. El terapeuta, incluido en ese territorio como cuerpo mediador garantizado, lo es también de pasaje y de diferenciación

Resumen

La tarea asistencial con familias, más que un método terapéutico, aportó un nuevo enfoque a la clínica, haciendo una propuesta distinta a la

ya conocida, de considerar el mundo interno o el mundo externo. Posiciones enfrentadas aún hoy (1983) pero que no resuelven, lo que con suma lucidez Winnicott describió como territorio transicional.

Este lugar, este espacio de categorización, nos parece ser el que mejor describe el lugar donde transcurre la cura, dado que por su virtualidad (ni es mundo interno, ni es mundo externo) se convierte en el lugar de pasaje para el logro de nuevas estructuraciones.

En trabajos posteriores a este artículo he logrado vincular esto con el procesamiento de la matriz narcisista primigenia constitutiva y constituyente del ser humano y que tendría una dimensión grupal y otra individual, posibilitando la formulación de un narcisismo familiar.

Summary

The task of assisting families, more than a therapeutic method, has contributed to clinical practice by introducing a different viewpoint from the one previously held, ie. consideration of the internal world or of the external world. Polarized positions even today (1983) which fail to resolve the question of the transitional territory, which Winnicott described so very lucidly.

This place, this space of categorization, seems to us to best describe the place in which the cure takes place, since because of its virtuality (it is neither internal world nor external world) it becomes the passage place to the obtention of new structurations.

In papers written since the present article, I have been able to link this concept to the processing of the primigenial narcissistic matrix, constitutive and constituent of the human being, having a group as well as an individual dimension which permits the formulation of a family narcissism.

Bibliografía

FREUD S.: "Introducción al Narcisismo". *Obras Completas*: Vol. XIV; Ed. Amorrortu. "La teoría de la libido y el narcisismo", (Conferencias Nº 26), Vol. XVI. Ed. Amorrortu.

PONTALIS J. B.: "La ilusión mantenida"; "El inasequible entre dos"; "Entre el saber y el fantasma"; "El nacimiento y reconocimiento del sí". *Entre el sueño y el dolor*. Ed. Sudamericana.

WINNICOTT: "Objetos transicionales y fenómenos transicionales"; "El juego"; "La creatividad y sus orígenes"; "Papel de espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño". *Realidad y Juego*. Ed. Gedisa.

WINNICOTT: "La capacidad de estar solo", *International Journal of Psychoanalysis*. Vol. XXXIX, 1958.

WINNICOTT, GREEN, MANNONI, PONTALIS y OTROS: *Winnicott*, Ed. Trieb. Colección Lo Inconsciente.

LAING R.: "Family and Individual Structure". Edited by Peter Lomas, en *The Predicament of the Family*.

LACAN: El estadio del espejo como formador de la función del yo". *Escritos I*, pág. 11. Siglo XXI.



CENTRO PRIVADO
DE TERAPIAS BREVES

"ALGUNOS MODELOS DEL ENFOQUE INTERACCIONAL"

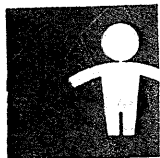
A cargo de:

- Lic. Celia Elzufan
- Dr. Pedro Herscovici
- Lic. Hugo Hirsch
- Lic. Estrella Joselevich
- Dra. Cristina Mazieres
- Dr. Hugo Rosarios

A partir del 10 de Agosto de 18.30 a 21 horas

INFORMES:

Av. del Libertador 5881, 1er. piso, "A"
785-1111 - 782-9851 - 783-3352 de 11 a 18 horas



centro médico psicológico buenos aires

Director: Dr. Octavio Fernández Mouján. **Secretaria de Prevención:**
Lic. Alicia Beramendi. Secretaria de Docencia: Dra. Ana Goldberg.
Secretario de Asistencia: Dr. Sergio Bruzzo Iraola. **Gerente Técnico:**
Dr. Julio Bello.

PREVENCIÓN: Psicoprofilaxis, talleres de reflexión, grupos de mujeres, orientación vocacional, etc. **DOCENCIA:** Escuela de Formación de Post-Grado en Salud Mental (formación teórica y práctica), seminarios, cursos, etc. **Práctica clínica** desde el 1er. nivel a través del Plan de Extensión Asistencial. **ASISTENCIA:** Niños, adolescentes, adultos, ancianos. Terapias individuales y grupales. Familia y parejas, geriatría, urgencias, Hospital de 1/2 Día (comunidad terapéutica diurna). **PROGRAMAS DE SALUD MENTAL:** (PSIMEFA S.A.) Para empresas, seguros médicos, sistemas de prepagos.

ORO 2242 - 1425 Buenos Aires - Tel. 773-8289 / 772- 8851

CEFYP

CENTRO DE FAMILIAS Y PAREJAS

DIRECTOR GENERAL: Dr. ADOLFO LOKETEK

DIRECTORAS:

Lic. MARIA ROSA GLASSERMAN Lic. ESTRELLA JOSELEVICH

Agosto a Noviembre

CURSO BREVE DE TERAPIA FAMILIAR

DOCENTES: Dr. Adolfo Loketek

Lic. María Rosa Glasserman - Lic. Lía Bikel

DIRIGIDO A: Profesionales en Salud Mental

Noviembre 21 a 23

SEMINARIO INTENSIVO DE TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

DOCENTES: Dr. Adolfo Loketek (Coordinador Responsable)

Lic. María Rosa Glasserman - Lic. Estrella Joselevich

DIRIGIDO A: Profesionales de Argentina y América
con experiencia en Salud Mental

INFORMES: SERRANO 1141 CAPITAL - TEL. 771-6078



Institución Psicoterapéutica

- Residencia terapéutica intermedia
- Clínica psiquiátrica
- Comunidad del tiempo (Hospital de Día)
- Talleres terapéuticos
- Centro institucional

Directores:

Dr. Felipe Díaz Usandivaras

Dra. Mirta Irene Méndez Puig

Soler 5961 - 1425 Capital Federal - Tel.: 771-8114/8108

Más allá de la homeostasis: hacia un concepto de coherencia *

PAUL F. DELL, PH. D.

Este trabajo fue realizado cuando el autor era docente del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas y del Instituto Familiar de Galveston. Actualmente el autor es el Director de Estudios Clínicos y Teóricos, Colonial Institute, 17579 Warwick Boulevard, Newport News, Virginia 23603.

Artículo original de Family Process n° 1/82. Publicado con permiso del Editor Responsable.

Agradecemos al Centro de Familias y Parejas (CEFYP), por su colaboración en la traducción de este artículo.

El concepto de homeostasis ha sido uno de los principales ladrillos, si no la piedra fundamental, de la construcción de la teoría familiar y de la terapia familiar. Designado para dar cuenta de la estabilidad percibida en los sistemas (y de los síntomas), el de homeostasis es un concepto epistemológicamente defectuoso que ha sido utilizado repetidamente al servicio de interpretaciones sistémicas animistas, dualistas y vitalistas. Por consiguiente, la homeostasis ha llevado a formulaciones clínicas caprichosas y a una gran cantidad de teorizaciones rebuscadas. Este trabajo sostiene que la noción de homeostasis es fundamentalmente inconsistente con una epistemología sistémica y debe ser reemplazada por el concepto más compatible de coherencia. Mientras que la homeostasis es

* Este artículo es el producto de cinco años de lucha con el concepto de homeostasis. La forma en que ahora se publica es el resultado de infinitas discusiones con mis colegas y participantes de seminarios. Más que nada, sin embargo, este artículo es el resultado de rumiar, con la consiguiente acidez de estómago e indigestión (puesto que mi epistemología no fue fácilmente transformada), sobre los trabajos de Gregory Bateson y Humberto Maturana. Debo especialmente a Humberto mucho de mi inspiración.

un concepto heurístico que no forma parte de una teoría más abarcadora, el concepto de coherencia es inseparable de la epistemología en la que está enraizado.

Family Process, Vol. 21:21-41, 1982

Parecería que hubiera un verdadero Gobernador, pero no encontramos huellas de su existencia.

Chuang T'zu

Homeostasis y Terapia Familiar: una breve historia

Desde por lo menos la época del trabajo de Fromm-Reichmann sobre la madre esquizofrenógena^{2,5}, ha habido una creciente conciencia en el campo de la psicoterapia acerca del contexto interpersonal de los síntomas. Ampliamente, se ha interpretado que este concepto tiene dos aspectos: encaje y causalidad. La de "encaje" es la más general de las dos nociones. Sin hacer referencia a la etiología o causalidad, la noción de encaje simplemente postula que las conductas que tienen lugar en el sistema familiar tienen una complementariedad general; encajan juntas. La "causalidad", por otro lado, es una interpretación particular del encaje que considera que la complementariedad observada tiene la forma: A causa B*. Por ejemplo, los padres malos enferman a sus hijos. Esta es la tesis

* Para la mayoría de los terapeutas familiares, la distinción entre encaje y causalidad parecerá idéntica a la distinción entre causalidad lineal y causalidad circular. Ambas dicotomías parecen idénticas, sin embargo son profundamente diferentes. Mientras que la dicotomía entre encaje y causalidad distingue al encaje de la causalidad, la dicotomía de la causalidad lineal y la circular distingue solamente entre tipos de causalidad. El problema de la segunda dicotomía es que el concepto de causalidad es un error epistemológico. Todas las explicaciones causales de fenómenos son fundamentalmente defectuosas y erróneas. Como las limitaciones de la noción de causalidad son más evidentes en las situaciones circulares que en las lineales, los teóricos han pensado que la distinción crucial está entre la causalidad lineal y la causalidad circular. No es así. La distinción crucial está entre la explicación causal de los fenómenos y lo que Maturana⁴⁰ llama explicación "estructuralmente determinada" de los fenómenos.

de Fromm-Reichmann sobre la etiología de la esquizofrenia^{2,5}. Como aclararemos luego, el fracaso de los teóricos clínicos en hacer la distinción entre encaje y causalidad ha sido el mayor responsable de la confusión respecto de la homeostasis familiar. Específicamente, ha habido una tendencia recurrente a considerar que encaje (i.e., complementariedad) implica causalidad (i.e., interacciones de causalidad circular, mutua o hasta lineal).

El campo de la terapia familiar obtuvo su ímpetu inicial del estudio del contexto interpersonal de la esquizofrenia: Bateson et al.^{1,3}, Bowen¹⁶, Lidz et al.^{3,7}, Wynne y Singer^{5,4-5,5-6,4}. Todos estos investigadores examinaron los modos en que el esquizofrénico encaja con su familia y viceversa^{2,1}. Singer y Wynne^{5,5} explícitamente utilizaron el concepto de encaje al realizar el apareamiento a ciegas de los protocolos de tests proyectivos de los miembros de familias, entre sí. El grupo de Bateson llegó a la teoría del doble vínculo preguntándose específicamente qué tipo de contexto interpersonal podría dar cuenta (i.e. encajaría con) de la conducta esquizofrénica. Su conclusión, por supuesto, fue que la conducta esquizofrénica encajaba con el contexto doble-vincular. El trabajo de Lidz y el de Bowen explícitamente tiende a enfatizar la noción de causalidad a expensas de una noción más general de encaje. Estos investigadores parecen entender la psicopatología de los hijos como causada por sus padres neuróticos. Bateson et al.^{1,4-3,3} y Singer y Wynne^{5,4} rechazan la causalidad en favor del encaje en las familias esquizofrénicas. Sin embargo entienden el encaje en términos de causalidad; esto es, causalidad circular.

Jackson, un miembro del grupo de Bateson, introdujo la homeostasis en el campo de la psicoterapia en su trabajo "La cuestión de la Homeostasis Familiar"^{3,2}. El tema básico de este trabajo es el paciente en su contexto. Jackson sugirió que una variedad de categorías diagnósticas en la psicopatología encajan dentro de patrones interaccionales particulares. Jackson afirmaba que, como consecuencia de ese encaje, la mejoría del paciente podría llevar a otros miembros de la familia al conflicto, disturbios psiquiátricos y hasta al suicidio. "Serías

consecuencias tienen lugar" en otro miembro de la familia que "ha estado 'comprando' salud de la enfermedad de la persona en tratamiento"³³, p. 8. El trabajo de Jackson es el primero en el campo de la psicoterapia en hacer referencia a *mecanismos homeostáticos*. Una lectura cuidadosa del comentario de Jackson sobre "comprar" salud mental de la "enfermedad..." revela la sugerencia de que la persona que ha "comprado", es de algún modo la causante de la enfermedad del paciente. Esta atribución implícita es isomórfica con aquella realizada el año anterior en "Hacia una Teoría de la Esquizofrenia"¹³*, en la cual Bateson, Jackson, Haley y Weakland afirmaban que las madres sometían a sus hijos al doble vínculo, causándoles síntomas esquizofrénicos. Poco tiempo después, Bateson et al. se retractaban de aquella posición de causalidad lineal, en favor de la causalidad mutua¹⁴⁻³³, pero la homeostasis siguió enfatizando la causalidad lineal invocada por la teoría del doble vínculo.

En los años subsiguientes el grupo de Bateson y el MRI expandieron rápidamente su utilización de la cibernética y de la teoría de la comunicación como modelos heurísticos para la interacción familiar. En 1959 Bateson, Jackson, Haley y Weakland describían a la familia como un sistema homeostático, activado por sus errores y con capacidad de auto-corrección²⁷. Jackson y Weakland³⁵ hablaban de mecanismos homeostáticos cuya función era restituir el sistema familiar a su status quo. El feedback negativo se utilizó como concepto acompañante y muchas veces como sinónimo de homeostasis. Se decía que el feedback negativo y la homeostasis mantenían al paciente enfermo. En 1962 Haley²⁸ adelantaba su Primera Ley Relacional: "Cuando un organismo indica un cambio en relación a

* Aunque "La cuestión de la Homeostasis Familiar" fue publicada en 1957 y "Hacia una Teoría de la Esquizofrenia" en 1956, Jackson escribió el primer artículo antes de unirse al grupo de investigación de Bateson. En realidad Bateson invitó a Jackson a unirse al grupo a causa de las ideas contenidas en su trabajo (agradezco a Carlos Sluzki esta información histórica).

otro, éste actuará sobre el primero como para disminuir y modificar ese cambio" (p. 277).

Durante este período, los teóricos mencionados se esforzaron infructuosamente para realizar el viraje epistemológico necesario para poder pensar "sistémicamente". Bateson⁹, por ejemplo, afirma su imposibilidad de realizar el viraje completo hasta fines de 1969. El problema es que la teoría de los sistemas involucra la idea de encaje no causal más que una causalidad lineal o mutua. Por consiguiente, *las descripciones causales de la homeostasis como aquello que mantiene el status quo o ayuda a mantener la enfermedad del paciente, son epistemológicamente incorrectas*.

En 1959 Bateson⁴ se esforzó por escapar de este problema, declarando que las familias esquizofrénicas eran

no simplemente homeostáticas alrededor del status de inválido del paciente identificado en particular. Parecería... que las variables que deben ser mantenidas constantes a cualquier costo son de alguna manera más abstractas o de naturaleza más secreta. No es que el paciente identificado deba ser mantenido en confusión a toda costa; parece más bien que el paciente mismo es un accesorio —hasta un sacrificio voluntario— para mantener la homeostasis familiar. Si el paciente deja de desempeñar este papel es probable que algún otro miembro de la familia lo asuma en su lugar. Como muchos sistemas homeostáticos complejos, la familia patogénica parece ser capaz, como el tritón, de regenerar una extremidad faltante. (pp. 128-129)

Aquí Bateson se acerca a entender la homeostasis como *la naturaleza de la organización* del sistema, cosa que se opone a la homeostasis como un *aspecto o parte* de la organización del sistema. Esta diferencia es crucial. En un sistema, por definición, los componentes están interconectados. De acuerdo a esto, un pensamiento sistémico claro prohíbe hablar de un aspecto del sistema como separado y actuando causalmente sobre otras partes del sistema. Asegurar que la homeostasis o feedback negativo regula ese sistema es caer en el error de pensar dualística y causalmente²³; error que ha sido virtual-

mente la plaga de toda discusión pasada y contemporánea sobre la homeostasis familiar.

En un trabajo titulado “¿Es suficiente la Homeostasis?”, Speer⁵⁶ hace serias objeciones a la penetración del pensamiento homeostático en el campo de la terapia familiar. Convincentemente señala que las familias ciertamente cambian y ese cambio obviamente no puede ser explicado por la homeostasis. Por otra parte hace notar la suprema ironía de fundamentar un acercamiento al cambio terapéutico en una teoría de cómo los sistemas no cambian. El llamado de Speer para que los terapeutas familiares reconsideren su homenaje al concepto de homeostasis ha sido esencialmente desatendido.

La interpretación de la homeostasis en términos de causalidad tiene una segunda falencia (además del dualismo) que consiste en el problema del *propósito*. Esto es, que si se le dice a un clínico que una familia tiene un mecanismo homeostático, éste no descansará hasta “descubrir” el “propósito” del mecanismo. Si el clínico es sofisticado, buscará su *función*, pero el error dualístico original aún condena al clínico a la confusión. Nuevamente, fue Jackson el que precipitó la confusión inicial con respecto al propósito.

Jackson observó patrones de conducta recurrentes en las familias (descriptos en otros lugares en términos de homeostasis y feedback negativo) y sugirió que los ciclos correctivos recurrentes podían ser comprendidos postulando que la familia tenía *reglas*. Al principio, Jackson sostuvo que estas reglas proporcionaban la razón o propósito de patrón observado de interacciones³³. Tales reglas fueron consideradas como los mecanismos homeostáticos impuestos en el sistema, que *prescribían*²⁷ o regulaban lo que podría ocurrir (ej., nadie en esta familia se enoja; mamá nunca se equivoca, etc.). Luego Jackson lo pensó mejor y dijo que estas “reglas” eran descripciones “como si” del observador²⁷⁻³⁴. Esto es, para poder conceptualizar, es útil describir el sistema funcionando “como si”^{34p. 592} existiera tal regla.

La posición “como si” de Jackson contenía pensamientos claros e incisivos que hubieran recorrido un largo camino

conducente a la eventual aclaración de las confusas ideas acerca de la homeostasis. Desafortunadamente, Jackson no pudo desarrollar esa línea de pensamiento antes de su muerte, en 1968. Como los pensadores de este campo luego ignoraron la aclaración “como si” de reglas efectuada por Jackson, el concepto de homeostasis se contaminó más aún. La noción de reglas ha sido aparentemente demasiado compulsiva como para que los terapeutas familiares la abandonaran. El resultado es que en la conceptualización clínica actual se sigue pensando que las familias poseen reglas y se habla repetidamente de que los miembros de la familia se comportan de cierto modo para variados propósitos sistémicos. Por ejemplo, “el chico se ha vuelto sintomático para salvar el matrimonio de sus padres”; “el hijo está actuando para volver a implicar a su padre”; “la hija se está sacrificando para proteger la homeostasis familiar”.

Hoffman³⁰ ha discutido el “ciclo homeostático”, en el cual “la secuencia, no sólo el mal comportamiento cumplía algún tipo de función homeostática o de resistencia al cambio” (p. 502). Esta autora agrega que “las conductas sintomáticas tienen lugar en una matriz de otras conductas, que están vinculadas y sostenidas por las primeras y que la totalidad constituye algún tipo de programa formal que tiene que ver con la supervivencia de una unidad mayor, habitualmente la familia” (p. 503). Esta línea de pensamiento sigue siendo desarrollada por Selvini-Palazzoli y sus colegas⁵²⁻⁵³.

La comparación hecha por Hoffman²⁹ del concepto de “enredo” de Minuchin⁴⁵ con el concepto de Ashby³ de “sistema demasiado entrecruzado” es la única excepción significativa dentro de la literatura acerca de terapia familiar del hábito de interpretar la homeostasis de modo dualístico y causal. Hoffman señaló que tanto el Homeóstato de Ashby como la familia enredada de Minuchin tienen una alta reactividad que se origina en el hecho de que sus componentes están demasiado entrecruzados. En un sistema densamente entrecruzado, la conducta de cualquiera de los miembros inmediatamente afecta a todas las demás, cuya conducta a su vez afecta a todas las otras y así sucesivamente. Tales sistemas raramente

llegan a resolver algo, porque son demasiado reactivos. Hoffman concluyó que estos sistemas sufren de "demasiada homeostasis" (p. 459). Esta visión es un adelanto sobre las otras visiones de la homeostasis en la literatura sobre terapia familiar, puesto que implica que la homeostasis es una característica del sistema como un todo y evita hablar de ciclos y mecanismos homeostáticos. Lamentablemente parecen haber pasado desapercibidas las ramificaciones de esta interpretación.

El problema de la Homeostasis

La sección precedente ha proporcionado al lector una visión conceptual retrospectiva de la homeostasis en el campo de la terapia familiar. La segunda parte de este trabajo explorará en detalle los problemas con la homeostasis mencionados anteriormente.

Errores en los Tipos Lógicos

Casi desde su comienzo, el concepto de homeostasis ha estado plagado de errores en los tipos lógicos. Quiere decir que es posible discutir un sistema en términos de su coherencia como un todo o en términos de sus componentes, pero mezclar ambos niveles de análisis es pensar confusamente. El "milieu interieur" de Bernard¹⁵ describía la coherencia de la fisiología humana. El concepto de homeostasis de Cannon¹⁸ por otro lado, estaba dirigido a cómo el organismo *mantenía* la presión sanguínea y otras variables dentro de ciertos límites críticos. Este modo de ver los fenómenos implica causalidad (i.e. A causa B: el organismo mantiene la presión sanguínea) y amenaza dualísticamente con mezclar dos niveles de análisis: el comportamiento de componentes específicos (presión sanguínea) y el funcionamiento coherente del sistema como un todo.

Los intentos subsiguientes de emplear el concepto de homeostasis llevaron a mucha confusión e insatisfacción con el concepto en fisiología, biología y psicología²⁹⁻⁴⁴⁻⁵⁸. Eventualmente, se rastreó una gran parte del problema a dos definiciones contrastantes de homeostasis: a veces se la consideraba un

fin (del de constancia, frente al cambio) y otras veces un *medio* para ese fin¹⁹⁻⁵⁸. La homeostasis como medio (i.e. el mecanismo homeostático) es un dualismo causal. Peor aún, es vitalista. Cualquier descripción de un sistema como resistente a los cambios propuestos por inputs del medio debe explicar cómo y por qué ocurre esta resistencia. Contestar que el sistema se mantiene estable "porque es homeostático" es un razonamiento circular. Contestar que estos sistemas son estables porque tienen una "fuerza homeostática" o "principio homeostático" es una forma de vitalismo. Este tipo de razonamiento equivale a explicar los fenómenos de la vida sobre la base del "élan vital". La descripción de la homeostasis como un fin no es mejor que describirla como medio, porque el fin sigue siendo dualísticamente opuesto al cambio del medio ambiente (que el sistema de algún modo resiste).

Dualismo y concreción mal ubicada

La homeostasis es una metáfora o modelo para describir el funcionamiento de un sistema. La homeostasis no es algo concreto, sino más bien un concepto sobre un modo de comportamiento. Es una descripción, una ficción explicativa. Siendo una metáfora conceptual, hablar de mecanismos homeostáticos es un dualismo. Hablar de la conducta del miembro de una familia como parte del ciclo homeostático o parte del mecanismo homeostático es cometer la falacia que Whitehead llamó concreción mal ubicada⁶². Hacer esto es tratar la descripción de un metanivel como verdadera. En otras palabras, respecto de cualquier familia dada, la homeostasis no es algo que *está* realmente. Más bien es un modo de hablar acerca del funcionamiento del sistema. Por las mismas razones, el "regulador" de una máquina a vapor no es algo que esté; la autorregulación es una manera de describir cómo funciona la máquina a vapor.

El concepto de homeostasis es un intento de aclarar la estabilidad percibida en un sistema. A su vez, esa estabilidad percibida es descripta como el resultado de un proceso de

auto-regulación. El problema de esto es que *la auto-regulación misma es una noción epistemológicamente defectuosa*. Si el sí mismo (o parte del sí mismo) regula al sí mismo, entonces ¿qué es lo que regula el aspecto del sí mismo que está efectuando la regulación? Esta, por supuesto, es la primera de una serie infinita de preguntas que finalmente no dejan a la regulación ningún terreno en el cual sostenerse. No hay manera de escapar a la naturaleza infinitamente auto-referente de la "auto-regulación". La búsqueda de la auto-regulación es muy parecida al intento de superar la segunda ley de la termodinámica inventando una máquina de movimiento perpetuo. Es un intento de anular lo imposible. Los mecanismos homeostáticos y las reglas familiares deben ser vistos como el equivalente de la terapia familiar al Demonio de Maxwell*.

El próximo punto es más sutil porque no se puede escapar al dualismo de la homeostasis simplemente aceptando los argumentos anteriores. Esto es, hasta concediendo que la noción de "mecanismo homeostático" implica un pensamiento dualista, el problema con el concepto de homeostasis sigue subsistiendo. Uno todavía está habituado a decir que la cons-

* El Demonio de Maxwell es un ser mítico con la habilidad de violar la segunda ley de la termodinámica⁴³. La temperatura de un volumen de gas es el medio de las velocidades de moléculas de gas individuales. Cuanto mayor la velocidad de las moléculas, mayor será la temperatura. Inversamente, a menor velocidad de moléculas, menor temperatura. El Demonio de Maxwell puede, sin gasto de trabajo, elevar la temperatura del gas de un compartimiento y disminuir la temperatura del gas de un compartimiento adyacente. Puede llevar a cabo esta acción imposible abriendo y cerrando un pequeño agujero entre ambos compartimientos para dejar pasar *solamente* las moléculas de alta velocidad del compartimiento A al B y *solamente* las de baja velocidad del B al A. Así, el Demonio de Maxwell da a entender que es capaz de realizar un trabajo sin trabajar. Es decir, algo por nada. Los mecanismos homeostáticos, la auto-regulación y la noción prescriptiva de las reglas familiares son equivalentes al Demonio de Maxwell; supuestamente realizan un trabajo (i.e., regulación) sin ningún trabajo (regulación) de regular, el regulador. Quis custodiet ipsos custodiet? (Algo como "¿Quién regulara el regulador?").

tancia homeostática del sistema (p.ej. patrones redundantes, conducta sintomática, etc.) *existe*, sin importar si es el resultado del todo sistémico o el producto de un mecanismo homeostático mítico. El problema con esta posición es que la constancia misma es dualista con respecto a los demás procesos que actúan en el sistema. Atender a la constancia significa verla como apartada del resto del sistema.

Este último punto suele provocar malestar en la gente, que insiste en que la constancia *existe* a pesar de todos los devaneos teóricos. Objetivamente está *allí*. Pero el hecho es que la constancia o patrón redundante está "allí" precisamente en el mismo sentido en que el mecanismo homeostático está "allí". Tales regularidades del funcionamiento sistémico no son rasgos del sistema *operativo*, sino de nuestra descripción⁴¹. Existe una infinidad de aparentes "rasgos del sistema", y cada uno es definido por un modo de describir el sistema. Estas descripciones no son *del* sistema; son algo que nosotros le traemos.

Puntuación

Con ese último punto llegamos al problema de la *puntuación*⁶¹. Todos los terapeutas familiares conocen bien el ciclo regaña - se retrae - regaña y la inutilidad de discutir cómo puntuarlo - "El se retrae porque ella regaña" versus "Ella regaña porque él se retrae". El párrafo precedente introduce el dilema de la puntuación a un nivel más profundo - "¿Es el sistema este ciclo homeostático de acá y todo el resto del mismo de allá?" versus "Es el sistema este mecanismo homeostático de acá y aquella constancia de allá", versus "¿Es el sistema...?" En otras palabras, no podemos decir lo que el sistema "es". Podemos solamente elegir una puntuación particular y afrontar sus consecuencias.

Y con toda seguridad habrá consecuencias de la elección. La decisión del terapeuta con respecto a lo que "es" el sistema puede muy bien determinar el resultado de la terapia. Nuevamente, sin embargo, debemos recordar que si algún modo de puntuar el sistema "funciona" (i.e. facilita una intervención

exitosa), todo lo que podemos decir es que funciona, que fue útil. El hecho de que funcione no quiere decir que sea acertado o verdadero; sólo quiere decir que funciona. Por ejemplo, el "propósito" es una manera de puntuar un sistema. Si la puntuación funciona permite hacer predicciones o resulta en un éxito terapéutico. Sin embargo, el hecho de que la puntuación elegida fuera útil no es evidencia de que tal propósito existiera realmente. Esta es la falacia lógica de afirmar lo consecuente.

Propósito

El concepto de propósito es y ha sido muy problemático para dar cuenta del comportamiento humano, tanto para la psicología como para la filosofía. Todas las atribuciones de propósito son hechas por algún observador que *interpreta* la conducta en cuestión. Esto es así incluso cuando el observador/interpretador se describe a sí mismo. Ni siquiera el que se auto-observa puede estar seguro del por qué de sus conductas. A nivel del sistema, la cuestión del propósito resulta, obviamente mucho más oscura que a nivel del individuo. Dados sus problemas epistemológicos inherentes y el hecho de que siempre debe sufrir las limitaciones de la lógica inductiva, se debe considerar al "propósito" sistémico un mal negocio al que es mejor hacer a un lado. La creencia de que una familia tiene un propósito sólo puede llevar a un tipo de pensamiento rebuscado, que puede describirse como animismo sistémico.

Los intentos de retener el propósito dentro de una perspectiva sistémica y evitar simultáneamente un animismo sistémico, en general conducen directamente a dualismos causales (p.ej., "Ella se comporta así para rescatar a sus padres del conflicto y para proteger a la familia"). Es decir, un componente del sistema es descrito como siendo aquello que determina o regula el funcionamiento del sistema. Peor aún, ese tipo de explicaciones llevan a un pensamiento retorcido e inconsistente sobre altruismo y miembros de la familia que se "sacrifican" por ésta. Como ya fuera mencionado, Bateson⁴ en una ocasión describió al paciente como "sacrificio voluntario... a la ho-

meostasis familiar". Similarmente, Hoffman³⁰ ha experimentado con la aplicación de la hipótesis socio-biológica de E. O. Wilson de un gen de altruismo, para explicar el mismo fenómeno. Selvini Palazzoli y sus colegas⁵² hablan constantemente de miembros de la familia que se sacrifican*.

La dificultad con esta línea de razonamiento es que estos mismos teóricos creen simultáneamente que el sistema familiar es un todo organizado cuyo funcionamiento está mutuamente determinado por todas sus partes. Por lo tanto, si otros miembros de la familia toman parte en provocar la conducta del paciente, entonces el paciente no puede ser completamente altruista, puesto que su conducta está por lo menos parcialmente determinada por el sistema. En otras palabras, en cuanto se evita el dualismo asegurando que la conducta de un sistema emerge de procesos causales mutuos, las interpretaciones de ese funcionamiento basadas en el propósito resultan imposibles. Eso, en parte, es lo que quieren decir los teóricos sistémicos cuando insisten en que la mejor explicación de un sistema es el sistema mismo. En breve, no existe un *por qué*; sólo existe un *existe*.

Evolución

Como fuera mencionado por Speer⁵⁶, las familias y otros tipos de sistemas efectivamente cambian y evolucionan, un fenómeno que aparentemente la homeostasis no puede explicar. Específicamente, la homeostasis no puede explicar la evolución del funcionamiento del sistema si la homeostasis es considerada como el mantenimiento de una estabilidad *particular* dentro del sistema*. En otras palabras, si la homeostasis se considera como

* Selvini-Palazzoli (comunicación personal) dice que ella y sus colegas en realidad no creen que los miembros de una familia se sacrifiquen los unos por los otros. Más bien ellas consideran que hablar a las familias sobre el sacrificio constituye una intervención terapéutica efectiva.

* La preferencia, dentro de la terapia familiar, por ver la homeostasis en términos de una estabilidad particular, es enfatizada por la frecuencia con que se la compara a un termostato que mantiene una temperatura fija.

algo que mantiene el status quo —mantiene el sistema *así*— entonces cuando el sistema evoluciona a un modo diferente, la homeostasis no puede dar cuenta de ello. (Se hace notar que la creencia en tal “homeostasis específica” lleva casi inevitablemente a buscar la razón o propósito de la misma). Por otra parte, el cambio sistémico puede ser explicado fácilmente si se considera a la homeostasis como la tendencia a buscar un estado estable, *cualquier* estado estable (lo que se opone a un estado estable específico). Por lo tanto, cuando un sistema es perturbado, como todos los sistemas lo son, tiende a buscar un estado estable que *siempre* es levemente diferente del estado estable anterior. En resumen, la homeostasis evoluciona.

El Dualismo Engañoso del Feedback

Al igual que su concepto hermano, la homeostasis, el feedback negativo es utilizado típicamente de un modo dualista y no evolutivo*. El feedback es definido como la introducción del output de un sistema a parte de su comportamiento interno como para “corregir” (feedback negativo) o ampliar (feedback positivo) la conducta de la variable a la que se apunta. Este modo de ver el feedback, sin embargo, resulta confuso por dos razones. La primera es que aísla una variable (aquella a la que se apunta) del sistema, de las demás. Este es un dualismo que implica que el comportamiento de la variable a la que se apunta es independiente del comportamiento del resto ignorado del sistema. Esto simplemente no es así; si la variable a la que se apunta fuera independiente, ¿no sería parte del sistema! La segunda es que este tipo de pensamiento implica que lo que vuelve como feed-back afecta solamente a la variable apuntada y no al resto del sistema*. Nuevamente, esto no es así.

* Se advierte al lector que esta discusión sobre feedback es extraña y difícil de seguir. La culpa no es ni del lector ni de la poca claridad de la exposición, sino del mismo concepto de feedback. El feedback parece, al principio, muy real y objetivo. Un estudio más detallado, sin embargo, lo hace aparecer como una prestidigitación epistemológica. Si se toma demasiado seriamente lleva a pensar en un círculo de nunca acabar.

* Un pensador sistémico sofisticado diría, “No, yo no pienso así. Me

Típicamente, estos otros efectos son ignorados o considerados peyorativamente como *efectos colaterales*.

El término *Feedback* muestra su herencia epistemológica al considerar que retro-alimenta algo que solamente ha sufrido un cambio de posición. Dada esa consideración, también se considera que este cambio es reversible, como en el feedback negativo. Esta visión ignora la evolución recurrente de la mayoría de los sistemas. Hasta el viejo Heráclito —“Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río”— sabía que el cambio era irreversible. La esencia del problema del “feedback” es que el mismo afecta a *todo* el sistema, y no únicamente a la variable apuntada. De acuerdo a esto, *aquellos que es retroalimentado puede “provocar” que la variable apuntada permanezca constante y al mismo tiempo “provocar” que el sistema como un todo evolucione.*

El último punto, por supuesto, es un poco sorprendente y difícil de captar al principio, porque habitualmente atendemos a las similitudes y constancias (a las que conferimos el status de “cosa”) mientras que, concomitantemente, solemos ignorar las diferencias y cambios²⁰. Tendemos a focalizarnos en el “feedback” y la constancia de la variable apuntada ignorando al mismo tiempo los cambios en todas las demás partes del

doy cuenta de que el feedback negativo no sólo afecta a la variable apuntada, sino también al resto del sistema”. Sin embargo, esta visión más sofisticada aún deja sin tocar el problema del status ontológico del feedback (negativo). Puede decirse que, *todo feedback existe como tal sólo en virtud de una descripción distintiva hecha por un observador*. El “feedback” no es realmente operativo en el sistema. Lo que sí existe es un sistema coherente unitario fluctuando dentro de los dominios de su operatividad. El observador desde su (inevitable) punto de vista subjetivo, correlaciona la conducta de una parte del sistema con otra parte del sistema. A esta correlación la llama “feedback”. El hecho de que haya una alta correlación entre las conductas de estas dos partes del sistema no significa que el feedback esté causando o restringiendo algo. Simplemente significa que el observador está creando una correlación al elegir observar estas dos partes del sistema³⁹. En cuanto al sistema mismo, funciona como un patrón que es una totalidad coherente. Es, *como un todo*, su propia “restricción” o “causalidad”.

sistema. Siempre que se introduce una constancia en un aspecto del sistema, el resto del sistema cambiará para acomodar esta constancia. Por ejemplo, un alcohólico o un adicto a la heroína introduce ciertas constancias en su fisiología, manteniendo constante el nivel de la droga en su sistema. Como resultado, el resto de la fisiología del adicto se ajusta para acomodarse a esta constancia. Cuanto más tiempo se mantenga la constancia, más cambia el resto del sistema. En otras palabras, el "feedback" que "mantiene" constante la variable apuntada, es la "causa" de que el sistema como un todo evolucione. Así, a nivel del sistema, todo "feedback" es evolutivo*.

La Falacia de la Resistencia

La Homeostasis se funda en dos nociones: a) el concepto de un sistema coherentemente organizado y b) la idea de que ese sistema se mantiene (el status quo) resistiéndose al cambio. De estas dos nociones, la primera es acertada, la segunda no lo es. En realidad se trata de un error epistemológico. La idea de un mantenimiento homeostático es doblemente dualista porque si algo está siendo mantenido, entonces a) debe haber algo que haga el mantenimiento (del resto de sí mismo) y b) debe haber algo más que está siendo resistido.

El problema con la cuestión de cómo y por qué un sistema "resiste al cambio" radica en el presupuesto del que parte la misma pregunta; es decir que el sistema "resiste". El sistema *no* resiste; solamente se comporta de acuerdo a su propia coherencia organizada. *Aparenta* resistir por tres razones: a) nuestra mala lectura Lamarckiana de la relación entre el sistema y su entorno; b) nuestro fracaso en ver el sistema más amplio (sistema/entorno); y c) nuestra incapacidad de aceptar el hecho de que los sistemas son mecanicistas.

* La idea de que todo "feedback" es evolutivo a nivel del sistema es expresada más simplemente por Maturana⁴⁰; Un sistema no sufre interacciones triviales. Esto es, *toda* interacción por la que pasa un sistema, no importa cuán trivial, sigue siendo significativa. *Toda* interacción deja su marca en el sistema. Para parafrasear a Heráclito, no se puede interactuar dos veces con el mismo sistema.

La Homeostasis como Lamarckismo Moderno

El punto de partida para pensar sobre cualquier sistema viviente es que el sistema parece estar adaptado a su entorno. Esto es, que el sistema parece resistirse al entorno respondiendo con conductas que "echan afuera" exitosamente a cualquier input del entorno. En realidad, sin embargo, el sistema no está *re-sistiendo*; esta *ex-istiendo* (en la única forma que le permite su organización). El hecho de que el sistema continúe existiendo (sin cambiar esencialmente) no significa que esté "resistiendo" al cambio; simplemente quiere decir que el sistema encaja en su entorno. Esto es, hasta ahora en la historia del sistema los inputs del entorno (incluyendo la terapia anterior y actual) no han contenido nada disruptivo para la organización del sistema. Si el sistema *hubiera* experimentado inputs disruptivos, se hubiera desintegrado (o reorganizado en un sistema diferente).

En el caso del cuerpo humano, por ejemplo, debemos recordar que su coherencia organizada (como sistema viviente) es producto de la selección natural ante el contexto del entorno. Las especies no resisten al entorno; sobreviven a él o no. Las especies o miembros de las mismas, cuya organización es la más adecuada al entorno, sobreviven (y transmiten sus genes a las generaciones futuras). Creer otra cosa es Lamarckismo*. Curiosamente, la creencia de que los sistemas (familias, individuos, grupos, organismos biológicos, etc.) resisten homeostáticamente al entorno es una forma actual de Lamarckismo. Esto es, que la doctrina del Lamarckismo y el concepto de homeostasis sufren el mismo error fundamental. Ambos ignoran la organización existente en el sistema y consideran que el entorno puede, de algún modo hacer que el sistema sea otra cosa de aquello que es. Lamarck creía que el entorno *podía* ser la causa de que los individuos (y por lo tanto las especies) cambiaran. La homeostasis implica que el entorno *debería* ser

* Lamarckismo es la creencia pre-Darwiniana de que los cambios en el entorno son la causa de que los animales y plantas sufran cambios estructurales que pueden ser heredados por las sucesivas generaciones.

la causa de que un sistema cambiara. Esto quiere decir que la necesidad de que haya un concepto de homeostasis *sólo* tiene sentido en el contexto de una creencia implícita de que el entorno debe provocar (y habitualmente provoca) el cambio en los sistemas (y otros objetos). Por lo tanto, cuando el sistema *no* cambia, el fenómeno de permanecer igual debe ser explicado, vía el concepto de homeostasis.

Este es, en realidad, el error que subyace a casi todo el pensamiento occidental acerca de la causalidad. El entorno es incapaz de hacer que un sistema haga algo que no sea ya capaz de realizar. Cualquier sistema dado (individuo, familia, combinación de genes de una especie, etc.) solamente puede comportarse de acuerdo a su propia organización, no importa cuán nocivos o poderosos sean los estímulos que le llegan del entorno^{3 9-4 0-4 2}. El sistema ni resiste ni es controlado por estos estímulos; sigue *siendo* él mismo.

La No Visión del Sistema más Amplio

Esta cuestión de un sistema que parece resistir al cambio también puede ser vista desde una perspectiva más abarcadora. Sería que, la naturaleza de la "adaptación" del sistema a su entorno (el hecho de que encaja en su entorno y parece resistir el cambio) es tal que *el sistema se ha convertido en uno con su entorno*. Así los "inputs" del "entorno" dejan de ser inputs para pasar a ser algo *interno* del funcionamiento y organización del sistema/entorno. Esta es la segunda razón de que el sistema *parezca* resistir. Si un observador puntúa el sistema/entorno como separados uno del otro, entonces inevitablemente debe interpretar al "entorno" como proponiendo cambios que el sistema compensa, pareciendo ser homeostático. Si en cambio el observador viera al sistema entorno como uno, podría ver un sistema fluctuando a través del dominio de su coherencia; vería al sistema siendo él mismo. Similarmente y tal vez más radicalmente, si el observador considerara a un paciente de terapia en términos de la coherencia de ese paciente en particular, entonces el observador no vería a un paciente

resistiéndose al cambio sino siendo simplemente él mismo. Qué podría aclarar más el hecho de que la tarea de la terapia no es cambiar al paciente, sino ayudarlo a tornarse no-sintomático en las formas compatibles con su particular coherencia sistémica?

El Rechazo del Mecanicismo

La tercera razón por la que los sistemas *aparentan* resistir al cambio es nuestro persistente fracaso en apreciar que los sistemas son mecánicos. Cada sistema (persona, familia, institución, etc.) tiene su propia organización, su propia identidad coherente^{5 9-6 0} que especifica cómo el sistema se comportará en *todas y cada una* de las situaciones. El sistema no tiene elección; siempre funciona del modo en que está organizado para funcionar. *Nunca* funciona del modo en que no está organizado para funcionar. El sistema es lo que es.

Esa verdad es el fundamento del principio de realidad: Las cosas son lo que son, no lo que nosotros queremos o esperamos. Werner Erhard (est) tiene razón: "Lo que es, es; lo que no es, no es". Esta verdad epistemológica resulta profundamente difícil de aceptar, terapeutas incluidos. La triste realidad es que muy pocos de nosotros dominamos con éxito el principio de realidad y renunciamos completamente al principio del placer. En un mayor o menor grado, la mayoría de nosotros quiere que las cosas sean como nosotros las queremos y nos molestamos cuando nuestras expectativas no se cumplen. El concepto de diferenciación de Bowen^{1 7} demuestra el rol central que el principio de realidad juega en la salud mental. Aquello que marca a la persona indiferenciada es su incapacidad de tolerar o aceptar que otros sean diferentes de lo que ella piensa o espera que deberían ser.

Este error epistemológico (el rechazo a aceptar aquello que es) está relacionado de varios modos con la *aparente* resistencia al cambio de un sistema. En primer lugar, si esperamos que un paciente actúe de determinada manera y no podemos aceptar que lo haga de otra, entonces hemos cometido un error epistemológico y creado la "resistencia". Este error es mucho más común

que lo que los terapeutas quisieran admitir. El así llamado "paciente resistente" habitualmente es definido por su odiosa mala voluntad para cooperar con el tratamiento. Ese paciente, sin embargo, no es resistente; el paciente simplemente está siendo quien es. Erickson²⁴ señaló hace tiempo que el epíteto "paciente resistente" resume simplemente el hecho de que el terapeuta permitirá a sus pacientes que tengan *algunos* síntomas, pero otros no (p.ej. esa osiosa falta de cooperación). Debemos notar también que el paciente no es odioso; simplemente está siendo quien es. Lo que encontramos odioso es el hecho de que no sea como nosotros queremos que sea.

Otro modo muy relacionado con el anterior que tienen los terapeutas para crear "resistencia" es *esperar* una particular respuesta de un paciente a una intervención terapéutica. Cuando no se cumple la expectativa del terapeuta, éste tiene dos opciones. Puede decidir que su expectativa era errónea (que en realidad el paciente es diferente de la noción del terapeuta acerca de él) o puede decidir que el paciente es resistente (está obstinadamente combatiendo su tratamiento). Una manera más sutil de cometer este mismo error epistemológico es decidir que el paciente "no está listo para el tratamiento". Un juicio así, por supuesto, no tiene sentido. No es el tratamiento lo que determina cómo responderá el paciente, sino la organización del paciente como sistema. Sería más acertado (y más honesto) decir que el tratamiento aún no está listo para el paciente.

El otro modo en que el terapeuta puede crear "resistencia" es creer en el control. Creer que uno puede controlar lo que sucede es aspirar a la altura de los dioses. Es un orgullo tremendo, el primero de los siete pecados capitales. El error inherente a la noción de control es la ecuación, "A causa B", o "A puede provocar que B ocurra". *Nunca* nadie puede provocar que algo ocurra. Las intervenciones del terapeuta no son la *causa* de que un paciente cambie. La organización del sistema (paciente) determina aquello que cambiará, *no* la intervención. Dicho simplemente, el hombre propone, pero el sistema (la organización del mismo) dispone.

En terapia, la organización del sistema es una realidad

inalterable con lo cual el terapeuta debe vérselas. Si esa realidad es negada, el sistema será "resistente". Los terapeutas estratégicos creen que la resistencia de los pacientes puede ser cambiada "aliándose con la resistencia". No es así. Los pacientes "resistentes" se "cambian" *aliándose con la realidad*; esto es, mediante la aceptación del terapeuta de que el sistema es lo que es y su comportamiento de acuerdo a esto. Resumiendo, no hay tal cosa como la *resistencia*; solamente hay malos entendidos con respecto a la realidad o un rechazo de la misma.

Esta, en efecto, es la característica que define al error epistemológico: Un error epistemológico es la mala interpretación o directamente el rechazo de la realidad. El modo más destructivo de rehusarse a aceptar la realidad es creer en la posibilidad del control. El control otorga licencia para el uso del *poder* (en la búsqueda del control). Si, como se ha dicho antes, A nunca puede causar o controlar a B, entonces el uso del poder por parte de A solamente puede empeorar las cosas. El poder crea una "resistencia" aún mayor, lleva a la virtuosidad, al odio y eventualmente al caos, si no a la carnicería. Basta con observar lo que sucede cuando los padres "sobre" controlan a sus hijos para ver que esto es así. El control hace estragos. La literatura sobre la desviación y su control atestigua esto.

Coherencia

Si he discutido mi caso en forma adecuada, debería estar claro que la homeostasis es un concepto que, como los epiciclos flogísticos Ptolomeicos y la generación espontánea, debe ahora ser relegado al museo de las ideas científicas apremiantes, pero erróneas. ¿Adónde nos deja esto?

De los dos componentes de la homeostasis a) el sistema organizado y b) el sistema manteniéndose a sí mismo mediante la resistencia al cambio, sólo el concepto de un sistema organizado coherente permanece viable. Más aún, no solamente este concepto es viable, sino que, entendido adecuadamente es

capaz de dar cuenta más comprensivamente de los mismos hechos que la homeostasis había "explicado". Hay, me parece, una decidida necesidad de un nuevo término que signifique "sistema coherente organizado". Este nuevo término tendría dos propósitos relacionados. Primero, indicaría o substituiría al significado epistemológicamente alterado de "sistema coherente organizado" que este trabajo se ha empeñado en transmitir. Segundo, es necesario un nuevo término para recordarnos que hemos abandonado la ilusión de la homeostasis. Sin un nuevo término, los fenómenos acuciantes de la aparente resistencia y de la aparente homeostasis nos seducirían reiteradamente llevándonos al error epistemológico. No cabe duda de que ya es tiempo para un término que no desvíe el pensamiento clínico. La terapia familiar ya es lo suficientemente difícil.

El término que sugiero es más bien prosaico y neutral: *coherencia*. Coherencia simplemente implica una interdependencia congruente del funcionamiento, por la cual todos los aspectos del sistema encajan entre sí. Parecería un término adecuado para describir el comportamiento de un-sistema-siendo-él-mismo sin implicar inadvertidamente nada más que eso. Sin embargo, debido a la carga epistemológica que trae, un-sistema-siendo-él-mismo seguramente implica mucho: gran parte de la teoría de la terapia familiar y su aplicación clínica debe ser replanteada y tal vez re-pensada.

El Sistema Coherente en Evolución

Una de las grandes limitaciones del concepto de homeostasis es su imposibilidad de explicar el cambio sistémico. En un intento de remediar esta limitación, los teóricos que creen en la homeostasis han comenzado a caer en dualismos que describen a los sistemas como teniendo *tanto* una tendencia hacia la homeostasis o morfostasis^{1-5,6,63} como una tendencia hacia el cambio, transformación, o morfogénesis^{1-5,6-63}. El concepto de coherencia puede abordar el cambio sistémico sin recurrir a este tipo de remiendo protector de paradigmas^{3,6}.

Cada conducta (contrariamente a lo que los conductistas

nos harían pensar) no es un átomo independiente del funcionamiento de un individuo, sino que está enraizada dentro de su coherencia sistémica. No solamente todas las conductas nacen de esta coherencia, sino que *afectan* la coherencia. Para volver a parafrasear a Heráclito, hay un sentido en el que el mismo sistema no puede conducirse dos veces, ¡porque en ese conducirse se torna diferente! *Un sistema no puede CONDUCIRSE SIN ALTERARSE*. Esto es verdad hasta para las máquinas. En los sistemas vivientes cada conducta participa en la evolución continua, recurrente y de primer orden de la coherencia sistémica*.

Si por cualquier razón un individuo muestra repetidamente una conducta en particular (o si es repetidamente sometido a un input particular del entorno) su coherencia se alterará de modo de tornarse más coherente con la conducta (o input) en cuestión. Los Occidentales típicamente no comprenden esto, mientras que los Orientales sí lo hacen¹¹. Esto es particularmente fácil de ver en la adquisición de destrezas (durante la cual, por supuesto, el individuo muestra repetidamente una conducta en particular). Los Occidentales practican (p. ej. tocando un instrumento, jugando al tenis, observando, etc.) para adquirir una habilidad. Por el contrario, cuando los Orientales practican algo, lo hacen para cambiarse a sí mismos. Comprenden que la prosecución de una disciplina o práctica cambia todo el self y no añade simplemente una habilidad al sí mismo pre-existente.

Similarmente, si una mujer se habitúa a trotar, tanto su físico como su fisiología se tornarán coherentes con su conducta. En añadidura, también su comportamiento social y su vida diaria se volverán coherentes con su "jogging". Si un hombre vigilante continúa siendo vigilante (cualquiera sea la razón), su estilo cognitivo, sus actitudes sociales y sus creencias políticas se tornarán coherentes con su conducta cada vez más paranoide. Obviamente, tanto la coherencia del "jogging" como la

* Piaget se refería a este mismo primer orden cuando hizo notar que (la organización de) el organismo se acomoda vía asimilación recíproca^{4,6}.

coherencia paranoide tendrán consecuencias interpersonales enormes que rebotarán en forma de feed back sobre el individuo y su coherencia en evolución. De este modo hay una co-evolución de la coherencia del individuo y la coherencia de la red familiar y los otros sistemas sociales a los que pertenece. Las coherencias co-evolucionantes de los individuos y del sistema más amplio son una complementariedad que no puede ser separada en sus componentes ni reducida a uno u otro.

Esta co-evolución de coherencias es un fenómeno central en toda terapia. Es el proceso por el cual el individuo o el sistema familiar "neutraliza" al terapeuta que está intentando cambiarlo. Esto es, el input terapéutico es definido por el hecho de tener impacto sobre el síntoma y la coherencia en la que está enraizado. Si el input ya no afecta (o nunca lo ha hecho) la coherencia con respecto al síntoma, entonces ya no es realmente un input. Cuando esto ocurre el terapeuta se ha convertido en parte del sistema familiar; la familia y el terapeuta han co-desarrollado una coherencia complementaria. Por otra parte, si una familia permanece mucho tiempo en terapia, esto *siempre* ocurre. La única cuestión relevante es si el terapeuta ahora es parte de un sistema familiar todavía disfuncional* o si éste ha cambiado y ahora el terapeuta es parte de un sistema familiar no sintomático.

Por el hecho de que el terapeuta se torna ineficaz cuando ha co-desarrollado una coherencia con la familia, es claro que la terapia será facilitada por cualquier factor que obstaculice la aparición de esta coherencia. Para incrementar la potencia, las estrategias que pueden retardar o impedir el co-desarrollo de una coherencia complementaria son: a) una sola consulta; b) supervisión permanente; c) coterapia; d) coterapia con uno de los terapeutas tras un espejo unidireccional; e) terapia (o coterapia) con un equipo detrás del espejo y f) sesiones de terapia poco

* La situación del terapeuta volviéndose parte de un sistema familiar (aún) sintomático era descripta como "el terapeuta siendo regulado por el sistema". Podemos ver ahora la arbitrariedad de aquella puntuación. Si el terapeuta es parte del sistema, no está dualísticamente regulado por él; simplemente participa en una coherencia que ha co-evolucionado.

frecuentes. Finalmente, la cuestión de retardar o impedir la formación de una coherencia co-desarrollada terapeuta/familia es un modo de resolver el debate acerca de si los terapeutas familiares deben estar analizados (o pasar por terapia apuntando a la familia de origen).

Mientras que muchos terapeutas familiares aseguran que los terapeutas deben analizarse, los terapeutas estratégicos y sistémicos insisten en que el análisis no es necesario. Los terapeutas estratégicos y familiares en general ven a las familias durante pocas sesiones y a menudo utilizan una o más de las estrategias mencionadas para retardar o impedir la co-evolución de una coherencia. De acuerdo a esto, pueden decir que tienen poca necesidad de un análisis personal. Por otro lado, los terapeutas que no utilizan ninguna de esas estrategias y que hacen terapia a largo plazo insisten justificadamente en la importancia del análisis personal para los terapeutas familiares. El análisis torna a la persona sensible a (y se espera que disipe) sus áreas de indiferenciación, su reactividad emocional y tendencias a fundirse en patrones de interacción (coherencia co-desarrollada) con otros. El análisis es así, la más importante y tal vez la única herramienta en una terapia a largo plazo para bloquear y deshacer la cristalización de una coherencia co-desarrollada que neutralice al terapeuta (y a la terapia).

Coherencia y cambio discontinuo

Muchos teóricos en diferentes campos han puesto énfasis recientemente en la importancia del fenómeno del cambio discontinuo; teoría de la catástrofe en matemática^{5 7}, estructuras disipadoras en química^{4 8}, reorganización jerárquica en física^{4 7}, equilibrio puntuado en biología^{2 4} y transformaciones en los sistemas humanos^{2 3-3 1-4 9-5 0-5 2-5 3}. Por lo tanto surge la pregunta "¿Cuál es la naturaleza del cambio discontinuo de la coherencia?" ¿Qué es el cambio discontinuo, de segundo orden, de la coherencia?

Para contestar esta pregunta es necesario distinguir tipos de discontinuidad. La mayoría de las discontinuidades son discon-

tinuas solamente desde el punto de vista del observador; *no* lo son en términos de la coherencia en cuestión. Por ejemplo, cuando un niño contrae varicela, el observador notará un cambio discontinuo. Antes el chico estaba sano y ahora está enfermo. No hay, sin embargo, un cambio discontinuo en la coherencia fisiológica del niño. La coherencia fisiológica del niño tiene la habilidad de sufrir varicela (y mil otros desórdenes). Aunque estos desórdenes puedan ser alejamientos discontinuos de la salud, no son discontinuidades de la coherencia, sino solamente un cambio de estado en la coherencia fisiológica estable del niño. ¿Qué *constituiría* un cambio discontinuo en la coherencia fisiológica? La muerte. Cualquier discontinuidad genuina casi con seguridad sería tan disruptiva en la organización de la coherencia como para terminar la habilidad del organismo para seguir viviendo. En resumen, entonces, podemos decir que los estados de enfermedad (y el retorno a un estado de salud) pueden ser cambios discontinuos para un observador, pero no para la coherencia fisiológica del organismo. Esto en cuanto a la fisiología. ¿Qué sucede con la *coherencia conductual* de un individuo?

Cuando una mujer cambia su modo de vivir, los otros muchas veces dicen: “¿Está irreconocible; es otra persona!” ¿Es otra persona? ¿El cambio en el carácter o la personalidad implica un cambio discontinuo en la coherencia conductual personal o se trata simplemente de la evolución a un nuevo estado dentro de una coherencia estable? Del mismo modo se puede preguntar si la psicoterapia ayuda a los individuos a evolucionar a un nuevo estado en su coherencia estable, o si los transforma de tal modo que tienen un cambio discontinuo hacia una coherencia totalmente diferente. La última pregunta es menos difícil que las anteriores. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que la psicoterapia sirve solamente para ayudar a una persona a evolucionar su coherencia estable, más que a transformarla de una manera discontinua. Lamentablemente, esta respuesta deja la cuestión básica sin tocar: ¿Es posible obtener un cambio discontinuo en la coherencia conductual de un individuo?

En el que tal vez sea el mejor tratado epistemológico existente sobre la personalidad, Bateson⁶ propone el concepto de Aprendizaje II. Aprendizaje II (que Bateson iguala a personalidad) “es un modo de puntuar los hechos”⁶ p. 300 tal que “yo soy mis hábitos de acción en contexto y conformación y percepción de los contextos en los que actúo”⁶ p. 304. En otras palabras, Aprendizaje II es un patrón de conductas y premisas que tiene un encaje perfecto, complementario, con el entorno del individuo, como él lo ha experimentado (y hecho). Bateson ve claramente a la personalidad como un patrón coherente que, hace notar, es altamante resistente al cambio. Si el individuo cambia, entonces puede reemplazar un patrón de Aprendizaje II por otro; alternatively puede “llegar a”⁶ p. 306 Aprendizaje III, estado algo místico en el cual el sentido de sí mismo del individuo se torna irrelevante a su experiencia, puesto que el individuo se funde con el todo (de su mundo).

En ninguna parte, sin embargo, Bateson habla directamente acerca de si el cambio de la personalidad es una evolución o un cambio discontinuo. Se podría discutir tal vez que el salto de Aprendizaje II a Aprendizaje III debe ser un cambio discontinuo de coherencia, puesto que representa un viraje tan profundo. Sin embargo, prefiero pensar que Bateson insistiría en buscar “el patrón que conecta”¹² p. 18 lo que está por encima, la coherencia de la persona. Visto simplemente, un hombre puede evolucionar, pero ¿cómo podría salirse verdaderamente de sí mismo? Después de todo, las posibilidades para una futura evolución de la coherencia siempre están dadas (y *sólo* pueden estar dadas por lo que ha ocurrido antes). La recientemente desarrollada coherencia siempre debe estar fundada en la anterior.

De últimas, la coherencia conductual debe seguramente estar ligada a la coherencia que define la especie a la que pertenece el organismo. Según esto, la conducta comienza en el nacimiento, con los reflejos y primeros esquemas^{4 6} y evoluciona a la gran complejidad de la adultez, pero nunca puede sobrepasar los límites de la coherencia de la especie. Así, romper la coherencia nos lleva, nuevamente, a la muerte. Por lo

tanto parece que el cambio en la personalidad puede ser solamente una evolución hermenéutica. Cualquier discontinuidad aparente existiría sólo desde el punto de vista de un observador; no sería una real transformación o un cambio discontinuo de la coherencia conductual*.

Si ni el "cambio" fisiológico ni el "cambio" en la personalidad constituyen un real cambio discontinuo de coherencia, ¿podemos decir que esas transformaciones discontinuas existen realmente? Existen. Todos los sistemas interaccionales multi-individuales son capaces de verdaderos cambios discontinuos: familias, grupos, amigos, vecindades, interacción entre animales, etc. Estos sistemas pueden pasar por un cambio discontinuo porque *la coherencia como sistema interactuante es fundamentalmente diferente de la coherencia que constituye a los miembros vivientes individuales que constituyen ese sistema*. Hemos mostrado que la disrupción en la coherencia fisiológica o conductual de un sistema viviente resulta en la muerte: no más sistema. La disrupción de la coherencia de un sistema interaccional también resultará en la muerte (de ese sistema), pero casi con seguridad sobrevendrá un entretejido que formará un nuevo sistema con una coherencia verdaderamente nueva. El entretejido es lo que Bateson ha llamado *tautología autocurativa*^{1 2}. Los ataques humanos al medio ambiente, por ejemplo, pueden violar la coherencia del ecosistema local, pero el ecosistema se ha de auto-curar formando una nueva tautología, aunque sea ésta indeseable para nosotros.

Maturana^{4 0-4 2} describe estos sistemas interaccionales en términos de un *emparejamiento estructural* recíproco en el cual la historia de las conductas de los miembros del sistema culmina en un sistema estable, de organización cerrada^{5 9-6 0}. El cerramiento de la organización se obtiene al alcanzar la circula-

* Un punto interesante a este respecto es que el observador puede observarse a sí mismo y *experimentar* un cambio discontinuo. Como el yo no es otra cosa que un pedazo de la coherencia del individuo, puede ser que el yo *pueda* sufrir un cambio discontinuo, mientras que la coherencia conductual como un todo no pueda hacerlo. Agradezco a Sue Crommelin hacerme notar esto.

ridad: las conductas de algunos miembros (A) actúan como disparador de las conductas de otros (B) que se vuelven disparadores de... que eventualmente regresan como disparadores de conductas de A. En otras palabras, los individuos han formado un sistema organizado.

Las implicancias del emparejamiento estructural son importantes. Primero, *la coherencia conductual de cada miembro individual es primaria, mientras que la coherencia de mayor orden del sistema interaccional (el emparejamiento estructural recíproco) es secundaria*. La coherencia del emparejamiento estructural recíproco puede ser transformada discontinuamente; la coherencia conductual de los miembros individuales no se puede transformar. Segundo, hay una co-evolución y una complementariedad que tiene lugar entre las coherencias conductuales de los individuos y entre éstos y la coherencia de orden mayor del sistema como un todo. La coherencia de mayor orden del sistema no determina, controla o mantiene homeostáticamente la coherencia conductual de cada uno de los miembros del sistema. Los miembros simplemente encajan unos con otros. Sin embargo, hasta en los sistemas más organizados (con las circularidades de interacción más rígidas), *la coherencia conductual de cada miembro individual tiene el potencial para conductas que pueden discontinuamente transformar la coherencia del sistema como un todo*. Ese es el potencial, por supuesto, que el terapeuta familiar está tratando de catalizar.

Para lograr la transformación, el terapeuta familiar debe actuar como disparador de conductas de los miembros individuales de la familia que sean transformadores del sistema. Esta es la tercera implicancia del apareamiento estructural: para ser exitoso en el disparar conductas transformadoras del sistema, el terapeuta familiar obviamente debe utilizar conductas (intervenciones) que difieran de las que ya venían siendo usadas dentro del sistema^{2 3}. Obviamente, las conductas que ya están siendo utilizadas no poseen la habilidad de promover conductas transformadoras de sistema en los otros. Cuarto, y más importante, la coherencia conductual de cada miembro de la familia

especifica las intervenciones que van a disparar conductas que pueden transformar el sistema. La coherencia conductual del individuo es la cerradura, y las intervenciones del terapeuta son las llaves. No importa cuántas llaves intrincadas de oro, plata, de platino u ornamentadas posea el terapeuta. Siempre es la cerradura la que determina qué llaves funcionarán. No existe la Verdad (Una Llave Verdadera). No hay Causalidad (la llave que *haga* que la cerradura se abra). Solamente hay Encaje (aquellas llaves que son complementarias con respecto de la cerradura).

Coherencia y Patología

El apego de los terapeutas familiares al concepto de homeostasis probablemente provenga del hecho de que ha sido una manera útil de hablar acerca de una patología; patología de las personas *dentro* de los sistemas y patología *de* los sistemas. Después de todo, cualquier clínico sabe que los sistemas patológicos están marcados por "redundancias homeostáticas rígidas". "Resisten" al cambio. Son "patológicos". El problema con esta óptica es que *todos* los sistemas son redundantes. *Todos* los sistemas resisten al cambio. *Todos* los sistemas son "homeostáticos". En realidad los terapeutas familiares se han sentido incómodos por tener conciencia de esto y se han visto forzados a realizar maniobras protectoras de paradigmas, tal como declarar que algunos sistemas son demasiado homeostáticos (patológicos) y otros son menos homeostáticos (normales). Los sistemas que son "demasiado homeostáticos" difieren de los sistemas normales en que son demasiado redundantes y tienen un repertorio reducido de estados estables. Pero lo más importante es que tales sistemas *deben* tener algo —homeostasis, feedback negativo, reglas familiares o lo que sea— que controle el sistema y limite su funcionamiento al rígido ciclo patológico que mantiene el status quo en detrimento de todos, especialmente del paciente.

¿Por qué "debe" haber algo (homeostasis) que mantenga el status quo? Pues por la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que, al pasar el tiempo,

todo se vuelve entropía. Toda estructura se degrada hacia el desorden. Hay más modos de que las cosas se desordenen que modos de que estén en orden; por lo tanto, las cosas tienden a desordenarse; esto es, se vuelvan entrópicas⁷. Se requiere energía (negentropía^{5,1}) para mantener la estructura. Sin energía los sistemas vivos decaen, mueren, se deterioran, pierden su estructura y regresan a la entropía desordenada. *Por lo tanto*, permanece rígidamente el mismo, no cambia o se gasta, está altamente estructurado y es negentrópico, *debe* haber algo (homeostasis) que está invirtiendo una enorme cantidad de energía en controlar y mantener las cosas iguales.

El argumento del párrafo anterior se encuentra desparpillado en toda la literatura acerca de terapia familiar, especialmente en aquellos libros que han tratado de ser los más rigurosamente teóricos y sofisticados. *El argumento está totalmente equivocado*. La segunda ley de la termodinámica no está equivocada pero es una equivocación aplicarla al mundo de la coherencia. Bateson¹⁰ seguramente era consciente de esto. Su distinción entre "Pleroma" y "Creatura"¹⁰⁻¹² precisamente establece la diferencia entre el mundo de la termodinámica y el mundo de la coherencia. Pleroma es el mundo de la física: masa, inercia, velocidad, energía, termodinámica. Creatura es el mundo de lo viviente: patrón, diferencia, relación, información.

En el mundo de la termodinámica la energía y el orden estructurado son esencialmente sinónimos. La Segunda Ley dice que toda energía y orden estructurado tienden a decaer. En el mundo de los sistemas interaccionales coherentes, contrariamente, la noción de energía es irrelevante, pero el orden estructurado es la esencia de la coherencia. En *este* mundo, una nueva Segunda Ley dice que el orden tiende a incrementarse. Makridakis ha sugerido una Segunda Ley de los Sistemas, que sostiene que "si las cosas se dejan libradas a sí mismas tienden a volverse más y más ordenadas"³⁸, p. 1. De esto se trata, en realidad, el encierro organizativo, el emparejamiento estructural y la tautología del auto-remedio: *en los sistemas interaccionales vivientes, el orden surge espontáneamente*. Maturana⁴⁰⁻⁴² demuestra que, si permanecen juntos durante un período de

tiempo, dos sistemas llegarán a un emparejamiento estructural; co-desarrollarán una coherencia. Bateson, por ejemplo, describió el desarrollo de patrones de interacción entre su perro y su gibón como una "evolución del encaje mutuo"¹², p. 138. Notó que "el sistema perro-gibón se volvió más simple, más consistente e integrado internamente"¹², p. 138. En otras palabras el perro y el gibón habían logrado un emparejamiento estructural. Bateson, por supuesto, describiría ese fenómeno en términos de la tautología del auto-remedio:

Mi opinión es que la Creatura, el mundo del proceso mental, es a la vez tautológico y ecológico. Quiero decir que es una lenta tautología de auto-remedio. Dejada sola, cualquier gran porción de Creatura tenderá a estabilizarse hacia una tautología, es decir, hacia una *consistencia interna* de ideas y procesos¹², p. 206.

La implicancia de esto es que la homeostasis es un concepto superfluo. La coherencia de los sistemas interaccionales no necesita otra explicación que la de que la coherencia es un fenómeno natural y espontáneo que surge cuando los organismos vivientes pasan un tiempo juntos. La homeostasis no es necesaria para explicar la "fuerza" o "principio" que *mantiene* la coherencia interaccional. La coherencia interaccional es un emparejamiento co-desarrollado cuya posibilidad de ser realizado es inmanente a las varias co-relaciones *potenciales* y complementariedades de las respectivas coherencias conductuales de los organismos implicados.

Si la coherencia hace todo (y más) lo que previamente era atribuido a la homeostasis y si coherencia es otra manera de decir "el sistema", entonces, en un sentido, la homeostasis (cualquiera sea el significado de este concepto luego de haber sido tan vapuleado en estas páginas) se iguala ahora "al sistema". Esto (para los devotos de la homeostasis) es un estado de cosas altamente insatisfactorio. Si homeostasis es lo mismo que "el sistema", entonces la homeostasis ya no significa nada y no tiene "raison d'être". Exactamente. El concepto ya no es necesario.

Esto nos lleva nuevamente a la cuestión de la patología. Obviamente, existe una diferencia entre la coherencia de las familias supuestamente normales y la coherencia de las familias que los terapeutas familiares estaban más habituados a llamar "homeostáticas" o "patológicas". ¿Qué posible contribución puede la noción de coherencia efectuar a nuestra comprensión y conceptualización de estas "familias rígidamente patológicas"? La respuesta es irónica. Aquellos lectores que se sienten más cómodos con el destripamiento epistemológico de la homeostasis efectuado en este artículo, serán posiblemente los que se sientan más molestos por las implicancias del concepto de coherencia para la comprensión de la patología.

Si la coherencia interaccional surge de las posibilidades de emparejamiento estructural inmanentes a las coherencias conductuales de los miembros del sistema a formarse, entonces, de últimas (como ya se dijo) la coherencia conductual de cada individuo es primaria y el emparejamiento estructural emergente es secundario. En otras palabras, *el sistema interaccional es una consecuencia de la naturaleza (i.e., la coherencia conductual) de los individuos que lo componen*. Por lo tanto, si un sistema interaccional es lo que antes hubiéramos denominado "rígidamente homeostático", entonces, la fuente de la "rígida homeostasis" está en los individuos que componen el sistema. La coherencia de los respectivos individuos del sistema es tal que se comportan de manera que constituye un emparejamiento estructural o coherencia interaccional que antes llamábamos "rígidamente homeostática". Nuevamente, ésta así llamada "rígida homeostasis" es simplemente otro emparejamiento estructural, otra coherencia interaccional. Surge de los individuos del sistema y no es necesario nada —tal como "mecanismos homeostáticos" o "reglas familiares"— para que exista (o permanezca) tal como es. Es como es porque ese es el modo en que esos individuos encajan unos con otros.

Este artículo no puede explorar en detalle la patología. La cuestión de la patología es un emprendimiento separado que debería culminar en algo que considero muy necesario en el campo de la salud mental; *una epistemología clínica*. Sin

embargo, podemos delinear brevemente un punto importante. Los sistemas patológicos "rígidos" se fundan en la coherencia conductual de los respectivos individuos que constituyen esos sistemas. ¿Qué pasa con esos individuos, que resulta tal patología sistémica? La respuesta es que ellos frecuentemente —demasiado frecuentemente— cometen errores epistemológicos con ellos mismos y con los demás.

Hay sólo dos errores epistemológicos fundamentales. Uno es pasivo y el otro es activo. El error pasivo es rehusarse a aceptar la realidad. Esta es una violación del principio de realidad. "Lo que es, es; lo que no es, no es". Negar aquello que es o enojarse con lo que es e insistir en que debería ser de otra manera que la ocurrida es un error epistemológico. El Seminario de Entrenamiento de Erhard (est) deriva mucho de su poder del éxito en hacer aceptar este punto.

El error epistemológico activo es tratar de controlar a los otros para hacer que sean lo que uno quiere. Es un error porque las personas (y todos los otros organismos) son lo que Maturana llama *determinados por su estructura*⁴⁰. Esto significa que los individuos siempre se comportan según su coherencia; no pueden comportarse de otra manera. El control es imposible. Su coherencia determina cómo se han de comportar y ningún intento de controlarlos puede jamás cambiar este hecho. Además, la coherencia de un individuo especifica su reacción a los intentos de control del otro. La coherencia, en la mayoría de los casos "responderá" de modo diferente al pretendido mediante el intento de control. Se puede llevar a un caballo al agua, pero no se puede hacer que beba. Cada intento sucesivo de hacer que el caballo beba resultará en que la coherencia (que es el caballo) haga lo que hace bajo esa perturbación en especial. La coherencia siempre determina. Lo máximo que se puede lograr es que el dueño del caballo descubra la perturbación a la cual la coherencia (el caballo) "responde" con la conducta de beber.

Las familias patológicas están llenas de individuos que repetidamente y con obstinación cometen esos errores epistemológicos en sí mismos y en aquellos que los rodean. Como los

errores epistemológicos casi siempre obstruyen el resultado que esperaban obtener, esos individuos se ven forzados a intentar de nuevo, una y otra vez. De acuerdo a esto, esas familias desarrollan una coherencia sistémica altamente redundante ("rigidez homeostática"). Sus intentos de control sobre sí mismos y sobre los demás tienen éxito por casualidad con la frecuencia suficiente como para mantener los intentos. De modo que siguen intentando resistirse a la realidad e intentando controlar, e intentando resistirse a la realidad e intentando controlar, e intentando, e intentando, e intentando... No es asombroso que esas familias tengan patrones de interacción tan rígidamente estereotipados.

Post-Data: Leitmotiv Epistemológico

Bateson⁹ sugirió una vez que todos los datos científicos están organizados de una de dos maneras: de acuerdo a fundamentos científicos o de acuerdo a "nociones explicativas imperfectamente definidas"⁹, p. xviii. Los *fundamentos científicos* son de dos tipos: a) tautológicos (p. ej. aritmética y geometría euclidiana) y b) verdades científicas mayores (e.g. leyes de conservación de la masa y la energía, segunda ley de la termodinámica, etc.). Bateson dijo que las "Nociones explicativas imperfectamente definidas" son comúnmente usadas en las ciencias de la conducta. Ejemplos de tales nociones explicativas son: el yo, la ansiedad, instinto, sí mismo, inteligencia, madurez, introversión, etc. Tales nociones, dice Bateson mordazmente, "tienen una derivación tan floja y son tan irrelevantes mutuamente, que se mezclan para formar una suerte de neblina conceptual que hace mucho por retardar el progreso de la ciencia"⁹, p. xviii.

Los fundamentos científicos son importantes, porque comprendemos los fenómenos del mundo en términos de los mismos. Esto significa que la explicación de los hechos se logra añadiendo datos a los fundamentos. Así, el éxito de las ciencias exactas se debe a y puede ser medido en términos de su lista de fundamentos cada vez mayor. Bateson insiste en que se

puede lograr muy poca comprensión agregando datos a nociones explicativas imperfectamente definidas. Piensa que el principal obstáculo a un progreso significativo de las ciencias de la conducta ha sido su permanente fascinación con esas nociones explicativas. Bateson asegura que, como consecuencia directa de esa "fascinación", las ciencias de la conducta han producido "escasamente algún principio digno de un lugar en la lista de fundamentos"⁹, p. xix.

De esto se trata "Más allá de la Homeostasis". Homeostasis es una noción explicativa imperfectamente definida. En realidad, el campo de la terapia familiar se halla a flor de agua con estas nociones: reglas familiares, resistencia, paradoja terapéutica, masa indiferenciada de yo familiar, jerarquía, feedback negativo, etc. Todas éstas son nociones explicativas imperfectamente definidas que cuelgan en el aire. Hay una necesidad desesperada de algunos fundamentos que puedan comenzar a explicar los datos de la interacción familiar, la psicopatología y la intervención terapéutica. Este trabajo es el intento de proporcionar uno de estos fundamentos.

El concepto de coherencia no es otra noción explicativa imperfectamente definida. En los términos de Bateson, es, tal vez, una noción explicativa *perfectamente* definida. Contrariamente a las nociones explicativas imperfectamente definidas, la coherencia se deriva directamente de un fundamento. ¿Cuál es este fundamento? A grandes rasgos, es la epistemología que este trabajo se ha empeñado en establecer. Específicamente, es el concepto de Maturana de sistema estructuralmente determinado. Lo que estoy sugiriendo es que tanto el universo como un todo, como todos sus pedazos, están determinados estructuralmente. El concepto de sistema estructuralmente determinado es el fundamento que hace de "puente" entre Pléroma y Creatura, el mundo cuantitativo de la física y el mundo cualitativo de patrones y de orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el universo es un sistema estructuralmente determinado, entonces tanto los fundamentos de Pléroma como de Creatura deben ser immanentes a ese sistema. Significa que tanto los fundamentos de las ciencias exactas como los de las

relaciones, orden y patrones deben ser immanentes a un universo estructuralmente determinado. Hay, en efecto, algún apoyo indirecto a esto.

Las dos verdades epistemológicas fundamentales (que corresponden a los dos errores epistemológicos fundamentales presentados en la primera parte de este trabajo) son inherentes al sistema estructuralmente determinado. Las dos verdades son: a) Aquello que es, es; y b) La estructura del sistema específica totalmente cómo el sistema puede comportarse y cómo se ha de comportar en cada situación posible. La segunda verdad no es otra cosa que la definición de sistema estructuralmente determinado. La primera verdad es tanto un comentario ontológico sobre la segunda verdad, como una consecuencia de la misma. El comentario ontológico es sobre aquello que *es*; se refiere al universo estructuralmente determinado. La consecuencia es que *cualquier cosa que sea* en todas y cada situación específica, deriva del hecho de que todo está estructuralmente determinado.

Para cerrar, hay dos últimos puntos a recalcar. Primero, que coherencia es similar, pero no equivalente, al concepto de Maturana de sistema estructuralmente determinado. Bien entendido, el concepto de Maturana es abarcativo de todo el universo y sus conceptos (vivos y no vivos) mientras que coherencia se aplica solamente a los sistemas vivos de organización cerrada. Segundo, contrariamente a la homeostasis, la coherencia está firmemente basada en su propia epistemología; es una noción explicativa (mucho más) perfectamente definida. La epistemología en la que se basa es muy familiar para los terapeutas familiares, tal como está representada en los escritos de Gregory Bateson; está definida con pureza y sin desviación en los escritos de Humberto Maturana. La coherencia, por lo tanto, no es simplemente otro concepto heurístico; es inseparable de su basamento epistemológico.

Bibliografia

1. ANDOLFI, M., "Prescribing the Family's Own Dysfunctional Rules as a Therapeutic Strategy", *J.M.F.T.* 6: 29-36, 1980.
2. ASHBY, W. R., *An Introduction to Cybernetics*, London, Chapman and Hall, 1956.
3. ASHBY, W.R., *Design for a Brain*, 2nd ed., London, Chapman and Hall, 1960.
4. BATESON, G., "Cultural Problems Posed by a Study of Schizophrenic Processes", in A. Auerbach (Ed.), *Schizophrenia: An Integrated Approach*, New York, Ronald Press, 1959.
5. BATESON, G., "The Cybernetics of 'Self': A Theory of Alcoholism", in G. Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, New York, Ballantine, 1972.
6. BATESON, G., "Logical Categories of Learning and Communication", in G. Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, op. cit.
7. BATESON, G., "Metalogue: Why do Things Get in a Muddle?" in G. Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, op. cit.
8. BATESON, G., "Pathologies of Epistemology", in G. Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, op. cit.
9. BATESON, G., "The Science of Mind and Order", in G. Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, op. cit.
10. BATESON, G., "Afterword", in J. Brockman (ed.), *About Bateson*, New York, Dutton, 1977.
11. BATESON, G., "Bateson's Workshop", in M. Berger (ed.), *Beyond the Double Bind*, New York, Brunner/Mazel, 1978.
12. BATESON, G., *Mind and Nature: A Necessary Unity*, New York, Dutton, 1979.
13. BATESON, G.; JACKSON, D. D.; HALEY, J.; and WEAKLAND, J. H., "Toward a Theory of Schizophrenia". *Behav. Sci.*, 1: 251-264, 1956.
14. BATESON, G.; JACKSON, D. D.; HALEY, J.; and WEAKLAND, J. H., "A Note on the Double Bind", *Fam. Proc.*, 2: 154-161, 1962.
15. BERNARD, C., *An Introduction to the Study of Experimental Medicine*, New York, Dover, 1957.
16. BOWEN, M., "A Family Concept of Schizophrenia", in D. D. Jackson (ed.), *The Etiology of Schizophrenia*, New York, Basic Books, 1960.
17. BOWEN, M., "Theory in the Practice of Psychotherapy", in P. Guerin, Jr., (ed.), *Family Therapy: Theory and Practice*, New York, Gardner Press, 1976.

18. CANNON, W., *The Wisdom of the Body*, New York, Norton, 1932.
19. DAVIS, R. C., "The Domain of Homeostasis", *Psychol. Rev.*, 65: 8-13, 1958.
20. DELL, P. F., "The Hopi Family Therapist and the Aristotelian Parents", *J. Mar. Fam. Ther.*, 6: 123-130, 1980.
21. DELL, P. F., "Researching the Family Theories of Schizophrenia: An Exercise in Epistemological Confusion", *Fam. Proc.*, 19: 321-335, 1980.
22. DELL, P. F., "More Thoughts on Paradox: Rejoinder", *Fam. Proc.* 20: 47-51, 1981.
23. DELL, P. F. and GOOLISHIAN, H. A., "Ordnung durch Fluktuation: Eine evolutionäre Epistemology für Menschliche Systeme", *Familien-dynamik*, 6: 104-122, 1981.
24. ERICKSON, M., "An Hypnotic Technique for Resistant Patients: The Patient, the Technique and its Rational and Field Experiments", *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1: 8-32, 1964.
25. FROMM-REICHMANN, F., "Notes on the Development of Treatment of Schizophrenics by Psychoanalytical Psychotherapy", *Psychiatry*, 11: 263-273, 1948.
26. GOULD, S. J. and ELDREDGE, N., "Punctuated Equilibria: The Tempo and Mode of Evolution Reconsidered", *Paleobiology*, 3: 115-151, 1977.
27. GREENBERG, G. S., "The Family Interactional Perspective: A study and Examination of the Work of Don D. Jackson", *Fam. Proc.*, 16: 385-412, 1977.
28. HALEY, J., "Family Experiments: A New Type of Experimentation", *Fam. Proc.* 1: 265-293, 1972.
29. HOFFMAN, L., "Enmeshment and the Too Richly Cross-Joined System", *Fam. Proc.*, 24: 457-468, 1975.
30. HOFFMAN, L., "Breaking the Homeostatic Cycle" in P. Guerin, Jr. (ed.), *Family Therapy: Theory and Practice*, New York, Gardner Press, 1976.
31. HOFFMAN, L., "The Family Life Cycle and Discontinuous Change", in E. A. Carter and M. Mc Goldrick (eds.), *The Family Life Cycle A Framework for Family Therapy*, New York, Gardner Press, 1980.
32. JACKSON, D. D., "The Question of Family Homeostasis", *Psychiat. Quart. Suppl.*, 31: 79-90, 1957.
33. JACKSON, D. D., "The Study of the Family", *Fam. Proc.*, 4: 1-20, 1965.

34. JACKSON, D. D., "Family Rules: The Marital Quid Pro Quo", *Arch. Gen. Psychiat.*, 12: 589-594, 1965.
35. JACKSON, D. D., and WEAKLAND, J. H., "Conjoint Family Therapy: Some Considerations on Theory, Techniques and Results", *Psychiatry* 24: 30-45, 1961.
36. KUHN, T., *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
37. LIDZ, T.; CORNELISION, A.; TERRY, D., and FLECK, S., "Intrafamilial Environment of the Schizophrenic Patient: VI. The Transmission of Irrationality", *A.M.A. Arch. Neurol. Psychiat.*, 79: 305-316, 1958.
38. MAKRIDAKIS, S., "The Second Law of Systems", *Int. J. Gen. Sys.*, 4: 1-12, 1977
39. MATURANA, H. R., "Strategies Cognitives", in E. Morin and M. Piattelli-Palmarini (eds.), *L'Unité de L'Homme*, Paris, Du Seuil, 1974.
40. MATURANA, H. R., "Biology of Language: The Epistemology of Reality", in G. A. Miller and E. Lenneberg (eds.), *Psychology and Biology of Language and Thought*, New York, Academic Press, 1978.
41. MATURANA, H. R., "Autopoiesis and Evolution", Paper present at the 145th National Meeting of the American Association for the Advancement of Science, Houston, Texas, 1979.
42. MATURANA, H. R. and VARELA, R. J., *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, Dordrecht, Holland, Reidel, 1980.
43. MAXWELL, J. C., *Theory of Heat*, London, Longmans, Green, 1971.
44. MAZE, J. R., "On Some Corruptions of the Doctrine of Homeostasis", *Psychol. Rev.*, 60: 405-412, 1953.
45. MINUCHIN, S.; MONTALVO, B.; GUERNEY, B. G.; ROSMAN, B. L. and SCHUMER, R., *Families of the Shums*, New York, Basic Books, 1967.
46. PIAGET, J., *The Origins of Intelligence in Children*, New York, International University Press, 1952.
47. PLATT, J., "Hierarchical Growth", *Bull. Atom. Scientists* 26: 2-4, 46-47, 1970.
48. PRIGOGINE, I., "Time, Structure, and Fluctuations", *Sci.* 201: 777-795, 1978.
49. RABKIN, R., "On Books", *Fam. Proc.*, 11: 245-248, 1972.
50. RABKIN, R., "Critique of the Clinical Use of the Double Bind Hypothesis", in C. E. Sluzki and D. C. Ransom (eds.), *Double Bind The Foundation of the Communication Approach to the Family*, N. Y. Grune and Stratton, 1976.

51. SCHROPINGER, E., *What is Life?*, Cambridge, Cambridge University Press, 1944.
52. SELVINI-PALAZZOLI, M.; CECCHIN, G.; PRATA, G. and BOSCOLO, L., *Paradox and Counterparadox*, New York, Jason Aronson, 1978.
53. SELVINI-PALAZZOLI, M.; BOSCOLO, L.; CECCHIN, G. and PRATA, G., "The Problem of the Referring Person", *J. Mar. Fam. Ther.*, 6: 3-9, 1980.
54. SINGER, M. T. and WYNNE, L. C., "Thought Disorder and Family Relations of Schizophrenics: III. Methodology Using Projective Techniques", *Arch. Gen. Psychiat.* 12: 187-200, 1965.
55. SINGER, M. T. and WYNNE, L. C., "Thought Disorder and Family Relations of Schizophrenics: IV. Results and Implications", *Arch. Gen. Psychiat.* 12: 201-212, 1965.
56. SPEER, D. C., "Family Systems: Morphostasis and Morphogenesis, Or, 'Is Homeostasis Enough?'", *Fam. Proc.*, 9: 259-278, 1970.
57. THOM, R., *Structural Stability and Morphogenesis*, Reading, Mass. Benjamin, 1975.
58. TOCH, H. H. and HASTORF, A. H., "Homeostasis in Psychology", *Psychiatry* 18: 81-91, 1955.
59. VARELA, F. J., *Principles of Biological Autonomy*, New York, Elsevier 1979.
60. VARELA, F. J. and GOGUEN, J. A., "The Arithmetic of Closure", in R. Trappl, G. Klir and L. Ricciardi (eds.), *Progress in Cybernetics and Systems Research*, New York, Halstead, 1978.
61. WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; and JACKSON, D. D., *Pragmatics of Human Communication*, New York, Norton, 1967.
62. WHITEHEAD, A. N., *Science and the Modern World*, New York, Macmillan 1925.
63. WYNNE, L. C., "Paradoxical Interventions: Leverage for Therapeutic Change in Individual and Family Systems", in J. Strauss, M. Bowers, T. Downey, S. Fleck, S. Jackson, and I. Levine (eds.), *The Psychotherapy of Schizophrenia*, New York, Plenum, 1980.
64. WYNNE, L. C.; RYCKOFF, I. M.; DAY, J.; and HIRSCH, S. I., "Pseudomutuality in the Family Relations of Schizophrenics", *Psychiatry*, 21: 205-220, 1958.

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, *Palo Alto, CA*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Maui, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, M. Duncan Stanton, *Philadelphia, Pa.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been *James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton.*

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

Gentlemen:

DATE _____

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

☐ \$24.00 per year United States

☐ \$35.00 U.S.

☐ \$27.00 per year Canada &
Latin America

☐ \$38.00 Canada &
Latin America

☐ \$30.00 per year All other countries

☐ \$42.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____ STATE/COUNTRY _____ ZIP _____

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

La lucha para sobrevivir. Perspectiva de un psiquiatra sobre la familia contemporánea.

ISRAEL ZWERLING M.D., Ph.D.

Para un número creciente de observadores la familia es una especie en peligro. Tengo conocimiento de algunas citas que se han hecho de afirmaciones tomadas de periódicos del siglo dieciocho y aún de inscripciones jeroglíficas extraídas de tablillas egipcias que tienen muchos siglos de antigüedad, que proclaman que la familia es una institución que está muriendo y que los hijos ya no respetan a sus padres. Se cita a esos elementos en general para "probar" que profetas de todo lo negativo respecto de la familia han existido durante siglos y han estado equivocados durante siglos. No puedo, sin embargo, extraer elementos optimistas de este tipo de argumentos en presencia de lo que me parece que está ocurriendo con la vida familiar hoy en nuestro país.

En éste que es el primer artículo de una serie, trataré de describir lo que percibo como características fundamentales de la estructura y funcionamiento de la familia contemporánea, evaluar la eficacia de la familia en tanto unidad social y relacionar lo que veo que está ocurriendo con la familia, en algunas vastas zonas de cambio sociocultural. Me gustaría decir breve-

mente y en el comienzo que describiré a la familia contemporánea como desposeída de sus funciones tradicionales y como unidad social cada vez más aislada y aislante; que existen comprometedores y tal vez alarmantes elementos conceptuales referentes a su ineficacia, que relaciono con su falta de funcionalidad y con su aislamiento; que las fuerzas que determinan cambios en la familia emanan de procesos socio-culturales más amplios y que no aparece por ahora una clara resolución de la secuencia que ha conducido sin pausa e inevitablemente a partir del cambio social, al fracaso de la familia en lo que concierne a integrar sus elementos jóvenes en la sociedad.

La literatura que existe en psiquiatría sobre "terapia familiar" y "práctica familiar" en medicina se refiere casi exclusivamente a los ítems "terapia" y "práctica". Por ejemplo, intentando definir patología, establecer etiología y describir tratamiento, se ha prestado muy poca atención a la naturaleza de la entidad a la cual se dirigen terapia y práctica: la familia. Parece una modesta expectativa el que aquellos que traten familias y miembros de la familia tengan conocimiento de las fuerzas a las cuales responden las familias así como del impacto que tienen esas fuerzas sobre el individuo y su comportamiento y sobre el comportamiento familiar. Quisiera que ahora dirijan su atención sobre estas áreas.

Breve comentario semántico

Mi diccionario Random presenta en secuencia numerada no menos de quince diferenciadas definiciones de la palabra "familia"; utilizo aquí sólo la primera "padres y sus hijos ya sea que vivan juntos o no". El Census Bureau define familia como "grupo de dos o más personas que residen juntas y que están relacionadas por sangre, matrimonio o adopción". Una vez que se involucra el problema de residencia de la unidad familiar, la dificultad para clasificar grupos problemáticos se torna casi insuperable. Por ejemplo: ¿cómo consideraríamos, en términos de unidad familiar, a la esposa de quién está cumpliendo con su servicio militar, que vive con sus padres (de ella), mientras que su marido está en el extranjero? ¿O a un soltero y su hermana

soltera que comparten un departamento? ¿O a un padre (o madre) anciano que viva con su hijo casado?

El problema es de poca importancia, desde el punto de vista conceptual para nuestros propósitos, excepto en que podría complicar la lectura de datos el no tener claro ese enfoque. Nuestra preocupación en tanto psiquiatras se relaciona con la unidad que tiene y socializa hijos y es esto lo que tengo en mi mente cuando me refiero a "familia". Con esto no quiero decir que los grupos problemáticos no tengan importancia estadística. Al contrario, no más de una familia de cada tres actualmente en los Estados Unidos consiste en padres y sus hijos; cerca del 65% de todas las casas y departamentos están ocupados por grupos que no son una "familia" en el sentido que yo utilizo el término; y casi tantas casas (1 de cada 5) son mantenidas por personas que viven solas o con un pensionista, como las que son mantenidas o habitadas por una "familia". Las familias en las que hay un único progenitor están creciendo a una tasa de 19 veces con respecto a las que albergan a dos progenitores; en 1975 el 35% de familias negras y el 10.5% de familias blancas estaban en esta situación; cabeza de familia era una mujer sola. De alguna manera los datos sobre la composición de las familias norteamericanas ya evidencian lo que tiene de ineficaz el concepto según el cual dicha unidad consiste en "padres y sus hijos".

La familia es hoy, virtualmente, la única institución social organizada en torno al amor no calificado, como fuerza de enlace de la misma. Esto constituye un enorme refuerzo de los lazos familiares.

Pérdida de las funciones familiares tradicionales

El primer punto sobre el que quisiera poner énfasis al describir la familia contemporánea es aquel que señala cómo, una por una, las funciones familiares han sido asumidas por instituciones sociales burocráticas. Podría suponer que el cambio más inmediatamente evidente en cuanto a vida familiar se refiere, desde el punto de vista de mis padres —tal como ellos

podrían ver si observaran mi generación, la de mis hijos y la de mis nietos— es la virtual desaparición de lo que mis padres experimentaron como rutinas de vida familiar cuando ellos eran niños. Mi padre creció en una familia que todavía era una unidad básica de producción económica. Su rol en la empresa de su familia, hombro con hombro con su padre y hermanos estaba tan firme y claramente determinado, como el rol de mi madre también hombro con hombro con su madre y hermanas. La vida familiar los socializó incorporándolos al mundo del trabajo. Mis hijos crecieron teniendo sólo una vaga idea en cuanto a qué era lo que hacía su padre —en cuanto a actividad para la subsistencia— y esto siguió así hasta su adolescencia. Cuando acepté un nombramiento como Director de la Clínica de Investigación sobre Alcoholismo de la Universidad del Estado de Nueva York, después de haber completado mi residencia en Cincinnati, mi hija, que tenía entonces 7 años les dijo a sus amigas que se mudaba a Nueva York porque “papi va a ser alcohólico”!

A mis padres se les enseñó no sólo su trabajo sino también a leer y escribir; les enseñaron sus padres y sus hermanos mayores quienes se turnaban con otros familiares que sabían leer y escribir para impartir estas enseñanzas. Mi padre solía recordar una severa enfermedad que tuvo a los cinco o seis años y el hecho que su madre u otro miembro de la familia estuviera siempre muy cerca de él durante esas dos semanas. Cuando mi hijo, de más o menos la misma edad tuvo un terrible dolor en un brazo una mañana, lo llevamos a que lo viera un pediatra; cuando el médico diagnosticó osteomielitis, lo llevamos a un hospital.

Tal como lo hiciera en cuanto a producción económica, educación y cuidado de sus enfermos, la familia ha cedido sus funciones tradicionales en lo que respecta a preparación religiosa, recreación, crédito financiero, participación política, cuidado de los ancianos y toda una variedad de servicios sociales a diversos expertos o a asociaciones o instituciones sociales. Hace algo más de veinte años Parsons y Bales, al escribir sobre las familias de clase media norteamericanas, extrajeron la

siguiente conclusión: “las funciones básicas e irreducibles de las familias son dos: primero, la socialización primaria de los hijos de manera que ellos puedan llegar a ser realmente miembros de la sociedad en el seno de la cual han nacido; segundo, la estabilización de las personalidades adultas de la población de la sociedad”.

Me pregunto con respecto a la irreductibilidad de esas dos funciones. Toda vez que se desarrollan problemas en el proceso de sociabilización de un niño o en la estabilización de la personalidad de un adulto, cada vez con mayor frecuencia, la familia recurre a un psiquiatra o a un terapeuta especializado en familias y es tan sensato el recurrir a un psiquiatra si un chico es anti-social o un adulto inestable, como lo es utilizar a un profesor capacitado en un colegio secundario o a un médico especializado en un hospital para el cuidado de un miembro de la familia que esté enfermo.

La influencia que tienen estos cambios en el funcionamiento familiar sobre la estructura de la familia ha sido profunda. En pocas palabras, la familia se ha desplazado de una organización orientada en base a su actividad y relativamente no especializada, cuyos miembros estaban unidos entre sí por muchos lazos emanados del cumplimiento de un amplio espectro de tareas, hasta una organización altamente especializada relacionada casi exclusivamente por lazos emocionales o afectivos.

Los lazos emocionales o afectivos por supuesto han actuado para mantener la unidad de las familias de generaciones anteriores y los vínculos derivados de la participación conjunta en las tareas de la familia, funcionan para mantener la unidad de la familia en el presente; pero ha habido un desplazamiento cualitativo y no meramente cuantitativo.

La familia es hoy, virtualmente, la única institución social organizada en torno del amor no calificado, y casi exclusivamente en torno del amor como fuerza de enlace. Esto pone un enorme acento en los lazos familiares. Marido y mujer están unidos sólo por el amor. Ellos pueden optar por organizar actividades compartidas para lograr la subsistencia de sus fami-

lias o, aún, en lo que respecta a sus carreras; pero cada uno de ellos sabe que todo, desde cocinar y limpiar, y hasta hacer el amor, está disponible en la persona de gente especializada y puede encontrarse en la calle o a la vuelta de la esquina. Hasta la exclusividad sexual como fuerza de enlace previamente importante, ya no lo es tanto, y esto ha ocurrido con particular rapidez en los últimos años en virtud de los métodos cada vez más eficaces de anticoncepción.

De manera similar, padres e hijos están unidos sólo por lazos afectivos. Una consecuencia es que simplemente no se hace lugar al hecho de tolerar ambivalencias cuando, por ejemplo, la enfermedad de un hijo interfiere con una carrera o con planes recreativos porque los padres no son los maestros o supervisores laborales o líderes religiosos, o quienes curan o cualquier otra cosa excepto padres que aman y el chico no es ni un estudiante ni aprendiz ni empleado ni futuro protector de los padres en la vejez o cualquier otra cosa, sino un hijo que ama. Y aunque pocos sentimientos son tan angustiantes como el tener que amar a alguien que en un momento particular resentimos, el resultado es que nunca puede reconocerse alguna pérdida o disminución de amor porque cualquier medida de pérdida de amor es una amenaza a la integridad y unión de la familia; simplemente no existe ningún otro lazo que pueda de manera aceptable resolver la falta y mantener la unión de la unidad familiar. Es bastante comprensible que la tasa de divorcio se haya elevado en un 700% en este siglo, de acuerdo con esto un niño de cada seis será fruto de una pareja divorciada.

La familia nuclear como aislada y aislante

Un problema separado pero que tiene cierta relación con lo anterior y que surge de la pérdida de la función familiar es el aislamiento de la familia en el presente. Veo este fenómeno como resultante de la confluencia de cuatro corrientes principales que van a dar al poderoso río de lo que parece ser el cambio irresistible.

Para comenzar, la familia nuclear, que es el modelo en los EE.UU., ha experimentado un rápido debilitamiento de los lazos que existían en las unidades familiares ampliadas o extendidas. Si se me permite recurrir otra vez a un ejemplo personal, mis padres vivían a sólo unas cuadras de sus familiares cercanos, cuando se casaron e instalaron su casa. Cuando mi padre y su hermano descubrieron que su hermana había sobrevivido al holocausto, la trajeron con toda su familia a EE.UU. desde un campo de refugiados y la instalaron en el mismo edificio en que vivían mis padres. En cuanto a mi generación, mi esposa y yo dedicamos poca atención a la idea de mudarnos a una zona diferente del país, en busca de lo que podríamos juzgar una oportunidad más deseable de preparación; y podría no habérsele ocurrido en absoluto a nuestros hijos el considerar las distancias que los alejarían de nosotros o de sus hermanos cuando llegaron al momento de decidir dónde instalarse.

El valor de adaptación de una red familiar firmemente unida es bastante claro en términos de la seguridad que puede ofrecer cada unidad familiar y en términos de la disponibilidad de adultos que no sean los padres para cuidar a los niños. Las ventajas de adaptación de la familia nuclear e individualista en una sociedad urbana industrializada son sin embargo, menos claras y están rígidamente circunscriptas, especialmente si las comparamos o contemplamos con el segundo factor aislante que quiero mencionar, nuestra extraordinaria movilidad.

Cada año cuarenta millones de norteamericanos —12.000.000 de familias o 20% de la población— se mudan.

El censo de 1970 reveló que la mitad de la población vivía en un domicilio diferente del que había tenido cinco años antes.

El mudarse, por supuesto impone a las familias muchas tensiones. Quiero hablar especialmente sobre el efecto o resultado aislante que indefectiblemente supone el mudarse. Debo de haber tenido nueve o diez años cuando me dí cuenta de que la familia vecina a quienes yo llamaba tío y tía no eran familiares unidos a nosotros por lazos sanguíneos sino sólo vecinos; pero

lo habían sido durante quince años. Hace cuatro años que mi mujer y yo vivimos en el mismo departamento y no creo que hayamos intercambiado cincuenta palabras con nuestros vecinos, y tampoco creo poder reconocer a la mayor parte de las personas que ocupan los otros ocho departamentos que hay en nuestro piso. No hemos sido vecinos por largo tiempo y es muy posible que no lo seamos por mucho tiempo más.

En la mayoría de los casos el hecho de mudarse está asociado con el deseo de obtener mejores o por lo menos diferentes oportunidades de trabajo. El dilema que afronta una familia puede por cierto ser doloroso cuando el padre o con menos frecuencia la madre, tiene el ofrecimiento de escalar posiciones en una ubicación diferente, algunas veces bastante distante, y una mudanza significaría la interrupción de la vida escolar y social de los hijos, la separación del padre y la madre de su núcleo de amigos y la venta de la casa o el levantar un departamento que constituya el hogar. Alvin Toffler, el autor de *Future Shock*, sugiere una desviada solución a este dilema. ¿Por qué no instalar un servicio de computadora —muy parecido a algunos servicios comunes de computadora que reúnen las preferencias y cualidades de hombres y mujeres que tienen interés de encontrar seres compatibles— y hacer una lista con todas las variables familiares esenciales: edad, altura y aspecto general de la mujer; número, sexo y edad de los chicos; tamaño de la casa, etc.? Entonces, si un hombre necesita mudarse para “adelantar”, puede consultar a la computadora y encontrar una familia estrechamente parecida a la suya con una “vacante” para el padre, y que viva cerca de su nuevo empleo y mudarse para ocupar él esa “vacante” sin arrancar a su propia familia de las raíces que han desarrollado.

El mundo del trabajo ejerce aún un tercer tipo de presión aislante sobre las familias por cuanto las áreas residenciales y las laborales están separadas (separación celosamente instituida por las leyes que demarcan zonas) e, inextricablemente entrelazadas con esto último, las exigencias del tiempo que recaen sobre los padres de clase media que aspiran profundamente al progreso. Para lograr seguridad y status, pasamos nuestro tiempo

conmutando, o sea cambiando, satisfaciendo obligaciones sociales y comunitarias, trabajando horas extras, durante los almuerzos, a la noche, los fines de semana; pasamos mucho tiempo en viajes de negocios y en todo tipo de cosas relacionadas con el trabajo, pero no con nuestra familia.

Urie Bronfenbrenner se ha referido en un reciente estudio a una experiencia; se sujetaron micrófonos a las ropas de bebés de un año de una comunidad o grupo de clase media. Pudo comprobarse que “los padres pasaban relativamente poco tiempo interactuando con sus hijos. El número más bajo de interacciones fue de 2.7 y el número promedio de segundos por día fue de 37.7”. Hubo una época en que los hijos veían a sus padres cumplir con su trabajo y compartían esos trabajos. Hoy, como ya he dicho, los hijos tienen sólo una vaga idea sobre qué es lo que hacen sus padres. Ven menos a sus padres y saben menos respecto de ellos y esta tendencia no muestra signos de variar.

El cuarto factor que contribuye al impacto de aislamiento de la familia por sus miembros es la incesante entrada de la mujer en la vida laboral. Hoy un 60% de esposas con hijos, trabajan; un tercio de todas las mujeres con niños de seis años, trabajan. Al mismo tiempo, la presencia de otro adulto en la casa, que podría cuidar a los chicos, ha disminuido. Hace cincuenta años, la mitad de las familias contaban entre sus miembros por lo menos con un adulto además de los padres; hoy la cifra es de 4%.

Además de las observaciones que ya he hecho respecto de la familia nuclear, desposeída de ciertas condiciones y funciones, hartamente individualista, que reduce la disponibilidad de familiares cercanos o buenos amigos y el número creciente de madres que trabajan, existe el hecho de la gran utilización de servicios que prestan ciertas instituciones burocráticas para reemplazar a la familia y la principal de ellas es por supuesto, el centro de cuidado diurno. Entre 1965 y 1970 se duplicó la afluencia de niños a los centros de cuidado diurno y, aunque éstos no gozan en los Estados Unidos de la misma aceptación

que, por ejemplo, en Europa Occidental, la demanda, continúa excediendo en mucho a la oferta.

La relación entre la condición psicológica resumida bajo la palabra "alienación" y las fuerzas que tienden a aislar a las familias nucleares, y, más aún a aislar a un progenitor de su pareja y a ambos de sus hijos, se hace inmediatamente evidente. El tema no es nuevo —Camus, Sartre, Dostoievski, Kafka, los poetas "beat", el "teatro del absurdo", en tanto reflejos de la condición humana, durante años han llamado con insistencia nuestra atención sobre el tema desgarrante de la soledad del hombre. Lo que es nuevo es la amplitud, el alcance de las manifestaciones de alienación —el sentimiento de impotencia para configurar nuestro propio destino; la sensación de total apartamiento que está invariablemente acompañada, de un lado por ataques a la estructura social y sus valores y del otro lado, paradójicamente, por la necesidad de reducir la sensación de auto-enajenación causada por la preocupación que tenemos sobre los efectos de nuestro comportamiento en los otros y, por ende, la necesidad de adecuarnos a los mismos valores que tenemos que atacar.

Ineficacia de la familia contemporánea

He sugerido más arriba que la información que refleja el grado de desorganización familiar y la importancia del hecho de la imposibilidad de la familia para integrar sus miembros a la sociedad son alarmantes. Hago referencia ahora a algunos índices que constituyen para mí, evidencia de la ineficacia de la familia. Muchos de ellos son bastantes conocidos —tasas de deserción escolar (alrededor del 11% en los últimos tres años), tasas de uso indiscriminado de drogas, tasas de delincuencia juvenil (35% de los 9.945 varones nacidos en Filadelfia en 1945 es decir 29% de los varones blancos y 50% de los negros—tenían por lo menos un arresto en su haber y habían sido rotulados "delincuentes" a los 18 años), tasas de divorcio —en 1974 se registró un divorcio por cada 2.35 matrimonios— todas estas cifras siguen subiendo y todas hablan con elocuencia del

fracaso de la familia en socializar a los hijos y en lograr estabilizar las personalidades adultas.

Me gustaría traer algunos índices menos conocidos aunque de alguna manera más significativos en cuanto a su connotación negativa. El incremento de divorcios se acompaña ahora de un nuevo fenómeno, la negativa o la falta de disposición de padre y madre para hacerse cargo de los hijos. Tampoco esperan en todos los casos al divorcio, cada vez más mujeres casadas, madres, faltan de sus hogares, tal como se constata en los registros policiales, y ha habido una verdadera explosión en el negocio de la actividad de pesquisa privada, financiada por los padres, que dejados a cargo de sus chicos, trataban de hallar a sus esposas que habían hecho abandono del hogar. El New York Times el 20 de marzo de 1977, publicó un estudio basado en observaciones hechas sobre 2.143 parejas casadas, seleccionadas para representar un muestreo demográfico de familias norteamericanas... "los progenitores pegan o golpean 1.7 millones de chicos por año, causan severos daños a otros 750.000 y atacan a 46.000 con revólveres o cuchillos... 2.3 millones de chicos han dirigido un cuchillo o revólver contra un hermano o una hermana... Todas las familias entrevistadas estaban completas. La violencia no estaba de ninguna manera referida a las personas mentalmente enfermas, se producía en norteamericanos comunes, aparentemente normales y tenía lugar con tanta frecuencia entre las personas educadas y con conocimientos, como entre aquellos que no los tenían".

La tasa de suicidios en chicos de 10 a 14 años se ha duplicado y en chicos —adolescentes— de 15 a 19 se ha triplicado en los últimos veinte años. Aún mayores son las cifras de abusos cometidos contra los niños, incluyendo muertes de bebés de menos de un año, registrados en las últimas dos décadas. Un estudio realizado en 1970 de más de 1.300 familias, indicó que la tasa de infanticidios había casi duplicado la de la década precedente. Podemos esperar que se informe sobre 2 a 4 millones de chicos "apaleados" en este año, 1.500 morirán y 15.000 sufrirán daño cerebral permanente. Nada se sabrá sobre otro número incontable de casos.

Algunas informaciones recientes sugieren que el matrimonio y el tener hijos están perdiendo —como instituciones— parte de la popularidad de que gozaban. La probabilidad de que una mujer contraiga su primer matrimonio entre los 18 y los 22 años ha declinado en más de un 10% en los últimos 5 años. El 28% de las mujeres de 20 a 24 años eran solteras en 1960, en ese mismo grupo en 1970 hay un 40% de solteras. Y usando la medida estadística standard de fertilidad —Tasa del Período de Fertilidad Total, Ryder y Glick independientemente señalan que la tasa de fertilidad había declinado desde 3.8 en 1957 hasta 1.9 en 1973. (La Tasa del Período de Fertilidad Total es la suma de todas las tasas de nacimientos calculadas tomando en cuenta mujeres en cualquier edad durante los años en que pueden concebir y tomando en cuenta un momento —o período, o fecha— que interesa en particular. Esta tasa representa el promedio de nacimientos que una mujer tendría en su vida si continuara teniendo hijos durante todos los años en que pudiese concebir dentro de la misma proporción en que otras mujeres en edad de concebir tuvieron sus niños dentro del período que se está estudiando.)

El Departamento de Recursos Humanos del Distrito de Columbia, anunció el 31 de agosto de 1977 que en 1966, el número de abortos legales en Washington fue un tercio más alto que el número de nacimientos. Ryder afirma “concluyo que la tasa de fertilidad general es ahora más baja que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos”. La única excepción está en el grupo de 12 a 19 años de edad, estas mujeres, o niñas, la mitad de las cuales no están casadas, son responsables del 21% de todos los nacimientos que tienen lugar en los Estados Unidos; los embarazos entre las adolescentes se incrementaron en un 33% entre 1971 y 1976.

Orígenes socioculturales de los cambios en la vida familiar

Los datos que he ofrecido dejan pocas dudas en cuanto que el funcionamiento de las familias contemporáneas es deficiente, pero quisiera sugerir precaución en cuanto a extraer

como conclusión que la familia como institución sea defectuosa. Por cierto, quisiera creerlo, entonces todo sería relativamente simple o a lo sumo, un tanto difícil pero manejable, en este caso se podrían proponer cambios en lo que respecta a formación de la familia y desarrollo familiar y con eso corregiríamos las faltas que advertiésemos.

Glick por ejemplo, cierra su extraordinariamente avanzado análisis demográfico de cambios recientes en las familias norteamericanas con una lista de seis sugerencias que los diversos especialistas en familias preocupados por la situación “estarían muy acertados en tomar en cuenta”. Esa lista incluye, primero “una preparación más eficaz en el hogar, en los colegios secundarios y en las universidades respecto de cómo los jóvenes pueden realizar una elección inteligente de su pareja para casarse”; segundo “designar, crear un sistema científicamente probado para seleccionar pareja con fines de matrimonio”; tercero, “periódicas revisiones de la pareja que ha contraído matrimonio en el curso de visitas a consejeros matrimoniales que tengan un alto grado de idoneidad en la materia”; cuarto, “modernización de las leyes de casamiento y divorcio”; quinto: “desarrollo de condiciones e instalaciones para el cuidado de los hijos con personal profesional de alta capacitación de manera que un mayor número de madres puedan sentirse libres para maximizar las alternativas disponibles para el empleo de su tiempo” y sexto: “finalmente, programas para incrementar el deseo de experimentar lo que es un buen matrimonio... de manera que pueda colocarse mayor énfasis en las facetas positivas de la vida matrimonial, en un período en que tantos estímulos... tienen como resultado el hacer aparecer como mucho más deseable el no casarse.”

La “falla” sin embargo, no radica en la forma “no científica” con que elegimos nuestras parejas o en la poca popularidad que goza el matrimonio. La familia es una institución social y en sus propias dislocaciones y tensiones refleja con sensibilidad exquisita las desubicaciones y tensiones de la sociedad y de la cultura. Maurice Levine comprendió esto muy bien. En su trabajo “Comentarios Psicoanalíticos sobre Planeamiento Comu-

nitario" escribió: "Nuestro concepto de la Familia debe incluir el hecho que en nuestra civilización actual, las hostilidades inconscientes más importantes tienen lugar en la vida familiar". Jules Henry fue aún más claro en *Pathways to Madness* (Camino de Locura): "La familia... es... el lugar donde la patología general de la cultura se incuba, se concentra y finalmente se transmite en forma de psicosis individual. La terapia familiar es algo bueno y la "dinámica familiar" es una teoría válida, pero recordemos que la familia simplemente destila en dosis letal aquello que existe en la cultura en general".

El tipo de pensamiento simplista y lineal, que ignora la compleja interacción de individuo, familia y sistemas sociales y ofrece consejo marital para problemas maritales, o programas de drogas para problemas de drogas, ofrece poca ayuda para la familia contemporánea. Es difícil para aquellos de nosotros que hemos crecido en medio de información transmitida principalmente por el trabajo impreso lineal, tradicional, autoritario e intelectualizado el aprehender el impacto audio-visual emocionalmente significativo, gráfico e inmediato de la información televisada respecto de la organización y funcionamiento del aparato mental.

Margaret Mead ha acuñado una frase feliz "sociedad post-figurativa" para describir el hecho que vivimos en una época de tan rápido cambio social que nosotros los adultos aprendemos más de nuestros chicos y de sus pares que lo que ellos lo hacen de nosotros y, tengamos en cuenta que tienen mucha menos edad. Muchas personas de mi generación han vivido una transición en algún momento de su adolescencia, desde una relación en la que podíamos recabar información en nuestros padres, hasta —hablamos de la transición— una en que la información llegaba a nosotros especialmente por vía de nuestros hijos. Como padres estuvimos a nuestra vez en contacto con lo que era importante en el mundo de nuestros hijos en un momento mucho más temprano de sus vidas.

Me acuerdo muy especialmente de una clara experiencia. Nuestra hija cuando tenía 8 años bailaba en la American Ballet

Company y tuvo que desempeñar el papel de uno de los niños en la producción anual de Balanchine de Cascanueces. Después del primer ensayo en el que intervinieron chicos y grandes, volvió a casa muy entusiasmada con el hombre que era su "padre" en el ballet. Nos contó cuánto la había ayudado él y después preguntó con amaneramientos exagerados en su gestos y voz ¿porqué habla él de una forma tan diferente? Nos sentimos sofocados y no supimos qué decir. Pocos días más tarde, durante un ensayo en el que estuvimos presentes mi esposa y yo, nuestra hija y una amiguita se sentaron directamente en frente de nosotros durante el descanso y escuchamos que le decía a su amiga respecto de alguien "Oh, no, estoy segura de que él es normal". Nuestra primera reacción fue de alivio —estábamos fuera del compromiso— pero inmediatamente después tuvimos un momento de pánico durante el cual nos preguntamos "¿Qué más sabe ella?".

No todos los ejemplos que pueden citarse respecto de la brecha entre padres pre-electrónicos y sus hijos post-electrónicos son humorísticos o inocentes. Un reciente estudio sobre jóvenes norteamericanos que abandonaron el sistema y eligieron la isla de Maui —los autores del estudio son Monsour y Davis— reveló que la mayor parte de ellos provenían de hogares intactos— padre y madre de clase media y que ni aceptaban ni se sentían aceptados por sus padres. Ellos no provenían de los confines ni de las áreas marginadas de la sociedad. No eran producto de la pobreza ni de una sub-cultura racial. Provenían de familias tipo de clase media, hijos e hijas de altos empleados, médicos, abogados, dentistas, ingenieros, hombres de negocios, ejecutivos, dueños de comercios.

Por otra parte los datos obtenidos por los tests de personalidad que se les hicieron no los señalaron como significativamente diferentes de la población que no había abandonado el sistema y que estaba en sus escuelas y empleos habituales. Y si hubiera que encontrar una única palabra para involucrar lo que estos jóvenes estaban buscando, ésta sería "personalización": Todos los valores —vocacional, político, religioso, social— respecto de los cuales disentían en un todo con sus padres tenían

que ver fundamentalmente con la substitución de metas y prioridades personales por otras socialmente deseables.

Una de las tareas con la que me enfrento con mayor frecuencia en clínica es la de responder a las quejas de padres cuyos hijos han entrado en un estilo de vida que los padres encuentran "enfermo" (sick). Invariablemente me hacen estas dos preguntas: ¿Qué fue lo que hicimos mal? y ¿Cómo podemos arreglar las cosas? Algunas veces hay cosas que han estado "mal" y que son identificables en términos de vida familiar y frecuentemente pueden corregirse. Pero es igualmente frecuente que lo que está "mal" sea la incapacidad de los padres para aceptar la moratoria que sus chicos han declarado, el esfuerzo que esos chicos están realizando para definir quiénes son o qué es lo que quieren, antes de seguir las huellas de sus padres a quienes aman pero cuyas vidas son para ellos conducidas, presionadas y vacías de satisfacción y de significado.

Esta lucha entablada a lo largo de la brecha generacional puede alcanzar proporciones muy indeseables. Nuestros hijos atacan nuestros valores y con poca frecuencia, nuestros símbolos estructurales, edificios, oficinas o bibliotecas. Nosotros los atacamos a ellos; por ejemplo muchos de ustedes recordarán haber escuchado decir a ese padre tan circunspecto durante una transmisión de la red televisiva nacional, y a la cabeza del movimiento antibélico, que él preferiría matar a su hijo antes que verlo destruir la bandera de nuestro país.

Quisiera enfocar otra vez el tema central que he tratado de explicar, que las fuerzas que forman la estructura y que conforman el funcionamiento de la familia contemporánea surgen principalmente en medio de un rápido cambio social. La industrialización y el desarrollo tecnológico han llevado a gigantescas asociaciones a extenderse por todo el país y aún por todo el mundo y la familia ha cesado totalmente de ser una unidad significativa de producción económica en nuestro país. La lealtad a las asociaciones se ha tornado de igual importancia —sino de mayor importancia— que la lealtad familiar como determinante del comportamiento; para muchos

se ha tornado más importante ser miembro de General Motors o de Exxon que de una determinada familia.

Repetimos, en otro área de cambio social, las mujeres comienzan a cuestionar su posición histórica en tanto subordinadas al hombre, y hemos sólo comenzado a ver las implicancias del movimiento de liberación femenina en la vida familiar. Otro impacto cuyas dimensiones aún no se conocen muy bien es el que causa la esposa que trabaja sobre la relación marido-mujer. La mujer que trabaja tiende a establecer una relación más simétrica con su marido y la ideología en familias en que se ejercen dos carreras comienza a poner el acento en la igualdad de oportunidades, casi con certeza, en base a una erosión de la estabilidad de parejas de rol segregado. Yo no cuestiono el papel desempeñado en la alta tasa de divorcios por la creciente aceptación social del divorcio y de la mayor disponibilidad de asistencia legal no paga, unido esto a la existencia de parejas que pueden solventar asistencia legal en jurisdicciones de divorcio "no culpable" o que no implica faltas en la pareja, pero pienso que todos estos elementos son mucho menos importantes que el rol desempeñado por el creciente número de jóvenes esposas con mayor preparación, empleos mejor pagados que las hacen económicamente independientes de sus maridos y una "elevada conscientización" respecto de sí mismas como mujeres en una sociedad sexista, que no se sientan presionadas a permanecer dentro de un matrimonio que no las satisface. Es en este contexto de interés que notamos que en 1974 hubo 907 divorcios entre 1.602 matrimonios —un divorcio por cada 1.8 matrimonios— pero una investigación demostró que en el momento en que fueron entrevistadas, 97,2% de la gente casada dijo que su matrimonio era "muy feliz" o "bastante feliz".

En otra área aún de cambio social, las ciudades crecen en tamaño y las exigencias de diversos servicios que cumplen las familias alcanzan una dimensión crítica y se tornan suficientes para apoyar una unidad de servicios profesionales, de manera que más funciones familiares aún son cedidas a otras entidades.

Lo que quiero destacar es que "las fuerzas que producen la

presión que lleva a la reducción de las funciones familiares y al incremento del aislamiento familiar son externas a la familia". Nadie está en falta. Y no veo ningún camino o forma apropiados para interrumpir o invertir las direcciones del cambio social.

La familia de mañana

De acuerdo con mi opinión personal es inevitable que las familias y la vida familiar, tal como las conocemos hoy, enfrentadas con las presiones crecientes e ineludibles que han producido ya tanta desorganización visible, deben dejar lugar a algunas nuevas unidades sociales. Puede ser, por supuesto, que yo sea una víctima de mi profesión y que porque veo tantas familias desorganizadas en mi consultorio, piense que todas lo son. Pero no creo que ese sea el caso.

Beels anotaba recientemente que la familia ha cambiado de un lugar caracterizado por el intercambio de claras obligaciones entre los sexos y entre las generaciones a un lugar —o situación— en que un grupo de personas viven juntas para lograr el desarrollo y bienestar emocional de los diferentes miembros que la forman. Todavía llamamos a esta unidad social que ha cambiado "familia" y si continuamos utilizando la palabra "familia" para cualesquiera de las unidades que evolucionen en el futuro, entonces, por supuesto algo llamado "familia" va a seguir existiendo. Pero sería mejor que confrontáramos la realidad y advirtiéramos que la "familia" de hoy no está suministrando los elementos adecuados para el "bienestar emocional" o la "estabilización de la personalidad" de un gran número de sus miembros adultos y está fallando seriamente en la tarea de integrar números cada vez más significativos de niños a la sociedad. Continúa en el presente suministrando lo necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría de los adultos y de los niños pero, pienso que sólo de manera marginal, y la tasa de incremento en los índices de desorganización familiar crece en progresión geométrica y no aritmética.

La unidad nuclear —madre, padre e hijos— es biológicamente indispensable, pero parece ser socialmente impracticable. Y

los procesos de cambio social que han llevado a la desorganización de la vida familiar tradicional continúan reduciendo aceleradamente la interdependencia de los miembros de la familia, reduciendo el lazo que mantiene unida a la familia por elementos emocionales, alejando un sexo del otro y una generación de la otra y, ubicando a los padres en una familia núcleo que es cada vez menos capaz de socializar a sus hijos.

No me tomaría el trabajo de dilucidar qué tipos de unidades sociales emergerán o cuándo ocurrirá esto; tal vez no ocurra hasta que el mundo se quede sin comida o combustible, cualquiera de estas carencias sea la que nos sobrevenga primero. Tal vez, alguna forma similar al Kibbutz, aunque originalmente creado para propósitos bien diferentes, constituya un elemento correctivo de las limitaciones de la familia de hoy. Los propósitos de los cuales tenemos noticia frecuentemente de extender la educación obligatoria hasta las escuelas llamadas guarderías que reciben chiquitos de tres años, apuntan en esa dirección, al igual que la decisión reciente del HUD de construir departamentos de bajo costo con dormitorios infantiles en los que podrán tener cabida las madres que trabajen.

Soy un empecinado optimista aunque no lo haya parecido. Mi fe inquebrantable reside en el hecho que existe suficiente inteligencia y amor en tantos de nuestros hijos como para que continúe existiendo suficiente inteligencia y amor en sus hijos y en las generaciones por venir como para garantizar soluciones viables a problemas que ahora parecen insolubles. No importa cuán alejadas esas soluciones puedan estar de la familia tal como la conocemos hoy, creo que una cantidad suficiente de nuestros hijos tienen la integridad, el coraje, el sentido común y la flexibilidad necesarios para crear los tipos de formas sociales que necesitarán para dominar el mundo que les dejamos, y para hacerlo según su propia manera. Y mientras tanto, aquellos de nosotros que trabajamos con familias o que capacitamos a trabajadores especializados en familias ya sea dentro del contexto médico o no, si vamos a acatar el pensamiento hipocrático fundamental: "Primero, no hacer daño" haremos bien en respetar la vulnerabilidad de la familia contemporánea.

THE American Journal of Family Therapy

● RECONCILING FEMINIST
AND FAMILY SYSTEMS
THERAPIES

● TALK ABOUT A PAST
RELATIONSHIP
PARTNER

● RELATIONSHIP ENHANCEMENT
WITH PREMARITAL
COUPLES

● INTERVIEW WITH
MARA SELVINI PALAZZOLI
AND GIULIANA PRATA

● COMPARING BEHAVIORAL
AND SYSTEMS FAMILY
THERAPIES

● UNILATERAL FAMILY
THERAPY FOR
ALCOHOL ABUSE

● SEXUAL AND MARITAL
DEFENSIVENESS
SCALES

● BOOK REVIEWS

● JOURNAL FILE

● RESEARCH & CLINICAL EXCHANGE



BRUNNER MAZEL Publishers

The American Journal of Family Therapy, formerly the *International Journal of Family Counseling*, is published quarterly by Brunner/Mazel, Inc., 19 Union Square West, New York, NY 10003. Application to mail at second-class postage rates is pending at New York, NY, and at additional mailing offices.

Address all correspondence regarding subscriptions, back issues and bulk sales to: Helen Mack, Brunner/Mazel, Inc., 19 Union Square West, New York, NY 10003. *Subscription rates:* individuals \$22/1 year; institutions \$36/1 year; outside the United States add \$4.00. Back issue rates on request. Make checks payable to Brunner/Mazel, Inc.

Address all advertising correspondence to: Alice Weisman, Brunner/Mazel, Inc., Box 419, Larchmont, NY 10538.

"La familia y los problemas psicosociales"

Hacia la atención de la familia, un problema, un camino

Dr. RAYMUNDO MACIAS AVILES

Asesor en Psiquiatría y Salud Mental del I.M.S.S. Director del Instituto de la Familia, A.C. Fuego 143, Jardines del Pedregal, Distrito Federal, México.

Tratar el problema de la Salud Mental de la Familia en América nos enfrenta a la necesidad de considerar la factibilidad de un enfoque conjunto o un manejo particular del problema en cada uno de los países, o en sectores de población limitados dentro de este ámbito universal. Esto estaría fundamentalmente señalado por las semejanzas y las diferencias de la problemática que encontráramos entre los distintos países y aun entre las diversas localidades de un mismo país.

No podemos desconocer, que la problemática de salud mental de la familia así como los servicios para su atención en cantidad y calidad se encuentran en íntima relación con el desarrollo socioeconómico de cada lugar, de cada Institución y nos encontramos en la América Latina en particular con un verdadero mosaico en el que se distinguen diferentes niveles de desarrollo entre diversos países y aun dentro del mismo país distintos grados de desarrollo socioeconómico entre las regiones del mismo y aun en una localidad entre diversos sectores de la población.

De aquí, el reconocimiento de la naturaleza y la participación de los factores económico-sociales y culturales del subdesarrollo en el condicionamiento de la patología, que es más evidente en lo referente a la patología somática, por ejemplo la presencia de carencias nutricionales, enfermedades infecciosas, etc., y se establece el principio de un círculo vicioso de miseria y enfermedad; la pobreza genera en ellos condiciones insalubres y patrones culturales indeseables, sin embargo, al nivel de Salud Mental, si bien existe un reconocimiento de esta situación, no existen estudios suficientemente confiables para definir en forma detallada la influencia de estos factores en la patología mental y en especial en las diferencias familiares.

Es preciso pues enfatizar que esta condición de pobre desarrollo socioeconómico redunda por otra parte en la presencia de servicios insuficientes, donde las iniciativas de acción de salud mental son incipientes y a veces de pobre calidad por la escasez de recursos. Consideramos por lo tanto indispensable tomar en cuenta esta situación básica en el planteamiento de cualquier programa de salud.

En forma semejante los datos que tenemos son más bien sobre epidemiología psiquiátrica y se derivan fundamentalmente de encuestas respecto a la prevalencia de los trastornos mentales y carecemos actualmente de estudios suficientes sobre su incidencia.

Por otra parte dentro de algunos estudios limitados en ámbito geográfico en la experiencia piloto particular del programa del Centro Comunitario de Salud Mental, de la Zona IV del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el análisis de resultados de consulta de un año (1976) nos encontramos que la prevalencia de trastornos que motivan la solicitud de consulta psiquiátrica entre la población derechohabiente en una zona urbana de la ciudad de México nos indica un alto número de *problemas infantiles* (42,2%), en cuanto a trastornos emocionales casi siempre reactivos a alteraciones en la dinámica familiar y trastornos de conducta y aprendizaje secundarios a disfunciones cerebrales e inmadurez del sistema nervioso central, debidas a factores perinatales en donde los factores socioculturales

inciden en forma significativa constituyendo indicadores básicos para la planificación posterior de programas de Salud Mental.

Así un programa específico tiene que cumplir con objetivos tanto asistenciales como preventivo-promocionales y de enseñanza e investigación.

Otros elementos en común que podemos *considerar* dentro de nuestros países de ascendencia latina es la importancia que aún tiene la familia en el desarrollo de patrones de conducta y de niveles de salud mental entre sus miembros. Los cambios debidos fundamentalmente al desarrollo industrial, a la migración del campo a la ciudad y al problema de urbanización y sobrepoblación en las grandes ciudades particularmente afectan de manera especial no solamente a las gentes que habitan los cinturones de miseria o zonas marginadas al desarrollo de la gran urbe, sino en general a la totalidad de la población urbana; y hacemos mención a esta situación porque la mayor parte de las experiencias de programas de esta naturaleza han sido desarrolladas en zonas urbanas. Esto ha influido extraordinariamente en cambios de los modelos familiares, donde el modelo de "familia extensa" que prevalecía entre el medio rural con una gran tolerancia para el enfermo mental y con apoyo para las funciones sociales de la familia en un sentido más amplio, encontramos que se sustituye por el modelo de "familia nuclear" en las zonas urbanas, cuyos miembros particularmente trabajan y van a la escuela ocurriendo en ocasiones que existe imposibilidad de atender a pacientes en el seno de la familia y a veces un mayor grado de intolerancia para el mismo.

En ocasiones en zonas de bajo desarrollo económico, no solamente ocurre esto sino que aún la familia nuclear no se encuentra perfectamente bien integrada, por la ausencia de la figura paterna; en estas circunstancias el impacto sobre la salud mental de sus integrantes es extraordinario manteniéndose un equilibrio inestable o con franco desequilibrio, resultando los más afectados los menores de tal célula social, con riesgos de desarrollo posterior de trastornos más importantes dada la condición de abandono emocional en que viven con frecuencia.

Por otro lado se ha venido aceptando comúnmente que entender la patología de un enfermo desde un punto de vista integral implica entender la dinámica de la familia en su totalidad y entender el equilibrio del núcleo familiar. La experiencia nos permite saber que con frecuencia los pacientes significan un balance para el resto de la familia y al alterarse su condición puede surgir un desbalance en otro miembro de la familia y los roles de enfermo y sano son con frecuencia mutuamente reforzantes con beneficios secundarios para ambos.

Derivado de esto consideramos que un enfoque familiar, para el tratamiento, las actividades preventivas y consecuentemente también promocionales, así como para los aspectos de enseñanza e investigación resulta de importancia extraordinaria por dos razones:

1) Por la utilización de todos los recursos positivos de un núcleo familiar en el restablecimiento de un equilibrio individual y colectivo de mejor funcionamiento, así como la acción terapéutica y preventiva dada a un nivel colectivo, a un mayor número de personas que mutuamente pueden ser beneficiadas por este enfoque.

2) Siendo nuestra tradición médica de enseñanza de un enfoque esencialmente individual es preciso que tanto el personal de psiquiatría y salud mental, como el personal de salud que sirva en general de apoyo a los programas de esta naturaleza pueda tener nociones importantes sobre un enfoque familiar conjunto.

Un enfoque familiar en un sistema de seguridad social

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una Institución descentralizada que integra el complejo sistema de prestaciones económicas, sociales y que cubre a casi la totalidad de la población trabajadora organizada del país y a sus beneficiarios.

Dentro de este sistema el ejercicio de las prestaciones médicas en su sentido más amplio, o sea la práctica de la medicina general, está a cargo de los llamados médicos familiares, cuya función principal es la de brindar la atención corres-

pondiente a los derechohabientes dentro del más alto nivel técnico y humano posible.

El ejercicio de la medicina institucional, en sus niveles colectivos e individuales, es así conceptualizado como el conjunto de acciones coordinadas dentro de un sistema cuyo eje central lo constituye la medicina general, al que se integran las actividades que realizan en su caso los especialistas y las facilidades de hospitalización para los pacientes que así lo requieran. El médico familiar, con conocimientos amplios de la medicina general moderna y adecuada información de las especialidades, se ve complementado en sus funciones por la acción consultante del especialista, el que cuenta con mayor preparación para valorar y plantear soluciones a problemas específicos y dispone para ello de mayores recursos, en centros médicos de concentración.

Dentro de esa estructura, el médico familiar tiene la posibilidad de atender un volumen determinado de pacientes (aproximadamente 2.400 derechohabientes por médico, o sea de 400 a 500 familias) lo que le daría la oportunidad de adentrarse en la constitución familiar, así como en la de trabajo y la comunitaria, facilitándole esto una mejor comprensión de los fenómenos que causan alteraciones tendientes a alterar la salud.

Dentro de este marco haremos referencia a la forma en que el Programa de Salud Mental del IMSS plantea su coordinación con el programa general de prestaciones médicas de la institución y brinda el apoyo, la información y la sensibilidad adecuada para sus actividades generales, así como los recursos para la atención especializada en esta área, conforme a los siguientes objetivos:

- 1) La atención de pacientes psiquiátricos.
- 2) La prevención en distintos niveles de problemas psico-emocionales.
- 3) La promoción de la salud mental, a nivel individual, familiar y comunitario.
- 4) Información y educación en el campo de la psiquiatría y

la salud mental, a los diferentes niveles de servicio como al público en general.

5) Investigación básica, clínica, epidemiológica y psicosocial en esta área.

A continuación haremos referencia a los distintos niveles de recursos que se consideran precisos para llevar a cabo las acciones o actividades necesarias, para cumplir con los objetivos enunciados, haciendo referencia en especial a la aplicación del programa en el Distrito Federal y Valle de México. En este ámbito operan en la actualidad 56 clínicas distribuidas en dos regiones: norte y sur, y cada una de estas regiones se divide a su vez en tres zonas. De estas 56 clínicas, cuentan con servicios de hospitalización general, además de los recursos de dos grandes Centros Médicos con servicios de hospitalización especializada y otras 4 unidades especiales de gineco-obstetricia. La población derechohabiente está adscrita a una clínica, correspondiente a la zona donde viven, en donde se ofrecen los servicios de medicina familiar general y de especialidades a un primer nivel (contacto primario), para un área geográfica bien definida con un volumen de población adscrita que fluctúa entre cincuenta y cien mil derechohabientes y beneficiarios según la ubicación de la clínica. Para la atención especializada a un nivel más complejo de recursos, los pacientes son canalizados para su atención correspondiente a las unidades de concentración mencionadas. De este modo el régimen de seguridad social protege aproximadamente a 5.742.429 personas en el área del Distrito Federal y Valle de México del total de la población derechohabiente incorporada al sistema, cercano a los 17.000.000 de derechohabientes (cifras al 30-11-76, Asesoría Técnico Administrativa, Jefatura de Planeación y Supervisión Médica, IMSS).

En base a esto los diferentes niveles de recursos que se han considerado para el desarrollo del programa de salud mental del I.M.S.S. en el Distrito Federal y Valle de México, son:

a) Como recursos generales de contacto primario se consideran un equipo de salud mental constituido por un psiquiatra, un psicólogo y una trabajadora social, a nivel de clínicas en

cada unidad de 80 a 120 mil derechohabientes. Se encuentran operando ya en 12 de estas clínicas y se irán implementando en forma progresiva en las restantes programadas con actividades integradas en el programa de Unidad.

b) A nivel de recursos intermedios de contacto secundario está programada la creación de Centros de Salud Mental. Con ubicación física flexible, con actividades selectivas y de programas especiales, integrada a programas de zona.

Uno en cada una de las seis zonas en que están divididos los servicios médicos del Distrito Federal y Valle de México, y los que contarán con varios equipos de salud mental, a los que incorporarán a nivel programático de intervención enfermeras, terapeutas y otro personal profesional en formación. Estos equipos coordinados con los de las Clínicas tendrán bajo su responsabilidades las actividades del Programa en la zona correspondiente. El primer Centro está funcionando en la Zona IV.

c) Finalmente como recursos especiales para la atención psiquiátrica hospitalaria, fundamentalmente, se considera los servicios de psiquiatría en cada uno de los dos Centros Médicos y un nuevo hospital psiquiátrico de concentración con capacidad para 350 pacientes, cuyo funcionamiento estará integrado al programa regional.

Frente a la realidad de las grandes necesidades de servicios en el presente, para satisfacer adecuadamente las demandas de una población creciente es preciso considerar la óptima utilización de los elementos actuales dentro del sistema y la implantación progresiva de los nuevos recursos necesarios, dentro de las limitaciones que prevalecen en un país en vías de desarrollo.

Es por esto que se proponen distintos niveles de atención familiar, en función de los niveles de acción terapéutica que sean necesarios en un momento dado y que se pueden ofrecer realmente dentro de la Institución.

a) Un primer nivel de comprensión dinámica general de la familia, de apoyo psicoterapéutico y de orientación, podría ser atendido por los propios médicos familiares del sistema y/o las trabajadoras sociales de las clínicas de adscripción, para ello es indispensable que este personal sea adecuado, sensibilizado y

entrenado adecuadamente para esta actividad del programa, buscando como motivación reforzante, además de la satisfacción indudable que da una atención integral de la población bajo su cuidado, el mejor control que pueda lograr de los factores que inciden en la salud y la enfermedad de las familias que están bajo su responsabilidad.

b) Un segundo nivel de manejo familiar (con orientación estructural funcional), tendiente a reeducar, modificando actitudes y conductas del sistema familiar y con un enfoque activo y breve puede ser realizado por los integrantes de los equipos de psiquiatría y salud mental de las clínicas que participen en el programa, en estrecha colaboración con el médico familiar al que adscriba dicha familia para que después de la intervención especializada continúe su control con su método familiar, siempre existiendo la posibilidad de una nueva intervención breve y activa si el caso así lo necesita.

c) Finalmente en un tercer nivel se considera la posibilidad de una intervención psicoterapéutica más a fondo y a plazo más largo, con orientación a lograr cambios más profundos en la estructura dinámica de la familia y si es posible el insight correspondiente, para aquellos casos seleccionados que después de una primera evaluación, se considere preciso. Este tipo de intervención requiere la ayuda del personal especializado con entrenamiento específico en los Centros Comunitarios de Salud Mental.

Resulta lógico el considerar que para cada uno de los niveles de atención familiar enunciados es preciso contar con personal cuya preparación le permita la intervención oportuna y adecuada. Es por esto que se plantean tres niveles:

1) En la formación de los nuevos médicos familiares que tienen un programa de residencia de tres años, se propone el entrenamiento necesario que los capacite para el primer nivel de atención, de apoyo y de orientación a la familia con la comprensión dinámica general de sus necesidades y problemas, lo que les permite una atención más completa y adecuada. De igual forma se haría para los cursos de actualización para médicos familiares y trabajadoras sociales que ya trabajan dentro del

IMSS. Esto puede ser logrado a través de programas de educación continua en cursos formales o bien en talleres intensivos de sensibilización. En ambos casos deberán cubrirse aspectos teóricos fundamentales sobre conceptos para evaluación de la familia y experiencia supervisada en entrevistas familiares ya sea en vivo, o mediante el uso de videotape o práctica con la técnica de familias simuladas.

2) En el segundo nivel de entrenamiento a los psiquiatras, psicólogos y trabajadoras sociales de los equipos de psiquiatría y salud mental en clínicas, en forma semejante se les ofrecerán cursos intensivos de capacitación y talleres que les permitan diagnosticar la problemática de las familias con una orientación estructural-funcional y diseñar la atención de los conflictos familiares con tácticas de nivel intermedio de acción, con objetivos concretos y limitados, en tiempo de intervención breve y programada (8 a 12 sesiones). Para ello se recurre a la discusión de los principios teóricos fundamentales de algunas categorías para el diagnóstico estructural funcional de la familia siguiendo ideas de Watzlawick, Montalvo, Barragán y otras aplicadas a nuestro programa, desarrolladas por nosotros.

Las categorías consideradas para la evaluación y manejo serían:

- 1) Límites de la familia nuclear
- 2) Permeabilidad sociofamiliar.
- 3) Límites generacionales.
- 4) Jerarquías.
- 5) Significancia.
- 6) Cohesividad.
- 7) Territorios.
- 8) Alianzas.
- 9) Relaciones y comunicación emocional.

Se ha desarrollado una representación gráfica explicativa por sí misma de tal evaluación, en tal forma que permite visualizar lo más objetivamente posible las estrategias y tácticas a seguir para lograr un nuevo balance estructural funcional más adecuado al funcionamiento de esas familias, con maniobras de acercamiento o desligue a través de intervenciones activas del

terapeuta en la sesión y tareas encomendadas a las familias para cumplir entre sesiones. Si consideramos que la conducta y las relaciones humanas dentro y fuera de la familia se apoyan en una estructura tripolar de influencias motivacionales, ubicando en cada uno de los polos elementos y factores: a) cognitivos o racionales por un lado, b) emotivos o afectivos por otro y, finalmente, c) conductuales propiamente dichos por el otro, este enfoque tiene como polo de entrada el último de los mencionados con la idea que el nuevo balance implicará un reajuste consecutivo o automático, de tal estructura.

3) Finalmente se trata de lograr que en los Centros Comunitarios de Salud Mental se integren a los equipos de trabajo profesionales de la salud mental (psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales), con experiencia y un entrenamiento especial en terapia familiar, con distintos enfoques y niveles de intervención, como la que ofrece en plan colaborativo con el IMSS y otras Instituciones el programa de entrenamiento de postgrado en terapia familiar del Instituto de la Familia. Este nivel de entrenamiento que además del nivel anterior permite a los profesionales el diagnóstico y la intervención, para cambios estructurales funcionales en la familia, puedan hacer una evaluación psicodinámica más completa e intervengan con todas las técnicas necesarias para lograr cambios profundos, con o sin insight, pero en los que participen en forma integrada todos los elementos conductuales, emocionales y racionales que sean precisos para lograr un nuevo equilibrio o balance que permita al sistema familiar realizar sus funciones más sanamente.

Para ello podrán recurrir a las diversas técnicas de interpretación, confrontación, vivenciación, así como las ya descritas anteriormente de modificaciones conductuales a través de todo acercamiento o de desligue.

Además del diagnóstico estructural de la familia sería necesario una evaluación psicodinámica más amplia sobre las categorías fundamentales que es preciso describir y son las siguientes:

1) Patrones de identificación de problemas tanto de tipo instrumental (de la mecánica de la convivencia familiar) como

de tipo afectivo (de la expresión y relación emocional entre sus miembros).

2) Patrones de solución de problemas: en forma semejante, en las dimensiones instrumental y afectiva, qué intentos de solución se hacen y por quién, qué colaboración o interferencia encuentran en otros miembros de la familia.

3) Expresión de afectos: la capacidad y la modalidad que tiene la familia en general y cada uno de sus miembros para expresar sus emociones y afectos, las de emergencia: coraje y tristeza, así como las de bienestar, alegría y ternura.

4) Patrones de comunicación en la familia: tanto en los aspectos instrumentales como afectivos si la familia en general y sus miembros en particular son capaces de comunicarse en forma clara y directa o si existen formas indirectas y encubiertas o desplazadas de comunicación entre ellos.

5) El grado de participación emocional de la familia: en general y entre sus diversas díadas, que pueden ir desde la indiferencia o falta de participación absoluta hasta niveles extremos de participación simbiótica.

6) Roles en la familia: quiénes y cómo realizan los roles tradicionales dentro de la estructura de la familia nuclear prevalente en nuestra cultura y qué roles ideosincráticos existen (el enfermo, el intermediario, el chivo expiatorio), quiénes los llevan a cabo y el funcionamiento o tal rol que tiene para la homeostasis familiar.

7) El tipo de control que existe en la familia: para las expresiones conductuales, afectivas o cognitivas, de conflicto o represión, sea por enfrentamiento o alejamiento, que pueda variar desde una rigidez completa hasta una situación caótica de anarquía.

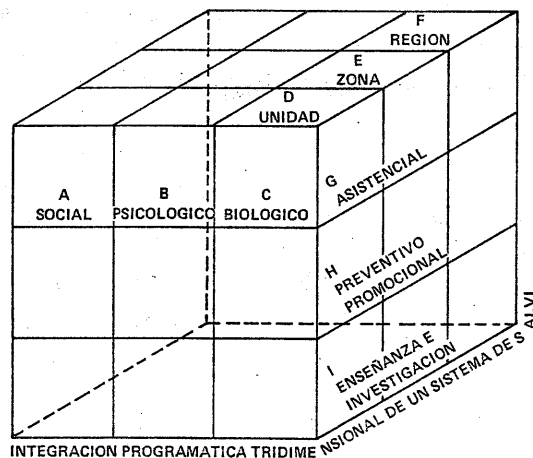
8) Grado de autonomía: capacidad de cada uno de los miembros de participar en la familia conservando y desarrollando su autonomía y su individualidad.

9) Áreas particulares de psicopatología en la conducta general de la familia y de cada uno de sus miembros, con la valoración dinámica de su significado tanto para el sistema individual como familiar.

10) Finalmente los distintos niveles de integración individual y familiar valorando tanto los recursos positivos de la familia y sus miembros que son con los que podrá trabajar, así como los problemas por resolver y las estrategias a seguir.

El programa presentado, pretende cubrir lo más ampliamente posible las necesidades de atención para el gran número de problemas de las familias amparadas por el régimen de seguridad social en la zona IV en el Distrito Federal y Valle de México y la gran variedad de problemas que pueden presentar pretendiendo hacerlo extensivo posteriormente al ámbito total del Instituto en todo el país. Como podrá considerarse, un programa tan ambicioso enfrenta múltiples dificultades, que van desde la falta de sensibilización y de respuesta en algunas autoridades del sistema, con frecuencia compensada por el entusiasmo, el interés y el apoyo de otras autoridades hasta la dificultad enorme a veces de cambiar sistemas de servicio y orientación establecidos por muchos años con los vicios, la rutinización y burocratización consecuentes.

Finalmente las limitaciones de recursos materiales y humanos obligan a pensar en que un Programa de este tipo deberá tener una acción permanente y a largo plazo con difícil aplicación inmediata en forma amplia sino a través de un énfasis en la acción de sensibilización y multiplicación de interés y capacitación del personal actual en una primera etapa de su implementación.



Un modelo sistémico de familias para terapeutas familiares

W. ROBERT BEAVERS, MD.

Esta es una versión ampliada del trabajo presentado en setiembre de 1979 en Ateneos de Investigaciones, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Yale. Publicado en el Journal of Marital and Family Therapy, páginas 299-307, en julio de 1981. Publicado con permiso del autor. W. Robert Beavers, MD, es profesor de clínica, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Texas Health Science Centre, Dallas, Texas.

Se presenta aquí un modelo de familia que provee una clasificación sistémica para terapeutas familiares, basado en la integración de investigaciones realizadas en familias sanas y perturbadas, y en datos clínicos. El modelo provee instrumentos para realizar, en familias, valoraciones de corte transversal y orientadas a procesos; tales apreciaciones derivan de considerar la eficacia familiar en el cumplimiento de tareas y en el estilo familiar de operación. Así resultan siete tipos de familias: óptimas, adecuadas, centrípetas intermedias, centrífugas intermedias, mixtas intermedias, disfuncionales severas centrípetas. Se proveen caracteres de identificación para cada tipo, y las estrategias de intervención y acercamiento que se presentan derivan en forma lógica de las apreciaciones.

Las investigaciones de familias y la terapia familiar están desarrolladas y se expanden a tal grado que indican la necesidad de modelos. El valor de un modelo estriba en proveer un lenguaje común, una manera de organizar información y una guía para dirigir y evaluar la intervención. El modelo que aquí se presenta es una integración de veinte años de práctica

clínica, e investigaciones sobre sistemas familiares sanos y perturbados.

Resulta evidente que un modelo de familia, que es un intento de clasificar y ordenar familias de manera que sea comunicable, es esencial para el desarrollo de nuevos y mejores estudios y una mejor selección de las estrategias de intervención. Desde el punto de vista de los sistemas, todas las familias comienzan con la conducta y las actitudes de al menos una familia previa, y generalmente de dos. La familia de origen es el modelo consciente e inconsciente de lo que uno espera en la vida familiar. Influye en el tipo de intimidad o distancia que hay entre los individuos, y en los roles que los diferentes individuos toman. Una pareja recién constituida está forjando algo potencialmente nuevo y diferente nunca antes experimentado. El intento de acomodar las necesidades de esos dos individuos, las necesidades de los niños aún sin nacer y la integración de todos sus miembros en la vida de la comunidad amplia, es un proceso creativo. Las parejas afortunadas comienzan este proceso mediante negociaciones acerca de asuntos personales y vitales, tales como espacio de vivienda, la expresión de los sentimientos, las mutuas expectativas establecidas, el estilo de comunicación y los standards de lo que es aceptable o tolerable. Esta negociación requiere una notable habilidad para arriesgar, declarar y explorar nuevas posibilidades. En realidad, sólo las personas competentes lo hacen bien. Los requisitos para tales negociaciones incluyen lo siguiente:

1. *Cierto grado de percepción (generalmente con la ayuda del otro cónyuge) acerca de sus creencias, patrones de conducta y fervientes expectativas.* El conocimiento consciente de tales asuntos es una medida de la salud de cada familia de origen. Cualquier estructura intrapsíquica de un adulto, refleja en gran medida las reglas del sistema de su familia original. Si las reglas en esa familia eran claras y reconocidas, el adulto está más consciente de la forma en que se relaciona. Si las reglas eran extremadamente oscuras, y no se compartían en forma abierta ni se hablaba de ellas, el adulto está discapacitado por una considerable cantidad de material inconsciente. Mientras que un

adulto puede discernir, esto es, puede tener sentimientos de terror y enojo y ser consciente de ellos y ocultarlos cuando no se siente seguro, un niño no tiene esa capacidad. Consecuentemente, para poder sobrevivir en una familia cuyas reglas impiden cierto tipo de expresiones humanas, prolifera el mecanismo de represión y el adolescente es no consciente de sentimientos inaceptables.

2. *Tener conciencia de que los mortales poseen verdades relativas, no absolutas.* En otras palabras, las familias pueden realizar y pensar tareas de diferentes maneras, sin que haya sólo una manera "correcta" de encarar un problema.

3. *Optimismo de la pareja en poder realizar el trabajo de construir una familia mejor (o al menos mejor para estos tiempos) que la que sus padres lograron hacer.* Aún pensando bien de sus familias, la mayor parte de las veces los miembros de una familia saludable creen que los tiempos cambian y que uno debe afrontar el presente usando el juicio y la experiencia antes que una servil adhesión a las reglas de su familia previa.

4. *Visión de la singularidad de cada cónyuge.* Cada cónyuge reconoce una visión subjetiva de la realidad, que incluye no sólo la confianza en que sus pensamientos merecen consideración, sino también respeto por otros puntos de vista y sentimientos, aún cuando sean diferentes. Desde esta perspectiva y con datos concernientes al desarrollo, estructura, y funcionamiento de las familias sanas y familias con miembros emocionalmente enfermos, he desarrollado un modelo, que parece ser clínicamente útil interviniendo en familias perturbadas. Es un modelo sistémico que describe la estructura, flexibilidad y competencia de una familia en una dimensión, y el estilo de la familia en la otra. El modelo es de corte transversal, representando un instante en el tiempo. Al emplazar familias en estas dimensiones, se describen las interacciones familiares más que la información histórica o individual. (Beavers, 1977). El eje horizontal se refiere a la estructura, flexibilidad adaptativa y tipos de interacción dentro de la unidad familiar. Las investigaciones de nuestro grupo publicadas en otros trabajos (Lewis, Beavers, Gossett y Phillips, 1976) ha descripto trece variables

cruciales utilizables en escalas de evaluación de familias. Estas variables cubren cinco áreas de conducta familiar: 1) estructura; 2) mitología; 3) negociaciones orientadas a un objetivo; 4) estimulación de autonomía individual por parte del sistema; 5) cuestiones de afecto o sentimientos.

La estructura de la familia fue reflejada en tres escalas: 1) distribución del poder evidente, de cómo fue compartido y usado; 2) la calidad de la coalición parental (la habilidad de trabajar juntos y ser líderes efectivos, emanando calidez y satisfacción al hacerlo); 3) la proximidad familiar (claridad con respecto a los límites individuales y monto de participación e intimidad).

La *mitología* fue definida como la visión compartida por los miembros de la familia sobre ellos mismos. Nuestro interés al valorar las familias se centra en la congruencia de estas visiones con respecto a las de un individuo ajeno a ella, dado que cuando son fácilmente compartidas por el grupo, estas percepciones son mecanismos poderosos y útiles para la adaptación. La *negociación orientada a un objetivo* se refiere a la eficiencia de una familia en tomar decisiones y realizarlas, y en estimular la participación de todos los miembros de manera que las soluciones representen lo mejor que la familia en su integridad puede producir. La *estimulación de la autonomía* por parte del sistema es un amplio aspecto del funcionamiento familiar que abarca claridad de comunicación, asunción de la responsabilidad personal, la intromisión o "lectura de la mente", y la receptividad de unos a otros.

Las cuestiones de afectos o sentimientos son evaluadas mediante la observación de la expresividad, el humor y el tono afectivo, el conflicto irresoluble (siendo la palabra "irresoluble" clave, dado que el conflicto está siempre presente), la empatía (la habilidad de los miembros para percibir y responder a sugerencias no verbales).

Los datos derivados de las escalas de evaluación familiar se desarrollaron en un continuum de competencia familiar que se muestra en el modelo, trasladándose desde lo caótico a lo rígido y luego a más y mayor flexibilidad. En términos de

sistemas esto podría llamarse "continuum negentrópico", dado que cuanto más negentrópica es la familia, es decir cuanto más flexible y más adaptable, mejor funcionará.

Esta dimensión es isomórfica y paralela a un continuum de desarrollo psicológico individual con grados progresivos de autonomía, separación, individualización y claridad de límites. *El eje vertical del modelo se refiere al estilo.* La dimensión estilística de Helm Stierlin y col., ha sido adaptada para delinear dos patrones de relación con el mundo exterior (Stierlin, 1972). Eric Erikson dio los primeros cimientos para esta dimensión (1963). La *familia centrípeta* (CP), se orienta hacia el adentro; es difícil para sus miembros desprenderse o tener un alto grado de inversión emocional fuera de la familia. Las reglas dicen que la familia en sí es la fuente de satisfacción de más valor y confianza, y los miembros deben presentar un buen frente al mundo exterior, ocultando perturbaciones y dolores para evitar llamar la atención. Las expresiones de sentimientos negativos y conflictos tienden a ser encubiertas y se realizan los mayores esfuerzos para mantener la armonía y así la cohesión de la unidad familiar. Los roles y los patrones de relación son relativamente estables. Los padres aceptan el status quo de su relación el cual involucra cierta dominación/sumisión. El control de los padres sobre los hijos es efectivo, al menos durante los primeros años. Los padres inhiben los esfuerzos agresivos de los hijos para lograr su independencia, y las conductas de dependencia, e incluso las "adhesivas" o "pegajosas" son recompensadas. Los hijos se desprenden de la familia más tarde de lo esperado y a veces nunca. La *familia centrífuga* (CF) tiene una orientación hacia afuera. La independencia o la apariencia de independencia es estimulada. Se espera que las satisfacciones provengan más del ambiente externo que de dentro de la familia. Opuestamente a las familias centrípetas se ve claramente cuando están perturbados. Los enojos y conflictos son expresados, lo cual estimula la acometida externa de los miembros. La coalición parental es típicamente crónica inestable, con conflictos evidentes y competición. El control parental sobre los hijos es inconsistente y generalmente ineficiente. Una

conducta independiente, agresiva, por parte de los hijos es probablemente recompensada; las conductas de dependencia o "adhesivas" no son recompensadas sino penadas. Los hijos de familia centrífuga intentan el desprendimiento mucho más temprano que la norma. Las clases sociales influyen en los estilos; los grupos de nivel socioeconómico bajo tienen más familias centrífugas ya que no esperan que el control sea efectivo.

La forma de flecha del diagrama refleja la observación de que las familias más capaces son las más flexibles y adaptables, y por ello hay menos posibilidades de que aparenten ser familias centrífugas o centrípetas. La familia de buen funcionamiento puede adaptar su estilo en respuesta a las condiciones cambiantes. Por ejemplo, una familia con hijos pequeños es apropiadamente más centrípeta que una familia con adolescentes que se adapta más al estilo centrífugo.

Las dimensiones, competencia y estilo organizan a la familia en tipos que permiten una definición y análisis de sus problemas y del objetivo de tratamiento. Las familias sanas se dividen en (1) Óptimas y (2) Adecuadas. Las intermedias (OM) producen tres subgrupos estilísticos (3) Centrípetos de Orden Medio (CPOM), (4) Centrífugos de Orden Medio (CFOM) y Mixtos de Orden Medio. Las familias severamente disfuncionales tienen dos estilos contrapuestos (6) Severamente Disfuncionales Centrípetas (SDCP) y (7) Severamente Disfuncionales Centrífugas (SDCF). Cada una de estas siete categorías tiene su propia y particular organización, patrones, necesidades y debilidades. La arrolladora y atolondrada variedad de información que generalmente se presenta en las entrevistas del médico con la familia, puede así ser organizada: y los métodos de intervención podrán fluir observando qué es lo que las familias pueden y no pueden hacer.

Familias sanas

Tipo 1. Familias óptimas. Estas familias nos proveen un paradigma de funcionamiento efectivo. Los miembros poseen lo

que hemos descripto como una orientación de sistemas, esto es, se hallan en conocimiento de las múltiples influencias que ejercen unos sobre otros, así como del movimiento circular de causas y efectos y una disciplina rigurosa conduce a un mal comportamiento que lleva a una disciplina rigurosa. Ellos ensayan varios acercamientos diferentes a los problemas internos de la familia. Los miembros buscan, y normalmente alcanzan la intimidad. Los padres comparten el poder de manera flexible. Los límites y la diferenciación entre los miembros son claros y respetados. El conflicto por supuesto está presente, pero normalmente puede ser resuelto con rapidez, ya que cada miembro sabe que es diferente de los demás, pero también que los necesita.

Tipo 2. Familias adecuadas. Estas familias están más orientadas hacia el control que las óptimas. Los padres se esfuerzan por obtener mayor poder manifiesto, son menos capaces de sentir confianza e intimidad entre ellos, son menos espontáneos y felices. El estereotipo del rol que le corresponde a cada sexo es más notable, siendo los varones más ponderosos e insensibles, en contraposición a mujeres menos ponderosas y más emotivas (a veces deprimidas). Los niños de estas familias, sin embargo, parecen ser tan capaces como los de las familias óptimas. Es probable que la firme creencia de los padres en la importancia de la paternidad y de la vida en familia, su tenacidad y sus cuidados, les sirvan para compensar menores habilidades interpersonales. Estas familias funcionan con miembros que son conscientes de estar experimentando dolor y cierta soledad, pero con intervenciones poco frecuentes de los profesionales de la salud mental.

Familias intermedias

El primer grupo de familias disfuncionales son llamadas intermedias (OM). Sus miembros son sanos pero limitados y susceptibles de enfermedades emocionales. Todas las familias intermedias están orientadas hacia el control, y se caracterizan por las diferencias y las luchas por el poder manifiesto. Ellos

asumen que la gente es básicamente antisocial y depravada, y debe por lo tanto ser controlada. Los miembros no tienen clamorosos problemas de límites, normalmente respetan el espacio interior de cada uno y no hablan por los demás. Ellos proyectan, a menudo atribuyendo la parte no reconocida de su propia ambivalencia a otro miembro de la familia a quien entonces tratan de controlar. Ellos expresan la convicción de que la gente "en realidad" tiene un sentimiento especial: "Ella en realidad me odia aunque trate de ser amable" o "en realidad él me quiere, aunque nunca demuestra afecto". Además, estas familias muestran con frecuencia problemas edípicos no resueltos, con hijos "favoritos", siendo generalmente el padre de un sexo con el hijo del sexo opuesto.

Tipo 3. Familias centrípetas intermedias (CPOM). La familia CP en esta categoría utiliza el control directo, y espera tener éxito al hacerlo, reprime la hostilidad y expresa cariño. Las reglas y la autoridad son enfatizadas; la espontaneidad es disminuida. La decreciente población de "buenos pacientes psiquiátricos" —aquellos que trabajan duro, disimulan sus penas ante los vecinos, desarrollan la transferencia en forma agradable y pagan los honorarios— son los productos usuales de las familias CPOM.

Tipo 4. Familias CFOM. El segundo estilo de familias intermedias utiliza el control indirecto, la manipulación o la intimidación y rara vez espera tener éxito con ello. Como el primer grupo, creen en su propia y básica malevolencia, pero difieren en que no esperan ocultarlo satisfactoriamente. Son mucho más abiertamente hostiles, casi constantemente culpan y atacan, y rara vez expresan calidez. Sus sentimientos negativos, fácilmente movilizados, alimentan sus movimientos centrífugos. Los padres pasan poco tiempo en sus casas y los hijos incursionan en el barrio y en las calles mucho más temprano que la norma. Los miembros luchan por el control, nunca se sienten triunfadores, y tienen una dificultad permanente así como un desprecio para con la autoridad, dentro y fuera del hogar. Tanto el autocontrol como el poder social son evitados.

Tipo 5. Mixtas. Algunas familias de OM tienen conductas centrípetas en forma alternada y conflictiva. En este grupo mixto, la coalición parental típicamente varía en una entrevista desde la dominación/sumisión hasta las disputas mezquinas y la atribución de culpas; los hijos alternan entre la aceptación y la resistencia al control parental.

Familias severamente disfuncionales

En el extremo inferior del continuum de competencia están las familias cuyas deficiencias más serias están en el área de la coherencia. Los observadores de estas familias notan que carecen de focos de atención compartidos y que poseen una sensación de desmembramiento. Los miembros tienen una gran dificultad en resolver ambivalencias y elegir objetivos. Dado que nadie logra el poder en forma clara, entonces es ejercido indirectamente y en forma encubierta. La interacción familiar parece caótica. Los miembros están patéticamente limitados en sus negociaciones y en sus capacidades adaptivas. Los límites entre miembros son débiles y los individuos frecuentemente hablan de los sentimientos y motivaciones por los otros. El estado de ánimo penetrante es descorazonador, cínico y desesperante.

Tipo 6. Familias severamente disfuncionales centrípetas. Las familias en este grupo tienen una frontera casi impermeable al mundo exterior. La familia y sus miembros son vistos como extraños o excéntricos por sus vecinos. Las reglas familiares requieren permanecer por siempre estáticos y en una nebulosa. La ambivalencia es denegada, con aceptación de sentimientos positivos y los negativos expresados tangencialmente o por medio de conductas. Esta es la energía para el estilo "centrípeto-adhesivo". Los niños están seriamente discapacitados en su lucha por crecer tomando conciencia de ser ellos distintas individualidades, y para funciones fuera de la familia. Una manera de expresarse y de resolver el dilema, es una apertura esquizofrénica.

Tipo 7. Familias severamente disfuncionales centrífugas. El

grupo final de familias patológicas tiene un tenue perímetro, a veces, incluso con la incertidumbre de quién constituye la familia. La interacción familiar está caracterizada por hostilidad manifiesta y desprecio. A pesar de que el estilo difiere del de la familia severamente disfuncional, las negociaciones confusas e incompletas son similares. Los sentimientos de calidez y ternura son expresados indirectamente o mediante conductas. Esto provee la energía para el volátil estilo centrífugo, con miembros alejándose con gran enojo y generalmente retornando con enfado. Los niños de familias SDCF están tan discapacitados en su desarrollo evolutivo como aquellos del grupo anterior. El resultado más común es una personalidad antisocial, resultante de deficiencias en la formación, calidez y ternura. El abuso de niños, las desviaciones sexuales y la drogadicción son frecuentes.

El modelo precedente y sus tipos familiares representan nuestra conceptualización sobre datos recogidos de la investigación y la clínica de familias. El movimiento desde contornos incoherentes y nada satisfactorios a través de una interacción rígidamente controlada, y hacia negociaciones compartidas, es un típico progreso hacia la competencia y la salud de los sistemas familiares. La regresión en un sistema revierte esta secuencia.

En nuestro trabajo clínico, este tipo de valoración apunta hacia objetivos y técnicas en la terapia familiar. El clínico considera el funcionamiento de toda una familia cuando interviene con una persona, con una pareja, una familia o una organización. El objetivo final es el de ayudar a la familia a trasladarse a un nivel más funcional. Los terapeutas eligen los métodos que encajan en las necesidades familiares.

Así como en terapia individual, un síntoma no es sólo una expresión sino también un esfuerzo por resolver un conflicto interno, en la terapia familiar el problema que se presenta puede ser entendido como un reflejo de y una tentativa de resolver el conflicto interaccional. En ambos casos, el síntoma previene el crecimiento y el movimiento.

Tal evaluación puede ser considerada una macro-evaluación, comparable a organizar y agrupar características de individuos para fomentar el pensamiento y la comunicación acerca de los pacientes (Beavers, 1977). Ello aumenta, pero no sustituye, lo que puede llamarse una micro-evaluación de familias al observar patrones singulares de las mismas.

El proceso de apreciación familiar puede ser rápidamente realizado y en forma eficiente, dándole a la familia una tarea pertinente, tal como "discutan acerca de lo que quisieran cambiar en vuestra familia" y dejarlos solos por quince minutos. El uso de un videotape o un espejo unidireccional es un método ideal, dado que la interferencia (y a veces confusión) por la presencia del terapeuta interrogador, es eliminada. Sin estas ventajas, el objetivo es razonablemente logrado si se asigna la tarea, se resiste el impulso de intervenir por unos momentos y se observa cuidadosamente. Una cantidad de datos emergentes puede ser organizada, usando los modelos de familia presentados.

Cuando una familia es valorada como severamente disfuncional, la coherencia es un objetivo necesario pero difícil de lograr. La intervención terapéutica debe estimular encuentros coherentes y afortunados entre los miembros de la familia, para que el desarrollo individual y familiar pueda ser llevado a cabo con éxito. El terapeuta ayuda modelando, dirigiendo y logrando un clima de seguridad psicológica en el cual se fomenta la clara y abierta expresión de sentimientos y deseos. Los miembros de las familias severamente disfuncionales manejan pobremente las ambivalencias y una parte vital de la intervención terapéutica es la estimulación y aceptación de la expresión de las ambivalencias no resueltas.

Las familias SDCP temen la expresión abierta de sentimientos de cólera, el empuje biológico del crecimiento y desarrollo de los hijos, de la individualidad, autonomía y el alejamiento de éstos de la familia. Gran parte de la normal evolución familiar —los hijos creciendo y dejando el hogar— es considerada desleal, y los síntomas de enfermedad emocional en los hijos son frecuentemente consecuencia de las reglas familiares que

impiden este necesario movimiento hacia la independencia y la individuación. Las estrategias terapéuticas están dirigidas a estimular a los miembros de la familia a aceptar el desprendimiento de los lazos familiares, la resolución de ambivalencias a través de elecciones individuales y la redefinición de estos esfuerzos como leales y dotados de amor. Es una característica de estas familias SDCP el aceptar fácilmente concurrir como familia, y la terapia familiar clásica es una técnica óptima.

Las familias SDCF también tienen problemas con la incoherencia y en aceptar ambivalencias, pero la polaridad es inversa a la descrita anteriormente. Los sentimientos de amor y ternura y los deseos de dependencia son vistos como amenazadores y son pobremente expresados.

Estas familias se resisten a ser vistas en terapia conjunta y modificaciones en el abordaje familiar son frecuentemente necesarias.

Por ejemplo, los padres de un niño de doce años emocionalmente perturbado, que no puede funcionar en su clase escolar, pueden rechazar repetidos pedidos de emprender una terapia familiar. El trabajo individual con el niño produce un mejoramiento social que permite al niño ser un emisario en la familia. La madre ve la mejoría y se acerca vacilante al terapeuta luego de haber rechazado invitaciones previas, y el contacto es realizado. Generalmente se requieren muchos meses para que el padre y los hermanos accedan a entrar en la arena terapéutica, dado que el solo hecho de asistir juntos como una familia es amenazador para el sistema. Mi observación al supervisar terapeutas que trabajan con tales familias es que el conceptualizar la dinámica y el estilo familiar puede mejorar la moral del terapeuta. Un terapeuta familiar no es un fracaso por ser incapaz de comenzar el trabajo inmediatamente con toda la familia. Cuando la familia es capaz de concurrir toda junta al terapeuta, una gran parte de la necesaria intervención ha sido concretada. El miedo al reconocimiento abierto de la necesidad y la vulnerabilidad es una parte del estilo centrífugo, que ilustran más dramáticamente estos grupos familiares más disfuncionales. Las familias de intermedia han conseguido un muy

importante primer paso en el desarrollo al procurar coherencia en la comunicación y cuando encuentros comprensibles se evidencian regularmente. El desarrollo individual y familiar ha progresado más allá que el de las familias severamente disfuncionales, y los problemas de límites, aunque presentes, no son tan dramáticos ni penetrantes. El control es la preocupación de las familias de intermedio, y el terapeuta familiar debe responder a esta necesidad a través de una redefinición de su expresión y a menudo de maneras totalmente diferentes. Una vez más la intervención efectiva depende de lograr una interacción satisfactoria, dirigiendo el cambio y procurando un clima en el cual el control sea utilizado para llevar a cabo tareas familiares más que para bloquearlas.

Los padres en las familias CPOM esperan que su control sea exitoso, y tienen un pasado en el cual lo fue. Ellos entran en una situación de tratamiento con la esperanza de que el terapeuta los ayudará a reestablecer el control de la familia y de sus miembros sin cambios significativos en los supuestos implícitos. Estos padres desafían al terapeuta familiar a desarrollar estrategias que abran nuevas posibilidades, nuevos conocimientos acerca de la parentalidad y el crecimiento.

Así como las SD, tampoco estas familias CP se resisten a acercarse como un grupo a pesar de que no ven el problema individual de un miembro como un problema de familia. El predominio de un hosco estado de ánimo, obtuso enojo y depresión hacen necesaria la intervención del terapeuta para ayudar a los miembros de la familia a expresar su humor, su confortable desamparo y las ubicuas paradojas inherentes a la empresa humana. Estas familias se "empantanán", se congelan y se transforman en inadecuadas debido a su suposición de que "tu ventaja se origina en mi pellejo". La ventaja del terapeuta es tener la confortable convicción de que en íntimas relaciones, o todos ganan o todos pierden. Los padres quieren que a sus hijos les vaya bien. Ellos simplemente temen el resultado de dejarlos ir, de controlarlos mediante el no-control. La redefinición, la contraparadoja y el responder a preguntas lineales con "locas" respuestas (esto es con otra visión del mundo, más

confiada y esperanzada) son elementos necesarios en la "galera" del terapeuta.

Es importante apuntar a la coalición parental, la cual a pesar de ser estable y eficaz, no ha evolucionado más allá del patrón de dominación/sumisión. Es muy raro que los padres disfruten al ver a sus hijos tomar sus decisiones y ganar autonomía hasta tanto ellos mismos no se alivien en el ser controlados o controlar su propia relación.

La familia CFOM también ha desarrollado coherencia y cierto grado de claridad en cuanto a los límites y las diferenciaciones. El control es el deseo consciente, pero en este grupo, a pesar de que el deseo está presente, la expectativa no lo está. Los padres discuten constantemente y los hijos aprenden a jugar uno contra el otro. No hay un pasado de control satisfactorio; más bien los miembros de la familia presentan un largo período de ineficiencia, de frustración e insatisfacciones mutuas. Un objetivo inmediato del terapeuta es entonces apuntalar la vacilante coalición parental y ayudarlos a ser más eficientes. Para realizarlo, hay dos acercamientos alternativos que parecen igualmente visibles, y la elección probablemente dependa de las características del terapeuta. Se debe insistir en que la familia venga como un todo, y el terapeuta ganar el control del grupo, diseñando las habilidades parentales que pueden luego ser adaptadas por los padres reales. Otra alternativa es aislar el matrimonio, y que el terapeuta actúe como asesor de la pareja, ayudándola a definir sus objetivos como padres y transformando su conducta, y así capacitarlos para trabajar juntos y alcanzar el éxito deseado.

Los objetivos son los mismos que para las familias CPOM: asistir a la familia en sus esfuerzos respecto del control y desarrollar nuevos conceptos que les permitan nuevas definiciones de los límites interpersonales e individuación de los miembros.

La categoría OM mixta, es importante, porque hay muchas familias que en el pasado y en el presente vacilan entre la esperanza de poder controlar y la creencia de que ello es imposible. Generalmente estas familias estarán de acuerdo en

ser entrevistadas como una unidad, y el acercamiento terapéutico requerirá atención a la coalición parental y también a la importancia de los logros individuales en el progreso exitoso a través de fases de desarrollo personales y familiares. El control y la elección no están en oposición, siempre y cuando el control se redefina como una facilitación de la responsabilidad personal. Esta es una poderosa paradoja, importante para todos aquellos que tengan que brindar ayuda (padres, maestros y terapeutas). Ellos sólo pueden controlar con responsabilidad a otros, siempre y cuando estos últimos se hagan responsables de su propio destino.

El tratamiento de las familias adecuadas y sanas, es, por supuesto, una pequeña parte de la actividad del terapeuta. La enfermedad, muerte de un miembro clave, presiones del sistema social tales como el desempleo, pueden producir un stress y llevar a tales familias a una reestructuración regresiva y entonces solicitarán ayuda terapéutica. Como Anthony (1970) observó, las familias competentes realizarán la regresión de una manera secuencial, inversa al desarrollo evolutivo familiar. A partir de una adaptabilidad flexible, los cambios inducidos por el stress, arrastran a la familia primeramente a una mayor rigidez y luego a la desorganización. Las familias que previamente eran adecuadas, responderán a demandas por el bienestar de los hijos. Las que previamente eran óptimas, apuntarán rápidamente a las necesidades prácticas de los miembros, y las soluciones podrán ser negociadas sin una intervención prolongada.

El integrar datos del desarrollo individual y la teoría, datos de sistemas familiares y material clínico con técnicas de intervención, es una tarea difícil para el entrenador y el aprendiz. El modelo descrito representa mi esfuerzo en lograr tal integración.

Existen dos temas bien distintos en la literatura familiar clínica que podríamos denominar "LEAPING" (de salto) o "INCHING" (de pasos cortos). Las técnicas de salto se utilizan para quebrar sistemas bloqueados, para re-definir radicalmente problemas todavía sin solución, para conseguir progresos tera-

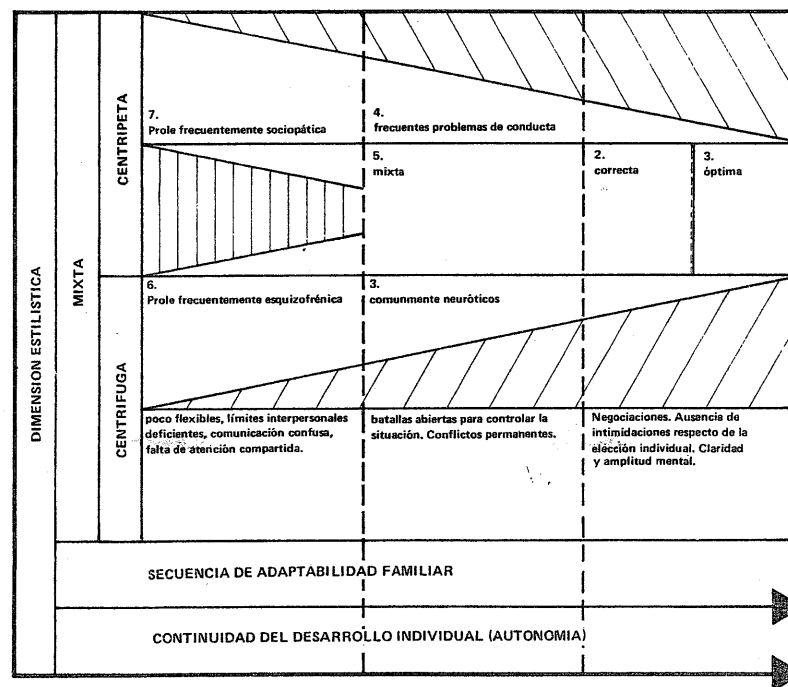
péuticos. Las técnicas de pasos cortos no son de carácter dramático, sus objetivos están dirigidos hacia un cambio progresivo y generalmente, ponen énfasis sobre el mejoramiento de las relaciones. Ambas son necesarias para un tratamiento familiar y funcionan a la par. Si alguna de las presunciones básicas de control está totalmente errada, ni la mayor paciencia ni el cariño más sincero podrán ayudar al desarrollo individual o familiar. Es necesario pasar a otro paradigma, a otra visión del mundo. Por otra parte, el crecimiento y desarrollo, ya sea de madurez, de relaciones o de intimidad, son lentos y podrían verse trabados por un terapeuta impaciente o quizás propenso al drama. Para esa tarea se requiere un adulto responsable y de confianza. Así, como distintas opciones terapéuticas pueden fracasar por haber puesto un enfoque demasiado intenso sobre las técnicas de "salto" o de "paso a paso", así también los sistemas familiares sintomáticos tienden a hacer lo mismo.

Generalmente familias CP muy unidas tienen esperanzas en el paso a paso pero no confían en cambios radicales, aun cuando resultan necesarios. Las familias CF sienten temor por cualquier trabajo sistemático en conjunto y sueñan con cambios rápidos o tal vez mágicos. Tales consideraciones pueden ser una ayuda para los terapeutas para poder combinar familias y estrategias.

En nuestro encuadre terapéutico del South West Family Institute, la evaluación es la piedra fundamental del entrenamiento y la supervisión. Facilitamos a los estudiantes y a los clínicos muchas técnicas y estrategias, y todas son consideradas por los que las proponen como útiles y aún esenciales. Presentamos conceptos de patrones familiares, reglas y procesos basados en la investigación sistémica que provee un esquema unificado al estudiante y le permite evaluar las estrategias de intervención y combinarlas con las estructuras y las necesidades de la familia particular entrevistada en el contexto terapéutico.

Bibliografía

- ANTHONY, E.: "The Impact of Mental and Physical Illness on Family Life", *American Journal of Psychiatry*, 1970, 127, 138-146.
- BEAVERS, W. R.: *Psychotherapy and Growth: A Family Systems Perspective*. New York, Brunner/Mazel, 1977.
- ERIKSON, E.: *Childhood and Society*, second edition, New York. W. W. Norton, 1963.
- LEWIS, J., BEAVERS, W., GOSSET, J., and PHILLIPS, V. *No Single Thread: Psychological Health in Family Systems*. New York, Brunner/Mazel, 1976.
- STIERLIN, H.: *Separating Parents and Adolescents*. New York. Quadrangle, 1972.



CERF

*Centro para el estudio de
las relaciones familiares*

Dirección: Lic. Alberto González Lic. Olga Benzaón de González

ESCUELA PARA TERAPEUTAS FAMILIARES
1984 — 1985

Inscripción: Septiembre 1983

SEPTIEMBRE 83. Martes 6, 13 y 20, de 13 a 15 horas: **REGLAS Y ORGANIZACION FAMILIAR.** Prof. G. Klimovsky y A. G. González.

OCTUBRE 83. Martes 4, 11, 18 y 25, de 13 a 15 horas: **BATESON Y LA TEORIA DE LA COMUNICACION.** Prof. Delia P. de Prada, G. Klimovsky y A. G. González.

NOVIEMBRE 83: Martes 15 y 22, de 13 a 15 horas: **MODELO DE FAMILIA CON PACIENTE ASMATICO.** Prof.: Lic. Liliana Feldman, Lic. Julia Korembliit, Lic. Susana Sola de Camarasa, Dr. Feldman y Dr. Dal Lago.

DICIEMBRE 83: Martes 6 y 13, de 13 a 15 horas: **GRUPO FAMILIAR Y ADOLESCENTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.** Prof.: Lic. Beatriz Havas, Lic. Marfa del Carmen Vázquez y Lic. Helen Lamuraglia.

INFORMES: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 15,30 horas a 19 horas - Soler 3765 4to. "J" Nro. 18 - Tel.: 802-0333, 824-1188.

CENTRO DE ESTUDIO DE TERAPIA FAMILIAR (C.E.TE.FA. ROSARIO)

Director: Dr. FIDEL LEBENSOHN

SEMINARIO DE EPISTEMOLOGIA SISTEMICA II
"GREGORY BATESON" — Agosto 5 y 6, 1983

LA VIDA Y SU ORGANIZACION

* Modelos sistémicos autorreflexivos, formas, figuras y movimientos. — * Teoría del Cambio, Sistemas recursivos y paradojas. — * Mapas perceptivos y autoconstrucción de la realidad. — * Naturaleza de las explicaciones científicas. — * Biología del conocimiento. — * Biología del fenómeno social. — * Fundamentos biológicos del espacio físico.

FIDEL LEBENSOHN — RUBEN MAKINISTIAN
* Invitado especial: **HUMBERTO MATURANA**

C.E.TE.FA. tiene la satisfacción en este segundo seminario de tener como invitado especial al profesor Humberto Maturana, quien es director del Laboratorio de Epistemología Experimental en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, sus obras básicas son en coautoría con Francisco Varela: "De Máquinas y Seres Vivos" y "Biología y Conocimiento".

Arancel: Antes del 30 de Junio: 1) Alumnos C.E.TE.FA., alumnos de Psicología y Medicina y grupos integrantes de instituciones, \$a 180. 2) Profesionales, \$a 230. Después del 30 de Junio: 1) \$a 250. 2) \$a 300.

Informes e inscripción: Tucumán 1060 P.B. "A" T.E. 67038 - 2000 Rosario.

Ateneo Clínico: De la aglutinación a la discriminación

El presente ateneo fue realizado sobre la base del material clínico presentado por la Licenciada Alicia Budnik de Gibert y la Doctora Diana Pavlosky. Fueron invitados a participar en el ateneo la Licenciada Gisela Ahlin, el Doctor Octavio Fernández Moujan y el Licenciado Hugo Hirsch.

Se trata de un tratamiento familiar iniciado hace aproximadamente tres años.

La familia inicialmente consulta debido a las actuaciones de Daniela, la hija menor, de 15 años, que resultan graves y peligrosas para sí misma y para los demás.

El grupo familiar está compuesto por: los padres, Mario y María, ambos de 49 años y tres hijas: Gabriela, de 24 años, casada, con un hijo de un año; Patricia, de 22 años y Daniela, de 15 años.

Todos muestran su intensa preocupación, por las conductas violentas, descontroladas y agresivas que tiene Daniela, llegando a conductas suicidas. Su aspecto físico es el de un varoncito.

Si bien había tenido trastornos de conducta desde chica, estos síntomas se hacen críticos durante el último período, en relación a cambiar dentro del grupo familiar.

En lo referente a los datos relevantes de la historia, los padres expresan que el embarazo no fue deseado, que coincidió con la muerte de la abuela materna.

Daniela fue educada como un varón, practicando junto al padre deportes y juegos masculinos. Hubo colecho.

Indagando acerca de la relación de pareja, relatan que existió siempre un vínculo caracterizado por: el sometimiento de la madre y la violencia del padre (que llega con mucha frecuencia a los castigos corporales) y marcada incomunicación entre ellos. En una entrevista realizada con la pareja de padres, aluden a serias dificultades sexuales.

Patricia presenta una marcada delgadez, consecuencia de sus dificultades alimenticias, siendo esta situación un elemento importante en el vínculo con su madre.

Gabriela ha hecho una pareja con un hombre de características poco viriles y de rasgos psicopáticos. A pesar de su casamiento está permanentemente en contacto con su madre.

Ambos padres son hijos menores y fueron los rebeldes de sus respectivas familias. Mario relata haberse separado de sus padres a los nueve años por razones económicas. Los progenitores del mismo sexo de cada uno de los padres fueron de carácter violento y agresivo.

Se inicia un tratamiento familiar en coterapia, con una frecuencia de dos veces por semana.

Daniela tiene muchas resistencias al tratamiento individual, al que concurre en forma irregular hasta abandonarlo.

Durante el tiempo transcurrido fueron surgiendo algunos episodios de importancia tales como modificaciones en Daniela, que comenzó a tener características femeninas y una franca actitud seductora frente a los muchachos, eligiendo como partenaires a varones con el masculino de su nombre, y que además estaban cerca de su padre.

Estos cambios de Daniela fueron dándose a partir de la revelación de situaciones existentes de ocultamiento, en especial entre la madre y las dos hijas mayores, de las que el padre quedaba excluido.

La madre siempre manejó a las hijas y la casa, y el padre lo económico.

Se promovían situaciones de promiscuidad.

Coincidiendo con su iniciación sexual y con una nueva situación de ocultamiento relacionada con un episodio de seducción de características francamente incestuosas, hace reite-

rados intentos de suicidio en breve tiempo y se decide su internación.

La internación se caracterizó por marcada violencia de Daniela, y por diversos ataques a las normas institucionales que dificultaron su contención, realizando actuaciones de todo tipo, con complicidad de la familia.

Una vez esclarecidos estos hechos, Daniela fue externada y paulatinamente se fueron produciendo una serie de cambios, que promovieron la diferenciación y la inclusión del padre.

Síntesis de los temas tratados en la sesión presentada:

- 1) Ausencia del padre por problemas laborales.
- 2) La necesidad de mudarse.
- 3) Se refieren a las terapeutas como familiares directos.
- 4) Preocupación por las deudas.
- 5) Patricia se hace cargo de la angustia frente a las dificultades económicas y la madre se pone pesimista.

Pensamos que esta familia podría ser descripta como una familia aglutinada, es decir que constituyen un conjunto de individuos con escasa discriminación en la que los intentos de individuación se realizan de un modo accesimal. Coincide con esta descripción los intentos de suicidio, la explosividad, las fugas, las somatizaciones, un rol materno exagerado, el afecto que ahoga y el predominio de los mensajes concretos con poca capacidad reflexiva.

La pareja de los padres presenta marcados rasgos narcisísticos (llevan ambos el mismo nombre), ambos apegados a su propio sexo y a su propia familia de origen.

Daniela, en este sentido, se identifica con su padre, siendo de este modo el varón para su madre. Repite en sus relaciones el vínculo con sus padres y la relación entre éstos. Busca hombres allegados a su padre, utilizados como objetos a través de los cuales reitera la imposibilidad de separarse de su madre, siendo injertada en el núcleo familiar a través de actuaciones agresivas y violentas, a la manera del padre.

Toda experiencia heterosexual está prohibida y traería serias consecuencias: el matar o ser muerto por el padre del mismo sexo. Daniela expresa la problemática incestuosa.

El padre aparece privado de la información-alimento y apela a la violencia como una forma de preguntar. Usa a las hijas como el lugar en el que experimenta angustia y a través de quienes cuenta su propia historia.

La madre es la que se queda en la casa, soportando la angustia y expresando el miedo de salir. Es la que promueve situaciones que impiden el pensamiento, a través de ocultar datos de la realidad.

La madre asume el papel de víctima del padre, se repliega narcisísticamente rechazando la sexualidad e incita y promueve un ideal de prostitución que espera realice alguna de sus hijas. De este modo fortalece la alianza con las hijas, descalifica al padre, excluyéndolo y promoviendo la promiscuidad.

Ambos padres se defienden de percibir las diferencias a través de la desmentida, observable clínicamente en los ocultamientos que son generadores de agresión.

Cabe señalar que en esta familia aparece una secuencia reiterada que es la siguiente: episodio de seducción de alguna de las hijas hacia un hombre allegado al padre o sustituto de éste, el ocultamiento de dicho episodio al padre, y como consecuencia actuaciones de violencia, en especial de Daniela y el padre.

Para esta familia existe el peligro permanente de consumación del incesto, por esta razón, como ya hemos dicho, los contactos heterosexuales son vividos como prohibidos, ocultos y generadores de violencia.

María y Mario no pueden hacerse cargo del rol de padres; otros deben cumplir esta función (Patricia, Daniela, las terapeutas).

El proceso terapéutico se desarrolló en varios tiempos. La primera etapa se caracterizó por situaciones de urgencia, llamadas telefónicas a cualquier hora de la noche, fugas y amenazas de Daniela, castigos del padre, intervención policial, etc., provo-

cando en las terapeutas el riesgo permanente de contraactuaciones.

En este sentido las terapeutas acordaron "darse tiempo para pensar".

El clima de las sesiones era de gran intensidad emocional. Las terapeutas jugaron en este sentido un rol complementario entre sí, siendo de gran utilidad el trabajo en co-terapia, debido a los fuertes sentimientos contratransferenciales de miedo, angustia y paralización del pensamiento.

En una segunda etapa se comenzaron a develar los ocultamientos, buscando en distintos momentos, en especial la madre, reiterar la exclusión del padre a través de la búsqueda de alianza con las terapeutas.

Debido a no encontrar eco en éstas, condicionó el que fueran excluidas, que se les omitiera información, ya que se convirtieron en las reveladoras de secretos.

La internación de Daniela le permitió a ésta y a la familia, encontrar un lugar de contención y de límites.

Ambos padres pudieron aceptar sus dificultades y pedir ayuda.

Este fue un período de intensa sobrecarga para las terapeutas, ya que Daniela y su familia trataron de violar todo tipo de normas, lo que determinó permanentes reuniones del equipo y del personal de la clínica para encuadrar el tratamiento.

A pesar de las serias resistencias y del franco ataque al tratamiento individual, la postura firme y acorde de las terapeutas permitió que éste fuera aceptado en forma estable.

La salida de la clínica era muy angustiante para ellos, pues debían hacerse cargo del rol de padres, aceptando la ineficacia de su funcionamiento anterior. Temían nuevas actuaciones.

La externación fue gradual, y Daniela pudo reubicarse lentamente en su familia, pidiendo, cuando estaba muy angustiada, volver a la clínica.

Creemos que actualmente siguen existiendo diversos problemas, pero ya en el ámbito de una familia más ordenada, que permite cierto grado de discriminación a sus hijas, pero aún con importantes dificultades de pareja que no pueden enfrentar.

Discusión

Lic. Gisela Ahlin: Yo preferí centrarme en la sesión exclusivamente porque me pareció muy coherente con el material que se trajo, creo que está mostrando con bastante claridad en qué punto de su evolución terapéutica está esta familia. Pienso que esta familia, en esta sesión fluctúa entre un reconocimiento y un desconocimiento ¿de qué? . La primera frase de la madre, "Mario no viene", alude a la ausencia del padre. Más allá del referente empírico, creo que esto es importante porque se está nombrando una ausencia con lo cual probablemente se reconoce la necesidad de su presencia, en tanto a función. Creo que esta función comienza a presentificarse a través del reconocimiento de la ausencia. Acto seguido hay una frase en la que se precisa un tiempo y un espacio. Se habla de una mudanza, a mi juicio la mudanza es el tema central de esta sesión porque casi toda la sesión gira alrededor de las dificultades de pasar de un departamento, en el que están viviendo, a otro. Si bien el departamento al cual se van a mudar es más pequeño, parece que a través de la mudanza desean una ampliación del espacio familiar, una ampliación de los vínculos, o sea la modificación de una relación predominantemente entre mujeres, a un proyecto de una relación más exogámica y heterosexual. Podríamos decir también, que tal vez es el cambio de un espacio donde predomina una estructura edípica negativa a otra donde predominaría una estructura edípica positiva. Esto tiene que ver con el conflicto básico que necesita resolver esta familia, el cual no es privativo de ella, es el mismo problema común, con variaciones propias y que sería: pasar de una relación predominante de consanguinidad y filiación, a una relación de alianza. Por eso aparece el tema de la deuda donde creo que también entran en conflicto, un reconocimiento y un intento de desconocimiento.

Quiero decir que en este momento, esta familia empieza a reconocer que tiene una deuda con la cultura; es decir que entran en contradicción las leyes propias que siempre estuvieron en vigencia en este grupo familiar (creo que las terapeutas han hablado bien de desmentida) con las leyes que la cultura

les opone desde otro marco de la realidad y parece que ellos han podido llegar a este punto justamente por todo el trabajo terapéutico anterior. Por eso es que pueden llegar a concebir la deuda como tal y tratar de saldarla, pero les resulta muy dificultoso como lo vemos en toda la sesión. Se hace referencia a las dificultades de conectarse con la inmobiliaria o con las terapeutas, que son agentes sociales y que tienen que ver con funciones de intercambio y de racionalidad, una racionalidad muy diferente a la de esta familia, intercambio además de lugares. La familia, que por un lado trata de oponerse al cambio y por otro está tratando de reconocer la deuda, intenta una defensa: convertir a las terapeutas en tías. Una especie de volver a una estructura inconsciente —básica— predominante de este grupo familiar que posiblemente tenga que ver con la relación con la familia materna, en todo caso se las convierte en familiares, están dentro de su propio grupo endogámico. Naturalmente esto está relacionado con la ausencia del padre. Ahora, vemos como la ausencia del padre genera determinados efectos. Se pone de manifiesto una relación entre hermanas que es una relación erótica o una relación autoerótica entre las dos. Con el cantito, ¡ay Esmeralda rascame la espalda! pero que empieza con un lamento, empieza con un ¡ay! Que frente a ese ¡ay! que tendría que ver con la falta probablemente, podríamos hacer esa hipótesis, aparece luego el Esmeralda rascame la espalda, la relación erótica entre hermanas.

Hay frases que son interesantes como cuando la madre dice: "vivimos separadamente". Separadamente, por una parte alude al problema de esta familia que está enunciado en el título del trabajo: pasar de la indiscriminación a una mayor discriminación en cuanto al recorte de los distintos aparatos psíquicos de los integrantes de este grupo familiar. Desde otro punto de vista, una de las cosas que se reactualizan en esta sesión, es una estructura histórica que tiene que ver con la relación con hermanas y podríamos pensar también en la historia de la madre que tiene dos hermanas, que son de otro matrimonio. Entonces al decir "vivimos separadamente" podría estar aludiendo, no en forma consciente por supuesto, que ella

viene de otro lugar en relación con sus hermanas. En la sesión son tres, así como ella es tres con sus dos hermanas, aunque una esté muerta. Lo cual alude a que ella viene de un padre diferenciado, un padre diferente. Me parece que esto podría estar apuntando también a que ahí hay un reconocimiento de un padre diferenciado y un padre diferenciado puede establecer diferencias.

El otro tema que está relacionado con esto es el de la devaluación. Por una parte este grupo parece sentir en este momento, que hay fantasías que ya no le sirven, pero creo que están en un intermedio y posiblemente la que esté mostrando más la contradicción en relación con la mudanza y pueda vivir la devaluación en dos sentidos diferentes, pareciera ser la madre. Es una figura clave en este grupo familiar. Por una parte posiblemente cuando ella dice: "lo primero que hay que cancelar son los créditos porque nos dan pérdidas, con los tratamientos cosechamos". Yo creo que ella tiene razón, ella se está dando cuenta de que con el tratamiento están realmente cosechando. Pero por otra parte también se muestra muy contradictoria, y con la devaluación podría estar aludiendo a un pérdida de ciertas fantasías que posiblemente tienen que ver con la idealización de alguno de sus miembros. Esto sería en relación de la madre consigo misma, ella perdería probablemente la idealización si esta estructura cambiara y perdería también el soporte que tienen sus hijas para mantener esa idealización. Por eso yo creo que acá aparecen dos tipos de defensa de la madre frente a esto, una que podría aludir más al autoerotismo, cuando ella dice que reza frente a esta situación conflictiva y la otra, más interesante desde el punto de vista del grupo familiar, al código de comunicación que tienen y qué efectos produce. Podríamos decir que la lectura de los mensajes es rápida, pero los mensajes que ella dirige a Daniela y a Patricia son distintos. Patricia funciona como de tejido interconectivo, ella está relacionada en esta sesión por lo menos, con casi todos los miembros de la familia y además también con el exterior. Es la que tiene que hablar con la inmobiliaria por ejemplo y creo que le sirve a la madre de apoyatura para su

palabra. La madre, cuando anuncia un tipo de juicio beneficioso para ella, busca inmediatamente el respaldo de Patricia y Patricia la apoya. Con Daniela es distinto. Fijense que a Daniela no la nombra, nombra a su marido, a sus otras hijas, a su yerno, a las terapeutas, a la inmobiliaria, pero a Daniela no la nombra. En realidad, esta actitud y la ausencia del padre son coherentes, tratándose de un grupo de estas características.

Yo no creo que la ausencia del padre haya sido motivada por la explicación racional que se ha dado, de un grupo así esperaríamos que en un momento conflictivo como éste se diera la ausencia del padre como algo que está diciendo, como algo que va más allá de la mera ausencia por motivos económicos, pienso que apunta a otra economía del grupo familiar.

Volviendo al modo de comunicación de esta madre con Daniela, pienso que el tipo de mensajes nos orienta para entender qué le pasa a esta chica y qué conductas pueden ser generadas en ella, a través de la palabra, no sólo de la madre sino de los distintos integrantes. La madre en un momento dado la descalifica, es cuando la hija dice que va a trabajar, que va a corretear fantasías, entonces la madre dice: "la gente vive de fantasías", además de esta descalificación, más adelante con un doble mensaje culpógeno le dice que por un lado no se quiere tratar y por el otro su tratamiento le va a hacer mal a todos ellos y que se van a contagiar. En realidad la que contagia es la madre. Y ¿qué contagia? Contagia el pesimismo. Cuando la madre dice: "estamos todos pesimistas", está hablando de todos, pero en realidad la que está pesimista es ella y yo diría que la que genera este tipo de afectos en los demás es la madre. A lo mejor ella hace lo mismo con el padre. Ella le decía a las hijas que le toquen la oreja al padre para conseguir de él lo que quieran. A lo mejor ella tiene una forma de "tocarle la oreja al padre" con las cosas que le dice, que genera luego de terminadas acciones o afectos en él, posiblemente similares a las que aparecen en Daniela. En Daniela no genera afecto, estimula la acción, la impulsa, no conscientemente a actuar. Podríamos hablar también del terapeuta chusma, que probablemente tenga que ver con una cierta vergüenza social

que puede tener este grupo familiar, con temor a que circule en el exterior su historia sexual. Desde otro punto de vista podría ser también que Daniela reaccione y se alfe con el grupo familiar, descalificando al terapeuta que representa al exterior.

Es interesante cómo se llega al final de la sesión.

Esta comenzó por el anuncio de la falta reconocida del padre, luego se llega al núcleo de la cuestión que es la mudanza. En el pasaje de un espacio al otro aparecen las actitudes contradictorias, las defensas de cada uno y finalmente se termina después del pesimismo en: Patricia apoyando a mamá, Daniela nuevamente excluida y diciendo que quiere dejar el tratamiento.

Doctor Octavio Fernández Mouján: Quiero concertar algunos hechos que me parecen claves para contestar mi pregunta ¿con qué mejoró esta chica en estos tres años de tratamiento? Los temas en los que me gustaría teorizar un poco son: la violencia, la complicidad, la seducción y la bisexualidad. Empezaría por la violencia, todos sabemos que el movimiento natural de todo grupo aglutinado es la violencia, la explosión, por algo se los llamaba también grupos epileptoides. Acá la violencia está engendrada desde dos polos, por un lado está la violencia que más que fundar una relación madre-hijo familiar, lo único que hace es quebrar y romper para que cada uno quede librado al otro, o sea es una violencia que no discrimina. Esto es interesante porque a veces la violencia puede discriminar, pero en este caso, no lo hace, solamente logra romper el vínculo madre-hijo. Con esto quiero decir que cuando se rompe la pareja madre-hijo, cada parte queda ligada con la otra, los vínculos narcisistas permanecen entre madre e hijos. Esta violencia, es importante considerarla en cuanto que, la función padre queda seriamente perturbada y esto es lo que dificulta que dentro de la familia se estructure la posibilidad de un espacio discriminador que permita a la familia funcionar como grupo familiar. Esto creo que fue uno de los logros de la terapia. Otro tema ligado a éste es la complicidad. Ellas utilizan la palabra ocultamiento, a mí me gusta más la palabra complicidad, porque considero que ésta es una madre cómplice con sus

hijas de excluir al padre y toda madre cómplice de sus hijos queda ligada a ellos, los toma como instrumento y el grupo cae en lo que podríamos llamar una relación (que después vamos a ver cuando hablemos de bisexualidad) no discriminada. En otros términos es una castración imaginaria, lo cual es lo que prima dentro de este ámbito familiar. Todo esto está muy ligado al problema por el que consultan que es la hija menor. Esto suele suceder con los hijos menores porque ellos son los que cierran el ciclo paterno. Se cierra el ciclo sexual paterno a través del hijo menor y queda entonces la madre como eternamente madre a través de este vínculo que aparece como instrumento de sus gratificaciones. Esto está ligado al otro concepto que quería traerles que es el de bisexualidad. A través de la bisexualidad se mantiene este vínculo donde el padre queda afuera y entonces las hijas y la madre funcionan bisexualmente. Después vamos a ver cómo se utiliza la seducción para mantener esta bisexualidad. Cuando la seducción se concreta en actuación sexual, aparecen los grandes dramas violentos. La bisexualidad funciona como una castración imaginaria, se puede imaginariamente funcionar con un sexo o con el otro, pero cuando se llega a la actividad sexual que es lo que pasa en un momento determinado, aparece la gran violencia de tres intentos de suicidio en una semana. Eso se debe a que la bisexualidad mantenida hasta este momento dentro de este grupo familiar, aglutinado por esta madre y por un padre ausente y violento, por lo tanto no discriminador, crea una herida narcisística de tal magnitud que provoca una gran violencia. El padre aparece ya no como algo imaginario, sino como algo concreto, cuando se consuma el acto sexual, eso rompe e invade directamente este maternaje, este matriarcado donde la madre y sus hijas se mantienen en este vínculo bisexual. La seducción sería el otro elemento importante, hay ejemplos abundantes de seducción en este material, no solamente porque la madre recomienda cómo se tiene que seducir al padre; porque se suceden actos de seducción permanentemente con el médico, con el empleado de comercio, con el primo, etc. Acá la seducción, complicidad y violencia entraría ahora muy

trabajo que está haciendo es adecuado, es probable que alcance su objetivo.

Si el problema definido era controlar la conducta de Daniela, pienso que provocando ciertas respuestas en los padres se hubiera podido definir a la joven y al mismo tiempo alentando la alianza entre ellos, se lograría destacar los diferentes roles que tienen que implementar cada uno en esta tarea.

Creo que diferenciaría mucho, la cuestión del trabajo común en relación al trabajo específico, ya que efectivamente esta es una familia muy poco discriminada. El tema de trabajo de las diferencias entre los distintos miembros me parece importante. El padre no está y supuestamente es importante que venga. ¿Qué se puede hacer con eso? Otra posibilidad es pensarlo desde la misma perspectiva: que el señor no viene porque está haciendo serios esfuerzos en otro lado, para sacar adelante la familia y seguramente se puede tomar esto como un mensaje, en el sentido en que él lo está expresando, que en este momento necesita más trabajar que venir a las sesiones. Puedo responder a esto proponiéndoles espaciar las sesiones, lo que creo les devolvería a ellos cierta posibilidad de decisión respecto a elegir y sobre todo, yo creo que es importante enfatizar el trabajo común de la pareja desde ángulos diferentes y los distintos roles de cada miembro. Si los cuatro participantes más importantes de la terapia familiar, además de los terapeutas, coinciden en que el trabajo consiste en prevenir las crisis de Daniela, por ejemplo creo que es posible discriminar el trabajo que cada uno debe cumplir para que esa tarea se realice y establecer ciertas pautas de referencias comunes, también para que cada uno pueda evaluar lo que el otro está haciendo. A mí me resultaría difícil ayudar a esta familia a discriminarse, a menos que yo tuviera muy claro qué trabajo encomendarles que les sirviera de vehículo para lograr su definición. Cuanto más preciso es este trabajo, más fácil resulta. Creo que estos enfoques son complementarios en un aspecto, pero también se relacionan con modelos que ponen énfasis en otros puntos.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Yo tampoco podría pensar de la manera que vos lo hacés, porque los modelos son

distintos y uno trabaja en familia con el modelo que considera más eficiente.

Esta familia llegó a la consulta en situación de emergencia. De entrada pidieron la internación de Daniela.

Licenciado Hugo Hirsch: Este es un recurso que suele utilizarse. Cuando los padres no saben cómo controlar la situación, piden la intervención del juez de menores o de la policía.

Licenciada Alicia B. de Gibert: En algunas circunstancias la policía fue llamada para amenazar a Daniela con quedar bajo el juez de menores o presa, si seguía con esas actuaciones. Nosotros en ese momento jugamos un papel bastante importante porque no aceptaban el tratamiento individual. Estábamos a cargo de una paciente grave que no tenía tratamiento individual. Nosotros decidimos no internarla y tratarlos a todos juntos, porque además pensamos que ellos no podían acceder al tratamiento individual porque no podían tolerar la individuación en ninguno de sus miembros y que la única posibilidad era ésta de tratarlos a todos juntos. Desde ya nosotros utilizamos un modelo psicoanalítico donde hicimos en algún momento las cosas que nos planteás pero no las únicas. Utilizamos distintas estrategias y diferentes recursos según la evolución del proceso terapéutico. En el momento de la internación se tuvieron que definir muy claramente las funciones profesionales, el terapeuta individual ser terapeuta individual, nosotras terapeutas familiares y el director de la clínica tomó la función de médico administrador, el objetivo fue dar justamente las pautas para comportarse con ellos, pero en un momento empezaron a aceptar su indiscriminación y su problema de identidad como grupo total. A partir de ahí el director de la clínica se encargaba de indicar qué podían hacer y qué no podían hacer, funcionó como una autoridad desde afuera y ellos empezaron ahí a recurrir recién como pareja, como padres que no sabían qué función podían tener.

Doctora Diana Pavlosky: Es importante destacar dos etapas, una primera es cuando ellos vienen con un pedido de

internación y nosotras decidimos no internar a Daniela y una segunda etapa en donde sí se la interna.

Nuestro objetivo en la primera etapa era dar la posibilidad de trasladar la situación a toda la familia y evitar así que Daniela fuera la depositaria de la disfunción del grupo familiar. Nuestro temor era que Daniela iba a ser depositada en un lugar neuropsiquiátrico en algún momento y la familia no se iba a hacer cargo de participar de otra manera. En cambio durante el segundo período la familia empezó a poder actuar y participar mucho más intensamente en el tratamiento.

Licenciada Alicia B. de Gibert: En esta segunda etapa se produce un cambio importante en el padre, cuando se interna Daniela, el padre dice: "me juego con todo". Es cierto que ellos perdieron cosas, como vos decías perdieron bastante. Se juntó toda la situación del tratamiento con la crisis general del país, con la depresión del padre, pero sin embargo ellos demuestran mucho agradecimiento por este cambio. Lo que Moujan decía con respecto a la inclusión del padre. El padre en determinado momento nos dijo que él nos iba a avisar cuando ya no diera más por su situación económica. Nosotras lo que le pedimos, fue que nos avisara con tiempo como para poder manejar la internación y que esto no fuese una situación impulsiva y brusca, como algunas veces había amenazado ser y realmente esta posibilidad que jugó el padre en el tratamiento fue para él una cosa muy importante: su inclusión.

Doctor Octavio Fernández Moujan: Releyendo la historia, considero que el punto clave fue el momento de la internación porque, justamente a partir de esa internación, que duró ocho meses, empieza realmente la pareja de los padres a cambiar. Es imposible resolver el problema de la bisexualidad si no está claramente distinguida la función padre de la función madre. A partir de la internación el padre vende la casa, deja de funcionar como alguien idealizado, onnipotente, decide poner su casa en un lugar más cercano y desliga a su esposa de su madre y hermana. El padre ahí paga sus deudas, se emociona, se deprime, como consecuencia cambia totalmente su figura y entra directamente en el ámbito familiar con otra función.

Licenciada Alicia B. de Gibert: La mudanza y la pérdida económica tiene un significado importante porque, por primera vez, la familia se hace eco del proyecto del padre y la madre va hacia él.

Doctor Octavio Fernández Moujan: Yo creo que ahí se funda la familia, porque la violencia deja de ser violencia y pasa a ser discriminación.

Doctora Diana Pavlosky: La otra cosa importante que coincide con esta situación es cuando Patricia se va de la casa a vivir a un departamento que le habían comprado los padres para cuando se casara. El padre colabora mucho con ella, se incluye más intensamente en la relación con la hija del medio.

Licenciada Alicia B. de Gibert: La mudanza fue una situación muy conmovedora. Nosotros pudimos hacer el abordaje de la problemática de la pareja recién en ese momento y las diferencias entre ellos era otro de los temas que ellos no podían mostrar.

Nosotros consideramos que la familia estaba en un período de crisis: la mudanza, el acomodar a su hija menor como hija menor y como hija adolescente, el aceptar el nacimiento de un nuevo nieto y la ida de Patricia. Es decir que había toda una serie de cambios muy importantes, muy difíciles de absorber. Desde nuestro punto de vista, ellos empiezan a hacer cosas juntos, tal vez por primera vez.

También, hay un abordaje de la intimidad, que en principio pasa por una situación de ocultamiento pero luego ellos ven la necesidad de pedir ayuda. Esto es un poco la idea de por qué seguimos.

Licenciado Hugo Hirsch: Mi pregunta no era tanto por qué siguen, sino qué se proponen en ese momento, porque tiendo a pensar más en oportunidades diferentes para trabajos terapéuticos que pueden estar emparentados, pero que son básicamente distintos, que en una historia en crisis sucesivas. Por ejemplo creo que hay una crisis que coincide con el momento en que ustedes se hacen cargo de esta familia, creo que ahí hay algunas pistas para una estrategia terapéutica en la que yo creo que hubiera tendido a tratar de correr la paciente identificada y

ubicarla en Patricia. Pero ese es un momento, hay una posibilidad y también una cantidad de estrategias. Hay otro momento que coincide con el comienzo de las relaciones sexuales de esta chica los tres intentos de suicidio, la internación y la crisis que se produce, lo demás creo que todo el mundo estuvo de acuerdo. Los padres quedan tan confundidos por el golpe que es el momento perfecto para un trabajo terapéutico importante. La crisis es en sí misma una oportunidad de trabajo más rica que otro momento. El tercer momento aparece y creo que esto está cerca del material, con todo este problema económico, mudanza, etc. Ya sé que están ligados, pero creo que es posible conceptualizarlo como tres oportunidades terapéuticas distintas, cada una de ellas con una estrategia terapéutica particular. Cuando yo mencionaba esto hace un rato, estaba tratando de abordar una de ellas, sin referencia a la anterior.

Doctora Diana Pavlosky: Estaríamos de acuerdo con lo que decían vos y Moujan, en cuanto a que la mudanza era toda una situación simbólica, que implicaba un cambio de espacio familiar, un cambio de estructura de la familia con la inclusión del padre.

Licenciado Hugo Hirsch: Digamos que la mudanza fue la situación simbólica que permitió la inclusión del padre.

Licenciada Gisela Ahlin: Yo agregaría algo respecto a lo que se estaba definiendo como objetivos o metas terapéuticas. Evidentemente, desde posturas teóricas diferentes, los objetivos y las metas terapéuticas son diferentes también. Cuando se hablaba de cuál tendría que ser la tarea específica, desde mi punto de vista es tratar de facilitarles, sin imponer nada ni forzarlos para que cambien, la elección del tipo de vida que desean a partir de sus propias posibilidades y estructura mental.

Efectivamente, estoy de acuerdo que Daniela es la paciente identificada, por lo tanto trabajaría con el grupo familiar para lograr que pudieran pensar. Trabajar con la pareja sería también un cambio de estrategia cuyo objetivo sería poder discriminar la pareja en medio de este conglomerado confuso y empezar a poder recortarse determinadas funciones. Pero siempre tratando de que sean ellos los que deciden sus cambios.

Público: Eso quedó claro en la presentación del material y de las distintas posturas en la modalidad de abordaje. Tomando notas de las posibles modalidades de abordaje pienso que no quedó claro por qué para esta familia es tan importante la discriminación de roles, la discriminación de cada uno en su función y en el espacio. ¿Por qué el papá no quiere estar presente? ¿Por qué una sesión de mujeres? ¿Cómo esta familia se relaciona entre sí? ¿Qué conciencia hay y cómo se establecen los vínculos entre los miembros presentes en la familia? Hablaron de mudanza, del factor económico, yo me pregunto: ¿qué pasó con el valor afectivo de una mudanza? ¿Qué pasó en las mujeres? ¿Y el padre? ¿Qué era esta mudanza para cada miembro de la familia? El papá por ejemplo, ¿era un ausente como padre y como esposo? No sé si ustedes han trabajado eso, ¿cómo, cuándo? En función de la discriminación de roles y el espacio de cada uno.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Te voy a contestar claramente. Nosotros tomamos esta sesión especialmente porque justamente es una sesión donde el padre está ausente.

Doctor Octavio Fernández Moujan: Se hace sentir su ausencia. Eso es importante. Porque una cosa es una ausencia como era antes, en un vínculo imaginario donde se evita sentir la falta, pero se empieza a sentir la falta del padre, por lo tanto se crea un nuevo espacio y hay un deseo. Esto para mí es importante en cuanto a que éste es un material de una familia ya bastante trabajado donde se logra hacer presente la ausencia del padre. El padre ya no tapa nada, no es un objeto imaginario cualquiera. Es un padre que se lo extraña, se lo necesita, hay que pagar cosas.

Público: A eso me refería y cómo se explicita esa ausencia, necesitada o no. ¿Por quién es necesitada? ¿Por todos? ¿Por algunos? ¿Se lo reconoce como padre, como par? ¿Le importa a la esposa, a los hijos? ¿A cuál más a cuál menos? En función de eso se podría establecer una discriminación desde los roles, desde el hombre y la mujer, desde el padre, la madre y las hijas, desde el vínculo distinto con cada uno.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Habitualmente la que traía

al padre a la sesión, la que se ocupaba de él y también la que lo celaba, en vez de la madre, era siempre Daniela. Nosotras creemos que en esta sesión hay una situación de cambio. Daniela aparece como la que de alguna manera rompe la situación e intenta que no se hable del tema que se está tratando. De alguna manera la madre descalifica al padre diciendo que no se ocupa o que se tendr a que ocupar m s de Patricia. En esta sesi n nos parece llamativo que Patricia sea la que se hace cargo del problema de la venta, la que est  angustiada, la que se preocupa, la que se acerca a los problemas del padre.

P blico: Cuando Patricia anuncia que se va a mudar, Daniela anuncia que ella est  cansada del tratamiento. Ella es la paciente identificada, ella est  hablando del tratamiento como de una mudanza, como de terminar con una situaci n.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Yo creo que es cierto lo que ustedes plantean. Ac  hay una cosa que es importante. Daniela se siente responsable. Siente, como en parte ha sido cierto, que por el tratamiento de ella los padres se endeudaron. Este es un tema que a ella la angustia mucho en toda la secuencia del tratamiento, porque el tema del dinero justamente, la ubica a ella en el motivo de la cuesti n y entonces ah  ella hace una protesta y por otro lado quiere que ese tema no se toque.

En ese sentido hace como una alianza, tambi n en esta sesi n, con la madre en la medida en que trata de negar el problema econ mico, el de la mudanza y vuelve a decir que no quiere tratarse.

Por otro lado quiere salir a trabajar, que en cierto sentido es despegarse; esta sesi n es casi inmediata a la salida de la cl nica o sea que, a nuestro parecer ella se plantea nuevamente un rol muy exigido, no termina de salir de la cl nica y ya est  trabajando para ayudar a la familia, lo que de alguna manera implica volver a la estructura anterior, no permitir el abordaje de esta nueva situaci n que es el problema econ mico.

Por otro lado el padre se hace cargo de la situaci n econ mica y responde valorando mucho el tratamiento.

P blico: Es decir que el padre le est  agradecido a Daniela por haberle permitido gastar tanto en ella, en su internaci n. Es el que se hizo cargo de todo esto y curiosamente Daniela siente culpa, es todo una distorsi n.

Doctor Octavio Fern ndez Moujan: Ah  est  tu proposici n: aliarse m s al padre.

Licenciado Hugo Hirsch: En varias direcciones, una, redefiniendo la conducta de  l que ah  est  como resistencia, como colaboraci n; dos, la misma conducta de Daniela puede ser definida tambi n como resistencia o como colaboraci n.

Doctora Diana Pavlosky: Nosotros pensamos durante todo el tratamiento que el padre fue la persona que m s colabor . Hubo momentos de resistencia y dificultad producidos por la actitud de violencia de  l, pero ha colaborado siempre.

Licenciado Hugo Hirsch: Si la chica se siente culpable tiene una raz n y si quiere terminar su tratamiento como modo de colaborar en que sus deudas se paguen m s r pidamente tambi n.

Doctora Diana Pavlosky: A nosotras nos preocupaba esto de la terminaci n del tratamiento para pagar las deudas a partir de ella misma, porque esto es como un nuevo sacrificio. Ella no tuvo posibilidades de un lugar  ntimo, los padres la met an en el medio de la cama por ejemplo. Y el tratamiento individual, s  es un espacio propio, personal y discriminado.

Licenciado Hugo Hirsch: Ocho meses de cl nica tambi n es un espacio muy personal.

Doctora Diana Pavlosky: S , con posturas diferentes.

P blico: Respecto al espacio y el lugar que ocupa cada uno en esta situaci n de mudanza,  c mo est  distribuido el espacio que Daniela va a tener en su casa?  Y Patricia?  Y el padre?  Y qu  lugar tiene la madre en la casa?

Licenciada Gisela Ahlin: Me parece que reci n se estaban mezclando algunos conceptos. Ser a importante diferenciar dos niveles: el de las relaciones manifiestas o el de lo emp rico y el que da sentido a estas relaciones manifiestas, que tiene otro sentido m s inconsciente. Por eso, me parece que tal vez trabajando con esta familia, yo no dejar a de ning n modo de lado el problema econ mico real que tienen, pero tampoco me

quedaría solamente en ese problema. Trataría de que ellos entendieran que ese es un problema, que lo tienen que resolver y ver cómo lo resuelven.

Pero el dinero o la distribución del espacio u otro tipo de situaciones que pueden hacer a lo manifiesto, además de tener sentido simbólico, nos muestran las funciones que ellos cumplen y la forma de relacionarse entre sí, apuntan a una estructura más inconsciente, quiero decir que es comprensible que esta familia tenga problemas si tiene que pasar de una casa más grande a otra más chica o si tiene que hacer una serie de sacrificios como vender la casa, son situaciones difíciles. Esto es interpretable y entendible y tienen que ser ayudados. Pero hay otra situación y otros espacios. Cuando ellos se están mudando de una casa a otra, recuerden que la madre no quería dejar una casa que estaba cerca de su hermana y de su hija, para pasar a otra que estaría cerca del negocio del marido, lo cual tiene que ver con un espacio mental diferente. Creo que tal vez tu pregunta apuntaba al espacio que ocuparía luego cada uno en la casa, el cual está directamente relacionado con el lugar que cada uno tiene en esa estructura inconsciente que rige las relaciones de esta familia. Son niveles diferentes y ambos atendibles. Pienso que se mezclaban en un mismo nivel, elementos que a mi juicio pertenecen a dos niveles diferentes.

Público: A propósito de lo que vos decías ahora, qué función o rol dentro de la estructura familiar cumplía la hija mayor casada ya que es, por lo menos en la historia clínica, el detonante de un cambio que hasta ese momento no se expresaba en la conducta de Daniela. En mi opinión, ese personaje hacía de representante de algo que no se podía decir de otra manera, más que a gritos, por lo menos en la voz de Daniela. Seguramente no era sólo que faltó la hermana casada del grupo familiar, en ese momento ella pasó a formar una pareja, se concretó además la paternidad y éstos son elementos que obviamente tocaban el punto álgido de la familia. Por otro lado quisiera saber si hay alguna anécdota con el cambio de sexo del terapeuta de Daniela. En un momento determinado estaba en manos de una terapeuta mujer, pasa a un varón.

Creo que esto es significativo, sobre todo por toda la historia de heterosexualidad.

Coincidiendo con lo que Octavio refirió acerca de la importancia de la internalización de la figura del padre, en el sentido de poder él sentirse más integrado con la posibilidad de desarrollar algo que hasta ese momento no tenía espacio. Creo que en ese sentido debe haber colaborado también como figura masculina, el administrador, el director de la clínica.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Sí, sí. Ese fue el padre.

Público: Y hay otro aspecto más en relación al padre que me llamó la atención, pienso que a lo mejor pudo hacer todos estos cambios con más facilidad porque dentro de su historia aparece como el último de los hermanos y a los siete años se tuvo que ir de la casa. El perdió su núcleo familiar. No sé que habrá pasado ahí, pero eso obviamente repercutió bastante y se nota después en una búsqueda desesperada de su lugar perdido. Quién sabe qué influencia habrá tenido la muerte del hermano y lo que representaba para él ese hermano.

Licenciada Gisela Ahlin: Parece ser que el detonante de la consulta fue el nacimiento del sobrino de Daniela, el nieto de los padres, yo me pregunto de qué manera eso produjo la consulta. Supongo que para cada uno de los miembros del grupo familiar debe haber tenido un sentido diferente. De todos modos, creo que no se puede establecer una causalidad lineal, nacimiento del chico-síntomas de Daniela. Es interesante observar de qué manera la madre puede generar, a través de su modo de comunicación, efectos en la hija. Ella se pone pesimista y Daniela se pone actuadora, si también el nacimiento de este chico tuvo efectos importantes para la pareja de los padres, para la madre por ejemplo, ella pudo haber variado ese modo de comunicación, con algunos efectos rebote en Daniela. De hecho pone en evidencia también una alianza, cosa bastante problemática de aceptar para este grupo. Entonces uno podría pensar que la madre u otros miembros del grupo tuvieron determinados modos de actuación que generaron en Daniela un tipo de respuesta, esto unido por supuesto al propio aparato psíquico de Daniela. La otra cosa que pensaba es que debe

haber sido difícil para las terapeutas, trabajar con este grupo porque había un solo hombre y tienen que haber estado permanentemente alertas para evitar entrar en la alianza con las mujeres.

Licenciada Alicia B. de Gibert: La terapeuta que nos había derivado el caso, describió a Daniela como una chica sumamente agresiva y violenta que amenazaba con agredir por lo tanto era conveniente que la tratara un hombre que pudiera incluso contenerla físicamente, como en verdad tuvo que hacerlo en muchos momentos. En un principio, esa fue una medida práctica que tomamos; pensar en una persona hombre y médico. Eso respecto a la indicación del terapeuta de comienzo. Nosotras también pasamos por situaciones de muy difícil manejo, por la violencia de toda la familia, por las actuaciones y la gravedad. En determinado momento de la internación esta chica estaba muy violenta y llegó a amenazar con vidrios y cuchillos, ahí se incluyó el terapeuta individual, ella le hizo todo tipo de pruebas desde esconderse hasta atacarlo físicamente, una serie de hechos anecdóticos que confirmó la necesidad de la inclusión de un hombre. Nosotras contratransferencialmente, estábamos en determinado momento muy asustadas. La inclusión del terapeuta individual, en la sesión familiar hizo que todos pudieran aceptar que ella se tratara individualmente. Por eso te decía que en el curso del tratamiento uno utiliza diversas técnicas en distintos momentos del proceso.

Doctora Diana Pavlosky: Otro hecho importante durante el curso del tratamiento que no incluimos en la historia por la cantidad de datos, fue que una de las terapeutas se embarazó. Yo seguí trabajando con ellos y vi que estaban muy asustados frente a esta situación porque los embarazos habían sido concomitantes de dificultades en la familia: cuando nace Daniela, se muere la abuela materna además a partir del embarazo de la hermana se inician también dificultades familiares. Esta situación fue bien tolerada por todos y yo pude sentirme bien con ellos también.

Licenciada Alicia B. de Gibert: En esta familia había dos miembros excluidos: Daniela y el padre. Es decir que estaban

unidos por la exclusión, ya que a Daniela también se le ocultaban cosas. La mayor parte de las cosas las sabían las dos hijas mayores. Respecto al nacimiento, ellos hacen una crisis con el nacimiento del primer nieto y aparecen todas las fantasías de la madre frente al hecho de ser abuela y morir como le había pasado a su propia madre.

Público: La reacción de Daniela cuando tiene su sobrino me hace acordar, en mayor escala, a una reacción de un hermanito celoso.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Los padres no estaban celosos, no tenían ningún problema por ser abuelos, tampoco el casamiento les había provocado nada, en realidad en este último período recién aparece el temor a las canas, al envejecimiento y a aparentar más de la edad que tienen.

Doctora Diana Pavlosky: Ellos funcionaban, en parte, como jóvenes en la familia, ese casamiento, ese nacimiento desencadena la crisis de la edad media.

Público: O sea una familia que no tolera el paso del tiempo.

Doctor Octavio Fernández Moujan: El casamiento de la hija mayor no fue problema porque ante cada crisis vital: casamiento, nacimiento, se incrementan las defensas de la estructura patológica de la familia y el hecho no incide, se casa la hija mayor y Daniela incrementa sus síntomas, por lo tanto la familia vuelve a encontrar su equilibrio. Ahora tiene otra estructura, ha pasado de un espacio imaginario saturado, a un espacio donde realmente hay una posibilidad de diálogo y de intercambio. Es una familia aglutinada donde no hay ningún tipo de espacio, donde todo es saturado, salen de lo imaginario y desde lo real empiezan a ver el paso del tiempo. Mientras tanto la familia no evidenciaba problemas frente a acontecimientos como el casamiento de la hija mayor o el nacimiento del bebé, se incrementaban los síntomas y así se mantenía el equilibrio. Hasta que no se rompiera esa estructura, ningún hecho por más importante que fuera iba a afectar a la familia. Cuando empezaron a modificarla, el padre recupera su función,

salen de este espacio imaginario y dentro de un espacio más real los roles se discriminan mejor.

Cualquier hecho económico, de mudanza, de nacimiento ahora sí va a afectar, antes no, el recurso era incrementar los síntomas con el objeto de volver a su homeostasis patológica.

Doctora Diana Pavlosky: De todas maneras digamos que la incrementación de los síntomas fue lo que permitió la consulta.

Doctor Octavio Fernández Mouján: Ese es otro problema.

Licenciado Hugo Hirsch: Yo considero que toda terapia familiar es en principio sintomática, y a menos que se produzca un tipo de intervención que rompa este círculo, no hay ninguna posibilidad de acceder a una reorganización real, en este caso yo creo que la intervención terapéutica principal fue la internación y ésta incluyó en términos de lo que decía Octavio antes, un tipo de violencia que no estaba presente en la familia, y que sirvió para discriminar, a partir de ahí se rompe este circuito defensivo y es posible una reorganización. Esto siempre se consigue cuando se bloquea el circuito de producción del síntoma.

Licenciada Alicia B. de Gibert: ¿Por qué se dio el proceso de cambio en esta familia?

Doctor Octavio Fernández Mouján: Un factor muy importante, fue el momento de la internación. Cuando se incrementaron los síntomas de Daniela, el equipo terapéutico tomó la decisión de la internación, ésta sirvió para reforzar la función paterna, discriminadora, creo que ahí se dieron los cambios fundamentales, descubrieron el paso del tiempo y la pareja empezó a diferenciarse. Esto era imprescindible para la elaboración de la bisexualidad, los vínculos con los terapeutas facilitaron la aparición de una nueva imagen de mujer, no seductora, no castradora, como figura de identificación. Creo que esos factores: la internación, la figura de un padre discriminador, de una madre que aparece con otro tipo de manejo respecto a la relación entre mujeres, fueron fundamentales para abrir este espacio dentro de la familia que estaba saturada, aglutinada o como queramos llamarla.

Licenciado Hugo Hirsch: En todo caso completando lo que

Octavio acaba de transmitir, esa internación sólo es eficaz y tiene sentido en función de la relación terapéutica previa, o sea si ustedes hubieran tomado la decisión de internarla a pedido del padre la primera vez no hubiera servido para nada.

Licenciada Alicia B. de Gibert: Sí, todo ese proceso fue necesario, entrar y salir en el juego de esta situación familiar sirvió para mostrar que se puede salir del mismo y pensar.

Nosotras a veces, nos hemos preguntado, por qué siguieron con el tratamiento, por qué no dejaron antes, pensamos que no tuvieron acceso a los tratamientos individuales, por eso éstos fracasaron, en cambio aceptaron la terapia familiar. Por otro lado el habernos dado tiempo para seguirlos acompañando y facilitarles la discriminación en cada momento, hizo que pudieran sentir que todos necesitaban un espacio y un tiempo. Lo básico de la internación fue que les permitió empezar a cambiar la estructura de la familia.

MRI

A BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH
AND TRAINING INSTITUTE FOCUSING
ON THE INTERACTIONAL VIEW OF
THE INDIVIDUAL, THE FAMILY, AND THE COMMUNITY

Second International Conference of the
Mental Research Institute

July 6-8, 1984
Munich, Germany

For information, write to: Diana Sullivan Everstine Ph.D. — MRI —
555 Middlefield Rd. — Palo Alto California 94301 — USA

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE

Summer Practicum in Family Therapy Rome, June 1-25, 1983

OBJECTIVE: To enable foreign therapists to gain experience in our model of therapy, supervision and training.

ORGANIZATION: Dr. Andolfi will lead the English speaking group. Groups in French will be led by Drs. Menghi, Nicolò and Saccu.

ACTIVITIES: Clinical work, participation in training groups, observation of direct supervision, theoretical seminars, study of clinical videotapes, indirect supervision, simulations, teaching related to leadership of training groups, a two-day workshop will be offered. Instruction will take place

four days per week for a total of 100 hours over the four weeks.

ELEGIBILITY: A minimum of three years training in family therapy and clinical experience in the field. Preference to teachers of family therapy. Priority on the basis of the date of application and professional experience.

FEE: \$1,400. A non-refundable deposit of \$400 will be required upon acceptance to hold your place. The remaining \$1000 is payable at the beginning of the program.

APPLICATION: Application forms must be received, together with applicants Curriculum Vita, by March 1, 1983. Candidates will be notified of their acceptance by March 20th. Late applications will be considered only if space is available, at an extra charge of \$50.

REGISTRATION

To reserve your place,
mail this registration form to:



Maurizio Andolfi
ISTITUTO
DI
TERAPIA FAMILIARE

via Reno, 30
00198 Roma

Make checks payable to
Paolo Menghi

For further information write to
Daniela Piccone at the above address,
of phone at (06) 426790.

Name
Address
City
State Zip
Office Phone
Home Phone
Profession
Degree

Check off your choice below:

- ☐ Summer Practicum 1983
☐ Please put me on your waiting list for 1984

Date

DIALOGO DEL DOCTOR ALFREDO A. CANEVARO CON EL DOCTOR CARLOS E. SLUZKI

Doctor Alfredo A. Canevaro: ... mirada abarcativa sobre este enfoque amplio, clínico, sólido que das desde un punto de vista teórico, estratégico y técnico.

Doctor Carlos E. Sluzki: Lo que he planteado en el curso y que me parece un punto importante de subrayar, es que en el campo de la terapia familiar hay desarrollos que tienen que ver con modelos de base, desarrollos que tienen que ver con modelos clínicos y otros que responden a ciertas necesidades, diría de mercado, que llevan a demarcar excesivamente territorios dentro del campo de la clínica. Los enfoques interaccional, estratégico y estructural, por ejemplo, son variedades de la "especie" sistémica, conceptualmente continuos; sin embargo, dado que se los demarca separadamente, pasan a ser percibidos como discontinuos o pertenecientes a clases distintas. Me refiero a lo siguiente: para poder trabajar coherentemente se necesita una epistemológica clara dentro del campo de las posibles organizaciones del conocimiento, tener claridad acerca del modelo que uno elige para recortar la realidad y organizar

la información. A partir de un paradigma de base conceptual claro es posible definir y desarrollar diversos modelos de observación y organización de la realidad, es decir modelos centrados en distintos observables, todos los cuales encajan en el paradigma general, con la lente con la que uno recorta la realidad. A partir de estos modelos intermedios se desarrollan las orientaciones o estrategias terapéuticas específicas coherentes. Es decir, es partiendo de esos modelos intermedios que uno puede desarrollar una serie de estrategias, tácticas y técnicas terapéuticas específicas y en muchos casos, idiosincrática (ya que la implementación de técnicas deriva no sólo de la prescripción de la técnica digamos así, sino también de características estilísticas del terapeuta, así como de las características del sistema más amplio que incluya al terapeuta y la familia). Si en lugar de partir de una base epistemológica ceñida para desarrollar estrategias y técnicas amplias, se toma como punto de partida las técnicas específicas dentro de la terapia familiar, se recorre como un camino inverso, y depende, a mi criterio, de que uno se embandere a ciegas con uno y otro estilo y conjunto de técnicas, no por razones conceptuales sino sólo por razones de mercadotecnia.

Si uno se embandera con las técnicas y no con los modelos de base, acaba por empobrecer el repertorio de posibles accesos a la familia, posibles intervenciones de posibles niveles alternativos de análisis, igualmente coherentes con la lente, con el modelo general. Este empobrecimiento, se puede entender a veces en la gente que comienza a trabajar en terapia familiar porque, dada la variedad del repertorio de estrategias y de modelos intermedios alternativos, uno quiere empezar por alguna parte y quiere tener un modelo seguro o, más que todo, sentirse dueño del campo, en lugar de estar flotando en un área amplia y compleja. Esa selección medio fanática de un conjunto específico de técnicas y esa ilusión óptica de suponer que esas técnicas constituyen "la terapia familiar". Pero después, a menos que uno tenga conciencia que lo que hizo fue una selección arbitraria llevada a cabo por uno al servicio de la propia necesidad, se puede caer en el error epistemológico de

suponer que el recorte del mapa constituye el territorio, para usar la metáfora de Korzybski y no es para nada así. Inclusive nuestro mapa, si llamamos así a nuestra epistemología es un mapa sumamente rico por la cantidad de elementos que tiene en cuenta pero mapa al fin. Un mapa orográfico no es *el* mapa de la región: un mapa orográfico es un mapa orográfico. Si nosotros nos confundimos y decimos que el mapa orográfico de esa región es equivalente al mapa de la región, nos sirve perfecto para navegar los ríos pero no nos sirve para viajar en ómnibus, tren o auto, ni para entender sobre seguro dónde hay montañas y valles. Si queremos trabajar con el máximo de herramientas conceptuales y técnicas y tenemos que ampliar al máximo nuestro repertorio de estrategias y técnicas y a nivel de análisis dentro de los confines de nuestro modelo epistemológico. Para diagramar estas ideas, se puede dibujar (fig. 1) como una pirámide cilíndrica (o un ángulo) donde, desde la punta central (el ángulo) hacia la periferia, el vértice corresponde a niveles epistemológicos, una zona intermedia más amplia a niveles estratégicos y niveles de análisis y más amplio todavía, al nivel de las tácticas y las técnicas en las que se incorporan características estilísticas del terapeuta y elementos de la interfase con la familia específicamente. El imperativo ético de nuestra profesión consiste en aumentar el repertorio, aumentar los grados de libertad de la familia. Tenemos que ser coherentes nosotros mismos con ese imperativo ético y aumentar al máximo los grados de libertad de nuestra acción terapéutica dentro de un marco epistemológico claro.

Doctor Alfredo A. Canevaro: ¿Cuando vos decís "nosotros pensamos que", corresponde a un grupo de teóricos y de clínicos que piensan lo mismo o pensás desde el punto de vista de una escuela de terapia familiar? Con esto quiero preguntar si la amplitud de tu enfoque radica en una experiencia vital, clínica cimentada a lo largo de años o si vos pensás que una escuela determinada ya tiene esas premisas básicas?

Doctor Carlos E. Sluzki: Mis opiniones se basan en haber

trabajado bastantes años en este campo y en haber hecho el esfuerzo de mantenerme informado acerca de diferentes orientaciones dentro del modelo o paradigma sistémico. Como representantes de modelos sistémicos se puede incluir al grupo del Mental Research Institute, empezando por Jackson, Weakland y Watzlawick y también a Minuchin, Mara Selvini Palazzoli y el resto de los terapeutas del grupo de Milán, Lynn Hoffman, Cloe Madanes y otros buenos ejemplos de gente que trabaja con un modelo general común, aún cuando en muchos casos han recortado el espectro clínico a una determinada franja, es decir se ha especializado en cierta aproximación, en cierta manera de trabajar las cosas. Con todo, en muchas oportunidades el mensaje de ese recorte no es recibido como: "éste es un fragmento del campo de las posibles intervenciones", sino como "ésta es la precisa", "así es como deben hacerse las cosas" o "esto o nada". Y eso puede que sea una necesidad de cada uno de nosotros, que cuando en un momento determinado, estamos desarrollando una idea, tengamos que volvernos fanáticos de esa idea para poder desarrollarla bien, digamos así (capaz que a mí me está pasando lo mismo con estas ideas de las que te estoy hablando). Pero el riesgo es que la gente que está formándose, se tome en serio ese mensaje, se lo crea y piense que ese fragmento de la realidad es la realidad, que ese fragmento de todo el repertorio de posibles técnicas y estrategias y niveles de análisis coherentes es en realidad la descripción del conjunto. Es un error de "parte por el todo".

Doctor Alfredo A. Canevaro: Podemos pensar que la terapia familiar ha surgido en las últimas décadas como una necesidad clínica, ya que éste ha sido uno de los parámetros comunes de muchos terapeutas de familia que partieron de los fracasos terapéuticos y de la necesidad de mejorar su instrumento de trabajo. ¿O vos pensás que es más bien una necesidad de tipo epistemológico que el terapeuta sea más abarcativo en su quehacer clínico, como operador social tomando entonces una unidad mucho más interrelacionada con el hombre, como puede ser el grupo familiar y no tanto el individuo en sí mismo?

Doctor Carlos E. Sluzki: Me resulta muy difícil contestarte esto, entre otras cosas porque vivimos tan comprimidos en el tiempo, tan impacientes. Me parece que nos olvidamos que somos testigos de un fragmento muy pequeño de todo el desarrollo de las ideas: hacer revisionismo histórico mientras se está viviendo la historia es muy difícil. De hecho el enfoque sistémico, eco-sistémico, interaccional, es muy nuevo, no sólo en clínica, es muy nuevo como modelo general en ciencia. Todos los cambios de modelo en el desarrollo del conocimiento científico ocurren muy lentamente, con marchas en zig zag. No me extrañaría nada que estemos siendo testigos o partícipes de los primeros pasos de una nueva manera de organizar la realidad en el campo de la física, de la biología, de la astronomía. Los modelos sobre recursividad y los modelos sobre orden, desorden y cambios, se están desarrollando en disciplinas muy diversas. A mi criterio ese es el resultado de un efecto de resonancia del desarrollo de las ideas en diversas ramas de la ciencia y ocurre que se cimenta a partir de gente que a su vez no se ha alojado previamente en paradigmas cerrados. Yendo a uno de los puntos que mencionas, si uno es coherente con un modelo de tipo intrapersonal, los fracasos terapéuticos no existen, ya que se suele explicar como un problema del paciente y no del modelo. Cuando se explican las dificultades del proceso terapéutico en términos de resistencias del paciente y no de insuficiencias de la terapéutica, o del terapeuta, se pierde la oportunidad de aprender de los propios errores y de poder revisar el mapa propio, el modelo. Como dijiste, los fracasos pueden ser fuente de apertura, si uno aprende del fracaso y cuando lo define como un fracaso del que uno puede hacerse responsable. Si no conseguimos romper esta piedra con un martillo, eso no es un problema de la piedra, es un problema del martillo o de la operación. Si uno no consigue generar ciertos cambios, la falta de cambios no es un producto de la dificultad para cambiar del objeto, sino un comentario sobre el instrumento con que intentamos cambiarlo. Ahí es donde uno puede empezar a explorar alternativas que muchas veces empiezan por ser técnicas y después se abren a

niveles de modelos más generales. Uno aprende de los fracasos explorando alternativas y oteando el horizonte en la búsqueda de organizaciones distintas de la realidad.

Doctor Alfredo A. Canevaro: Ahora bien, tu apoyatura en los cambios simultáneos, en distintos espacios o territorios de la ciencia, ¿es a tu juicio un fenómeno explicativo, secundario a la búsqueda epistemológica del terapeuta de familia o pensás que es por así decir, a grosso modo, un fenómeno deductivo desde la teoría hacia la realidad clínica? No sé si está clara la pregunta.

Doctor Carlos E. Sluzki: Pienso que cualquiera de las dos versiones es el resultado de una puntuación y por lo tanto es arbitraria. Existe una correlación permanente entre las dos cosas. De hecho, una tarea importante de un científico con un pie en la teoría y otro pie en la técnica es poder, en primer lugar, trabajar con técnicas que sean coherentes con los modelos generales y en segundo lugar, observar los procesos terapéuticos tal cual se van dando, detectar las anomalías, desviaciones y otros fenómenos que aparezcan al azar, tratar de encontrar las regularidades de esos fenómenos e ir de vuelta a la teoría para revisarla y enriquecerla, es decir enriquecer la técnica con la teoría y entablar un doble camino dialéctico permanente. Buena parte de los conocimientos novedosos y de algunos rompimientos con modelos previos se dan a partir de haber observado un fenómeno que no encaja con la teoría, para lo cual se tiene que revisar a la teoría o desarrollar una teoría nueva para explicar el fenómeno. A su vez esa teoría permite observar otros fenómenos que previamente no tenían ningún sentido, o bien que previamente podían ser explicados con teorías más fragmentarias y siguiendo el principio de la relatividad los modelos más abarcativos son modelos más económicos. Así se van produciendo cambios conceptuales a partir de la observación empírica y ésta se enriquece enormemente a partir de cambios conceptuales. Y eso, por cierto se aplica a la terapia familiar. Los modelos teóricos, los paradigmas que subyacen a

la familia han sido enriquecidos con mucha frecuencia por los clínicos y a su vez la clínica se ha visto enriquecida por el refinamiento de los modelos generales que la subyacen.

Doctor Alfredo A. Canevaro: Pasando a un campo más específico de tu desarrollo profesional, tengo entendido que el campo de la medicina familiar ha sido objeto de interés tuyo desde hace ya rato y que estás haciendo cursos en la Universidad de California sobre este tema. Me gustaría que pudieras contarnos los últimos desarrollos.

Doctor Carlos E. Sluzki: "Medicina de familia" es un nombre de especialidad para una generalidad. El médico de familia tal cual el modelo del viejo médico de familia, es simplemente un clínico general que trabaja con un repertorio muy amplio e integrado de conocimientos médicos y que hace un poco de pediatría, un poco de medicina de adultos, un poco de obstetricia, como el médico de campo que solía ser descripto como en parte médico, en parte consejero, un poco sacamuelas y un poco exorcista. En USA, por de pronto (pero pienso que eso es cierto en todo el mundo) con la tecnologización, se fue dando una valoración progresiva de los especialistas de foco más estrecho y más en profundidad. La cantidad de especialistas era tal que el paciente se transformaba en un conjunto muy poco sistémico, de pedacitos, órganos, sistemas, sectores, mente por acá, estómago por allá, ojos por acá y medio interno por allá. Mientras tanto, los médicos generales pasaban a ser profesionales de segunda categoría que "ni siquiera tenían especialidad". La falta de médicos generales llegó a ser un fenómeno crítico en muchos países. En buena medida para responder a esta necesidad, se creó la especialidad en medicina de familia, con residencias y con Academias, o sea con toda aquella cosa que connotaba nivel jerárquico importante. Así es como se desarrolló, en los últimos quince años, la especialidad de medicina de familia. En la actualidad, en Norte América solamente, hay ya más de doscientas residencias en medicina de familia. Con todo, y no es de extrañar, la mayor

parte de las residencias de medicina de familia constituyen un cambio sin cambio, eso es un entrenamiento en un collage asistémico de segmentos: durante tres años estudian más pediatría, más obstetricia y más acerca de cada una de las especialidades, o sea que el especialista en medicina de familia es un médico general que sabe más de nariz, de riñones, etc. Hay algunas residencias, con todo, en donde se está intentando hacer el salto cualitativo, tratando de integrar los órganos en un organismo y el organismo en un contexto. Yo participé desde 1973, en la concepción y organización de una residencia de medicina de familia con esas características y pude contribuir de manera importante a desarrollar la filosofía del programa. Además, con la ventaja de estar en un hospital general de ciudad, en la zona pobre de la ciudad, lugar de confluencia de muchas culturas y muchos grupos étnicos distintos. En nuestro programa se enseña al residente a pensar en términos de conjunto, en términos de sistema, incluyendo en el entrenamiento, de una manera integrada los puentes, los elementos y modelos conectivos, las ideas que juntan todo. Fundamentalmente enseñamos a pensar en términos de unidad psicosomática dentro de una unidad interpersonal —la familia es un punto clave en ese aspecto— dentro de un contexto comunitario, dentro de un contexto sociocultural más amplio. Empezamos nuestra enseñanza con los residentes desde primer año, en su práctica simplemente ampliando su campo visual, por así decir, mostrándoles variables que tienen que ver con elementos novedosos para ellos, tales como: el impacto del medio, las vicisitudes psico-socio-económicas, el efecto de los rótulos diagnósticos en los destinos de los pacientes, las funciones que los síntomas cumplen en los conjuntos, la manera en que la impronta etnocultural va organizando la definición de salud, la definición de enfermedad, la definición del curar, la definición del vínculo médico-paciente, etc., y la manera en que otras variables organizacionales juegan en la vida de un sujeto que consulta. Además del trabajo directo con cada residente que llevamos a cabo a través de los tres años, tenemos seminarios específicamente centrados en familia, en cultura y en comuni-

dad y ámbitos en donde todas esas especificidades se entrelazan. Para los residentes de segundo y de tercer año en nuestra residencia, tenemos por ejemplo dos clínicas semanales de intervenciones sistémicas donde ellos traen sus propios casos para trabajar conjuntamente con nosotros, los instructores, en problemas que puedan tener con los pacientes y sus familias. Trabajamos con cámara de Gesell, hacemos un video de cada entrevista para después analizarla; trabajamos en grupo: detrás de la cámara hay varios residentes y después discutimos en conjunto cada situación. Los problemas que motivan esta consulta varían de acuerdo con el grado de claridad conceptual de los residentes y con diferentes necesidades institucionales. Incluyen, por ejemplo, problemas interpersonales y crisis situacionales (no necesariamente patologías, sino períodos del ciclo vital colectivo de la familia en los que prevalecen ciertas dificultades), problemas del comportamiento, síntomas físicos reiterados, es decir, personas que aparecen con sintomatología a repetición, o bien que no responden al tratamiento de la manera esperada o bien presentan un repertorio sumamente amplio de problemas.

Doctor Alfredo A. Canevaro: Lo que por distintos órdenes de necesidades clínicas o teóricas nos fue llevando a un espacio que llamamos terapia de familia, vemos que ahora es más abarcativo, que abarca también a la medicina de familia y que torna a la familia misma en una unidad de comprensión del individuo, enraizado, por así decir, en su medio ambiente. Ahora bien, ¿esto nos llevaría según tu opinión a redefinir lo que ya en términos habituales se conoce como terapia familiar y pensar ya en un estudio más específico y global de la familia en sí? No sé cómo podríamos llamarlo.

Doctor Carlos E. Sluzki: La terapia familiar como nosotros la conocemos tiende a ser una extensión más bien antipsiquiátrica de la psiquiatría y por lo tanto ha tomado mucho de la impronta del tratamiento psiquiátrico. En nuestro programa de medicina de familia intentamos desarrollar la visión "familia"

desde la clínica médica, y por así decirlo, los territorios de clínica médica y psiquiatría son compartimentos arbitrarios, por cierto. De hecho un enfoque interaccional, o un enfoque sistémico de los problemas humanos incluye como comportamientos significativos a síntomas psiquiátricos, síntomas físicos, etc. La división entre psique y soma se vuelve más y más artificial, más y más incompleta, insuficiente, insatisfactoria. Uno podría pensar, haciendo un poco de ciencia ficción, que en la práctica de los servicios de salud, se podrían llegar a borrar progresivamente la diferenciación entre esos territorios en la medida en que se tenga una lente suficientemente abarcativa que cubra competentemente esos diferentes segmentos o fragmentos. Todavía estamos a años luz de eso, porque entre otras cosas, la dicotomía psico-somática es una división vieja, muy adentrada y reflejada en la misma organización de los servicios de salud, por lo que modificar eso implica un cambio tan revolucionario que, si llega a ocurrir, no lo vamos a ver nosotros. Además no me extrañaría que en un momento dado a su vez otro cambio paradigmático (que no sé cuál sería porque no hay límite en la ciencia ficción) haga innecesario u obsoleto ese modelo. Si alguna vez se llega a desarrollar esa nueva organización, no dicotómica y sí sistémica del servicio de salud, en ese momento van a haber ocurrido nuevos desarrollos que se acompañarán con la opinión de que ese modelo ya no sirve y probablemente tengan razón.

Doctor Alfredo A. Canevaro: Cuando vos decís de hacer ciencia ficción estás hablando de un futuro que si bien quizás no lo veamos, podría resultar predecible. En ese sentido y como última pregunta, me gustaría conocer tu opinión acerca de si la terapia familiar va a tener un futuro supeditado a un cambio sociocultural, por así decir, o si tiene un peso específico propio, un cuerpo de doctrina que haga que en los próximos 100 años el desarrollo en términos de familia o de familia en comunidad pueda sustituir a lo que fue el estudio del individuo hasta el siglo veinte.

Doctor Carlos E. Sluzki: Yo pienso que la terapia familiar constituye una muestra de que ese cambio ya está realmente en acción, que el proceso de cambio está ocurriendo, tanto a nivel conceptual como a nivel de la acción sanitaria. Existe un riesgo al que me referí hace un rato, el de una familia aislada de su entorno, de la misma manera que por años se definió en exceso la frontera de ese sistema cuya frontera física es la piel. ¿Cuál es la unidad de análisis óptima? En este momento mi unidad de análisis y de trabajo óptimo es la familia y al mismo tiempo mantengo in mente constantemente que el paradigma sistémico es un paradigma abierto y no cerrado, por lo que trabajar en el tema familia, de una manera coherente tiene que significar trabajar con un modelo donde para poder intervenir con cierto grado de sabiduría, se tiene que ir evaluando las variables contextuales más amplias a nivel de la cultura, la realidad social e histórica, etc. Ese es el límite de mi realidad de trabajo actual. El límite de la fantasía va mucho más allá.

Dr. Alfredo A. Canevaro: Muchas gracias por tu gentileza. Creo que quedan abiertos ciertos interrogantes que pueden ser muy fecundos para promover el crecimiento de nuestra disciplina. Gracias de nuevo.

Journal of Marriage and Family Counseling

"In its fourth year of publication, the *Journal of Marriage and Family Counseling* shows a healthy trend of integration among the various clinical approaches to relational problems. I welcome the holistic attitude of the editorial policy which should lead to a better definition of priorities and connections in a growing and promising field."

Ivan Bozormenyi-Nagy, M.D., Clinical Professor of Psychiatry, Hahnemann Medical College and Director of Family Psychiatry, Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute

"The recent launching of the professional journal, *Journal of Marriage and Family Counseling*, by AAMFC reflects positively on the growing stature of this national organization and the field. Already, this journal is publishing some of the most significant articles on the cutting edge of the marriage and family counseling field. In addition the articles are helping to bridge the traditional gap that typically exists between theory, research and clinical practice. Congratulations on a great beginning!"

David H. Olson, Ph.D., Professor, Family Social Science, University of Minnesota



A publication of the American Association of Marriage and Family Counselors, the *Journal of Marriage and Family Counseling* is published to advance the professional understanding of marriage and family behavior, and to improve the psychotherapeutic treatment of marital and family dysfunction.

Florence W. Kaslow, Ph.D., Editor

ORDER FORM

Please enter my subscription to the *Journal of Marriage and Family Counseling*.

☐ INDIVIDUAL - one year/\$15

☐ Check Enclosed

☐ INSTITUTIONAL (libraries and multi-reader establishments) - one year/\$25

☐ Please bill me for this order.

NAME _____
Last First Middle

(OR INSTITUTION) _____

STREET _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

MAIL TO: JMFC BUSINESS OFFICE, 225 YALE AVENUE, CLAREMONT CA 91711 USA

SINTESIS DE LIBROS

La Terapia Familiar Psicoanalítica

A. Ruffiot - A. Eiguer y D. Litovsky de Eiguer - M. C. Gear y E. C. Liendo - J. Perrot.

Ed. Dunod, París, 1981; 221 páginas, en francés.

Este libro pertenece a una colección dirigida por René Kaës y Didier Anzieu y está dirigido a llenar un espacio psicoanalítico entre los aportes a la teoría sobre la terapia familiar. Comprende cuatro artículos diversos entre sí; los dos primeros son más afines y están basados en la teoría del aparato psíquico grupal de R. Kaës.

Desde el prefacio André Ruffiot aclara que el abordaje psicoanalítico grupalista está inspirado en una representación fantasmática y grupal del individuo en el seno de su familia. Es una escucha, más allá de los intercambios verbales y comportamentales, del funcionamiento de la fantasmática familiar en el aparato psíquico grupal de la familia; ese inconsciente a varias voces se revela en la asociación libre de los miembros de la familia reunidos en sesión. Más allá de los intercambios interaccionales, el analista escucha la comunicación inconsciente subyacente a toda comunicación manifiesta por interacción, ese nivel de funcionamiento arcaico en el cual los individuos diluyen sus psiquismos individuales en un psiquismo grupal.

En "El grupo-familia en análisis. El aparato psíquico familiar", André Ruffiot propone la hipótesis de un aparato psíquico familiar según el modelo del aparato psíquico grupal conceptualizado por R. Kaës en 1976 y redefinido en 1979. Con la

regresión específica del grupo familiar en análisis se pone en juego una comunicación inconsciente muy arcaica, propia de un yo sin fronteras corporales. Este modo de intercambio primitivo se realiza en la lengua fundamental de la cual habla Freud en 1911 (Presidente Schreber), luego en 1917 (en el simbolismo del sueño), qué es el lenguaje del sueño, más allá de los contenidos secundarizados que nos quedan al despertar.

Su hipótesis es que esas vivencias de psiquismo puro, propios del lactante, son el fundamento de la comunicación inconsciente de la familia. Son también la tela de fondo de los fenómenos grupales en general y sin duda la malla de toda comunicación.

Por eso indica especialmente esta terapia para las familias psicóticas cuya comunicación está basada en paradojas que parecen desanudarse, gracias a la regresión, en el lugar mismo en el que se anudan: en ese psiquismo primario sin fronteras, donde el cuerpo individual y la lógica secundaria no son tomados en cuenta.

Este escrito es el que conceptualmente ha sido mejor elaborado de los cuatro que reúne este libro.

A continuación Alberto Eiguer y Diana Litovsky de Eiguer presentan una "Contribución psicoanalítica a la teoría y la práctica de la psicoterapia familiar", que tiene marcadas afinidades con el anterior. Para ellos el objeto de estudio en cuestión no es una suma de disturbios patológicos de dos o más individuos, sino la evidencia de una disfunción que se expresa en alguien en tanto entre en relación con otro u otros. Aunque la familia no tenga un cuerpo único sino varios, posee un sustratum común de reacciones y de comportamientos así como de procesos inconscientes.

También se basan en la conceptualización de Kaës acerca del inconsciente grupal como punto de encuentro de los aspectos recíprocos del funcionamiento inconsciente individual. Además integran ideas de D. Anzieu, Freud y Bion entre otros.

Sostienen que desde el momento en que se funda, la familia va creando un sistema de intercambios, de reglas y de defensas al mismo tiempo que formula ideales y una moralidad propia.

Esto puede impedir la evolución individual y la creatividad o, por el contrario, puede permitir la armonía entre las pulsiones, los objetos y las exigencias de la realidad, facilitando el crecimiento personal. La vida fantasmática compartida subyace al sistema defensivo. Explicitarla constituye un aporte original del psicoanálisis al conocimiento del psiquismo familiar. Este funcionamiento inconsciente puede deducirse a partir de las reglas, comportamientos y manifestaciones sintomáticas —patológicas o no— consideradas como formaciones de compromiso del inconsciente familiar. Subrayan la doble función de la actividad fantasmática inconsciente de la familia que por un lado, juega un rol organizador y por otro, está en el origen de los conflictos los que a su vez refuerzan el investimento recíproco del vínculo.

Partiendo del concepto de aparato psíquico grupal de Kaës, elaboran una minuciosa serie de ideas que tienden a comprender ese funcionamiento inconsciente familiar a la manera del aparato psíquico individual. En cambio Ruffiot pone más el acento en los aspectos primarios, arcaicos de este "espacio onírico común" que descubre en toda terapia familiar y en cuyo seno ocurre la experiencia terapéutica.

María Carmen Gear y Ernesto César Liendo han sido vertidos al francés con el título de "Psicoanálisis, semiología y comunicación familiar". De entre sus conocidos trabajos anteriores en la Argentina han seleccionado un capítulo donde intentan elaborar una síntesis conceptual de marcos teóricos diferentes. De Jacques Lacan toman el concepto de función paterna en el complejo de Edipo. De Claude Lévi-Strauss, la relevancia del avunculado. De Eliseo Veron, la elaboración realizada a partir de la teoría de la comunicación en que postula tres niveles estratégicos: el nivel individual, el nivel familiar, y el nivel de la estratificación social y cultural. Luego integran los conceptos de la teoría de la comunicación con la escuela psicoanalítica inglesa (Paula Heimann, Melanie Klein, Bion) en lo que se refiere a las interacciones y la comunicación y metacomunicación entre madre-padre-hijo y los objetos internos. También hace referencia a los tres espejos invertidos de la

estructura familiar de A. Green. Fundamentalmente articula la teoría de los roles de Enrique Pichon-Rivière, la teoría de la comunicación y el grupo familiar para volcarlas en una estrategia operatoria de abordaje clínico de la familia que en la práctica es más cercana a los desarrollos de Pichon-Rivière, de la escuela inglesa y de la teoría de la comunicación. Muchas referencias teóricas quedan integradas en menor medida. Es inevitable porque no se puede integrarlo todo. Sólo es posible optar.

Por último Jean Perrot preparó un artículo original dentro de la literatura sobre terapia familiar. No se trata ni de aportes teóricos ni clínicos sino de una mirada hacia atrás en la historia de la psiquiatría (incluso presenta el caso Eduardo J. del Dr. Morel), y sobre todo es una reivindicación de los "hijos" que mediante un esfuerzo de superación psíquica hicieron posible el pasaje de una concepción determinista al descubrimiento del inconsciente y de la familia edípica. Y los hijos que menciona son nada menos que Gustavo Flaubert y los hermanos Williams y Henry James, que entre otros hicieron posible en los años 80 del siglo pasado, una ruptura epistemológica y el posterior advenimiento del psicoanálisis.

En "Homeostasis y degeneración de la familia hereditaria" Perrot propone además a través de esta retrospectiva, líneas que llegan a conceptos tales como la homeostasis familiar, el rol del chivo expiatorio y la teoría de que "hacen falta tres generaciones para producir un psicótico". Nos muestra cómo, debajo del mito de la degeneración hereditaria progresiva, ya existía una disimulada preocupación por la patología familiar. El dilema que impedía pensarlo de otro modo era considerar al loco como un "monstruo", producto de la herencia de la degeneración progresiva.

Intentando evaluar el aporte que significa este libro, creo que sus artículos son muy minuciosos en cuanto a fundamentos teóricos y que de algún modo preanuncian futuras síntesis que simplifiquen y den cuenta estructuralmente de las relaciones familiares desde el punto de vista psicoanalítico.

Lic. Stella Maris Molina

La Adopción

Por Eva Giberti

El Cid Editor. Buenos Aires.

Este "negado" tema, se ha visto sólidamente enriquecido por esta obra vasta, que puede impresionar inicialmente al lector por su extensión (570 pág.), y que su autora justifica por su necesidad de explicitar, a priori, sin lugar a dudas, sus ideologías, metodología y presupuestos filosóficos. El riesgo, plenamente asumido por E.G., cuando lo define como obsesividad logicista y metodológica necesaria, es el de que pueda desalentar al lector desprevenido que no encuentra un abordaje directo del tema hasta bastante avanzada la lectura (pág. 57 aprox.). No obstante, superado el impacto inicial, es posible, salvo en algunos párrafos especialmente densos y difíciles, gozar de una obra amena que puede atrapar al lector.

Según su autora, está escrito "para profesionales que deben intervenir en asuntos vinculados con la Adopción". No es un libro de divulgación, sino una obra teórica, hecha desde la "teoría Interpretativa" que podríamos precisar más como teoría psicoanalítica desde la vertiente Lacaniana, aunque acepta aportes Kleinianos y de la escuela Argentina y aún algunos no estrictamente Psicoanalíticos; especialmente en la faz técnica y clínica, posiblemente, imaginamos, más usados que explicitados.

No es tampoco una obra clínica, aunque ilustra conceptos teóricos con interesantes ejemplos de la vasta experiencia de E.G.

Desde el comienzo la autora define su ideología en favor de la Adopción, como "algo que permite a esas familias vivir de modo estimulante y placentero", en oposición a la contraideología que sustentan los que desconfían de la Adopción pensando que "es peligroso adoptar" o que los que adoptan son "neuróticos graves". Planteo metodológicamente honesto, dado que descarta la neutralidad ideológica, y que se presta, como E.G. lo expresa claramente, a la polémica. En este sentido al mostrar las numerosas dificultades que debe superar una familia adoptiva para estructurarse saludablemente no parece tan congruente con aquella ideología aparentemente tan optimista, aunque tampoco con la contraideología pesimista sobre la Adopción. Lo que vemos, más bien, en su trabajo es que probablemente el punto más adecuado esté en la síntesis entre esta dialéctica de ideología y contraideología; que podría definir a la Adopción como una forma posible y gratificante, pero no fácil, de formar una familia sana.

La experiencia clínica que provee los datos que elabora E.G. es el Psicoanálisis, en tratamientos de padres e hijos adoptivos - Grupos de orientación y profilaxis de padres, orientados psicoanalíticamente pero que sospechamos enriquecidos por otras técnicas apenas mencionadas y que tal vez merecerían más comentarios y finalmente también algunas referencias a la Terapia Familiar, que nos hubiera gustado fuera más tenida en cuenta.

Hay en esta obra varias líneas de pensamiento y desarrollos interesantes y valiosos, algunos realmente originales de E.G. El tema del "Saber" y sus implicancias, es motivo de un desarrollo fundamental. Cómo "el Saber" del hijo quita poder a los padres; tema que sólo se ve un poco limitado porque la teoría psicoanalítica, en la que E.G. se encuadra, no dispone de argumentos suficientes para el estudio de las relaciones de poder en los grupos humanos.

Pero sin duda, el desarrollo que nos parece más interesante

y valiente es el que se refiere al tan negado tema de la paternidad o maternidad biológicas, a los que tiene que renunciar el miembro fértil de la pareja de adoptantes, con su correlato de duelos, sometimientos, resentimientos, etc., que explican muchas de las, a veces incomprensibles, dificultades de la Adopción. También este concepto avala la idea de E.G., de que la Adopción se realiza por separado y no en pareja. Concepto que rompe el mito de "la pareja estéril" en la que se diluyen las responsabilidades, negándolas; pero que puede prestarse a confusión si se toma como suficiente la valoración de las problemáticas individuales.

Las identificaciones bizarras del adoptado constituyen otro tema, no nuevo, pero sí novedosamente desarrollado. Tampoco es nuevo el capítulo fundamental de las defensas maníacas en la Adopción, pero está aquí muy bien planteado. Si bien no era uno de los objetivos de E.G., hubiera sido interesante extender el concepto del nivel individual a los sistemas familiares y sociales, que caen también en este tipo de defensas a través de la "sacralización maníaca" de la Adopción como institución filantrópica de la que a veces nos es difícil escapar.

Otro desarrollo, fundamental por sus connotaciones clínicas y prácticas es el que se refiere a la "Función Crianza", destacada a partir de su libidinización narcisista, como sustituto de la "Función Reproductora". En este capítulo se inscriben las dificultades de los padres que se sienten sin permiso para ejercer "la Hostilidad Frustrante", necesaria y estructurante, incapaces de demostrar que son los padres. Otra vez vemos la limitación teórica sobre "las relaciones de Poder" entre miembros de la familia, que obliga a referirnos a "Hostilidad", sentimiento individual, aplicable sólo a fenómenos de causalidad lineal.

El concepto más operativo de la obra de E.G., es su desarrollo sobre el problema de "la Verdad". Casi todos, estamos de acuerdo en que los niños adoptados deben saber "la verdad". Sobre lo que hay que discutir es en el "cómo decirlo" y "cuál es la verdadera verdad". Este es el punto de urgencia y E.G. afirma que no se ayuda a los padres alentándolos a que

digamos la verdad, si no se les ayuda en el "cómo" decirlo. En este sentido nos muestra un ejemplo valioso de cómo pueden disociarse instrumentalmente la teoría y la técnica psicoanalítica. E.G. apela, creativamente, a un recurso que llama "el Relato". Inspirado en la teoría psicoanalítica pero no psicoanalítico como técnica. Fórmula verbal, que transmite, en la forma más adecuada y completa posible, las informaciones básicas que los padres deben dar a sus hijos adoptados. Ello implica tocar el tema de los padres biológicos que abandonaron, la esterilidad de los adoptantes, el encuentro, la adopción y finalmente la "función de padres". La construcción de este "Relato" con los padres, en un contexto de justificación y de descubrimiento —no quiero decir terapéutico— sería la principal función del profesional. Esta tarea, que se nos ocurre como un verdadero trabajo de Terapia Familiar Reestructurante, consistiría en ir cuestionando y cambiando aquellas concepciones que son, o más probablemente se convertirán en "mitos familiares patológicos" por un "mito familiar sano", en última instancia, en desmistificar a la adopción oponiéndole el descubrimiento de una verdad. E.G. siente la necesidad de justificar su posición y defenderla ante la posibilidad de que se la acuse de "Receta" o "Fórmula Directiva o Pedagógica" por no ser técnicamente psicoanalítica. Esto sería poner la Clínica al servicio del Psicoanálisis y no el Psicoanálisis al servicio de la Clínica. Está claro que la autora optó por esto último, y que ya es hora de que encaremos estas opciones sin temor. Después de todo, los criterios estructurales en la familia son normativos y esto significa que hay cosas que están bien hechas y otras que no. Para trabajar sobre estos temas no es suficiente hacer consciente lo inconsciente. Frecuentemente debemos ser Pedagógicos o Directivos en algunas Fórmulas Familiares para nuestros pacientes o clientes a riesgo de ser inútiles si lo evitamos.

En síntesis "La Adopción" es una obra, no sólo necesaria, por llenar un vacío en el material bibliográfico sobre el tema, sino de gran valor por la seriedad con que transmite y elabora teóricamente la vasta experiencia clínica de su autora; aunque a veces nos impresiona que para sus ricas observaciones le pueda

quedar un poco chico el marco teórico en que trata de ubicarlas y tal vez la enriquezca ampliarlo.

La diagramación de la impresión es prolija pero tal vez, en otras condiciones económicas en nuestro país, una obra de esta categoría hubiera merecido una terminación editorial de más calidad.

No puede dejar de ser leído por todos aquellos profesionales que tienen que intervenir en asuntos relacionados con la Adopción.

Dr. Carlos María Díaz Usandivaras.

THIS IS YOUR JOURNAL

Share it with your friends and colleagues.

For those interested in subscribing, an order form is provided below.

Please Enter My:

Individual Subscription

☐

1 year @ \$20
(4 issues)

☐

Check is enclosed

☐

Bill me for this order
plus postage and handling

Institutional Subscription (libraries and multi-reader establishments)

☐

Enclosed is a check for \$30 (1 year's subscription)

☐

Bill us \$30 plus postage and handling

(Orders outside of North America, add \$2 per year for postage and handling)

Name _____

Institution _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Mail to: JOURNAL
OF MARITAL
AND FAMILY
THERAPY
924 W. 9th
Upland, CA
91786



American
Association
of Marital and
Family Therapy

Explorations in Marital and Family Therapy

(Selected Papers of James L. Framo, Ph. D.).

Comentado por la Lic. Silvia Stuhlman.

En la introducción el Dr. Framo expresa que una motivación importante para publicar este libro fue la de poder reunir en un solo texto todos sus trabajos y de este modo hacer más accesible su consulta. Originalmente el plan para este libro contemplaba un orden cronológico (desde 1965 a 1980) que mostrara el desarrollo de su pensamiento a través de los años. Pero artículos escritos en períodos distintos y con propósitos diferentes no necesariamente siguen una progresión coherente. Por eso decidió finalmente agrupar los trabajos alrededor de cinco grandes temas: teoría, aplicación a las familias, aplicación al casamiento y divorcio, aplicación al proceso intergeneracional y temas profesionales y personales.

Sus escritos cubren así un vasto espectro desde su orientación teórica y su método de trabajo con familias, parejas, grupo de parejas, parejas en proceso de divorcio, familia de origen, hasta temas profesionales y aspectos personales de ser un terapeuta familiar (este último es un tema que raramente se discute).

En cuanto a su orientación teórica, creo que no hay nada mejor que reproducir las expresiones del Dr. Framo al respecto:

“Mi orientación en cuanto a teoría y terapia marital y familiar, enfatiza en profundidad los aspectos dinámicos de la vida familiar, así como la psicología de las relaciones íntimas, la relación entre lo intra-psíquico y lo transaccional y las fuerzas históricas y transgeneracionales escondidas, que ejercen su poderosa influencia en las relaciones actuales”.

En cuanto a los terapeutas familiares que influyeron su pensamiento y su práctica, el Dr. Framo distingue a: Iván Nagy, con quien trabajó durante 13 años, empezando juntos un proyecto sobre la esquizofrenia que terminó siendo uno de los centros más importantes en terapia familiar. Estuvieron incluidos en ese proyecto Oscar Weiner, Gerry Spark, Gerry Lincoln, Leon Robinson, Dave Rubinstein, Jerry Zuk. También estuvo influido por Nathan Akerman, el abuelo de la terapia familiar. Los conceptos de Murray Bowen, acerca de los procesos multigeneracionales, le sirvieron como guía para su propio trabajo con las familias de origen. El concepto de duelo desarrollado por Norman Paul también tuvo su influencia. En cuanto al contacto con Virginia Satir, su profundo conocimiento acerca de las familias y su optimismo, le permitió ver el potencial aun en las peores situaciones familiares. Y por supuesto, no puede dejar de nombrar a Carl Whitaker, terapeuta de los terapeutas familiares, que indudablemente tuvo su influencia sobre todos, y que a Framo lo ayudó a aflojarse, a ser más suelto con familias y parejas, y a sentirse mejor con su “propia locura”.

La primera parte “Teoría”, comprende dos capítulos: el primero se denomina “Teoría y Terapia Familiar” (1979) y el segundo “Síntomas desde un punto de vista transaccional” (1970).

El trabajo del capítulo primero “Teoría y terapia familiar”, fue encomendado al Dr. Framo como editorial para un número especial de la revista *The American Psychologist*, en honor al Año Internacional del Niño. Dado que dicha publicación es la única en su género recibida por todos los distintos especialistas dentro de la psicología (experimental, industrial, evolutiva, social, clínica), consideró que era una excelente ocasión para

hacer conocer a todos ellos los conceptos de la familia como un sistema.

Este trabajo presenta un breve resumen de algunos conceptos básicos de teoría y terapia familiar, e intenta estimular una nueva epistemología distinta de la seguida por la mayoría de los psicólogos (causalidad lineal, independencia del contexto).

Señala el gran desarrollo que la terapia familiar ha alcanzado en los últimos años, ya sea en forma de literatura especializada, cursos (hay más de 300 programas de entrenamiento en todo el país).

Los problemas familiares que se repiten de generación en generación, son previsibles y pueden ser abortados en esta generación, ya que tenemos algunas herramientas conceptuales y terapéuticas, que pueden aliviar sufrimientos innecesarios. La verdadera “Sociedad para la prevención de la crueldad con los niños, es el tratamiento de toda la familia”.

En el capítulo II “Síntomas desde un punto de vista transaccional de la familia”, Framo considera a este trabajo como su teoría más importante y la base para su trabajo con las familias de origen. El objetivo de este trabajo es documentar mediante teoría y observaciones clínicas del Dr. Framo y otros, que los síntomas psicológicos en lugar de ser vistos y tratados como entidades intrapsíquicas, pueden ser mejor entendidos y mejorados dentro del sistema transaccional familiar. Pasa revista al concepto de síntoma en Freud, Fairbairn y neo-freudianos como Sullivan, Honey, Fromm y Erikson.

Luego plantea la teoría de que los síntomas están formados, elegidos, mantenidos, intercambiados, fingidos y removidos como una función de la naturaleza del contexto relacional dentro del cual está íntimamente incluido.

El acercamiento transaccional a la familia surge como consecuencia de la integración de desarrollos provenientes de la psicología social, psicología del yo, psicoanálisis, teoría general de los sistemas, teoría de la comunicación, psicología evolutiva, dinámica de grupos, sociología de la familia y terapia familiar.

Señala la dificultad de contar con un lenguaje apropiado, ya que por ejemplo la palabra síntoma proviene de un modelo

médico individual. Y en cierto modo es inadecuado usar esta palabra para designar fenómenos patológicos complejos, como los que se dan en una familia. Asimismo, considera inadecuado diagnosticar a una familia usando categorías diagnósticas desarrolladas por la psicología individual.

En este trabajo la palabra síntoma será usada en un sentido amplio, incluirá no sólo las quejas individuales sino también las observaciones hechas por otros acerca de que algo no está bien en la conducta, sentimientos o pensamientos de una persona.

Presenta material clínico para ejemplificar situaciones familiares productoras de síntomas (asignación irracional de roles, parentificación de los niños y barreras generacionales cruzadas).

El punto de vista del autor es que si bien no todos los síntomas no están determinados en forma interpersonal, siempre tienen consecuencias interpersonales y relacionales que determinarán su naturaleza, curso, mantenimiento o desaparición. O sea, que en otras palabras, síntomas pueden ser vistos como hechos relacionales desordenados. Destaca que si bien la psicología intrapsíquica fue minimizada en este trabajo, hay que reconocer que ni el nivel intrapsíquico ni el transaccional pueden ser reemplazados el uno por el otro, o reducido al otro y ambos son necesarios para tener una imagen completa. Si bien la enorme complejidad de la relación entre estos dos niveles recién empieza a ser estudiada.

El autor recomienda la entrevista diagnóstica familiar independientemente de los síntomas que presente cualquier miembro de la familia. Eso no quiere decir que todos tienen que hacer terapia familiar o que no hay lugar para otras formas de psicoterapia. La mayoría de las familias se pueden beneficiar con una terapia familiar breve cuando están en medio de una crisis aguda. Cuando observamos la interacción familiar se puede hacer una mejor evaluación diagnóstica y se ven los síntomas en una perspectiva diferente. Esto será de gran valor incluso si el tratamiento que seguirá será la psicoterapia individual.

Considera que los psiquiatras, psicólogos clínicos y asisten-

tes sociales no tienen el entrenamiento que les permite una visión transaccional de la psicopatología. Y para ello propone como primera medida la modificación de los programas de entrenamiento de acuerdo a la línea expuesta en este trabajo.

La segunda parte, "Aplicación a familias", está dedicada íntegramente a un trabajo titulado "Fundamentos y técnicas en terapia familiar intensiva". Fue escrito entre 1963-64 y está basado en experiencias del Family Therapy Project en el Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute (EPPI) en Filadelfia, dirigido por Iván Boszormenyi-Nagy. Este proyecto comenzó en 1957 como un programa de investigación acerca de la naturaleza, curso y tratamiento de la esquizofrenia. Este capítulo fue escrito en un momento de transición del tratamiento individual hacia una orientación familiar. Analiza en profundidad temas tales como las fases en terapia familiar (particularmente los procesos que tienen lugar en la fase del medio), el tipo de obstáculos que se dan únicamente en el tratamiento de personas con una relación muy cercana, problemas maritales en terapia familiar, los hermanos "sanos", transferencia y contra-transferencia y co-terapia. Fases: inicial, del medio y terminal. Este artículo termina con una frase que considero muy significativa: "El valor último de la terapia familiar probablemente recae en el área de la prevención; los niños de las familias tratadas que luego se casarán y formarán sus propias familias, van a tener una mayor capacidad para crear una vida familiar sana".

La tercera parte se dedica a "Aplicaciones al matrimonio y divorcio". Contiene cuatro artículos. El primero dedicado al matrimonio y terapia marital (editado en 1980), presenta algunas nociones teóricas acerca del matrimonio, una clasificación de los problemas maritales y su método para conducir la primera entrevista con parejas. Su trabajo se basa en parejas de clase media alta, desde el punto de vista educacional y económico y que tienden a estar más motivadas para el tratamiento. No obstante el abandono del tratamiento es alto, alrededor de una quinta parte de las parejas que consultan no vuelven a la segunda sesión.

En el segundo artículo, "Terapia marital en grupo de parejas" (1973), Framo explica el origen de este tipo de tratamiento y lo relaciona con su experiencia en el Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, donde hacía terapia multifamiliar con familias de esquizofrénicos. Destaca la importancia terapéutica del proceso grupal que se da entre una y otra unidad familiar en contraposición al proceso grupal que se da entre personas no relacionadas entre sí, tal como se observa en un grupo terapéutico convencional. Posteriormente, comenzó a ver parejas en grupo en su práctica privada. Con el correr del tiempo, llegó a considerar al grupo de parejas como el tratamiento de elección para parejas que viven juntas, así como también para problemas prematrimoniales, maritales, separación y divorcio. Asimismo, encontró que el grupo de parejas es el mejor camino para preparar a los cónyuges para traer al tratamiento a sus familias de origen. El único criterio usado para seleccionar a las parejas para un grupo determinado es la edad y etapa del ciclo vital en el que se encuentran. Describe el modo de funcionamiento de un grupo de parejas.

El tercero se titula "Reacción de los maridos a la infidelidad de sus esposas" (1975). Es una descripción clínica de las diversas reacciones que presentan los maridos cuando en el curso del tratamiento, se enteran de las relaciones extra-matrimoniales de su mujer. El autor destaca que este es un fenómeno que se está dando con mayor frecuencia en nuestros días. Al respecto de este tema, el autor se pregunta si honestidad es siempre la mejor política y responde que él considera que hay secretos que deben permanecer siempre como tales. Y que cada situación merece un tratamiento particular, teniendo en cuenta todas las consecuencias posibles. El cuarto se titula "El divorcio amistoso" (1978). Se describen, considerando a la familia como un sistema, algunos principios y técnicas que fueron desarrollados para enfrentar la ruptura de un matrimonio y de una familia. La realidad nos muestra que el número de divorcios aumenta. Este tipo de tratamiento tiene por objeto hacer más humano y constructivo lo que es generalmente una experiencia amarga y dolorosa.

El capítulo IV trata de la "Aplicación a los procesos intergeneracionales" y consta de tres artículos. El primero se titula "La familia de origen como un recurso terapéutico para adultos en terapia marital y familiar: Ud. puede y debe volver a casa" (1976).

El método de tratamiento descrito en este trabajo, es fundamental para todas las formas de terapia, ya sea que se trate de familia, pareja, grupo de parejas o divorcio. El objetivo es que los adultos tengan sesiones con sus familias de origen (padres y hermanos) para que puedan tratar entre ellos esos temas difíciles que hacen a su relación. Los conceptos teóricos fueron desarrollados en otro artículo de 1970. Su teoría sobre los síntomas está basada parcialmente en la teoría de las relaciones objetales, desarrollada por Fairbairn (1954) y Dicks (1967).

Distingue cuatro formas de relación con la familia de origen: sobre-involucradas, superficial, alejada (cut off) y apropiada. Hace una descripción de su técnica y la diferencia de la de Bowen.

En el segundo, titulado "La integración de la terapia marital con sesiones con la familia de origen" (1980), Framo expone sus conceptos más recientes respecto de este método de trabajo con las familias de origen. Se refiere a: concepto de matrimonio y familia normal, concepto de disfunción, objetivos, a quienes es aplicable este método, la estructura del proceso terapéutico, el rol del terapeuta, técnicas, efectividad del tratamiento, factores curativos y entrenamiento de terapeutas.

El artículo tercero se refiere a la descripción detallada y paso a paso del tratamiento de una pareja (1977) realizado en coterapia por el Dr. Framo y su mujer. Se pone especialmente énfasis en los pensamientos y sentimientos de los terapeutas durante el curso del tratamiento. Se trata de una pareja que estuvo en terapia marital, en grupo de parejas y que también tuvo sesiones con sus familias de origen.

El quinto y último capítulo se refiere a "Temas profesionales y personales", y contiene cuatro artículos. El primero se

titula "Reflexiones personales de un terapeuta familiar" (1975). El Dr. Framo comenta sus primeros años como terapeuta familiar, su percepción acerca de algunos de los cambios que se han producido en este campo a través de los años y termina haciendo referencia al aspecto subjetivo y personal. Al respecto hace referencia a algunos de sus sentimientos frente a este tipo de trabajo.

El segundo artículo data de 1976 y comenta las dificultades para establecer una unidad de terapia familiar en un centro comunitario de salud mental. Hace referencia a su lucha durante 4 años y termina preguntándose si un modelo de terapia sistémica puede ser integrado a un modelo médico de enfermedad individual, tal como se enseña en las escuelas de medicina.

El tercer artículo se titula "Un punto de vista personal respecto del entrenamiento en terapia marital y familiar" (1976). Aquí el autor expresa su preocupación por la calidad de los numerosos entrenamientos que se ofrecen a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, calificándolos desde excelentes hasta muy pobres. Considera indispensable que se establezcan ciertas normas al respecto.

Este libro termina con un artículo titulado "Mis familias, mi familia" (1968). Usando sus propias palabras diremos que "comparte pensamientos acerca del aspecto personal y humano de ser un terapeuta". Merece unas palabras aparte este trabajo ya que no es habitual, en nuestra profesión, encontrarnos con alguien que esté dispuesto a compartir con un desconocido lector vivencias tan íntimas.

"FIRST EUROPEAN TEACHING SEMINARY"*

"A propósito de las especias de Venecia"

Desde el 1 al 6 de noviembre de 1982, organizado por Maurizio Andolfi y el Instituto de Terapia Familiar de Roma, con el patrocinio de la Fundación Científica Querini-Stampalia de Venecia, se realizó el Primer Seminario Didáctico sobre Terapia Familiar. Relatores: Carl Whitaker, Salvador Minuchin y Maurizio Andolfi.

Cuando en los siglos pasados llegaban los mercaderes a Venecia para intercambiar sus mercaderías, los venecianos los encerraban en los "fondaci", las barracas, de las cuales sólo salían cuando habían terminado sus negocios. De este modo, los mercaderes de Europa del norte jamás podían encontrar a los que venían del Oriente, y los venecianos comerciaban con todos, vendiendo las pieles y los minerales de los unos a los otros, y vendiendo las sedas y las especias de éstos a los primeros. Encerrados en el "fondaco", la barraca de la Fundación Querini-Stampalia, cuarenta maestros de Terapia Familiar, provenientes de 14 países de Europa (aunque había también argentinos, canadienses, israelitas) intercambiaron sus mercaderías. De entre ellos, los mercaderes más importantes eran tres: un italiano que vendía especias nuevas y picantes, un argenti-

* De "Notizie e commenti", aparecido en Revista "Terapia Familiare", No. 12, diciembre, 1982, Roma, Italia.

no-norteamericano que sabía todo sobre las mercaderías de los otros y un norteamericano que afirmaba que no quería venderle nada a nadie...

Lo llamaron "First European Teaching Seminary", aunque de hecho no ha sido el primer encuentro de estudios de ese tipo organizado en Europa. Los ingleses, como se sabe, habían reunido ya en el 79, en la Clínica Tavistock, a norteamericanos y europeos que no pudieron disfrutar de un ornamento tan fascinante como Venecia, que para esta ocasión quiso prolongar un clima casi primaveral que mitigara las aguas inquietas de la discusión: ¿en qué punto se encuentra hoy la enseñanza de la terapia familiar en Europa? ¿Cuáles son los problemas urgentes de quien se constituye en su promotor y la enseña, y cuáles son las dificultades del que aprende y busca diferenciarse de los maestros? ¿Cómo ubicar correctamente la relación supervisor-terapeuta y terapeuta-familia-supervisor tanto en los centros privados como en las instituciones públicas, teniendo en cuenta no sólo la delicada interacción entre los terapeutas y el grupo de observadores en formación sino también la estructura jerárquica, que a veces tiene fuerte gravitación, especialmente en el contexto de las instituciones? Y además, ¿cuándo se debe privilegiar la coterapia —y si hay que hacerlo y cómo— respecto de la supervisión detrás del espejo, o bien respecto del control? En fin, ¿cómo ubicarse hoy de manera crítica y retrospectiva frente a problemas de tipo especulativo tales como: ¿es correcto hablar de técnicas y de modelos relacionales; de contenidos paradigmáticos o de estilos de intervención, de relación terapéutica *estructural, sistémica, provocativa, de sostén, o de experiencias simbólicas*?

No hay duda, el tema central encarado en Venecia es un tema ambicioso, tanto como de difícil acceso, pues todavía no existe una teoría unificante de la enseñanza. Es preciso, ante todo, individuar los criterios de fondo que definan la coherencia entre un modelo de intervención terapéutica y un modelo de enseñanza. El problema consiste en intentar transmitir una cultura hecha de ideas, procesos y técnicas en el interior de un grupo de entrenamiento. Pero eso no basta. Es preciso propor-

cionar al terapeuta alumno la posibilidad de poner en juego su sí mismo y de descubrir sus límites, de los cuales, y del reconocimiento de los cuales nace, en forma creativa la "personalidad" terapéutica. (Andolfi.)

Otro punto esencial: frente a un terapeuta que se encuentra en dificultades, ¿cuál es la utilidad de intervenir con un *modelling*, un modelamiento magistral, a lo Minuchin, y luego salir de la sala de terapia? Y aún más, es posible poner en acto una relación coterapéutica en la cual un terapeuta alumno se sienta libre para mantener la comparación y expresarse de manera más autónoma con un coterapeuta bastante más experto, como por ejemplo Carl Whitaker, que repropone continuamente en un nivel simbólico, con una desenvoltura casi desconcertante, temas tales como la muerte, el homicidio o el suicidio?

Todas estas problemáticas fueron propuestas, aunque no agotadas en los cinco días de tareas estructuradas en los pequeños grupos de 13/15 participantes de la mañana y en las sesiones plenarias de la tarde, realizadas en la Sala Luzzato. En los grupos reducidos cada participante o conjunto de clínicos y operadores que trabajan juntos habitualmente en sus respectivas sedes, presentaron temas neurálgicos al coordinador del día, recibiendo feed-backs significativos por parte del grupo. C. Whitaker, M. Andolfi y S. Minuchin, unidos por vínculos de estima y amistad en el plano personal, aunque muy diferentes unos de los otros, tanto por su ubicación teórica y metodológica como por su edad, ofrecieron una contribución clínica de altísimo nivel sobre todo en el "triálogo" que constituyó uno de los puntos de máximo interés y de vivaz confrontación del Seminario.

En el grupo I, las contribuciones más importantes provinieron de los ingleses y de los italianos. Alan Cocklyn y Gill Gorell-Barnes del Family Therapy Institute de Londres, presentaron un interesante modelo de supervisión, comparado dos días después, con el que presentó Rodolfo de Bernart de Florencia. La coterapia como modelo de enseñanza constituyó el tema de la comunicación de Camillo Loredi, de Roma.

Mark Nevejan, de Holanda, presentó un modelo de enseñanza mediante una coterapia con grupo de parejas. Muy estimulante también, resultó la contribución de Guy Ausloos acerca de su trabajo, desarrollado en una "Casa-famiglia", alojamiento familiar para menores en Suiza.

En el grupo II, Daniel Sampalo presentó un modelo de aprendizaje horizontal (paritario e intercambiable), desarrollado por los ocho representantes de la Sociedad Portuguesa de Terapia Familiar: Heidi Salm y Mona Krahe-Boegner, de Alemania, hicieron una demostración práctica de técnicas de aprendizaje audiovisual, privilegiando, sobre todo, la utilidad de las técnicas auditivas como correctivos para individuar y modificar preconceptos y proyecciones inconscientes de los terapeutas acerca de la familia, en el curso de la primera sesión. Adolfo Loketek concentró su exposición en algunas de las técnicas que se utilizan en el Centro de Familias y Parejas que dirige en Buenos Aires, para hacer aflorar los potenciales más creativos de los terapeutas que realizan su entrenamiento.

En el grupo III, John Byng-Hall y Rosemary Whiffen, de Gran Bretaña, encararon el problema técnico de las cintas didácticas, al presentar el *tape* de una supervisión realizada con auxilio del auricular. El Dr. Gulens y la Sra. D. Horn, de Canadá, trataron el tema de la enseñanza en tres niveles —conceptual, perceptual y ejecutivo—ilustrado con un video de una entrevista familiar en supervisión, y sucesivas discusiones entre supervisor y supervisado. Wenke Seltzer, de Noruega presentó un *paper* sobre el enfoque antropológico de los sistemas culturales (mágicos y ritualistas) de la familia que se encuentra en terapia. No faltaron intervenciones más desconcertantes: Piero de Giacomo, de Italia habló del uso de la computadora en terapia familiar y Hugo Eysel, de Alemania, hizo una aproximación entre teoría sistémica y sinergismo (teoría del láser).

Las sesiones plenarias se llevaron a cabo aunque después del primer día la disposición programada del "triálogo" (una presentación de las síntesis más recientes teóricas y metodológicas de cada uno de los tres líderes, a la cual habría debido

seguir un comentario crítico de los otros dos integrantes del triángulo y de los participantes al Seminario), se modificó gradualmente para permitir una participación activa cada vez mayor por parte de todos los integrantes y un intercambio por medio de situaciones terapéuticas simuladas.

Fue impecable la ejemplificación de supervisión directa —casi mayéutica— que proporcionaron Maurizio Andolfi y Rodolfo de Bernart; muy diferente resultó la supervisión de S. Minuchin con Giovanna Todini, en la simulación de una familia anoréxica "imposible", en la cual Minuchin repropuso la entrada magistral del supervisor con todos los méritos y límites que representa; finalmente, muy estimulante la demostración de una coterapia presentada por Whitaker y Camillo Loredio que "enfervorizó" la sesión plenaria del cuarto día.

Para concluir, en Venecia se habló más de supervisión y de coterapia que de modelos de enseñanza y de curriculum formativo. No hubo espacio suficiente para esclarecer los presupuestos teóricos de los participantes, ni siquiera del todo, de los tres "grandes". Muchas fueron las cuestiones que quedaron sin resolver. Por ejemplo, ¿la coterapia puede ser verdaderamente un medio de enseñanza? Si es así, ¿crea mayor dependencia en el alumno respecto de la supervisión? ¿Se puede realmente enseñar a un alumno a ser terapeuta sólo transmitiéndole técnicas? Muchos estaban de acuerdo en que esto no sería posible, pero ¿cómo ampliar entonces el campo experimental? ¿qué técnicas de enseñanza son más válidas para obtener este objetivo?

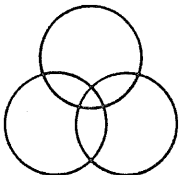
Parece entonces pertinente auspiciar un Segundo Seminario Europeo para Didactas que afronten más en profundidad el problema del entrenamiento con el fin de proponer una plataforma coherente para ejercer la didáctica de la terapia relacional en la próxima década.

Rodolfo de Bernart

Marcella de Nichilo

Trad. Julia F. de Prieto

(Comisión Bibliografía de CEFYP).



FAMILY SYSTEMS MEDICINE

A Journal at the Confluence of Family Therapy,
Systems Theory and Modern Medicine

A new publication joining psychological and biomedical approaches to health care and adding a penetrating focus on the family as the primary unit of diagnosis and treatment. It investigates all illness from a family systems perspective, focusing on how families are organized around chronic illness, accidents and catastrophic illness, in order to determine how the family organization enables or disables patient care and compliance with medical regimens, and in turn is affected.

Topics include: Hierarchical Issues in a Systems Approach to Illness and Health; A Family Approach to Patient Compliance; Psychosomatic Families; Terminal Illness and Death; What Is the Family in Family Medicine?

CIRCULATION AND FREQUENCY

First Issue: Spring 1983. Family Practice Physicians, Family Therapists, Psychologists, Clinical Social Workers, Nurses, and related research and clinical disciplines.

Publication is quarterly in March, June, September and December. Subscription rate is \$27 per year for individuals; \$44 for institutions.

Editor:

Donald A. Bloch, M.D.

Assoc. Eds:

Michael L. Glen, M.D.

Barry Dym, Ph.D.

Donald Ransom, Ph.D.

Correspondence to: Mrs. Alice Weisman; Advertising and Promotion
Director; Box 419, Larchmont, N.Y. 10538; (914) 834-3920

CONCURSO 1982 DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR

La Revista TERAPIA FAMILIAR instituyó un concurso de trabajos teóricos, clínicos o de investigación que signifiquen un aporte relevante al desarrollo del conocimiento y de la práctica de nuestra disciplina.

Recordamos que las condiciones son las siguientes:

- El concurso se realizará anualmente a partir de 1980.
- Los trabajos podrán ser presentados individual o grupalmente, pudiendo tratarse de terapeutas familiares o de equipos interdisciplinarios residentes en el país.
- El jurado estará compuesto por 6 (seis) personalidades reconocidas en nuestra disciplina y será designado por los responsables de la Revista Terapia Familiar. En caso de empate se requerirá el voto del Director de la Revista.
- El premio consistirá en un diploma y la publicación del trabajo en la Revista TERAPIA FAMILIAR. Podrá ser compartido o declarado desierto. El jurado podrá otorgar menciones a otros trabajos que serían eventualmente publicados.
- Los trabajos, que deberán ser inéditos, serán presentados en 7 (siete) copias escritas a máquina, a doble espacio, tamaño carta. Serán firmados con un seudónimo; que a su vez figurará con el título del trabajo en la cara externa de un sobre cerrado conteniendo en su interior el nombre y domicilio del o los autores.
- La recepción de los trabajos quedará a cargo de los responsables de la Revista TERAPIA FAMILIAR, hasta el 15 de Octubre de 1983. El trabajo premiado y las menciones que hubiera resuelto el jurado serán publicados en el segundo número de la revista de ese mismo año.

Comité de Redacción.

SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR

Resumen de las actividades realizadas durante el año 1982

Abril:

- Introducción a la Teoría General de los Sistemas, del 1° de abril al 24 de junio.
Dra. Nora Mattenet, Dr. Charles François, Lic. Alejandro Piscitelli, Lic. Ricardo Guarinoni, Lic. Héctor Label.
- “Modelos teóricos clínicos alternativos en psicoterapia familiar”, del 2 de abril al 26 de noviembre.
Dra. Analía Kornblit y Lic. Jaime Szwarcstein.
- “Curso sobre teoría y técnica de la terapia familiar” (1a. parte), del 1° de abril al 25 de noviembre.
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser.
- “Curso sobre teoría y técnica de la terapia familiar” (2a. parte), 26 de marzo al 26 de noviembre.
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser.
- “Revisión de la obra de G. Bateson”, del 5 de abril al 26 de julio.
Dra. Analía Kornblit y Lic. Jaime Szwarcstein.
- Supervisiones con Lic. Juan Carlos Nocetti.
- Proyección y discusión de tapes con Lic. Silvia Stuhlman y Lic. Afda Tarrab.

Mayo:

- Programa de entrenamiento (1 reunión por mes) en mayo, junio, julio, octubre, noviembre, diciembre.
Dra. Cristina Mazieres, Dr. Gastón Mazieres y Lic. Silvia Crescini.

Junio:

- Reuniones sobre “Reflexiones sobre el papel del terapeuta familiar en la situación bélica”.
Lic. Ruth Schwartz.

Julio:

- Proyección de un tape de S. Minuchin, 7 y 14 de julio.
Dra. Cristina Mazieres y Psic. Alberto González.

Agosto:

- Proyección de tapes de la Dra. Mara Selvini Palazzoli, 26 y 31 de agosto.
Dra. Susana Bullrich y Lic. Sara Tutorán.

Septiembre:

- II Congreso Argentino de Terapia Familiar.
9, 10 y 11 de septiembre.

Octubre:

- Conferencia con el Dr. Ráymundo Macías (entrevista de una familia en vivo).
11 de octubre.

Noviembre:

- "Familias psicósomáticas, según el modelo de Minuchin"
4 clases en noviembre.
Dra. Analía Kornblit, Lic. Jaime Szwarcstein, Dra. Silvia Wasertreguer.
- "Seminario intensivo teórico-clínico"
6 de noviembre.
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser.

Diciembre:

- Proyección de tapes de la Dra. Mara Selvini Palazzoli.
3 y 10 Dra. Susana Bullrich y Dr. José Bechuk.
16 y 23 Dra. Susana Bullrich y Lic. Martha Schejtman.

Resumen de las actividades realizadas durante el año 1983

- Introducción a la teoría y técnica de la terapia familiar.

12 de abril al 29 de noviembre.

Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser.

- Sobre la teoría y la técnica de la terapia familiar (2a. parte)
7 de abril al 24 de noviembre.
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser.
- Sobre la teoría y la técnica de la terapia familiar (3a. parte)
8 de abril al 25 de noviembre
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser.
- Los roles genéricos del hombre y la mujer en la familia y la sociedad.
17 de mayo al 5 de julio
Lic. Cristina Gerlic y Lic. Jorge Pailles.
- Introducción al psicodrama y su aplicación a la terapia de pareja y familia.
28 de abril al 19 de mayo
Dr. Carlos Martínez Bouquet y Lic. Cristina Florez Monroy
- Entrenamiento en terapia familiar estructural
8 de abril al 25 de noviembre.
Dra. Analía Kornblit y Lic. Jaime Szwarcstein
- Familia y pareja: distintos abordajes terapéuticos.
16 de mayo al 4 de julio
Lic. Silvia Stuhlman y Lic. Aída Tarrab.

Nos. 11 y 12.

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal **Localidad**

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Editorial ACE S.R.L., No a la orden, por pesos

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL

Argentina \$a 85.-
Exterior u\$s 26.-

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

La Revista de Terapia Familiar publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

Artículos

— La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

— No se paga honorarios por los trabajos aceptados.

— El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o de someterlos a corrección de estilo.

— Los trabajos deben estar escritos a máquina y a doble espacio. Se debe presentar original y dos copias, también deben incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su envío a revistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañan el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

— Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a las normas internacionales: 1) Ordenadas y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2) Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3) Título completo del trabajo citado. 4) Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volumen o Volúmenes; referencia de primera y última página y año de publicación (en este orden).

— Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.